ЛОР-справочник

Разборы клинических рекомендаций

19 рекомендаций Минздрава РФ · сборка от 22.10.2026 · каждый пункт сверен с текстом КР

Оглавление

Абсцесс, фурункул и карбункул носа 5
J34.0

1. Главное 6
2. Клиника и классификация 6
3. Диагностика 7
4. Лечение 9
5. Наблюдение, профилактика, госпитализация 13
6. Источник и актуальность 14

Аллергический ринит 16
J30.1, J30.2, J30.3, J30.4

1. Главное 17
2. Клиника и классификация 17
3. Диагностика 18
4. Лечение 19
5. Дети, беременность, кормление грудью 23
6. Контроль лечения 23
7. Наблюдение, профилактика, госпитализация 24
8. Источник и актуальность 24

Болезнь Меньера 25
H81.0

1. Главное 26
2. Клиника и классификация 26
3. Диагностика 27
4. Лечение 30
5. Наблюдение, профилактика, госпитализация 31
6. Источник и актуальность 32

Гипертрофия аденоидов. Гипертрофия нёбных миндалин 33
J31.1, J35.1, J35.2, J35.3, J35.8

1. Главное 34
2. Клиника и классификация 34
3. Диагностика 35
4. Лечение 37
5. Наблюдение, профилактика, госпитализация 39
6. Источник и актуальность 40

Наружные отиты 42
H60.0, H60.1, H60.2, H60.3, H60.4, H60.5, H60.8, H60.9, H61.0, H61.8, H61.9, H62.0, H62.1, H62.3, H62.4, H62.8

1. Главное 43
2. Клиника и классификация 43
3. Диагностика 44
4. Лечение 44
5. Профилактика и госпитализация 46
6. Источник и актуальность 46

Нейросенсорная тугоухость у взрослых 47
H90.3, H90.4, H90.5, H91.1, H91.2, H91.8

1. Главное 48
2. Клиника и классификация 48
3. Диагностика 50
4. Лечение и реабилитация 52
5. Наблюдение, профилактика, госпитализация 57
6. Источник и актуальность 57

Носовое кровотечение 59
R04.0

1. Главное 60
2. Клиника и классификация 60
3. Диагностика 61
4. Лечение 62
5. Профилактика и госпитализация 64
6. Источник и актуальность 64

Острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) у взрослых 66
B34.0, B34.2, B34.9, B97.0, B97.4, J00, J01, J02, J03, J04, J05, J06, J20, J21, J22

1. Главное 67
2. Клиника и классификация 67
3. Диагностика 69
4. Лечение 72
5. Наблюдение, профилактика, госпитализация 76
6. Источник и актуальность 78

Острый ларингит 79
J04.0, J04.2

1. Главное 80
2. Клиника и классификация 80
3. Диагностика 81
4. Лечение 83
5. Наблюдение, профилактика, госпитализация 87
6. Источник и актуальность 87

Острый синусит 89
J01

1. Главное 90
2. Клиника и классификация 90

3. Диагностика 91
4. Лечение 92
5. Госпитализация и осложнения 95
6. Источник и актуальность 95

Острый тонзиллит и фарингит 97
J02, J02.0, J02.8, J02.9, J03, J03.0, J03.8, J03.9

1. Главное 98
2. Клиника и классификация 98
3. Диагностика 99
4. Лечение 100
5. Профилактика, госпитализация, осложнения 103
6. Источник и актуальность 104

Отит средний острый 105
H65.0, H65.1, H66.0

1. Главное 106
2. Клиника и классификация 106
3. Диагностика 107
4. Лечение 108
5. После острого периода и госпитализация 111
6. Источник и актуальность 111

Отосклероз 112
H80

1. Главное 113
2. Клиника и классификация 113
3. Диагностика 114
4. Лечение 117
5. Наблюдение, профилактика, госпитализация 120
6. Источник и актуальность 121

Паратонзиллярный абсцесс 122
J36, J39.0, J39.1

1. Главное 123
2. Клиника и классификация 123
3. Диагностика 124
4. Лечение 125
5. Профилактика, госпитализация, осложнения 126
6. Источник и актуальность 126

Полипозный риносинусит 128
J33.0, J33.1, J33.8, J33.9

1. Главное 129
2. Клиника и классификация 129
3. Диагностика 130
4. Лечение 132

5. Наблюдение, профилактика, госпитализация 134
6. Источник и актуальность 135

Травма носа 136
S00.3, S01.2, S02.2

1. Главное 137
2. Клиника и классификация 137
3. Диагностика 139
4. Лечение 140
5. Наблюдение, профилактика, госпитализация 145
6. Источник и актуальность 145

Хронический синусит 147
J32.0, J32.1, J32.2, J32.3, J32.4, J32.8, J32.9, J34.1

1. Главное 148
2. Клиника и классификация 148
3. Диагностика 151
4. Лечение 152
5. Наблюдение, профилактика, госпитализация 155
6. Источник и актуальность 156

Хронический средний отит 158
H65.2, H65.3, H65.4, H66.1, H66.2, H66.3, H72.0, H90.0, H90.1, H90.2, H90.6, H90.7, H90.8

1. Главное 159
2. Клиника и классификация 159
3. Диагностика 160
4. Лечение 163
5. Наблюдение, профилактика, госпитализация 167
6. Источник и актуальность 167

Хронический тонзиллит 169
J31.2, J35.0, J35.8, J35.9

1. Главное 170
2. Клиника и классификация 170
3. Диагностика 171
4. Лечение 172
5. Наблюдение, профилактика, госпитализация 174
6. Источник и актуальность 174

Клинические рекомендации

Абсцесс, фурункул и карбункул носа

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**J34.0** — Абсцесс, фурункул и карбункул носа
Пациенты	взрослые, дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 14.10.2025, пересмотр не позднее 2028 года
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/956_1

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 22.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

1. Главное

- В стадии инфильтрации фурункул лечат консервативно; при абсцедировании и при карбункуле гнойник вскрывают и дренируют, продолжая консервативное лечение.
- Системные антибиотики назначают всем пациентам с фурункулом, карбункулом и абсцессом носа — чтобы санировать очаг и предупредить осложнения.
- При каждом осмотре ищут признаки внутричерепных осложнений: синдром системной воспалительной реакции, неврологические и глазные симптомы, тромбоз угловой вены и кавернозного синуса.
- Лихорадка, головная боль, хемоз, экзофтальм и поражение III, IV, V и VI пар черепных нервов указывают на возможный тромбоз кавернозного синуса; в этом случае делают КТ головного мозга с внутривенным болюсным контрастированием.
- Ребёнка с этим диагнозом всегда госпитализируют в круглосуточный ЛОР-стационар; взрослого в стадии инфильтрации можно лечить амбулаторно.
- Массировать область носа и выдавливать содержимое фурункула нельзя.

2. Клиника и классификация

2.1 Определения

Фурункул носа — острое гнойно-некротическое воспаление волосяного фолликула и сальной железы на кончике или крыльях носа, в преддверии носа или в области дна носа у верхней губы. Карбункул носа — гнойно-некротическое воспаление нескольких волосяных фолликулов и сальных желёз, которое распространяется вглубь тканей и по поверхности, с обширными некрозами кожи и подкожной клетчатки. Абсцесс носа (абсцедирующий фурункул) — скопление гноя при острой инфекции с разрушением тканей в очаге, часто с отёком вокруг.

2.2 Причины

Главный возбудитель — золотистый стафилококк; бессимптомные носители служат резервуаром инфекции. Пиодермию и фурункул носа могут вызывать и стрептококки, прежде всего бета-гемолитический стрептококк группы А. Инфицированию фолликула способствуют микротравмы кожи носа и преддверия, загрязнение кожи техническими маслами и пылью при плохой гигиене, а также переохлаждение, перегревание, стресс и нарушение секреции кожи. У детей фурункул чаще всего возникает из-за привычки ковырять в носу и слишком частого сморкания.

Фурункул носа нередко бывает проявлением фурункулёза — множественных фурункулов на фоне вторичного иммунодефицита при эндокринных болезнях, прежде всего при сахарном диабете, а также при гиповитаминозе, нарушениях питания и болезнях желудочно-кишечного тракта.

2.3 Почему фурункул носа опасен

Венозная кровь от средней зоны лица — так называемого опасного треугольника, ограниченного линиями от назиона к углам рта, — оттекает по угловым венам, венам орбиты и крыловидному сплетению в кавернозный синус. У этих вен нет клапанов, поэтому инфекция с кожи лица, носа и пазух может по сосудам попасть в глазницу, затем в кавернозный синус и на мозг. В кавернозном синусе проходят внутренняя сонная артерия, III, IV и VI пары черепных нервов и первая и вторая ветви тройничного нерва, к нему прилежат гипофиз и клиновидная пазуха; отсюда тяжесть внутричерепных осложнений.

При сниженной сопротивляемости и высокой вирулентности возбудителя процесс может генерализоваться: стафилококки распространяются в окружающие ткани или попадают в кровь и вызывают сепсис. В инфильтрате тромбируются мелкие вены, и с ростом очага растёт угроза распространения тромбоза.

2.4 Классификация

По стадии воспаления выделяют I стадию — инфильтрации и II стадию — абсцедирования.

2.5 Клиническая картина

Пациенты с фурункулом носа жалуются на боль в области носа, головную боль, слабость, снижение работоспособности и субфебрильную температуру. В анализе крови может быть сдвиг лейкоцитарной формулы влево и повышенная СОЭ. Фурункул бывает на кончике носа, в преддверии, у перегородки или в области дна носа.

> В разделе 1.6 сказано, что фурункул бывает «в области дна носа у нижней губы», а в определениях (раздел 1.1 и «Термины») — «у верхней губы». Дно носа граничит с верхней губой, так что в разделе 1.6, по-видимому, опечатка.

В стадии инфильтрации кожа над фурункулом постепенно краснеет, появляется местная боль, которая усиливается при мимике и жевании, нарастает инфильтрация мягких тканей. Вокруг очага образуется некроз, формируется стержень. На внутренней поверхности входа в нос виден болезненный конусовидный инфильтрат.

При благополучном течении некротический стержень отторгается, выделяется немного гноя, инфильтрат уменьшается, боль стихает, температура нормализуется и общее состояние улучшается.

В стадии абсцедирования, если процесс прогрессирует, зона некроза растёт, кожа над инфильтратом истончается, появляется флюктуация и формируется абсцесс.

При карбункуле и абсцессе носа общее состояние тяжёлое, температура фебрильная, пациента беспокоят распирание и сильная пульсирующая боль. На носу появляется несколько плотных инфильтратов, которые сливаются в один растущий очаг. В области карбункула образуется большая полость с гнойно-некротическим содержимым, а на коже — несколько отверстий, из которых выделяются гной и некротические кровянистые массы.

У детей болезнь протекает тяжелее из-за интоксикации: головной боли, слабости, вялости, лихорадки. Местные изменения могут развиваться быстрее, а обширный отёк и покраснение верхней губы или щеки могут маскировать фурункул под болезнь челюстно-лицевой области.

2.6 Анамнез

В анамнезе бывают переохлаждение и косметические процедуры на наружном носе и в его преддверии.

---

3. Диагностика

Диагноз фурункула носа ставят по трём признакам. Первый — жалобы на сильную боль в носу в области очага, которая усиливается при прикосновении, головную боль, недомогание и повышение температуры. Второй — данные осмотра: покраснение, отёк и инфильтрация мягких тканей наружного носа, преддверия и носо-лицевой области, резкая болезненность при пальпации. Третий — данные передней риноскопии: в преддверии носа у волосяного фолликула видны покраснение кожи, инфильтрат и гнойный стержень в центре.

3.1 Осмотр

Каждого пациента с подозрением на фурункул носа первично осматривает оториноларинголог, врач общей практики или педиатр, чтобы поставить и уточнить диагноз.

При передней риноскопии сначала может определяться остиофолликулит преддверия носа — покраснение и уплотнение в устье волосяного фолликула. В течение 1–2 суток появляются отёк, инфильтрат и покраснение кожи входа в нос (стадия инфильтрации), затем кожа истончается, ткани в очаге гнойно-некротически расплавляются и образуется детрит. Снаружи видны покраснение, отёк и болезненность преддверия и кончика носа; пациенту больно, когда касаются носа и во время риноскопии. Кожу преддверия могут покрывать толстые жёлтые корки. При выраженном воспалении отёк переходит на щёку и верхнюю губу.

Основной инструментальный метод — передняя риноскопия; её проводят всем пациентам, чтобы осмотреть полость носа и уточнить, где расположен фурункул.

3.2 Признаки внутричерепных осложнений

При каждом осмотре проверяют, нет ли симптомов внутричерепных осложнений. О них говорят три синдрома: инфекционный, неврологический и офтальмологический.

Инфекционный синдром — это синдром системной воспалительной реакции: температура 38 °C и выше или 36 °C и ниже, частота сердечных сокращений 90 в минуту и больше, частота дыхания больше 20 в минуту, лейкоциты больше 12 × 10^9/л или меньше 4 × 10^9/л либо незрелых форм больше 10%, прокальцитонин плазмы 0,5 нг/мл и выше.

Неврологический синдром — сильная головная боль, тошнота и рвота, не связанные с едой, несистемное головокружение. О менингеальном синдроме говорят светобоязнь, звукобоязнь, повышенная чувствительность кожи и ригидность затылочных мышц; могут определяться симптомы Кернига и Брудзинского, скуловой симптом Бехтерева и симптом Менделя. По мере прогрессирования возможны оглушение, психомоторное возбуждение и судороги.

Офтальмологический синдром — отёк век, хемоз и экзофтальм на стороне поражения; при пальпации век могут прощупываться болезненные тромбированные вены. При офтальмоскопии бывают признаки внутричерепной гипертензии.

При тромбозе угловой вены пальпация резко болезненна, беспокоит сильная головная боль, лицо отекает на стороне поражения, а сама угловая вена прощупывается как плотный болезненный тяж.

Для тромбоза кавернозного синуса, особенно в начале, характерен выраженный цианоз слизистой губ, кожи лба и носа. Затем нарастает отёк верхней губы и щеки на стороне поражения, который переходит на височную и лобную области, на веки и на другую половину лица. Нарушается, вплоть до полного выпадения, функция глазодвигательного, блокового, отводящего и тройничного нервов.

При подозрении на тромбоз кавернозного синуса делают компьютерную томографию (КТ) головного мозга с внутривенным болюсным контрастированием.

На возможный тромбоз кавернозного синуса указывают фебрильная лихорадка, головная боль, хемоз, экзофтальм и признаки поражения III, IV, V и VI пар черепных нервов.

При осложнённом течении пациента первично осматривают офтальмолог и невролог — для дифференциальной диагностики и выбора лечения.

Если воспаление распространилось на лицо, целесообразна консультация челюстно-лицевого хирурга.

По алгоритму КР при внутричерепных осложнениях пациента консультируют нейрохирург, офтальмолог и челюстно-лицевой хирург.

> Состав консультантов при осложнениях в КР не совпадает: в разделе 2.5 и в критериях качества — невролог и офтальмолог, а в алгоритме (приложение Б) — нейрохирург, офтальмолог и челюстно-лицевой хирург.

3.3 Анализы

На любой стадии всем пациентам делают развёрнутый общий анализ крови, чтобы оценить общее состояние и выраженность воспаления.

Биохимический анализ крови назначают, чтобы выявить сахарный диабет, нарушения углеводного обмена и другие состояния, которые способствуют фурункулу и утяжеляют его течение.

Сахарный диабет ухудшает частоту, течение и прогноз фурункула. При повышенной глюкозе пациента направляют к эндокринологу, чтобы скорректировать глюкозу, выявить диабет и назначить лечебное питание. Изменения билирубина, креатинина, мочевины, АЛТ и АСТ указывают на нарушение работы печени и почек.

Коагулограмму делают всем пациентам с осложнённым фурункулом носа и с сопутствующими болезнями.

При абсцедирующем фурункуле, карбункуле и абсцессе носа гнойное отделяемое отправляют на посев на аэробы и факультативные анаэробы с определением чувствительности, чтобы правильно выбрать антибиотик.

Материал берут из раны после вскрытия, не касаясь окружающих тканей, и до начала антибиотиков.

---

4. Лечение

Метод лечения выбирают по стадии фурункула и его проявлениям — есть ли карбункул или абсцесс. При неосложнённом течении лечат в основном консервативно, местно и парентерально. Лечение комплексное: уничтожить возбудителя, снять интоксикацию, восстановить обмен веществ и повысить защитные силы организма.

По алгоритму КР в стадии инфильтрации проводят консервативное лечение, в стадии абсцедирования — хирургическое вместе с консервативным. В стадии разрешения пациента консультирует физиотерапевт, при рецидиве — эндокринолог и аллерголог-иммунолог.

4.1 Местное лечение

Всем пациентам с фурункулом носа местно применяют антисептики, чтобы подавить инфекцию и воспаление.

В первые часы после появления инфильтрата хорошо помогает повторное смазывание пустулы 5% спиртовым раствором йода. Выраженно действуют четвертичные аммониевые соединения (бензилдиметил-миристоиламино-пропиламмоний), препараты йода (повидон-йод — детям старше 28 дней) и хлоргексидин; их можно применять у взрослых и детей. Как часто обрабатывать рану, зависит от выраженности воспаления; обрабатывают до разрешения инфекции. В стадии инфильтрации кожу вокруг очага бережно обрабатывают 70% этанолом.

Пациентам с фурункулом и карбункулом носа назначают мази с антибиотиками широкого спектра, чтобы санировать очаг.

Мупироцин в мази взрослым наносят 2–3 раза в день 5–7 дней, детям — с рождения 2–3 раза в день не дольше 10 дней. Фузидовую кислоту взрослым наносят на кожу над фурункулом в виде мази или крема до 3–4 раз в день 7–14 дней, детям с рождения — крем 3–4 раза в день 7–14 дней. Мазь диоксометилтетрагидропиримидин + хлорамфеникол действует и противомикробно, и противовоспалительно; взрослым и детям с года её наносят раз в день, пока рана не очистится от гнойно-некротических масс.

4.2 Обезболивание

Если нет противопоказаний, назначают противовоспалительные и обезболивающие средства, чтобы снять воспаление и боль.

Применяют нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) и другие анальгетики-антипиретики по отдельности или вместе. Хорошо действует сочетание НПВП с парацетамолом, а для снятия боли у взрослых и детей, в том числе после операции, — метамизол натрия. Из НПВП у детей можно применять ибупрофен с 3 месяцев, кетопрофен с 15 лет, а кетопрофен в гранулах для раствора внутрь — с 6 лет.

Детям в амбулаторной практике метамизол натрия не назначают, а в стационаре применяют, только если нет других разрешённых детям анальгетиков, — из-за риска серьёзных нежелательных явлений.

4.3 Обезболивание у взрослых

Препарат	Разовая доза	Интервал	Максимум в сутки	Длительность
Парацетамол	0,5–1 г внутривенно, инфузия 15 минут	6 ч	4 г	5–7 суток
Диклофенак	75 «мл» внутримышечно (так в таблице КР; по смыслу — 75 мг)	12 ч	150 мг	2 суток
Кеторолак	30 мг внутривенно или внутримышечно	8 ч	60–90 мг	2 суток
Кетопрофен	100 мг внутривенно или внутримышечно	12 ч	200 мг	не больше 2 суток
Лорноксикам	8 мг внутривенно или внутримышечно	12 ч	16 мг	1–7 суток
Декскетопрофен	50 мг внутривенно или внутримышечно	8–12 ч	150 мг	2 суток
Метамизол натрия	500–1000 мг внутривенно или внутримышечно	8–12 ч	2 г	1–5 суток

> Разовая доза диклофенака в таблице 1 записана как «75 мл в/м»; по смыслу и по суточному максимуму 150 мг речь о 75 мг.

4.4 Обезболивание у детей

Препарат	Разовая доза	Интервал	Максимум в сутки	Длительность
Парацетамол внутривенно	Инфузия 15 минут: меньше 10 кг — 7,5 мг/кг; 10–50 кг — 15 мг/кг; больше 50 кг — 1000 мг	4 ч	Меньше 10 кг — меньше 30 мг/кг; 10–50 кг — меньше 60 мг/кг, но не больше 2 г; 33–50 кг — меньше 60 мг/кг, но не больше 3 г; больше 50 кг — 4 г	5–7 суток

Препарат	Разовая доза	Интервал	Максимум в сутки	Длительность
Парацетамол внутрь	С 12 лет — 0,5–1 г; 6–12 лет — 240–480 мг; 1–6 лет — 120–240 мг; от 3 месяцев до года — 72–120 мг	6 ч	С 12 лет — 4 г; 33–50 кг — меньше 60 мг/кг, но не больше 3 г; 10–50 кг — меньше 60 мг/кг, но не больше 2 г; меньше 10 кг — меньше 30 мг/кг	С 12 лет — 3 суток, до 12 лет — 5–7 суток
Парацетамол в ректальных суппозиториях	10–14 лет — 500 мг; 5–9 лет — 250 мг; 1–4 года — 100 мг; 3–12 месяцев — 50–100 мг	4–6 ч	Меньше 60 мг/кг	До 5 суток
Ибупрофен внутрь	Старше 6 лет — 200–400 мг; 4–6 лет — 150 мг; 1–3 года — 100 мг; 3–12 месяцев — 50 мг	8 ч	12–17 лет — 1 г; 6–12 лет — 800 мг; 4–6 лет — 450 мг; 1–3 года — 300 мг; 6–12 месяцев — 200 мг; 3–6 месяцев — 150 мг	4 суток
Ибупрофен в ректальных суппозиториях	3–9 месяцев — 60 мг; 9–24 месяца — 60 мг	8 ч (3–9 месяцев), 6 ч (9–24 месяца)	3–9 месяцев — 180 мг; 9–24 месяца — 240 мг	Не больше 3 суток
Кетопрофен	С 15 лет — 100 мг внутривенно или внутримышечно	12 ч	200 мг	Не больше 2 суток
Кетопрофен в гранулах для раствора внутрь	Старше 6 лет — 40 мг	8 ч	120 мг	Не больше 2 суток
Метамизол натрия внутримышечно	13–14 лет — 0,8–1,8 мл (400–900 мг); 10–12 лет — 0,5–1,0 мл (250–500 мг); 7–9 лет — 0,4–1,0 мл (200–500 мг); 4–6 лет — 0,3–0,8 мл (150–400 мг); 1–3 года — 0,2–0,5 мл; 3–11 месяцев — 0,1–0,2 мл (50–100 мг)	8–12 ч	С 15 лет — 2 г; 8–14 лет — 900 мг; 4–7 лет — 600 мг; 2–3 года — 300 мг	1–5 суток

> В строке метамизола натрия таблицы 2 для детей 1–3 лет указано «0,2–0,5 мл (100–2500 мг)»: при тех же 500 мг в 1 мл, что и в соседних строках, 0,5 мл — это 250 мг, так что «2500» — опечатка. Возраст «79 лет» в той же строке — это 7–9 лет.

4.5 Системные антибиотики

Системные антибиотики назначают всем пациентам с фурункулом, карбункулом и абсцессом носа, чтобы санировать очаг инфекции и предупредить осложнения.

Внутрь взрослым и детям старше 12 лет или с массой больше 40 кг дают амоксициллин с клавулановой кислотой по 1000 мг (875/125) 2 раза в сутки 7 дней. Детям от 3 месяцев до 12 лет с массой меньше 40 кг назначают суспензию (400 мг амоксициллина + 57 мг клавулановой кислоты в 5 мл) из расчёта 20 мг/кг в сутки, новорождённым и детям до 3 месяцев — 30 мг/кг по амоксициллину 2 раза в день, 7–14 дней. С 12 лет можно цефдиторен по 200 мг каждые 12 часов 10 дней.

При тяжёлом или рецидивирующем фурункуле и при непереносимости бета-лактамов с 18 лет назначают левофлоксацин 750 мг раз в сутки 7–14 дней или моксифлоксацин 400 мг раз в сутки 7 дней.

Из парентеральных препаратов первая линия — цефазолин: взрослым 0,5 г внутривенно или внутримышечно 2 раза в день, детям от месяца до 18 лет — 20–50 мг/кг в сутки в 3–4 введения, 7–10 дней. Цефтриаксон взрослым и детям старше 12 лет или тяжелее 50 кг вводят по 1–2 г раз в сутки; новорождённым до 14 дней — 20–50 мг/кг раз в сутки, не больше 50 мг/кг; детям от 15 дней до 12 лет — 20–80 мг/кг раз в сутки, 7–10 дней.

Ампициллин с сульбактамом вводят внутримышечно или внутривенно (капельно 60–80 капель в минуту или струйно медленно за 3–5 минут): взрослым 3–12 г в сутки в 3–4 введения по тяжести инфекции, детям 150 мг/кг в сутки в 3–4 введения, недоношенным и детям первой недели жизни — 75 мг/кг в сутки в 2 введения, 5–14 дней. Амоксициллин с клавулановой кислотой внутривенно взрослым и детям старше 12 лет вводят по 1 г по амоксициллину 3 раза в сутки; детям до 3 месяцев и с массой меньше 4 кг — 25/5 мг/кг каждые 8 часов, только медленной инфузией за 30–40 минут; от 3 месяцев до 12 лет — 25/5 мг/кг каждые 6–8 часов по тяжести инфекции, 5–14 дней.

Клиндамицин назначают при аллергии на бета-лактамы: взрослым парентерально 0,6–2,7 г в сутки в несколько введений, детям 3–18 лет — 20–40 мг/кг в сутки в 3–4 равных приёма, 7–10 дней. Детям младше 3 лет он противопоказан.

4.6 Парентеральные антибиотики

Препарат	Разовая доза	Кратность	Максимум в сутки	Длительность
Цефазолин	Взрослым 0,5 г; детям старше месяца 10–20 мг/кг; внутривенно или внутримышечно	2 раза в сутки	Взрослым 6 г, детям старше месяца 100 мг/кг	7–10 дней
Цефтриаксон	Взрослым 1–2 г; новорождённым до 14 дней 20–50 мг/кг; детям от 15 дней до 12 лет 20–80 мг/кг; внутривенно или внутримышечно	1 раз в сутки	Взрослым 4 г, детям 2 г	7–10 дней
Ампициллин + сульбактам	Взрослым 1–2 г; детям старше месяца 50 мг/кг; новорождённым до 14 дней 75 мг/кг; внутривенно или внутримышечно	Взрослым и детям старше месяца 3 раза, новорождённым 2 раза в сутки	Взрослым 6 г, детям 150 мг/кг	5–14 дней внутримышечно (или 5–7 дней внутривенно, затем внутримышечно до 14 дней)
Амоксициллин + клавулановая кислота	Взрослым и детям старше 12 лет 1 г внутривенно; до 12 лет 25 мг/кг внутривенно	Взрослым и детям старше 3 месяцев 3 раза, детям до 3 месяцев 2–3 раза в сутки	Взрослым и детям старше 12 лет 6 г, до 12 лет 50–75 мг/кг	5–14 дней

Препарат	Разовая доза	Кратность	Максимум в сутки	Длительность
Клиндамицин	Взрослым «0,2–0,9 мг» (так в таблице; внутримышечно не больше 0,6 г, внутривенно не больше 1,2 г на введение); детям 3–18 лет 5–10 мг/кг внутримышечно или внутривенно	3–4 раза в сутки	Взрослым 4,8 г, детям 40 мг/кг	7–10 дней

Текст раздела 3.1 и таблица 3 расходятся. Цефазолин детям: в тексте 20–50 мг/кг в сутки в 3–4 введения, в таблице — 10–20 мг/кг 2 раза в сутки. Ампициллин с сульбактамом: в тексте взрослым до 12 г в сутки, в таблице максимум 6 г; новорождённым в тексте 75 мг/кг в сутки в 2 введения, в таблице 75 мг/кг на введение 2 раза в сутки. Амоксициллин с клавулановой кислотой детям: в тексте 25 мг/кг каждые 6–8 часов (до 100 мг/кг в сутки), в таблице максимум 50–75 мг/кг в сутки. Разовая доза клиндамицина взрослым в таблице указана в миллиграммах («0,2–0,9 мг»), хотя по смыслу и по тексту (0,6–2,7 г в сутки) это граммы.

4.7 Антикоагулянты

При осложнённом течении фурункула, карбункула или абсцесса носа всем пациентам для профилактики тромбозов назначают антикоагулянты прямого или непрямого действия.

Дозу подбирают по показателям свёртываемости крови.

4.8 Хирургическое лечение

Оперируют фурункул носа только при абсцедировании, а также карбункул носа.

При осложнённом течении абсцесс или карбункул носа вскрывают, чтобы эвакуировать гной и обеспечить дренирование.

Оперируют под местным или общим обезболиванием. Материал из раны на бактериологическое исследование берут обязательно.

В стадии разрешения пациента консультирует физиотерапевт, чтобы ускорить выздоровление.

5. Наблюдение, профилактика, госпитализация

5.1 Рецидивы

При рецидивирующих фурункулах носа пациента консультирует эндокринолог (ребёнка — детский эндокринолог), чтобы найти причину рецидивов.

В ряде случаев целесообразна и консультация аллерголога-иммунолога.

При рецидивирующем фурункуле носа для профилактики рецидивов назначают бактериофаги.

Местно бактериофаги оправданы в комплексном лечении, если выделенные штаммы устойчивы к антибиотикам, если в анамнезе было больше двух курсов антибиотиков, при непереносимости антибиотиков и при рецидивах.

5.2 Профилактика

Главное в профилактике фурункула и его осложнений — личная гигиена: мыть руки до и после еды, после туалета, транспорта и общественных мест. Важна и гигиена труда — защитные средства при пыльной и грязной работе. Нельзя трогать лицо, особенно нос, грязными руками, массировать болезненные места, выдавливать фурункул и лечиться самостоятельно. При сахарном диабете и других сопутствующих болезнях важно соблюдать диету и вовремя принимать лекарства. Гигиене учат в семье, детском саду и школе.

Пациенту объясняют, что нужно осторожно относиться к косметическому уходу за лицом, включая чистку лица и бритьё, и что при гнойничке на коже носа или верхней губы категорически нельзя массировать его и выдавливать. Родители следят за чистотой рук ребёнка, учат его правильно чистить нос и не давать ковырять в носу. При отёке или покраснении в области фурункула пациенту советуют обращаться в ЛОР-стационар.

5.3 Госпитализация

У детей сам диагноз абсцесса, фурункула или карбункула носа — показание к госпитализации в круглосуточный ЛОР-стационар. Взрослых в стадии инфильтрации можно лечить у оториноларинголога амбулаторно. Пациентов с фурункулом в стадии инфильтрации и сопутствующими болезнями и пациентов с рецидивирующими фурункулами КР упоминает отдельно, но действие для них не указано. В большинстве случаев лечит оториноларинголог в хирургическом стационаре.

> В разделе 6 фраза о пациентах с сопутствующими болезнями и рецидивирующими фурункулами оборвана: не сказано, что с ними делать, — по контексту, видимо, госпитализировать. Кроме того, в информации для пациента (приложение В) всем, у кого есть отёк или покраснение в области фурункула, советуют обращаться в ЛОР-стационар, хотя покраснение и отёк есть уже в стадии инфильтрации, при которой взрослых, по разделу 6, можно лечить амбулаторно.

Выписывают при положительной динамике и отсутствии осложнений: когда абсцесс, фурункул или карбункул разрешился, общее состояние удовлетворительное и температура нормализовалась.

При неосложнённом течении прогноз благоприятный. У пациентов с первичным или вторичным иммунодефицитом и с сахарным диабетом следует ждать более тяжёлого течения и высокого риска осложнений.

---

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Абсцесс. Фурункул носа. Карбункул носа»
Версия	1-я, опубликована в рубрикаторе 14.10.2025
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее октября 2028 года
Код в рубрикаторе	956_1 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Пациенты	Взрослые и дети

6.1 Неточности в самом тексте КР

- В разделе 1.6 фурункул располагается «в области дна носа у нижней губы», в определениях — «у верхней губы».
- В таблице 1 разовая доза диклофенака записана как «75 мл».
- В таблице 2 у метамизола натрия для детей 1–3 лет указано «100–2500 мг» (по объёму 0,2–0,5 мл должно быть 100–250 мг), а возраст «79 лет» означает 7–9 лет.

- Дозы антибиотиков в тексте раздела 3.1 и в таблице 3 не совпадают: цефазолин у детей, максимальная доза ампициллина с сульбактамом у взрослых и его доза у новорождённых, суточная доза амоксициллина с клавулановой кислотой у детей.
- Разовая доза клиндамицина взрослым в таблице 3 указана как «0,2–0,9 мг» вместо граммов; в тексте фраза «противопоказан детям в возрасте старше до 3-х лет» искажена (по контексту — младше 3 лет).
- Цефдиторену приписан код АТХ N07AX02, левофлоксацину — неполный код J01MA.
- Состав консультантов при внутричерепных осложнениях в разделе 2.5 и критериях качества (невролог, офтальмолог) не совпадает с алгоритмом в приложении Б (нейрохирург, офтальмолог, челюстно-лицевой хирург).
- В разделе 6 фраза о пациентах с сопутствующими болезнями и рецидивирующими фурункулами не закончена; совет из приложения В обращаться в стационар при любом отёке или покраснении расходится с возможностью амбулаторного лечения взрослых в стадии инфильтрации.
- Хирургическое лечение описано по-разному: в разделе 3.2 — при абсцедировании и при карбункуле, в рекомендации — «при осложнённом течении», в критериях качества — при стадии абсцедирования.
- Раздел «Иное лечение» пронумерован как 4 вместо 3.3, поэтому номер 4 повторяется дважды.
- В комментарии о бактериофагах упомянута «комплексная терапия ОС» — сокращение в КР не расшифровано и к фурункулу носа, по-видимому, не относится.

Клинические рекомендации

Аллергический ринит

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**J30.1** — Аллергический ринит, вызванный пыльцой растений **J30.2** — Другие сезонные аллергические риниты **J30.3** — Другие аллергические риниты **J30.4** — Аллергический ринит неуточненный
Пациенты	взрослые, дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 11.07.2024, пересмотр не позднее 2027 года
Разработчик	Российская ассоциация аллергологов и клинических иммунологов; Союз педиатров России; Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/261_2

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 22.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

1. Главное

- Диагноз ставят, когда хотя бы два из четырёх симптомов (заложенность носа, ринорея, чихание, зуд в носу) беспокоят ежедневно не меньше часа, прослеживается связь с аллергеном и аллергообследование положительное.
- Лечение подбирают по ступеням. На первой назначают один препарат: антигистаминный внутрь или в нос, кромоглициевую кислоту или монтелукаст. На второй предпочтителен назальный глюкокортикостероид. На третьей к нему добавляют один-два препарата из первой ступени, а четвёртая — омализумаб, который назначает только специалист.
- Назальные глюкокортикостероиды действуют сильнее антигистаминных препаратов внутрь и кромоглициевой кислоты, особенно при выраженной заложенности.
- Сосудосуживающие капли назначают только при обострении с выраженной заложенностью и только коротким курсом, на 3–7 дней.
- Контроль оценивают по визуальной аналоговой шкале и тесту «дыхание с закрытым ртом» на первом приёме и через 2–4 недели лечения.

2. Клиника и классификация

2.1 Определение

Аллергический ринит — IgE-опосредованное воспаление слизистой оболочки носа, которое развивается под действием аллергенов. Хотя бы два симптома — заложенность носа, ринорея, чихание, зуд в полости носа — проявляются ежедневно в течение часа и дольше.

2.2 Классификация

По причине выделяют сезонный, круглогодичный (бытовой) и профессиональный ринит. По течению — интермиттирующий, когда симптомы беспокоят меньше 4 дней в неделю или меньше 4 недель в году, и персистирующий, когда больше 4 дней в неделю и больше 4 недель в году.

При лёгком течении симптомы не мешают сну и дневным делам. При среднетяжёлом мешают работе, учёбе, спорту и нарушают сон. При тяжёлом без лечения пациент не может нормально работать, учиться и спать. Кроме того, различают обострение и ремиссию.

В диагнозе указывают аллергены, к которым выявлена повышенная чувствительность.

Отдельно выделяют локальный аллергический ринит. Симптомы типичные и чётко связаны с аллергеном, но кожные пробы и специфические IgE в крови отрицательны. Специфические IgE в носовом секрете в России не определяют, а назальные провокационные тесты положительны.

2.3 Жалобы

Основные жалобы — заложенность носа с дыханием ртом, сопением, храпом и изменением голоса; водянистые выделения; чихание, часто приступами по утрам; зуд, реже жжение в носу, иногда зуд нёба и глотки. Пациенты трут кончик носа ладонью («аллергический салют»), из-за чего появляется поперечная складка на носу. На поздних стадиях снижается обоняние.

Жалобы и анамнез собирают у каждого пациента с подозрением на аллергический ринит. При круглогодичной форме ведущий симптом — заложенность носа со слизистыми выделениями, при сезонной — приступы чихания, зуд и ринорея. Важно расспросить о связи симптомов с аллергеном и об аллергических болезнях у пациента и кровных родственников.

Из-за обильных выделений и нарушения проходимости слуховых труб бывают раздражение и отёк кожи над верхней губой и у крыльев носа, носовые кровотечения после сморкания, боль в горле и покашливание, боль и треск в ушах при глотании, снижение слуха.

При сезонном рините часто встречается оральный аллергический синдром — перекрёстная непереносимость свежих фруктов, овощей, орехов и семян. Проявления разные: от зуда во рту до анафилаксии.

2.4 Осмотр

Всем пациентам осматривают верхние дыхательные пути, проводят общий осмотр и аускультацию, чтобы не пропустить бронхиальную астму, конъюнктивит и атопический дерматит. Характерны затруднённое носовое дыхание, приоткрытый рот, тёмные круги под глазами, мацерация кожи над верхней губой, отёчность лица.

---

3. Диагностика

Диагноз ставят, когда есть характерные жалобы (два симптома из четырёх, ежедневно не меньше часа), анамнез указывает на связь с аллергеном или на другие аллергические болезни и аллергообследование положительно.

Пациента ведут вместе оториноларинголог и аллерголог-иммунолог. Оториноларинголог проводит риноскопию и эндоскопию, дифференциальную диагностику, выявляет осложнения и анатомические нарушения и определяет показания к операции. Аллерголог-иммунолог ставит кожные и провокационные тесты, оценивает их, исключает астму и решает вопрос об аллерген-специфической иммунотерапии (АСИТ).

3.1 ЛОР-осмотр

Переднюю риноскопию проводят всем. Обычно видны отёк носовых раковин и много водянистого секрета. Слизистая ярко-красная при обострении сезонного ринита и цианотичная или серая при круглогодичном, бывает «мраморной» (симптом Воячека), могут быть полипы.

Эндоскопию полости носа, носоглотки и пазух проводят, если стандартное лечение не помогает или ринит осложнённый. Проба с сосудосуживающим средством показывает, обратима ли обструкция.

Контроль симптомов оценивают по визуальной аналоговой шкале и тесту «дыхание с закрытым ртом» на первом приёме и через 2–4 недели лечения. Подробнее — в разделе «Контроль лечения».

3.2 Аллергообследование

Если противопоказаний нет, ставят кожные пробы (prick-тесты или скарификационные), чтобы подтвердить аллергическую природу ринита, найти причинные аллергены и решить вопрос об АСИТ.

Пробы ставят в аллергологическом кабинете. На результат влияют возраст младше 5 и старше 60 лет, приём системных глюкокортикоидов, антигистаминных и психотропных препаратов, дермографизм (ложноположительный результат) и недавняя острая аллергическая реакция (ложноотрицательный).

Специфические IgE в крови определяют, если кожные пробы противопоказаны или невозможны, их результат сомнителен или расходится с анамнезом.

По методу ImmunoCAP результат считается положительным при значении больше 0,70 kU/l.

Общий IgE для диагностики не назначают: он неинформативен.

3.3 Анализы

Развёрнутый общий анализ крови назначают при выраженных симптомах в обострении или перед АСИТ. Смотрят эозинофилы; лейкоцитоз со сдвигом влево — повод искать инфекцию, прежде всего острый риносинусит.

При выраженных симптомах в обострении можно сделать цитологию смывов из носа. Для аллергического ринита характерна эозинофилия носового секрета — 10% и больше.

Общий IgE определяют только перед назначением омализумаба (с 12 лет, при тяжёлом течении), потому что по нему рассчитывают дозу.

3.4 Лучевая и функциональная диагностика

Рентгенографию пазух делают при симптомах риносинусита (гнойные выделения, боль в проекции пазух, головная боль, температура) или при лейкоцитозе со сдвигом влево.

КТ пазух нужна, если лечение не помогает, обструкция выраженная и длительная, держится аносмия или аллергообследование отрицательное. Прежде всего её делают при подозрении на полипозный риносинусит.

Спирометрию с бронхолитиком проводят при кашле, свистящем дыхании и одышке, а также перед АСИТ, чтобы выявить скрытый бронхоспазм.

Перед инъекционной АСИТ записывают ЭКГ.

3.5 Дифференциальная диагностика

Аллергический ринит отличают от инфекционного ринита, аномалий внутриносовых структур, аденоидов у детей и полипозного риносинусита. Его отличают и от неаллергических ринитов: эозинофильного, лекарственного (НПВП, альфа- и бета-адреноблокаторы, ингибиторы АПФ, резерпин, долгий приём деконгестантов), гормонального (беременность, пубертат, менструальный цикл, контрацептивы, акромегалия, гипотиреоз), профессионального, атрофического ринита пожилых, пищевого и алкогольного, идиопатического. Кроме того, исключают первичную цилиарную дискинезию и муковисцидоз.

---

4. Лечение

Цель лечения — полный контроль симптомов. Если контакт с аллергеном, табачным дымом или другими раздражителями продолжается, можно добиться лишь уменьшения симптомов.

4.1 Ступени лечения

На любой ступени исключают контакт с аллергеном, при показаниях оперируют сопутствующую патологию и рассматривают АСИТ.

Ступень	Назначения
1-я ступень	Один препарат: антигистаминный внутрь без седативного эффекта, антигистаминный спрей в нос, кромоглициевая кислота в нос или монтелукаст.
2-я ступень	Один препарат, предпочтительно назальный глюкокортикостероид; можно антигистаминный внутрь или в нос либо монтелукаст.
3-я ступень	Назальный глюкокортикостероид вместе с одним или несколькими препаратами: антигистаминным внутрь или в нос, монтелукастом.
4-я ступень	Омализумаб при тяжёлом течении, с 12 лет. Назначает только специалист.
Для быстрой помощи	Сосудосуживающие капли коротким курсом или глюкокортикоиды внутрь.

> Прежде чем переходить на ступень выше, перепроверьте диагноз, приверженность лечению, сопутствующие болезни и анатомические аномалии.

4.2 Антигистаминные препараты внутрь

Антигистаминные препараты без седативного эффекта назначают всем пациентам: они уменьшают зуд, чихание, ринорею и заложенность. Цетиризин в больших дозах вызывает сонливость чаще остальных.

Седативные антигистаминные первого поколения не назначают: они вызывают сонливость, нарушают сон и могут приводить к апноэ во сне.

Препарат	Доза
Дезлоратадин	Взрослым и детям с 12 лет — 5 мг 1 раз в сутки, детям 6–11 лет — 2,5 мг, детям 1–5 лет — 1,25 мг, детям 6–12 месяцев — 1 мг 1 раз в сутки.
Левоцетиризин	Взрослым и детям старше 6 лет — 5 мг 1 раз в сутки, детям 2–6 лет — 1,25 мг 2 раза в сутки.
Лоратадин	Взрослым и детям старше 12 лет — 10 мг 1 раз в сутки. Детям 2–12 лет при весе до 30 кг — 5 мг, больше 30 кг — 10 мг 1 раз в сутки.
Фексофенадин	Взрослым и детям старше 12 лет — 120 мг 1 раз в сутки, детям 6–11 лет — 30 мг 2 раза в сутки.
Цетиризин	Взрослым и детям старше 6 лет — 5–10 мг 1 раз в сутки. Детям 2–6 лет — 2,5 мг 2 раза или 5 мг 1 раз в сутки, детям 1–2 лет — 2,5 мг 2 раза в сутки, детям 6–12 месяцев — 2,5 мг 1 раз в сутки.
Эбастин	Взрослым и детям старше 12 лет — 10–20 мг 1 раз в сутки. Есть форма для рассасывания под языком.
Рупатадин	Взрослым и детям старше 12 лет — 10 мг 1 раз в сутки.
Биластин	Взрослым и детям старше 12 лет — 20 мг 1 раз в сутки.

4.3 Назальные глюкокортикостероиды

Их назначают при среднетяжёлом и тяжёлом течении, особенно при выраженной заложенности. Они сильнее антигистаминных препаратов внутрь и кромоглициевой кислоты и помогают также при глазных симптомах. Возможны сухость, носовые кровотечения, редко перфорация перегородки, поэтому пациента нужно научить правильно вводить спрей.

Препарат	Доза в каждый носовой ход
Мометазон	Взрослым и детям старше 12 лет — 2 дозы (100 мкг) 1 раз в сутки, для поддержки — 1 доза; при необходимости до 4 доз. Детям 2–12 лет — 1 доза (50 мкг) 1 раз в сутки.
Флутиказона фуроат	Взрослым и детям старше 12 лет — 2 дозы (55 мкг) 1 раз в сутки, для поддержки — 1 доза. Детям 2–12 лет — 1 доза (27,5 мкг) 1 раз в сутки, при необходимости 2 дозы.
Флутиказона пропионат	Взрослым и детям старше 12 лет — 2 дозы (100 мкг) 1 раз в сутки, для поддержки — 1 доза. Детям 4–12 лет — 1 доза (50 мкг) 1 раз в сутки.
Будесонид	Взрослым и детям старше 6 лет — 2 дозы (100 мкг) 2 раза в сутки, для поддержки — 200 мкг в сутки. Не дольше 3 месяцев.
Беклометазон	Взрослым и детям старше 6 лет — 2 дозы (100 мкг) 2 раза в сутки, это максимальная доза; для поддержки — 1 доза 2 раза в сутки.

4.4 Антигистаминные спреи и комбинации

Антигистаминные спреи быстро уменьшают симптомы, в течение 30 минут. Их назначают отдельно или вместе с другими препаратами; возможна сухость слизистой.

Если нужны и антигистаминный, и гормональный спрей, удобнее назначить один комбинированный.

Препарат	Доза в каждый носовой ход
Азеластин	Взрослым и детям старше 6 лет — 1 доза (0,14 мг) 2 раза в сутки, с 12 лет при необходимости 2 дозы. Не дольше 6 месяцев.
Левокабастин	Взрослым и детям старше 6 лет — 2 дозы 2 раза в сутки, при выраженных симптомах 3–4 раза. Если за 3 дня эффекта нет, препарат отменяют.
Азеластин и флутиказон	Взрослым и детям старше 12 лет — 1 доза (137 мкг азеластина и 50 мкг флутиказона) 2 раза в сутки.
Азеластин и мометазон	Взрослым с 18 лет — 1 доза (140 мкг азеластина и 50 мкг мометазона) 2 раза в сутки, курс 2 недели.
Мометазон и олопатадин	Взрослым и детям старше 12 лет — 2 дозы 2 раза в сутки (в КР указано 50 мкг мометазона и 1200 мкг олопатадина). Детям 6–11 лет только при сезонном рините — 1 доза (25 и 600 мкг) 2 раза в сутки.

4.5 Монелукаст и кромоглициевая кислота

Монелукаст можно назначать при любой тяжести, отдельно или вместе с другими препаратами, но он слабее назальных глюкокортикостероидов.

Если у пациента ещё и бронхиальная астма, монелукаст помогает контролировать обе болезни. Курс — от 1 до 3 месяцев и дольше; по инструкции ограничений по длительности нет.

Если нужны и антигистаминный препарат внутрь, и монелукаст, можно назначить комбинированную таблетку левоцетиризина с монелукастом.

Кромоглициевую кислоту в нос назначают при лёгком течении. Она безопасна, но слабее антигистаминных препаратов, монелукаста и назальных глюкокортикостероидов.

Препарат	Доза
Монелукаст	Взрослым и детям старше 15 лет — 10 мг 1 раз в сутки, детям 6–15 лет — 5 мг, детям 2–6 лет — 4 мг (жевательная таблетка) 1 раз в сутки.
Левоцетиризин и монелукаст	Взрослым и детям старше 15 лет — 1 таблетка (5 мг и 10 мг) 1 раз в сутки.
Кромоглициевая кислота, спрей	Взрослым и детям старше 5 лет — 1 доза в каждый носовой ход 4 раза в сутки, при необходимости до 6 раз. Когда наступит эффект, можно применять только при контакте с аллергеном. Курс 4 недели.

4.6 Сосудосуживающие препараты

При обострении с выраженной заложенностью их назначают коротким курсом, на 3–7 дней.

Длительные курсы не назначают: после 10 дней развиваются привыкание, отёк слизистой и медикаментозный ринит.

Если нужны и антигистаминный, и сосудосуживающий препарат в нос, можно назначить комбинацию диметиндена с фенилэфрином, не дольше 7 дней.

Препарат	Доза в каждый носовой ход
Оксиметазолин	Взрослым и детям старше 6 лет — 1–2 дозы 0,05% раствора 2–3 раза в сутки. Детям 1–6 лет — 1–2 капли 0,025%, детям от 5 недель до года — 1–2 капли 0,01%, до 4 недель — 1 капля 0,01% 2–3 раза в сутки. Курс 3–4 дня.
Ксилометазолин	Взрослым и детям старше 6 лет — 1 доза 0,1% раствора 1–3 раза в сутки, детям 2–6 лет — 1 доза 0,05% 1–2 раза в сутки. Не дольше 5–7 дней.
Диметинден и фенилэфрин	Взрослым и детям старше 6 лет — 1–2 дозы спрея или 3–4 капли 3–4 раза в сутки. Детям 1–6 лет — только капли, по 1–2 капли 3–4 раза в сутки.

4.7 Тяжёлое течение

При тяжёлом обострении или если третья ступень не помогает, можно назначить короткий курс глюкокортикоидов внутрь.

Это четвёртая линия или лечение тяжёлого обострения. Вводить растворы и депо-формы глюкокортикоидов в носовые раковины недопустимо: это грозит тяжёлыми осложнениями вплоть до слепоты. Дозу преднизолона, метилпреднизолона или дексаметазона подбирают индивидуально; преднизолон в таблетках противопоказан детям до 3 лет.

Депо-формы глюкокортикоидов не назначают: побочные эффекты развиваются быстро, вплоть до надпочечниковой недостаточности.

Омализумаб рассматривают с 12 лет при тяжёлом персистирующем течении или тяжёлом обострении, если третья ступень не помогает.

Его вводят подкожно раз в 2 или 4 недели, доза от 75 до 600 мг — по таблице дозирования. При сезонном рините начинают хотя бы за неделю до начала пыления и продолжают до его окончания.

4.8 Без лекарств

Всем пациентам рекомендуют по возможности избегать контакта с аллергеном. Даже частичное ограничение облегчает течение и снижает потребность в лекарствах.

Всем рекомендованы изотонические солевые растворы для носа, в том числе на основе морской воды.

Перед введением назального глюкокортикостероида нос промывают: так препарат лучше контактирует со слизистой, а сухость и кровотечения возникают реже.

4.9 Аллерген-специфическая иммунотерапия

АСИТ рассматривают у всех пациентов в ремиссии, в том числе медикаментозной. Она уменьшает симптомы и потребность в лекарствах, предупреждает развитие астмы и расширение спектра аллергенов.

Показания, противопоказания и выбор аллергена определяет аллерголог-иммунолог, он же назначает АСИТ.

4.10 Хирургическое лечение

Операцию проводят только при сопутствующей патологии; показания определяет оториноларинголог по данным эндоскопии и рентгенологического обследования. Плановые операции в сезон пыления причинных аллергенов не проводят.

4.11 Нетрадиционные методы

Гомеопатию, фитотерапию, гипноз, техники релаксации, ионизаторы воздуха и физиотерапию не рекомендуют: доказательств их пользы нет.

Иглоукалывание можно рассмотреть в составе комплексного лечения.

5. Дети, беременность, кормление грудью

5.1 С какого возраста можно детям

Мометазон и флутиказона фуроат разрешены с 2 лет, флутиказона пропионат — с 4 лет, беклометазон и будесонид — с 6 лет.

Цетиризин и дезлоратадин разрешены с 6 месяцев, лоратадин — с 2 лет. Антигистаминные первого поколения (хлоропирамин, диметинден) разрешены с 1 месяца, но, когда ребёнок дорастёт до нужного возраста, предпочтение отдают препаратам без седативного эффекта.

Монтелукаст в дозе 4 мг разрешён с 2 лет, в дозе 5 мг — с 6 лет.

АСИТ по инструкциям к препаратам проводят с 5 лет.

Назальные глюкокортикостероиды назначают детям в минимальной эффективной дозе, а при длительном применении следят за ростом.

Лучше ограничить препараты с высокой биодоступностью — будесонид (30–40%) и беклометазон (40–50%). У дексаметазона биодоступность больше 80%; это важно помнить, потому что он входит во многие комбинированные капли.

5.2 Беременность и кормление грудью

У беременных нужно помнить о рините беременных: заложенность носа без признаков инфекции и аллергии, которая полностью проходит в течение 2 недель после родов. Выявленная сенсибилизация говорит в пользу аллергического ринита.

Кожные пробы во время беременности и кормления не ставят; вместо них определяют специфические IgE в крови.

Предпочтение отдают ограничению контакта с аллергеном и промыванию носа. Лекарства назначают, если этого недостаточно, взвешивая риск для матери и ребёнка.

Доказательств риска для человека нет у лоратадина, цетиризина и будесонида (категория B по классификации FDA).

В первом триместре лекарства по возможности не назначают, если в них нет жизненной необходимости.

При кормлении грудью лучше ограничиться местными средствами с минимальной биодоступностью: все системные препараты проникают в молоко.

6. Контроль лечения

Визуальная аналоговая шкала — линия длиной 10 см, на которой пациент отмечает, насколько его беспокоят симптомы. Если отметка от 0 до 50 мм, ринит контролируется, если 50 мм и больше — не контролируется.

У подростков и взрослых при отметке 5 см и больше начинают с антигистаминных препаратов на 2–4 недели. Если ринит стал контролируемым, лечение продолжают по потребности и рассматривают АСИТ. Если нет, добавляют назальный глюкокортикостероид или монтелукаст ещё на 2–4 недели. Если и тогда контроля нет, пересматривают диагноз, ищут сопутствующую патологию, рассматривают АСИТ и хирургическое лечение.

Ринит считается контролируемым, если за последние 4 недели не было симптомов, не нарушались сон и дневная активность, а тест «дыхание с закрытым ртом» нормальный. Любое отклонение, в том числе более частая потребность в препаратах быстрой помощи, означает потерю контроля, и тогда можно переходить на ступень выше.

Для теста пациента просят закрыть рот и 30 секунд дышать только носом.

Для дневника симптомов (шкала TNSS) пациент каждый день оценивает чихание, водянистые выделения, заложенность и зуд от 0 до 3 баллов, сумма — от 0 до 12. Врач считает среднее за 7 дней. Дневник ведут в обострение и для оценки эффекта АСИТ.

Отдельно оценивают лекарства: только антигистаминные — 1 балл, назальные глюкокортикостероиды — 2, системные глюкокортикоиды — 3.

7. Наблюдение, профилактика, госпитализация

Каждому пациенту или его представителям объясняют суть болезни, составляют индивидуальный план лечения и учат управлять болезнью самостоятельно.

Пациенты находятся на диспансерном наблюдении у аллерголога-иммунолога или оториноларинголога: взрослые приходят не реже раза в год, дети — не реже двух раз в год. Наблюдение пожизненное или до стойкой ремиссии длительностью 3 года и больше.

АСИТ используют и для вторичной профилактики: она помогает предупредить астму, утяжеление ринита и расширение спектра сенсибилизации.

При пыльцевой сенсибилизации советуют ограничить перекрёстно-реагирующие продукты и растительные лекарства.

Лечат обычно амбулаторно. Госпитализируют при крайне тяжёлом или осложнённом течении, детей — при тяжёлом обострении с выраженной заложенностью, а также планово для ускоренного курса АСИТ. Выписывают, когда симптомы под контролем или курс АСИТ завершён.

8. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Аллергический ринит»
Версия	2-я, опубликована в рубрикаторе 11.07.2024
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее июля 2027 года
Код в рубрикаторе	261_2 · открыть текст КР ↗
Разработчики	Российская ассоциация аллергологов и клинических иммунологов; Союз педиатров России; Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Пациенты	Взрослые и дети

8.1 Неточности в самом тексте КР

- Разовая доза кромоглициевой кислоты указана в КР как «2.8 мкг», суточная — как «22.4 мкг». Сверьте с инструкцией в ГРЛС.
- Подпись к алгоритму в приложении Г1 гласит «пациентов, получавших лечение ранее», а в оригинальном названии — «untreated patients», то есть не получавших лечения.
- В тексте доз мометазона и флутиказона фуроата повторяются обрывки фраз; на смысл доз это не влияет.

Клинические рекомендации

Болезнь Меньера

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**H81.0** — Болезнь Меньера
Пациенты	взрослые
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 18.03.2024, пересмотр не позднее 2026 года
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/18_2

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 22.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

1. Главное

- Достоверный диагноз ставят, если было не меньше двух самопроизвольных приступов головокружения длительностью от 20 минут до 12 часов, аудиометрия подтвердила сенсоневральную тугоухость на низких и средних частотах во время или после приступа, слух, шум и ощущение полноты в ухе колеблются, а других причин нет.
- Всем пациентам делают тональную пороговую аудиометрию, чтобы оценить степень тугоухости, и импедансометрию — тимпанометрию с акустической рефлексометрией, — чтобы исключить патологию среднего уха.
- Приступ купируют атропином или платифиллином подкожно, антигистаминными препаратами (дименгидринатом, дифенгидрамином) или бензодиазепинами (лоразепамом, диазепамом) не дольше 3 суток; из-за тошноты и рвоты лекарства лучше вводить парентерально.
- После приступа и если приступы повторяются чаще чем раз в 3 месяца, назначают бетагистин по 24 мг 2 раза в день на 2–3 месяца и дольше.
- Если консервативное лечение не помогает 6–12 месяцев, оперируют: сначала выполняют слухосохраняющие вмешательства, а деструктивные — вторым этапом или когда слух уже социально незначим.
- КТ височных костей и МРТ головного мозга с внутренними слуховыми проходами и мостомозжечковыми углами нужны, чтобы исключить опухоль, прежде всего акустическую шванному при односторонней сенсоневральной тугоухости.

2. Клиника и классификация

2.1 Определение

Болезнь Меньера (БМ) — заболевание внутреннего уха, при котором повторяются приступы системного головокружения, а также бывают шум в ушах и сенсоневральная тугоухость.

2.2 Классификация

По классификации Американской академии оториноларингологии и хирургии головы и шеи (AAO-HNS) выделяют четыре формы болезни: несомненную, достоверную, вероятную и возможную.

Болезнь начинается по-разному. При кохлеарной форме сначала появляются слуховые расстройства, а затем вестибулярные. При классическом варианте они возникают одновременно: уже первый приступ головокружения сопровождается снижением слуха и шумом в ухе. Реже встречается вестибулярная форма, когда сначала бывают только приступы головокружения, а слуховые расстройства присоединяются позже.

По данным разных авторов, колебания слуха сочетаются с головокружением у 82,7% пациентов и бывают без головокружения у 17,3%; по другим данным, болезнь начинается только со слуховых симптомов у 54,4%, а классически — у 45,6%.

2.3 Клиническая картина

Типична триада: приступы системного головокружения, шум в ухе и тугоухость. Приступ начинается внезапно, в любое время суток и года, на фоне полного здоровья и ничем не провоцируется. Иногда ему предшествует аура — появление или усиление заложенности и шума в больном ухе. Приступ всегда сопровождается вегетативными симптомами, прежде всего тошнотой и рвотой, длится несколько часов, чаще 4–6, и проходит сам, без лекарств. Шум в ухе односторонний, чаще низко- или среднечастотный, он усиливается перед приступом и во время него.

Тугоухость обычно односторонняя и колеблется. При аудиологическом исследовании находят так называемую скалярную, или ложную сенсоневральную, тугоухость: горизонтальную или восходящую аудиометрическую кривую с костно-воздушным интервалом 5–10 дБ на низких или средних частотах. Пороги восприятия ультразвука нормальные, а сам ультразвук латерализуется в хуже слышащее ухо.

2.4 Стадии

Первая, начальная стадия. Приступы редкие — 1–2 раза в год или даже раз в 2–3 года — и длятся в среднем 1–3 часа, с тошнотой и рвотой. Шум, заложенность или распирание в ухе появляются до или во время приступа, но постоянными не бывают. Характерны колебания слуха: он снижается, как правило, перед приступом и затем улучшается. Некоторые пациенты замечают, что сразу после приступа слух заметно лучше, а в течение суток снова возвращается к обычному уровню.

Вторая стадия — разгар болезни. Приступы становятся типичными, с интенсивным системным головокружением и выраженными вегетативными симптомами, и повторяются от нескольких раз в месяц до нескольких раз в неделю или ежедневно. Шум в ухе беспокоит постоянно и усиливается во время приступа, заложенность и дискомфорт в больном ухе бывают каждый день, слух снижается от приступа к приступу.

Третья, затухающая стадия. Типичные приступы становятся реже или прекращаются, но пациента постоянно беспокоят шаткость и неустойчивость. Слух на больное ухо значительно снижен, и часто в процесс вовлекается второе ухо. Возможны отолитовые кризы Тумаркина — внезапные падения из-за резкого смещения отолитовых рецепторов и внезапного включения вестибулярных рефлексов; они могут приводить к серьёзным травмам.

> Длительность приступа в КР указана по-разному: в общем описании клинической картины — несколько часов, чаще 4–6, для первой стадии — в среднем 1–3 часа, а в диагностических критериях — от 20 минут до 12 часов.

2.5 Степень тяжести

По частоте и длительности приступов и по сохранности трудоспособности выделяют три степени тяжести. При тяжёлой приступы ежедневные или еженедельные, длятся несколько часов со всем комплексом статокинетических и вегетативных расстройств, и трудоспособность потеряна. При средней приступы еженедельные или ежемесячные, тоже по нескольку часов, статокинетические расстройства умеренные, вегетативные выражены, трудоспособность теряется во время приступа и на несколько часов после него. При лёгкой приступы короткие, а ремиссии длятся месяцы или годы.

2.6 Жалобы

Пациенты жалуются на приступы нарастающей глухоты, шум в ушах, периодическую потерю равновесия, головокружение, тошноту вплоть до рвоты.

---

3. Диагностика

Диагноз ставят по критериям AAO-HNS (редакции 1972, 1985 и 1995 годов) и по критериям 2015 года, которые согласовали Общество Барани, Европейская академия отологии и нейроотологии (EAONO), комитет по равновесию AAO-HNS и Корейское общество равновесия.

3.1 Диагностические критерии

Форма	Критерии
Несомненная	Эндолимфатический гидропс подтверждён гистологически; не меньше двух приступов головокружения длительностью от 20 минут до 12 часов; сенсоневральная тугоухость на низких и средних частотах, подтверждённая аудиометрией во время или после приступа; колеблющиеся слуховые симптомы — слух, шум, ощущение полноты в ухе.
Достоверная	Не меньше двух самопроизвольных приступов головокружения длительностью от 20 минут до 12 часов; сенсоневральная тугоухость на низких и средних частотах, подтверждённая аудиометрией во время или после приступа; колеблющиеся слуховые симптомы; других причин нет.
Вероятная	Хотя бы один приступ головокружения; сенсоневральная тугоухость, подтверждённая хотя бы однократной аудиометрией; шум или заложенность в больном ухе; других причин, объясняющих симптомы, нет.
Возможная	Приступы головокружения без подтверждённого снижения слуха либо стойкая или непостоянная сенсоневральная тугоухость с нарушением равновесия, но без явных приступов головокружения; других причин, объясняющих симптомы, нет.

3.2 Осмотр

Пациента обследуют комплексно, с участием терапевта и невролога. Проводят акуметрию — исследуют слух шёпотной и разговорной речью, ставят камертональные пробы Вебера, Ринне и Федериче. Оценивают спонтанный нистагм, выполняют тест импульсного (быстрого) поворота головы (тест Хальмаги — Кертойза), статокоординаторные и статокинетические пробы — позу Ромберга, пробу Фишера — Барре, ходьбу по прямой и фланговую походку, пробу на диадохокинез — и позиционные пробы: пробу Дикса — Холлпайка и roll-тест Пагнини — Макклюра.

3.3 Анализы

Для дифференциальной диагностики делают общий и биохимический общетерапевтический анализы крови.

3.4 Аудиометрия и импедансометрия

Всем пациентам проводят тональную пороговую аудиометрию, чтобы определить степень тугоухости.

Всем пациентам проводят импедансометрию — тимпанометрию и акустическую рефлексометрию, — чтобы исключить патологию среднего уха.

Чтобы подтвердить гидропс лабиринта при клинических признаках вероятной болезни Меньера, а также если консервативное лечение не помогает, определяют пороги чувствительности к ультразвуку и его латерализацию, проводят электрокохлеографию (ЭКоГ) или дегидратационный тест — по отдельности или в сочетании.

Вызванную отоакустическую эмиссию и коротколатентные слуховые вызванные потенциалы (КСВП) исследуют, если МРТ головного мозга противопоказана, например из-за металлических конструкций в теле, и если результаты тональной аудиометрии сомнительны — при подозрении на аггравацию или симуляцию.

На аудиограмме при болезни Меньера видна скалярная, или ложная сенсоневральная, тугоухость: горизонтальная или восходящая кривая с костно-воздушным интервалом 5–10 дБ на низких или средних частотах. Пороги ультразвука нормальные, ультразвук латерализуется в хуже слышащее ухо. Амплитуда пиков спонтанной отоакустической эмиссии может быть снижена.

Если поражение ретрокохлеарное, пороги акустического рефлекса повышены по сравнению с нормальными порогами слышимости.

О ретрокохлеарной дисфункции по КСВП говорят отсутствие всех пиков с I по V, которое трудно объяснить потерей слуха; отсутствие всех пиков после I или после III; удлинение межпикового интервала I–V больше 4,4 мс; снижение отношения амплитуд V/I ниже 0,5, особенно вместе с другими изменениями. Диагностическое значение имеет и патологически большая разница параметров между правым и левым ухом, особенно межпиковых интервалов, если её трудно объяснить односторонней или асимметричной тугоухостью периферического уровня.

Универсального способа выявить гидропс лабиринта нет. Чтобы подтвердить диагноз, нужен широкий набор исследований с оценкой в динамике, а их результаты сильно зависят от стадии болезни.

3.5 Вестибулярные исследования

Вестибулометрию проводят для дифференциальной диагностики, если диагноз не удаётся установить по клинической картине, и при планировании операции.

Между приступами спонтанных вестибулярных симптомов нет, статическое и динамическое равновесие в норме, в том числе при постурографии (стабилографии). Во время приступа развивается периферический вестибулярный синдром: системное головокружение, тошнота, рвота, нарушение равновесия и горизонтальный вестибулярный нистагм. Вестибулометрия в межприступном периоде показывает угнетение вестибулярной функции, сильнее выраженное на больной стороне.

По тем же показаниям — для дифференциальной диагностики и перед операцией — проводят видеонистагмографию (ВНГ) с записью калорической или вращательной пробы, видеоимпульсного и других тестов.

3.6 Лучевая диагностика

Выполняют компьютерную томографию височных костей и магнитно-резонансную томографию головного мозга с выведением внутренних слуховых проходов и мостомозжечковых углов, в том числе с контрастированием.

Так исключают опухоли (при односторонней сенсоневральной тугоухости — прежде всего акустическую шванному), демиелинизирующий процесс, нейроваскулярный конфликт, приобретённые и врождённые структурные изменения височных костей.

3.7 Дифференциальная диагностика

Диагноз	Отличительные признаки
Болезнь Меньера	Приступы системного головокружения со снижением слуха, распиранием и шумом в ухе, тошнотой и рвотой
Доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение (ДППГ)	Короткие приступы системного головокружения при изменении положения тела
Вестибулярный нейронит	Сильнейшее вращательное головокружение, расстройство равновесия, тошнота и рвота на фоне вирусной инфекции
Перилимфатическая фистула	Головокружение разной силы и расстройства слуха вплоть до глухоты после травмы уха или при хроническом отите; провоцируются изменением давления или громкими звуками
Инфаркт лабиринта	Острое системное головокружение, часто вместе с острой односторонней глухотой и шумом в ухе

Диагноз	Отличительные признаки
Аутоиммунные заболевания внутреннего уха	Преимущественно вестибулярное прогрессирующее головокружение с двусторонним снижением слуха и другими признаками аутоиммунного заболевания
Вестибулярная мигрень	Головная боль по типу мигрени при части приступов головокружения

4. Лечение

Лечение складывается из трёх частей: купирования приступа головокружения лекарствами, лекарственной профилактики в межприступный период и хирургического лечения.

4.1 Купирование приступа

Чтобы купировать острый приступ вестибулярного головокружения, подкожно вводят #атропин или #платифиллин: они блокируют импульсы от раздражённого лабиринта. Знак # означает применение вне инструкции.

Для купирования приступа применяют также дименгидринат или дифенгидрамин.

Это H1-антигистаминные препараты, которые проникают через гематоэнцефалический барьер и действуют как центральные вестибулярные блокаторы. Их используют в первые сутки приступа, максимум до 3 суток.

В первые сутки острого головокружения, максимум до 3 суток, для купирования приступа можно использовать #лоразепам или #диазепам.

Из-за тошноты и рвоты во время приступа лекарства лучше вводить парентерально, а когда симптомы стихнут, можно перейти на таблетки.

Препарат	Доза
#Атропин	1 мл 0,1% раствора подкожно
#Платифиллин	2 мл 0,2% раствора подкожно
Дименгидринат	50–100 мг 2–3 раза в сутки
Дифенгидрамин	25–50 мг внутрь 3–4 раза в сутки; внутримышечно — #дифенгидрамин 10–50 мг
#Лоразепам	1 мг, можно сублингвально
#Диазепам	10 мг внутримышечно

4.2 Межприступный период

После приступа головокружения, а также если между приступами проходит меньше 3 месяцев, назначают бетагистин по 24 мг 2 раза в день (48 мг в сутки) на 2–3 месяца и дольше.

Бетагистин улучшает кровообращение в сосудистой полоске внутреннего уха, снижает возбудимость нейронов вестибулярных ядер и ускоряет восстановление вестибулярной функции, в том числе за счёт центральной компенсации.

Курсами назначают диуретики — калийсберегающие, тиазидные и другие — или ингибиторы карбоангидразы, оптимально ацетазоламид. В КР приведён пример схемы: в 1–3-й день по 1 таблетке 2 раза в день (утром и днём), в 7–9-й и 13–15-й дни — по 1 таблетке утром. Курс подбирают индивидуально.

Петлевые диуретики не применяют из-за возможной ототоксичности. При длительном приёме ацетазоламида контролируют электролиты крови и при необходимости восполняют потери.

Всем пациентам назначают диету: соль ограничивают до 2 г в сутки, исключают глутамат натрия, питание делают сбалансированным, чтобы нормализовать прежде всего водно-солевой обмен.

Соли и готовых продуктов должно быть как можно меньше; алкоголь, кофеин и никотин исключают, жидкость пьют умеренно.

В плановом порядке проводят инфузионную дегидратационную терапию: в первые 2 года болезни — раз в 6–12 месяцев, затем — раз в 2–3 года. Конкретные препараты КР не называет.

4.3 Хирургическое лечение

Оперируют, если консервативное лечение не помогает в течение 6–12 месяцев.

На первой и второй стадиях первым этапом выполняют слухосохраняющие вмешательства: хордоплексустомию, интратимпанальное введение глюкокортикоидов, обнажение (дренирование) эндолимфатического мешка или селективную лазеродеструкцию ампулярного рецептора горизонтального полукружного канала.

Деструктивные вмешательства — интратимпанальное введение гентамицина, лазеродеструкцию лабиринта, вестибулярную нейроэктомию — выполняют вторым этапом, если слухосохраняющая операция не помогла, или если слух уже социально незначим.

4.4 Реабилитация

При нарушении равновесия в межприступном периоде на третьей стадии назначают лечебную физкультуру для коррекции вестибулярной функции. При двусторонней хронической нейросенсорной тугоухости, если средние пороги на речевых частотах на лучше слышащем ухе выше 31 дБ, проводят слухопротезирование.

Если на фоне хронической вестибулярной дисфункции развиваются соматоформные расстройства, проводят психолого-социальную реабилитацию.

---

5. Наблюдение, профилактика, госпитализация

Пациентов с болезнью Меньера ставят на диспансерное наблюдение и осматривают раз в год, чтобы оценить эффект лечения и проконтролировать слух и вестибулярную функцию.

Для профилактики КР называет здоровый образ жизни, раннее выявление воспалительных заболеваний ЛОР-органов, особенно у детей, и предупреждение рецидивов хронических воспалительных заболеваний ЛОР-органов путём диспансерного наблюдения.

Пациенту советуют избегать резких перепадов давления в среднем ухе — при подводном плавании, резком сморкании, авиаперелётах. В еде ограничивают углеводы, солёное, острое и жирное мясное, каждый день едят продукты, богатые калием, например печёный картофель, творог, курагу. Исключают алкоголь, курение, кофеин и продукты с консервантами, особенно с глутаматом натрия. Нужно избегать переутомления, работы на высоте и с движущимися предметами.

5.1 Организация помощи

Первичную специализированную помощь оказывает оториноларинголог в поликлинике.

При тяжёлом состоянии пациента госпитализируют в оториноларингологическое отделение; при тяжёлом течении — по скорой помощи сразу в специализированное ЛОР-отделение, минуя поликлинику.

Выписывают, когда приступы головокружения прекратились или стали реже, либо пороги слуха улучшились или стабилизировались.

На течение и исход болезни влияют её длительность и тяжесть, сопутствующие заболевания, возраст пациента, наличие и характер осложнений.

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Болезнь Меньера»
Версия	2-я, год утверждения 2024, опубликована в рубрикаторе 18.03.2024
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	На титульном листе КР указано «пересмотр не позднее 2026 года»; в приложении А2 — обновление каждые 3 года
Код в рубрикаторе	18_2 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Пациенты	Взрослые

6.1 Неточности в самом тексте КР

- Длительность приступа указана по-разному: в описании клинической картины — «чаще 4-6 ч.», для первой стадии — «в среднем от 1 до 3 часов», в диагностических критериях — от 20 минут до 12 часов.
- Срок пересмотра не согласован: на титульном листе — «пересмотр не позднее 2026», то есть через 2 года после утверждения, а в приложении А2 — обновление «каждые 3 года».
- В критериях качества у обследований стоит УДД 4, а у тех же рекомендаций в разделе 2 — УДД 5.
- Схема ацетазоламида дана в таблетках без дозы в миллиграммах.
- Для плановой инфузионной дегидратационной терапии (раздел 6) не названы препараты и не указаны УУР и УДД; уровней нет и у рекомендаций по хирургическому лечению и диспансерному наблюдению.
- Профилактика сформулирована через воспалительные заболевания ЛОР-органов «особенно в педиатрической практике», хотя КР адресована взрослым, а воспаление среди причин болезни не названо.
- Опечатки: «импендансометрии» вместо «импедансометрии», «Н3-гистаминовых» вместо «Н3-гистаминовых».

Клинические рекомендации

Гипертрофия аденоидов. Гипертрофия нёбных миндалин

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**J31.1** — Хронический назофарингит **J35.1** — Гипертрофия миндалин **J35.2** — Гипертрофия аденоидов **J35.3** — Гипертрофия миндалин с гипертрофией аденоидов **J35.8** — Другие хронические болезни миндалин и аденоидов
Пациенты	взрослые, дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 25.10.2024, пересмотр не позднее 2027 года
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/662_2

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 22.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

1. Главное

- Сами по себе глоточная и нёбные миндалины у ребёнка — не патология. Обследование начинают из-за жалоб, клинических проявлений или сопутствующей болезни, на течение которой могут влиять аденоиды и миндалины.
- Гипертрофию нёбных миндалин диагностируют по жалобам, анамнезу и фарингоскопии с обязательной оценкой нижнего полюса миндалин, а гипертрофию аденоидов — только с инструментальным подтверждением: эндоскопией носоглотки, рентгенографией носоглотки или КТ.
- Пальцевое исследование носоглотки для диагностики аденоидов у детей не проводят.
- При наличии показаний аденоиды и миндалины оперируют в плановом порядке; если показаний нет или есть абсолютные противопоказания, пациента динамически наблюдает оториноларинголог.
- Детей с гипертрофией аденоидов лечат консервативно только при признаках аденоидита. У детей младше 7–9 лет, если нет осложнений и заметного влияния на качество жизни, аденоидит не считают патологией и ограничиваются наблюдением.

2. Клиника и классификация

2.1 Определения

Гипертрофия аденоидов — увеличение глоточной миндалины со стойким затруднением носового дыхания и (или) другими осложнениями: обструктивными нарушениями сна, экссудативным средним отитом, деформацией лицевого скелета. Гипертрофия нёбных миндалин — увеличение одной или обеих нёбных миндалин; она может протекать бессимптомно или проявляться храпом, остановками дыхания во сне, нарушениями глотания и артикуляции, деформацией лицевого скелета.

Аденоидит — реактивные воспалительные изменения глоточной миндалины как органа местного иммунитета слизистых в ответ на антигены, попадающие на слизистую носа и глотки. У детей младше 7–9 лет без заметного влияния на качество жизни и без осложнений, например средних отитов, его не считают патологией.

Рецидивирующим острым синуситом называют 4 эпизода и больше за последний год. Рецидивирующий острый средний отит — 3 эпизода и больше за 6 месяцев или 4 и больше за 12 месяцев.

2.2 Причины

Наиболее вероятными причинами считают вирусную инфекцию, генетическую предрасположенность и влияние окружающей среды. Роль бактериальной инфекции, гастроэзофагеального рефлюкса и аллергии спорна. Обычно действует сразу несколько факторов, и выделить ведущий не удаётся.

Особое внимание уделяют вирусу герпеса IV типа: герпетическая инфекция — одна из частых причин выраженной гипертрофии глоточной миндалины со стойкой обструкцией носоглотки.

2.3 Классификация

Для аденоидов в России чаще всего используют классификацию А. Г. Лихачёва — по тому, какую часть сошника прикрывает ткань глоточной миндалины. При I степени она прикрывает не больше верхней трети сошника, при II — от 1/3 до 2/3, при III — больше 2/3.

Для нёбных миндалин чаще всего используют классификацию Б. С. Преображенского. Расстояние между вертикалью через середину язычка и линией по краю передней (нёбно-язычной) дужки делят на три части. При I степени миндалина занимает треть этого расстояния, при II — две трети, при III миндалины доходят до язычка и соприкасаются друг с другом.

2.4 Клиническая картина

Жалобы и симптомы чаще всего бывают при гипертрофии III степени. При I и II степени пациенты обычно, хотя и не всегда, ни на что не жалуются.

При гипертрофии нёбных миндалин родители обычно жалуются только на храп. В отличие от храпа при воспалении, он постоянный и часто не зависит от позы во сне. Иногда родители замечают и классические признаки синдрома обструктивного апноэ сна (СОАС): дневную сонливость и снижение успеваемости. Значительно реже бывают изменения прикуса и лёгкая дисфония.

При гипертрофии аденоидов, в том числе в сочетании с увеличением нёбных миндалин, жалобы разнообразнее. Кроме нарушений дыхания во сне, беспокоят стойкое затруднение носового дыхания и его следствия — постоянно открытый рот, гипоназальность (закрытая гнусавость), сухость во рту. Нередко снижается слух из-за экссудативного среднего отита или в анамнезе есть повторные острые средние отиты. Даже при II степени ринологические симптомы — заложенность носа, стекание отделяемого по задней стенке глотки, кашель — после простуды могут держаться до нескольких недель. У школьников с аденоидами часто бывают острые синуситы, в том числе рецидивирующие.

При аденоидите главная жалоба — кашель, обычно продуктивный, ночной и утренний: это проявление постназального синдрома, то есть стекания отделяемого по задней стенке глотки. Аденоидит бывает и при небольшой глоточной миндалине. При аденоидите на фоне гипертрофии аденоидов II–III степени обычно одновременно жалуются на заложенность носа и кашель.

Реактивные изменения глоточной миндалины после простуды или на фоне аллергического ринита у детей младше 7–9 лет физиологичны. Патологией их не считают, если нет осложнений (средних отитов, острого синусита) и симптомы — кашель или затруднённое носовое дыхание — не нарушают сон и дневную активность ребёнка.

Симптомы гипертрофии аденоидов и аденоидита не патогномоничны. Их отличают от острого и хронического риносинусита, аллергического, вазомоторного и гипертрофического ринита, искривления перегородки носа, инородных тел и новообразований полости носа и носоглотки. Гипертрофия аденоидов часто сопутствует острому и хроническому синуситу и аллергическому риниту.

У взрослых симптомы те же, что у детей.

2.5 Жалобы и анамнез

Уточняют, сколько длится болезнь, с чем пациент связывает её начало, как менялись жалобы и как они влияют на сон и повседневную активность ребёнка, какое было лечение, его эффект и нежелательные явления. Важно, есть ли симптомы вне эпизодов острых респираторных инфекций, и насколько они выражены сейчас по сравнению с прошлым. Из анамнеза жизни выясняют сопутствующие болезни, прежде всего аллергию: наблюдается ли по ним ребёнок у специалиста, как лечится, планируются ли операции. Большое значение имеют перенесённые операции и манипуляции в полости носа, включая назотрахеальную интубацию и любые назальные зонды.

---

3. Диагностика

Наличие у ребёнка глоточной и нёбных миндалин — не патология. Обследование оправдано, если есть жалобы, клинические проявления или сопутствующая болезнь, на течение которой могут влиять аденоидит, гипертрофия аденоидов или нёбных миндалин.

Гипертрофию нёбных миндалин диагностируют по жалобам, анамнезу и физикальному обследованию — фарингоскопии с обязательной оценкой нижнего полюса миндалин. Для диагноза гипертрофии аденоидов, кроме этого, нужно инструментальное исследование: эндоскопия носоглотки, рентгенография носоглотки или компьютерная томография (КТ).

3.1 Осмотр

Всех пациентов осматривает оториноларинголог, чтобы оценить общее состояние, выраженность симптомов и сопутствующую патологию, — и амбулаторно, и при госпитализации в ЛОР-отделение.

Пальцевое исследование носоглотки для диагностики аденоидов у детей в амбулаторной практике не проводят: его результаты крайне субъективны, процедура неприятна ребёнку и может травмировать структуры глотки.

Лабораторные исследования для диагностики гипертрофии аденоидов и нёбных миндалин не используют; они нужны только для диагностики сопутствующих болезней.

3.2 Инструментальные исследования

При симптомах, характерных для гипертрофии аденоидов, проводят эндоскопический осмотр полости носа и носоглотки.

Если эндоскоп гибкий и изображение можно сохранить на фото или видео, это наиболее предпочтительный метод. Эндоскопия носоглотки — метод первого выбора для дифференциальной диагностики и для оценки носоглотки после операции, в том числе в отдалённые сроки. Ригидный эндоскоп ребёнок, особенно дошкольник, переносит хуже, а осмотр без сохранения изображения значительно менее объективен для последующих консультаций.

Рентгенографию носоглотки в боковой проекции делают при симптомах, характерных для гипертрофии аденоидов, чтобы оценить размер глоточной миндалины.

Метод дешёвый, доступный и безболезненный. Минусы — небольшая лучевая нагрузка, необходимость правильной укладки с открытым ртом и невозможность отличить аденоиды от других объёмных образований носоглотки; результат не всегда соответствует выраженности симптомов. После аденотомии рентгенография малоинформативна: аденоиды нельзя отличить от компенсаторной гипертрофии трубных валиков и нельзя оценить рубцы.

КТ верхних дыхательных путей и шеи делают не всем, а по специальным показаниям — в сложных случаях, когда нужно отличить гипертрофию аденоидов от другой патологии носа с похожими симптомами или диагностировать их одновременно.

При гипертрофии аденоидов проводят тимпанометрию, чтобы объективно оценить состояние среднего уха.

3.3 Чего не делать

Мазки из глотки на микрофлору для диагностики гипертрофии аденоидов и нёбных миндалин у детей не берут. Условно-патогенные бактерии часто есть в глотке и у здоровых людей, поэтому ни рост, ни отсутствие роста при отсутствии признаков бактериальной инфекции не позволяют оценить риск и прогноз.

3.4 Консультации специалистов

По специальным показаниям пациента направляют к аллергологу-иммунологу, чтобы подтвердить или исключить сопутствующую аллергию и согласовать лечение. Направляют планово при клинических и анамнестических признаках аллергического ринита, атопической бронхиальной астмы или атопического дерматита.

В первую очередь консультация нужна при глазных симптомах или повторном чихании и зуде в носу; при ринологических симптомах, которые пациент связывает с цветением, животными или другими определёнными ситуациями; при повторных приступах кашля, свистящего или затруднённого дыхания и стеснения в груди, особенно ночью и рано утром; при кожных проявлениях атопического дерматита, крапивницы и других аллергических болезней кожи; при рецидивирующих острых средних отитах или риносинуситах.

При признаках повторяющихся обструктивных нарушений сна пациента по возможности планово направляют к специалисту по расстройствам сна для объективной диагностики и согласования лечения.

При врождённых или приобретённых изменениях челюстно-лицевой области пациента планово направляют к ортодонту.

По специальным показаниям пациента направляют к инфекционисту для диагностики персистирующих вирусных инфекций, прежде всего герпесвирусной.

Показание — хотя бы один из признаков, который держится 3 месяца и дольше: увеличение лимфоузлов в 3 группах и более (не меньше 3 узлов в каждой); увеличение печени и (или) селезёнки; снижение абсолютного числа нейтрофилов в анализе крови ниже возрастной нормы и (или) общего числа нейтрофилов ниже 5×10^9/л. Оториноларинголог только оценивает симптомы, а решение о лабораторном поиске вирусов принимает инфекционист.

---

4. Лечение

При наличии показаний гипертрофию аденоидов и нёбных миндалин лечат хирургически в плановом порядке. Если показаний нет или есть абсолютные противопоказания, пациента динамически наблюдает оториноларинголог. При хронической или врождённой сопутствующей патологии операцию проводят только по согласованию с профильным специалистом.

Абсолютные противопоказания к операции — шок, острая стадия инфаркта миокарда и нарушения мозгового кровообращения, поздние стадии тяжёлых инфекционных и онкологических болезней, тяжёлое, крайне тяжёлое или терминальное состояние из-за сопутствующих болезней. Относительные — неконтролируемое или плохо контролируемое течение сопутствующей соматической патологии и аномалии строения носа, резко повышающие риск серьёзных осложнений во время операции.

Консервативное лечение оправдано только при клинических и анамнестических признаках воспаления глоточной миндалины (аденоидита) или нёбных миндалин (тонзиллита), если есть соответствующие жалобы или осложнения.

4.1 Хирургическое лечение

Аденотомию при гипертрофии аденоидов делают по специальным показаниям, чтобы восстановить проходимость носоглотки, и только при отсутствии противопоказаний.

Показания у детей: частые или регулярные эпизоды обструктивных нарушений сна (храп, иногда с дневной сонливостью и вялостью); экссудативный средний отит, который не проходит 3 месяца, не поддаётся консервативному лечению и подтверждён тимпанометрией; рецидивирующие острые средние отиты или острые синуситы (3 эпизода и больше за 6 месяцев или 4 и больше за 12 месяцев), если исключены другие причины, прежде всего иммунодефицит, а медикаментозная профилактика не помогла; хронический синусит с выраженными симптомами или частыми обострениями, если не помогли 1–2 курса консервативного лечения; стойкое затруднение носового дыхания без других причин, которое ухудшает качество жизни или ведёт к деформации лицевого скелета по данным цефалометрии и заключению ортодонта или челюстно-лицевого хирурга; заключение других специалистов, что аденотомия нужна как этап лечения сопутствующей болезни, например перед кардиохирургической операцией.
Если обструктивные нарушения сна можно оценить объективно, ориентируются на индекс апноэ-гипопноэ: от 5 до 15 — среднетяжёлая форма, больше 15 — тяжёлая.
Детям аденотомию предпочтительно делать под общим обезболиванием в ЛОР-отделении стационара или в стационаре кратковременного пребывания.

Тонзиллотомию детям с гипертрофией нёбных миндалин делают по специальным показаниям, чтобы уменьшить миндалины. Основное показание — частые или регулярные эпизоды обструктивных нарушений сна (храп, иногда с дневной сонливостью и вялостью); при возможности ориентируются на индекс апноэ-гипопноэ, как при аденотомии.

Если у ребёнка одновременно есть показания и к тонзиллотомии, и к тонзиллэктомии, лучше сделать тонзиллэктомию. Тонзиллотомию предпочтительно проводить под общим обезболиванием в ЛОР-отделении стационара или в стационаре кратковременного пребывания.

Если увеличены и аденоиды, и нёбные миндалины, аденотомию делают вместе с тонзиллотомией по тем же показаниям, что и аденотомию.

Такую операцию проводят только под общим обезболиванием с обязательным визуальным контролем операционного поля, а в раннем послеоперационном периоде пациента наблюдают в ЛОР-отделении стационара.

Взрослым с гипертрофией нёбных миндалин и синдромом обструктивного апноэ сна при отсутствии противопоказаний делают тонзиллэктомию, чтобы уменьшить симптомы апноэ.

> У рекомендации о тонзиллэктомии взрослым не указаны ни уровень убедительности, ни уровень достоверности доказательств. Кроме того, разделы о госпитализации, послеоперационном обезболивании и реабилитации говорят только об аденотомии и тонзиллотомии, а о тонзиллэктомии у взрослых не упоминают.

4.2 Консервативное лечение аденоидита

Консервативно лечат детей с гипертрофией аденоидов только при признаках аденоидита: продуктивном кашле из-за постназального затёка, выделениях из носа, периодическом затруднении носового дыхания. Если у ребёнка младше 7–9 лет нет заметного влияния на сон, еду и повседневную активность и нет осложнений, например средних отитов, это не патология, и врач ограничивается наблюдением.

Всем пациентам с аденоидитом назначают ирригационно-элиминационную терапию — промывание полости носа.

Нос орошают 1–2 раза в день изотоническими или гипертоническими (1,5–3%) солевыми растворами на основе морской воды: это облегчает туалет носа, уменьшает симптомы и улучшает условия для последующих местных лекарств. Детям дошкольного возраста не промывают нос большими объёмами раствора из-за высокого риска средних отитов.

По специальным показаниям при аденоидите назначают местные антибиотики, чтобы подавить условно-патогенную флору носоглотки.

Применяют назальный спрей фрамицетина, детям старше 2,5 года — комбинированный препарат дексаметазон + неомицин + полимиксин B + фенилэфрин, или раствор для ингаляций тиамфеникола глицинат ацетилцистеинат. Курс короткий, до 7 дней. Показание — признаки бактериальной инфекции: слизисто-гнойные выделения из носа и по задней стенке глотки в течение всего дня или отсутствие улучшения за 7–10 дней противовоспалительной терапии.
Растворы антибиотиков для парентерального, внутриконъюнктивального или ушного введения в нос не вводят: они не предназначены для полости носа и могут нарушить мукоцилиарный транспорт.

Пациентам старше 2 лет с аденоидитом назначают отхаркивающие муколитики, чтобы уменьшить постназальный затёк. Подходят только препараты с преимущественно мукорегулирующим действием; оптимальным в КР назван карбоцистеин.

Карбоцистеин в сиропе, в том числе в виде карбоцистеина лизина моногидрата, назначают курсом от 1 до 3 месяцев. Он уменьшает постназальный затёк и повышает вероятность разрешения сопутствующего экссудативного среднего отита. При монотерапии отличие от выжидательной тактики становится заметным только ко 2–3-й неделе. Одновременно другие муколитики, в том числе местные, не назначают, чтобы не усилить затёк.

Детям старше 2 лет с аденоидитом и сопутствующим аллергическим ринитом назначают топические глюкокортикостероиды: #мометазон в виде назального спрея по 1 дозе (50 мкг) в каждый носовой ход 1 раз в сутки (100 мкг в сутки) курсом от 1 до 3 месяцев.

Ни гипертрофия аденоидов, ни аденоидит, ни назофарингит не зарегистрированы в России как показание ни для одного местного глюкокортикостероида; знак # означает применение вне инструкции.

Масла, в первую очередь масло туи, при гипертрофии аденоидов и аденоидите не применяют: их эффективность не доказана, а в носу они угнетают работу ресничек, нарушают эвакуацию секрета и повышают риск бактериальной инфекции.

Ежедневно промывать нос растворами антисептиков не рекомендуется: эффективность не доказана, нарушается мукоцилиарный транспорт и возможны местные дисбиотические изменения.

4.3 Обезболивание после операции

При боли после аденотомии и (или) тонзиллотомии назначают нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) или парацетамол. Обезболивают при жалобах на боль или других её проявлениях — отказе от еды и питья, повторной рвоте и тошноте.

Препарат	Доза у детей
Ибупрофен	8–10 мг/кг на приём, не больше 30 мг/кг в сутки, внутрь в форме по возрасту (таблетки, покрытые оболочкой, — с 6 лет); младшим детям — ректальные суппозитории.
Кетопрофен	С 6 лет — гранулы для приготовления раствора для приёма внутрь (кетопрофена лизиновая соль), 40 мг на приём до 3 раз в день.
Парацетамол	10–15 мг/кг на приём, не больше 60 мг/кг в сутки, в любой форме по возрасту. Если принимать внутрь нельзя, а свечей нет, — парентерально 15 мг/кг на введение.

4.4 После операции

После аденотомии и (или) тонзиллотомии оториноларинголог осматривает пациента перед выпиской и амбулаторно через 7–14 дней после выписки, чтобы оценить состояние и исключить поздние послеоперационные осложнения.

В течение 5–7 дней после операции соблюдают охранительный режим.

Он включает ограничение контактов (без детского коллектива и людных мест), ограничение физической нагрузки и исключение перегрева, особенно головы и шеи, в том числе отказ от горячей еды и питья.

Если дисфония сохраняется больше месяца после операции, пациента направляют к логопеду-дефектологу.

Если симптомы обструктивных нарушений сна сохраняются больше 6–8 недель после операции, пациента направляют к специалисту по расстройствам сна.

---

5. Наблюдение, профилактика, госпитализация

5.1 Профилактика

Специфической профилактики гипертрофии аденоидов и нёбных миндалин нет. Поскольку важную роль играют респираторные вирусы, соблюдают общие правила профилактики ОРВИ. Некоторые лекарства можно использовать для плановой и экстренной профилактики аденоидита у детей.

Детям старше 1 года из групп риска по респираторным инфекциям назначают стандартизированные растительные препараты для приёма внутрь из группы прочих антисептиков, чтобы предупредить эпизоды ОРВИ и сделать последующие эпизоды аденоидита короче и легче.

Это препараты с корнем алтея, цветками ромашки, хвощом, листьями грецкого ореха, тысячелистником, корой дуба и одуванчиком лекарственным. Их назначают и для лечения аденоидита при появлении симптомов ОРВИ — отдельно или в комплексе.

Детям старше 3 лет при появлении симптомов острого назофарингита назначают комбинированный препарат лизоцим + пиридоксин, чтобы последующий аденоидит был короче и легче.

Детям из групп риска по респираторным инфекциям назначают лизаты бактерий (другие иммуностимуляторы), чтобы эпизоды аденоидита и его осложнений были короче и легче.

Обычно это плановая профилактика курсами по инструкции 2–3 раза в год; подходят и формы для приёма внутрь, и местные.

Для профилактики аденоидитов и их осложнений у детей можно рассмотреть местные пробиотики на основе бактерий нормальной микрофлоры глотки.

В информации для пациента КР советует обратиться к врачу, если после простуды у ребёнка появились и в течение 2 недель не проходят заложенность носа, храп, снижение слуха или кашель (когда исключена патология нижних дыхательных путей).

5.2 Госпитализация и выписка

Госпитализируют для плановой аденотомии и (или) тонзиллотомии при наличии показаний и отсутствии противопоказаний. Аденоидит лечат амбулаторно или в консультативно-диагностическом отделении. Выписывают после операции при удовлетворительном общем состоянии и отсутствии осложнений.

5.3 Что влияет на результат

При хронических соматических болезнях после аденотомии и (или) тонзиллотомии возможно их обострение в раннем послеоперационном периоде. Аллергический ринит повышает вероятность, что назальные симптомы — передняя и задняя ринорея, меньше заложенность — не пройдут полностью. Ожирение повышает вероятность сохранения обструктивных нарушений сна после операции. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь повышает вероятность сохранения назальных симптомов и риск инфекционных осложнений в раннем послеоперационном периоде.

При гипертрофии нёбных миндалин лекарственное лечение аденоидита очень мало помогает избавиться от обструктивных нарушений сна.

Если у ребёнка есть сопутствующая болезнь, которая может повлиять на результат операции, врач должен сказать об этом пациенту или родителям до операции.

---

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Гипертрофия аденоидов. Гипертрофия нёбных миндалин»
Версия	2-я, опубликована в рубрикаторе 25.10.2024
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее октября 2027 года
Код в рубрикаторе	662_2 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Пациенты	Взрослые и дети

6.1 Неточности в самом тексте КР

- Рекомендация о тонзиллэктомии взрослым с гипертрофией нёбных миндалин и СОАС дана без уровня убедительности и уровня достоверности доказательств, а разделы о госпитализации, обезболивании и реабилитации упоминают только аденотомию и тонзиллотомию.
- Для хронического аденоидита в разделе 1.4 предложены два кода: J31.1 («как возможный вариант кодирования») и J35.8 («например, аденоидит»).
- Растительные препараты рекомендованы в разделе профилактики, но в комментарии к ним сказано, что их назначают и для лечения аденоидита при симптомах ОРВИ.

- В комментарии к ибупрофену фраза о суппозиториях оборвана: «ректальные суппозитории (у детей младше) 2 лет»; возрастная граница неоднозначна.
- В рекомендации об осмотре после операции пропущено слово: «через 7-14 после выписки» — по смыслу дней.
- Сведения о незарегистрированных показаниях для мометазона даны «на конец 2020 года», хотя КР утверждены в 2024 году.
- В разделе профилактики есть ссылка «см. КР 25» без пояснения, о каких рекомендациях речь.

Клинические рекомендации

Наружные отиты

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**H60.0** — Абсцесс наружного уха **H60.1** — Целлюлит наружного уха **H60.2** — Злокачественный наружный отит **H60.3** — Другие инфекционные наружные отиты **H60.4** — Холестеатома наружного уха **H60.5** — Острый наружный отит неинфекционный **H60.8** — Другие наружные отиты **H60.9** — Наружный отит неуточненный **H61.0** — Перихондрит наружного уха **H61.8** — Другие уточненные болезни наружного уха **H61.9** — Болезнь наружного уха неуточненная **H62.0** — Наружный отит при бактериальных болезнях, классифицированных в других рубриках **H62.1** — Наружный отит при вирусных болезнях, классифицированных в других рубриках **H62.3** — Наружный отит при других инфекционных и паразитарных болезнях, классифицированных в других рубриках **H62.4** — Наружный отит при других болезнях, классифицированных в других рубриках **H62.8** — Другие поражения наружного уха при болезнях, классифицированных в других рубриках
Пациенты	взрослые
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 13.11.2024, пересмотр не позднее 2027 года
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/663_2

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 22.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

1. Главное

- Наружный отит — воспаление ушной раковины, наружного слухового прохода и эпидермального слоя барабанной перепонки.
- Неосложнённый наружный отит лечат местно: ушными каплями, а при бактериальном отите в первую очередь фторхинолонами. Всем нужны туалет слухового прохода и обезболивание.
- Системные антибиотики при неосложнённом отите не назначают. Они нужны при постлучевом отите, сахарном диабете, иммуносупрессии и хондроперихондрите.
- Эффект оценивают через 48–72 часа. Если его нет, уточняют диагноз: это может быть атопический или контактный дерматит, псориаз или экзема.
- При злокачественном наружном отите сильная боль, грануляции, в посеве синегнойная палочка, лечение не помогает больше недели; чаще болеют пожилые с сахарным диабетом. Нужны глюкоза крови, КТ, госпитализация и антибиотики не меньше 6 недель.

2. Клиника и классификация

2.1 Определение

Наружный отит — воспалительные изменения ушной раковины, наружного слухового прохода и эпидермального слоя барабанной перепонки.

Отит бывает острым и хроническим, если длится дольше 6–12 недель. Диффузный наружный отит включает экзему, дерматит, рожу, герпес, перихондрит, хондроперихондрит и злокачественный наружный отит. Ограниченный — это фурункул и абсцесс.

Воспаление начинается с повреждения кожи: травмы, долгого пребывания во влажной среде, сахарного диабета, дерматита или экземы. Предрасполагают узкий слуховой проход, экзостозы, слуховой аппарат, попадание воды, нарушение образования серы и облучение.

2.2 Жалобы

Пациенты жалуются на дискомфорт и боль в ухе, часто сильнее при надавливании и жевании; боль может отдавать в глаз, зубы, глотку. Слух снижается, если слуховой проход полностью закрыт. Иногда беспокоят зуд и выделения. Температура обычно субфебрильная.

2.3 Осмотр

При осмотре видны гиперемия, отёк, инфильтрация и лихенификация кожи слухового прохода, иногда ушной раковины и поверхностного слоя барабанной перепонки, а также патологическое отделяемое. При ограниченной форме находят абсцессы и инфильтраты, бывает регионарный лимфаденит.

2.4 Особенности форм

Фурункул слухового прохода в стадии инфильтрации вызывает дискомфорт, который усиливается при манипуляциях в ухе, а после формирования абсцесса на первый план выходит боль. При диффузном отите беспокоят боль, выделения и иногда снижение слуха.

При экзематозном отите видны желтовато-розовые очаги с чешуйками, беспокоит зуд, иногда сильный и появляющийся раньше высыпаний. Затем образуются микровезикулы, эрозии и мокнутие, причём элементы разных стадий видны одновременно.

При герпетическом поражении за 1–2 суток до высыпаний появляются жжение, зуд и покалывание, затем эритема, пузырьки и корочки. Обычно всё проходит за 10–14 дней, при вторичной инфекции — за 3–4 недели.

3. Диагностика

Диагноз ставят по характерным жалобам и клинической картине; при необходимости его подтверждают лабораторно и другими методами.

Отделяемое отправляют на посев на бактерии, на микроскопию и посев на грибы, делают цитологию; при подозрении на новообразование — биопсию.

Мазок берут до начала противомикробного лечения, под контролем отоскопии, тампоном на глубине до 0,3 см из просвета или со стенок слухового прохода, не касаясь его наружных отделов.

Если после стихания воспаления пациент жалуется на снижение слуха, проводят аудиометрию, чтобы исключить острую нейросенсорную тугоухость. При неосложнённом наружном отите возможна кондуктивная тугоухость.

КТ и МРТ нужны при осложнённой форме, когда есть костные секвестры или абсцессы, чтобы оценить распространённость процесса. При неосложнённом отите лучевая диагностика не нужна.

Если наружное ухо поражено на фоне системного, в том числе инфекционного, заболевания, пациента направляют к профильному специалисту и дообследуют.

3.1 Злокачественный наружный отит

При злокачественной форме определяют глюкозу крови, чтобы выявить сахарный диабет: в 90–100% случаев злокачественный отит сочетается с ним.

Основные признаки злокачественного наружного отита: боль в ухе и головная боль на стороне поражения, отёк стенок и выделения из слухового прохода, грануляции в нём, микроабсцессы в области уха и основания черепа, очаг воспаления на сцинтиграфии, отсутствие эффекта от лечения больше недели и синегнойная палочка в посеве.

Дополнительно учитывают сахарный диабет, поражение черепных нервов, истощение и пожилой возраст. Если сцинтиграфию сделать нельзя, назначают местное лечение на 1–3 недели: отсутствие улучшения говорит в пользу злокачественного отита.

4. Лечение

Всем пациентам устраняют предрасполагающие факторы, хорошо обезболивают и регулярно проводят туалет наружного слухового прохода.

4.1 Местное лечение

Неосложнённый наружный отит лечат местно, препаратами, которые действуют на золотистый стафилококк и синегнойную палочку. Эффект оценивают через 48–72 часа. Если симптомы держатся, уточняют диагноз: это может быть атопический или контактный дерматит, псориаз или экзема.

При бактериальном наружном отите ушные капли с фторхинолонами — препараты первого выбора.

Ушные капли назначают всем пациентам с бактериальным наружным отитом; варианты — в таблице ниже.

При любой форме применяют антисептики (бензилдиметил[3-(миристоиламино)пропил]аммоний хлорид; йод с калия йодидом и поливиниловым спиртом) и противомикробные средства: фторхинолоны, аминогликозиды, противогрибковые. При местном лечении 65–95% пациентов выздоравливают на 7–10-е сутки.

При экзематозной форме назначают кортикостероиды вместе с противомикробными средствами.

4.2 Ушные капли

Препарат	Состав	Возраст
Офлоксацин	офлоксацин	с 1 года
Ципрофлоксацин + дексаметазон (в КР — «Комбинил»)	антибактериальный — ципрофлоксацин; противовоспалительный — дексаметазон	с 18 лет
Норфлоксацин	норфлоксацин	с 15 лет
Рифамицин	рифамицин	без ограничений
Лидокаин + неомицин + полимиксин B	антибактериальный — неомицин + полимиксин B; анестетик — лидокаин	с 1 года
Беклометазон + клотримазол + лидокаин + хлорамфеникол	антибактериальный — хлорамфеникол; противогрибковый — клотримазол; противовоспалительный — беклометазон; анестетик — лидокаин	с 6 лет
Дексаметазон + неомицин + полимиксин B	антибактериальный — неомицин + полимиксин B; противовоспалительный — дексаметазон	без ограничений
Фрамицетин + грамицидин + дексаметазон	антибактериальный — фрамицетин + грамицидин; противовоспалительный — дексаметазон	без ограничений

> В этой КР капли с норфлоксацином разрешены с 15 лет, а в КР «Отит средний острый» — детям старше 1 года. Проверьте возраст по инструкции в ГРЛС.

4.3 Системные антибиотики

При неосложнённом наружном отите системные антибиотики не назначают: если добавить их к местному лечению, результат не улучшается.

Системные антибиотики нужны при постлучевом наружном отите, сахарном диабете и иммуносупрессии.

Злокачественный наружный отит лечат системными антибиотиками не меньше 6 недель; препараты должны действовать на синегнойную палочку и стафилококк.

При хондроперихондрите ушной раковины назначают системные антибиотики и противовоспалительные средства, чтобы снять боль и отёк.

4.4 Хирургия и другое

При ограниченном отите вскрывают и дренируют абсцессы слухового прохода. При злокачественном удаляют грануляции, костные и хрящевые секвестры и холестеатому в пределах зоны поражения.

Для повышения эффективности лечения применяют физиотерапию.

Посевы повторяют до тех пор, пока не подтвердится, что возбудитель исчез.

При сахарном диабете и нарушении толерантности к глюкозе контролируют уровень глюкозы крови.

5. Профилактика и госпитализация

Для профилактики советуют реже пользоваться ватными палочками и не чистить слуховой проход слишком часто, а также соблюдать гигиену берушей, слуховых аппаратов и наушников.

Лечат обычно амбулаторно, а при некротическом (злокачественном) наружном отите госпитализируют. Выписывают, когда воспаление в слуховом проходе стихло и гнойно-септических осложнений нет.

Медицинская реабилитация не рекомендована.

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Наружные отиты»
Версия	2-я, опубликована в рубрикаторе 13.11.2024
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР — не реже одного раза в три года: следующая ожидается не позднее ноября 2027
Код в рубрикаторе	663_2 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Пациенты	Взрослые. Для детей — отдельная КР «Наружный отит» (21_3)

6.1 Неточности в самом тексте КР

- Норфлоксацин в каплях: здесь — с 15 лет, в КР «Отит средний острый» — детям старше 1 года.
- В таблице 1 у фрамицетина с дексаметазоном антибактериальный компонент назван «Грамидин»; по названию препарата — грамицидин.
- Одна строка таблицы 1 дана торговым названием «Комбинил» (ципрофлоксацин + дексаметазон).
- Сокращение «зО» в разделе 2.5 — по смыслу злокачественный наружный отит.

Клинические рекомендации

Нейросенсорная тугоухость у взрослых

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**H90.3** — Нейросенсорная потеря слуха двусторонняя **H90.4** — Нейросенсорная потеря слуха односторонняя с нормальным слухом на противоположном ухе **H90.5** — Нейросенсорная потеря слуха неуточненная **H91.1** — Пресбиакузис **H91.2** — Внезапная идиопатическая потеря слуха **H91.8** — Другие уточненные потери слуха
Пациенты	взрослые
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 22.03.2023, пересмотр не позднее 2026 года
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/518_3

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 22.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

1. Главное

- Диагноз ставят по жалобам, нормальной отоскопической картине и аудиологическим данным: тимпанограмма типа «А», средний порог воздушного звукопроведения на частотах 500, 1000, 2000 и 4000 Гц — 26 дБ и выше, костно-воздушный интервал — не больше 10 дБ.
- Степень тугоухости определяют по среднему порогу воздушного звукопроведения на тех же четырёх частотах: I — 26–40 дБ, II — 41–55 дБ, III — 56–70 дБ, IV — 71–90 дБ, глухота — 91 дБ и более.
- При внезапной и острой идиопатической потере слуха тональную аудиометрию проводят не позднее суток от первого обращения и повторяют перед выпиской, чтобы оценить эффект лечения.
- Пациента с острой сенсоневральной тугоухостью экстренно госпитализируют в ЛОР-отделение (или в неврологию) и назначают глюкокортикоиды по убывающей схеме.
- Слуховой аппарат подбирают при среднем пороге в зоне речевых частот на лучше слышащем ухе 31 дБ и выше; при двусторонней тугоухости IV степени или глухоте показана кохлеарная имплантация.
- При хронической тугоухости сурдолог-оториноларинголог наблюдает пациента и 1–2 раза в год повторяет тональную и речевую аудиометрию.

2. Клиника и классификация

2.1 Определение

Сенсоневральная (нейросенсорная) тугоухость (СНТ) — снижение слуха вплоть до его утраты, при котором поражается какой-либо участок звуковоспринимающего отдела слухового анализатора: от сенсорного аппарата улитки до невральных структур.

2.2 Причины

Основное условие развития тугоухости — повреждение чувствительных структур улитки. Начинается оно с дистрофии волосковых клеток, которая может быть обратимой, если помощь оказана вовремя.

К внезапной и острой СНТ приводят инфекции (грипп, эпидемический паротит, корь, клещевой энцефалит, менингококковый менингит, скарлатина, дифтерия, тифы, сифилис), острые интоксикации и ототоксические препараты (аминогликозиды, петлевые диуретики, противоопухолевые препараты, нестероидные противовоспалительные препараты и другие), болезни сердца и сосудов, включая нарушения мозгового кровообращения в вертебро-базилярном бассейне и нарушения реологии крови, дегенеративные болезни позвоночника с синдромом позвоночной артерии, а также моногенная наследственная патология и генетическая предрасположенность.

2.3 Степени тугоухости

Степень определяют по усреднённому порогу слышимости воздушного звукопроведения на частотах 500, 1000, 2000 и 4000 Гц.

Степень	Средний порог воздушного звукопроведения
I степень	26–40 дБ
II степень	41–55 дБ
III степень	56–70 дБ
IV степень	71–90 дБ
Глухота	91 дБ и более

2.4 Другие классификации

По остроте различают внезапную тугоухость, когда слух снижается в срок до 12 часов; острую, когда снижение развивается за 1–3 суток и сохраняется до месяца; подострую, когда снижение сохраняется 1–3 месяца; и хроническую (стойкую), когда оно держится дольше 3 месяцев.

По времени возникновения тугоухость бывает врождённой и приобретённой; по течению — стабильной, прогрессирующей, флюктуирующей и обратимой; по стороне поражения — односторонней и двусторонней, симметричной или асимметричной; по этиологии — генетической (наследственной), мультифакториальной (с наследственной предрасположенностью) и приобретённой.

2.5 Клиническая картина

Основные признаки сенсоневральной тугоухости у взрослых — снижение слуха, ухудшение разборчивости речи, шум в ушах и ощущение заложенности ушей.

На первом месте среди жалоб стоит снижение слуха вместе с шумом в ухе, чаще постоянным и преимущественно смешанной тональности.

Для острой сенсоневральной тугоухости характерно внезапное одно- или двустороннее снижение слуха вплоть до глухоты. Иногда — при острой травме, нарушении кровотока в лабиринтной артерии, токсическом поражении лабиринта — оно сопровождается шумом в ухе, а также острой вестибулярной и вегетативной дисфункцией: атаксией, головокружением, тошнотой, потливостью, тахикардией, колебаниями артериального давления и спонтанным нистагмом.

2.6 Жалобы и анамнез

Уточняют, когда возникло снижение слуха, как быстро нарастало, одинаково ли слышат правое и левое ухо, насколько выражены трудности общения. Активно расспрашивают о шуме в ушах, его выраженности и тональности, о вестибулярных нарушениях и неврологических симптомах.

В анамнезе особое внимание уделяют слуху ближайших родственников, характеру работы, перенесённым инфекционным и соматическим заболеваниям и наблюдению у других специалистов.

Выясняют факторы риска: тугоухость у родственников (особенно если совпадают степень, форма и условия возникновения), работу в условиях производственного шума, приём ототоксических препаратов, перенесённые инфекции (менингит, эпидемический паротит, корь, грипп и другие) и соматические болезни.

При острой тугоухости расспрашивают по плану: самочувствие и температура тела; какое ухо хуже слышит, когда и как снизился слух, менялся ли он, с чем пациент это связывает, снижался ли слух раньше; есть ли шум в ушах; было ли головокружение, какое оно (с определённым направлением или хаотичное), были ли тошнота, рвота, диарея, потливость и уменьшились ли головокружение и шум после рвоты; были ли раньше приступы системного головокружения и не ставили ли болезнь Меньера; не болеет ли пациент отитами, какие принимал лекарства, какое у него артериальное давление.

Также уточняют, нет ли гипертонической, ишемической или цереброваскулярной болезни; не было ли перед снижением слуха травмы головы или шейного отдела позвоночника, интенсивного звукового воздействия, плавания или приёма ванны; нет ли слабости в конечностях, асимметрии лица, нарушений чувствительности, движений и зрения; не лечился ли пациент недавно у стоматолога и не протезировал ли зубы.

3. Диагностика

Диагноз ставят на основании жалоб на снижение слуха, шум в ушах и ухудшение разборчивости речи, нормальной отоскопической картины и аудиологических данных. При тимпанометрии регистрируется тимпанограмма типа «А»; акустические рефлексы, в зависимости от степени потери слуха, регистрируются или нет. При тональной пороговой аудиометрии средний порог воздушного звукопроведения на частотах 500, 1000, 2000 и 4000 Гц составляет 26 дБ и более, а костно-воздушный интервал — 10 дБ и менее. Результаты речевой аудиометрии соответствуют тональной.

3.1 Осмотр

Убеждаются, что наружное и среднее ухо не изменены: при сенсоневральной тугоухости отоскопическая картина нормальная — слуховой проход свободный, барабанная перепонка перламутрово-серая, матовая, опознавательные знаки чётко видны.

Острая сенсоневральная тугоухость может развиться и у пациента с прошлой или текущей патологией среднего уха, поэтому отоскопия необходима, но для диагноза и выбора тактики её недостаточно.

Осматривают и другие ЛОР-органы, чтобы исключить болезни уха, носа и глотки, нарушающие воздушное звукопроведение.

3.2 Анализы

Всем пациентам делают общий (клинический) анализ крови, чтобы оценить общее состояние.

При соответствующей сопутствующей патологии исследуют липидный спектр (холестерин, ЛПНП, ЛПВП), общетерапевтическую биохимию (глюкоза, общий и прямой билирубин, АЛТ, АСТ, креатинин, мочевина), коагулограмму (АЧТВ, МНО, протромбиновое время, фибриноген) и тиреотропный гормон.

3.3 Акуметрия

Всем пациентам с подозрением на СНТ составляют слуховой паспорт: исследуют слух шёпотной и разговорной речью и камертонами.

Акуметрия ориентировочна, но на ЛОР-приёме её достаточно, чтобы направить пациента к сурдологу-оториноларингологу.

3.4 Тональная пороговая аудиометрия

Всем пациентам с подозрением на СНТ определяют пороги слышимости методом тональной аудиометрии: по воздушному звукопроведению на частотах 125–8000 Гц и по костному — на 250–6000 Гц. Если пороги в норме, но пациент жалуется на снижение слуха или шум в ушах, исследуют расширенный диапазон частот — 125–20 000 Гц. Тональная аудиометрия — базовый метод и для первичной диагностики, и для динамического наблюдения.

При внезапной и острой идиопатической потере слуха аудиометрию проводят не позднее суток от первого обращения. Во время лечения, перед выпиской, её повторяют, чтобы зафиксировать восстановление порогов до нормы, их частичное восстановление или стабилизацию (отсутствие дальнейшего прогрессирования) и выбрать дальнейшую тактику.
При хронической двусторонней тугоухости по аудиограмме определяют показания к слухопротезированию — традиционному или имплантационному, включая кохлеарную имплантацию, — а при необходимости и к направлению на медико-социальную экспертизу и составлению индивидуальной программы реабилитации. Если пациент уже пользуется слуховым аппаратом, аппаратом костной проводимости или кохлеарным имплантом, оценивают эффективность слухопротезирования и при необходимости корректируют его.
При асимметричном снижении слуха лучше слышащее (не исследуемое) ухо маскируют.

Всем пациентам с подозрением на СНТ проводят надпороговые тесты — определение порогов дискомфорта, тест SISI, тест Люшера, — чтобы выявить нарушение функции громкости (рекрутмент).

Исследование можно дополнить сравнением порогов слышимости с порогами акустического рефлекса на частотах 500–4000 Гц.

3.5 Тимпанометрия и акустическая рефлексометрия

Всем пациентам с подозрением на СНТ проводят импедансометрию — тимпанометрию и регистрацию акустического рефлекса ипси- и контралатерально. Она нужна, чтобы исключить патологию среднего уха, отличить сенсоневральную тугоухость от кондуктивной и выявить поражение слухового и лицевого нервов, центральных слуховых путей и ядер VII и VIII пар черепных нервов на уровне продолговатого мозга и моста.

Если регистрировать рефлекс в широком временном окне, до 10 секунд, можно выявить его распад — признак ретрокохлеарного поражения.

Других типов тимпанограмм КР не описывают: для сенсоневральной тугоухости в критериях диагноза указана тимпанограмма типа «А», а акустические рефлексы в зависимости от степени потери слуха могут регистрироваться или отсутствовать.

3.6 Речевая аудиометрия и объективные методы

Всем пациентам с подозрением на СНТ проводят речевую аудиометрию в тишине и на фоне маскирующего шума.

Она даёт пороги восприятия и разборчивость речи; речетональная диссоциация — несоответствие речевой и тональной аудиограмм — может указывать на центральные нарушения.

Чтобы рано выявить признаки эндолимфатического гидропса, всем пациентам с подозрением на СНТ проводят электрокохлеографию.

Амбулаторно делают экстратимпанальную электрокохлеографию с внутриушным электродом, регистрируя ответы на стимулы со сгущением и разрежением в начальной фазе.

Для дифференциальной и топической диагностики всем пациентам с подозрением на СНТ исследуют коротколатентные слуховые вызванные потенциалы (КСВП), вызванную отоакустическую эмиссию и отоакустическую эмиссию на частоте продукта искажения.

При асимметричной тугоухости целесообразно предъявлять стимулы низкой частоты и сравнивать межпиковые интервалы I–V с обеих сторон.

Отоакустическая эмиссия (ОАЭ) — слабые звуковые колебания, которые генерируют наружные волосковые клетки улитки; их регистрирует зонд в наружном слуховом проходе. ОАЭ не регистрируется, если пороги слышимости превышают 25–30 дБ на частотах 1–4 кГц, охватывающих большую часть речевого диапазона.

КСВП отражают электрическую активность слухового пути в ответ на звук и регистрируются с поверхности головы. Ответ выглядит как комплекс положительных пиков I–VII, самый стабильный из которых — V пик.

3.7 Как читать аудиограмму

Для периферического (кохлеарного) поражения типична нисходящая аудиограмма без костно-воздушного разрыва с признаками феномена ускоренного нарастания громкости (ФУНТ). При центральных — корковых и подкорковых — формах аудиограмма тоже чаще нисходящая и без костно-воздушного разрыва, но ФУНТ нет; при этом заметно страдают разборчивость речи в шуме и локализация звука.

3.8 Вестибулометрия и визуализация

Всем пациентам с подозрением на СНТ проводят вестибулометрию, чтобы оценить преддверие и полукружные каналы, выявить дисфункцию лабиринта и провести дифференциальную диагностику.

Чтобы оценить анатомические структуры, всем пациентам с подозрением на СНТ делают МРТ головного мозга, в том числе с внутривенным контрастированием (внутренние слуховые проходы, мостомозжечковые углы, задняя черепная ямка), и КТ височных костей высокого разрешения, в том числе с болюсным контрастированием. Особенно ценны эти методы при односторонней и асимметричной тугоухости, но важны при любой степени и симметрии снижения слуха.

Отдельной рекомендацией КР называет рентгенографию шейного отдела позвоночника с функциональными пробами и МРТ головного мозга, а при односторонней тугоухости — МРТ с контрастным усилением, чтобы подтвердить или исключить невриному слухового нерва.

МРТ уточняет дифференциальный и топический диагноз, уровень поражения слухового анализатора и анатомические особенности уха.

При соответствующих сопутствующих болезнях делают дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий (экстра- и интракраниальных отделов) с цветным допплеровским картированием и триплексное сканирование вен.

3.9 Консультации и дифференциальная диагностика

При любом виде СНТ, независимо от длительности, пациента консультируют терапевт, невролог и эндокринолог. При аутоиммунных болезнях и иммунодефицитах исследуют иммунный статус.

Выявленные нарушения липидного и углеводного обмена позволяют построить патогенетическое лечение.

Дифференцируют с другими причинами снижения слуха: лабиринтопатиями после хронического гнойного отита, радикальной операции на ухе или перенесённого лабиринтита, поражением внутреннего уха при инфекциях и интоксикациях, невриномой VIII нерва, нарушением кровообращения в вертебро-базилярном бассейне, рассеянным склерозом, объёмными процессами мозга, черепно-мозговой и спинальной травмой, серной пробкой, сахарным диабетом, гипотиреозом, хронической почечной недостаточностью и другими.

До госпитализации диагноз острой сенсоневральной тугоухости предположительный. Но даже предположительный диагноз требует экстренной защиты сенсорных структур внутреннего уха и срочной эвакуации в многопрофильный стационар с ЛОР-отделением для дифференциальной диагностики и лечения.

Если по МРТ или КТ подозревают невриному слухового нерва или другое объёмное образование, пациента консультирует нейрохирург.

---

4. Лечение и реабилитация

4.1 Внезапная и острая тугоухость

С диагнозом «острая сенсоневральная тугоухость» пациента направляют на лечение в стационар или дневной стационар.

Пациента экстренно госпитализируют в отделение оториноларингологии или неврологии.

> КР в одном разделе допускает лечение острой тугоухости в дневном стационаре, а в следующей же рекомендации требует экстренной госпитализации в ЛОР-отделение или неврологию.

Назначают охранительный слуховой режим.

Проводят внутривенную инфузионную терапию глюкокортикоидами по убывающей схеме с учётом сопутствующих болезней, противопоказаний и возможных побочных эффектов.

Глюкокортикоиды можно вводить системно (внутрь или инфузионно) и местно (транстимпанально и транстубарно) и сочетать эти пути. В остром периоде сочетание позволяет снизить системную дозу без потери эффекта.

Если острая тугоухость предположительно ишемическая, на фоне сердечно-сосудистых нарушений, внутривенно вводят препараты для лечения заболеваний нервной системы, например #этилметилгидроксипиридина сукцинат.

Препарат	Доза
#Дексаметазон	Внутривенно на 100 мл натрия хлорида: в 1-й и 2-й дни — 24 мг, в 3-й и 4-й — 16 мг, в 5-й — 8 мг, в 6-й — 4 мг, в 7-й день препарат не вводят, в 8-й — 4 мг.
#Этилметилгидроксипиридина сукцинат	Раствор 5% — 4 мл на 16 мл натрия хлорида внутривенно, 8–10 дней.

4.2 Хроническая тугоухость

По индивидуальным показаниям, с учётом соматической патологии, проводят поддерживающие курсы лечения.

Назначают охранительный слуховой режим.

Лечат фоновые соматические болезни и 1–2 раза в год проводят курсы поддерживающей терапии таблетированными препаратами, улучшающими мозговой и лабиринтный кровоток и тканевой обмен.

При некоторых формах хронической тугоухости — наследственной, постменингитной, ототоксической — лечение в отдалённом периоде неэффективно.

Если при острой тугоухости слух ещё можно восстановить лечением, то при хронической возможность улучшить пороги лекарствами крайне мала. Корректнее говорить о лечении сопутствующих сердечно-сосудистых, неврологических, эндокринных и иммунных нарушений: оно одновременно служит профилактикой прогрессирования тугоухости. При вестибулярных нарушениях и ушном шуме проводят патогенетическое и симптоматическое лечение.

4.3 Слухопротезирование

Пациентам с хронической тугоухостью подбирают и настраивают слуховые аппараты, если средний порог на речевых частотах (500, 1000, 2000 и 4000 Гц) на лучше слышащем ухе составляет 31 дБ и более.

В алгоритме КР уточнено, что пороги должны быть стабильными, а при выборе учитывают возраст, профессию, образовательные потребности и социальную активность пациента.

Если слуховыми аппаратами пользоваться невозможно, устанавливают имплант среднего уха при условии, что пороги костного звукопроведения на 500 Гц не превышают 55 дБ, а на высоких частотах — 75 дБ.

У пациентов со сниженным зрением и другими инвалидизирующими болезнями показания к слухопротезированию шире, а требования к техническим средствам реабилитации выше.

4.4 Кохлеарная имплантация

При двусторонней тугоухости IV степени или глухоте проводят слухоречевую реабилитацию методом кохлеарной имплантации (КИ).

Сейчас это единственный эффективный метод реабилитации при тугоухости высокой степени и глухоте: комплекс аудиологических, сурдопедагогических, психологических и хирургических мер.

4.5 Показания к кохлеарной имплантации

№	Показание
1	Хроническая двусторонняя тугоухость IV степени с порогами слуха 80 дБ и более по КСВП
2	Хроническая двусторонняя тугоухость IV степени со средними порогами на частотах 500, 1000, 2000 и 4000 Гц 80 дБ и более по тональной пороговой аудиометрии
3	Пороги в свободном звуковом поле с оптимально подобранными слуховыми аппаратами (бинаурально) выше 55 дБ на частотах 2–4 кГц
4	Нет выраженного улучшения восприятия речи с оптимально подобранными аппаратами при среднем пороге выше 95 дБ после 3–6 месяцев пользования, по заключению сурдопедагогической комиссии
5	Разборчивость речи в свободном звуковом поле с оптимально подобранными аппаратами меньше 40% после 3–6 месяцев пользования, по заключению сурдопедагогической комиссии

> Пороги для кохлеарной имплантации в КР не согласованы с её же классификацией. IV степень по разделу 1.5 — это 71–90 дБ, а показания 1 и 2 говорят об «IV степени с порогами 80 дБ и более», то есть охватывают и глухоту, но не всю IV степень. Показание 4 требует среднего порога выше 95 дБ — это уже глухота, хотя названо «высокой степенью тугоухости».

Абсолютные противопоказания — полная аплазия внутреннего уха (аномалия Мишеля), полная облитерация улитки, тяжёлые соматические, неврологические и психические болезни, недостаточность интеллекта и отсутствие коммуникативных возможностей (исключения возможны для слабовидящих и слепых).

Относительные противопоказания — отсутствие мотивации и возможностей для длительной реабилитации, частичная облитерация улитки, выраженные аномалии улитки и слухового нерва, обострение острых или хронических воспалительных болезней ЛОР-органов и ретрокохлеарная патология. В трёх случаях — при облитерации, аномалиях и ретрокохлеарной патологии — решает врачебная комиссия центра, где оперируют.

Двустороннюю (бинауральную) имплантацию делают одномоментно или последовательно. Она даёт стимуляцию слуховых путей с обеих сторон, локализацию звука, лучшую разборчивость речи в шуме и в разговоре нескольких людей, более естественное и менее утомительное восприятие и сохраняет слух при поломке одного импланта.

Одномоментная бинауральная имплантация показана при хронической двусторонней тугоухости IV степени и глухоте после менингита (с выпиской из стационара) по решению врачебной комиссии.
Последовательная — при оссификации или облитерации улитки после перелома височных костей и при отосклерозе, при аномалиях развития внутреннего уха, а также при хорошей динамике слуха и речи после односторонней имплантации и высокой мотивации; всё — по решению врачебной комиссии центра. Объём последовательных имплантаций не должен превышать 10% годового объёма этой помощи в учреждении.
Противопоказания те же, что к имплантации вообще, а также интервал между операциями, когда система КИ используется с одной стороны больше 5 лет.

Объём кохлеарной имплантации взрослым в учреждении не должен превышать 20% государственного задания по этому виду высокотехнологичной помощи. Гарантийный срок на имплант — не меньше 10 лет, на речевой процессор — не меньше 5 лет.

4.6 Повторная имплантация

Причина	Что делают
Техническая неисправность импланта	Реимплантация
Гнойное воспаление среднего уха на стороне импланта (хронический гнойный средний отит, мастоидит)	Санация полостей среднего уха, тимпанопластика. Если имплант сохранить нельзя — эксплантация с сохранением электродной решётки в улитке и одномоментная имплантация на другом ухе при отсутствии противопоказаний
Экструзия корпуса импланта	Эксплантация с сохранением электродной решётки в улитке и одномоментная имплантация на другом ухе при отсутствии противопоказаний
Миграция корпуса импланта, при которой нельзя пользоваться речевым процессором, или экстракохлеарное положение электродной решётки	В таблице КР не заполнено

Реимплантацию выполняют системой того же производителя; систему другой фирмы можно поставить только за внебюджетные средства, что указывают в информированном согласии.

Если имплант вышел из строя в гарантийный срок, производитель по заявлению медицинской организации в течение 10 суток даёт первичное заключение и в течение 30 суток после него предоставляет новый имплант. Окончательно неисправность устанавливают технической экспертизой извлечённого импланта, которая длится не больше трёх месяцев.

4.7 Физиотерапия и другие методы

Пациентам с тугоухостью и шумом в ушах проводят электростимуляцию.

Используют постоянный импульсный ток прямоугольной формы и флюктуирующие токи силой 0,5–2 мА; частоту подбирают по частоте шума. Процедура 10–15 минут, курс 10–15 процедур. Противопоказана пользователям кохлеарного, стволомозгового импланта и импланта среднего уха.

Проводят курс гипербарической оксигенации: 10–20 процедур при давлении 1,5–2,5 атм по 1–2 часа.

Начинать лучше в первый месяц от начала болезни; результат лучше в сочетании с глюкокортикоидами.

В курс лечения включают рефлексотерапию.

Она эффективна как дополнительное лечение, в том числе на поздней стадии; электропунктура эффективнее классической иглорефлексотерапии. Импульсы 1 мс переменной полярности частотой 61 Гц, амплитуда — до лёгкого покалывания, по 10 минут на пару точек; курс 10–15 процедур ежедневно или через день.

Проводят электронейростимуляцию головного мозга.

Лучше всего она помогает при начальной и лёгкой степени тугоухости, в том числе в виде аудиоселективной транскраниальной электростимуляции: ток до 1,0 мА, по 20 минут, 15 процедур через день. Противопоказана пользователям имплантов.

В курс лечения включают дозированные физические нагрузки.

Это баланстерапия и дыхательная гимнастика курсами 3 месяца, 3 раза в неделю по 40 минут, а также ежедневный терренкур не меньше 20 минут.

Проводят транскраниальную магнитную стимуляцию, в том числе при шуме в ушах на фоне тугоухости.

Ритмически стимулируют височно-теменные, лобные и префронтальные области коры. Противопоказана пользователям имплантов.

Применяют лекарственный ультрафонофорез и внутриушной электрофорез лекарственных препаратов.

В слуховой проход вливают 1,5–2,0 мл лекарства, нагретого до 36–37 °C. Процедура 5–15 минут при частоте 880 кГц, мощности до 0,2 Вт/см² и гальваническом токе до 0,3 мА; курс 10–12 процедур. Противопоказана пользователям имплантов.

В курс лечения включают медицинский массаж.

Делают лечебный массаж шеи и воротниковой зоны — классический, точечный или вакуумный — ежедневно, курсом до 10 процедур.

В комплексной терапии применяют лазеротерапию.

Внутривенное лазерное облучение крови сочетают с введением трентала: длина волны 630 нм, мощность 1,0–2,0 мВт, 25–30 минут, 5–7 процедур ежедневно. При эндауральной методике длина волны 808–810 нм, плотность потока 8–15 мВт/см², 8–10 минут, 12–14 процедур ежедневно.

В курс лечения включают слуховой тренинг в виртуальной реальности.

Он показан как дополнительный метод при хронической тугоухости лёгкой степени и скрытой потере слуха: ежедневно 7 дней по 15 минут с одной паузой в 2 минуты.

Проводят вестибулярные тренировки, в том числе в виртуальной реальности.

Тренируют равновесие ежедневно или через день по 30 минут, курс 20 процедур.

Для улучшения слуха, в том числе после кохлеарной имплантации, используют мобильные приложения с шумоподавлением в реальном времени.

Методы из пунктов 4–15 раздела реабилитации обычно применяют во время санаторно-курортного лечения, после консультации врача.

4.8 Санаторно-курортное лечение

Санаторно-курортное лечение проводят в хронической стадии тугоухости, врождённой или приобретённой; в таблице КР перечислены все степени — от I до глухоты.

Код	Заболевание
H90.3	Нейросенсорная потеря слуха двусторонняя
H90.4	Нейросенсорная потеря слуха односторонняя с нормальным слухом на противоположном ухе
H90.5	Нейросенсорная потеря слуха неуточнённая

Подходят бальнеологические курорты с углекислыми, радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми и йодобромными водами, а также климатические — приморские, лесные, равнинные, низко- и среднегорные — и грязевые.

Если ни слуховые аппараты, ни кохлеарные импланты не помогают, нужен другой способ общения: обучение дактилю и жестовому языку, сурдоперевод.

5. Наблюдение, профилактика, госпитализация

Пациентов с хронической тугоухостью диспансерно наблюдает сурдолог-оториноларинголог в сурдологическом кабинете или центре по месту жительства, оценивая эффективность лечения и состояние пациента.

Эффективность слуховых аппаратов оценивают речевой аудиометрией в свободном звуковом поле в тишине и в шуме и анкетированием о качестве жизни. Тональную аудиометрию, речевую аудиометрию в тишине и в шуме и коррекцию настроек слухового аппарата по их результатам проводят 1–2 раза в год.
При остром ухудшении или быстром прогрессировании тугоухости исследование повторяют незамедлительно, чтобы успеть провести лечение и восстановить пороги.
После кохлеарной имплантации речевую аудиометрию в свободном поле в тишине и в шуме проводят после подключения процессора и на каждой настроечной сессии, 2–4 раза в год, плюс анкетирование. Тональную и речевую аудиометрию повторяют 1–2 раза в год, речевой процессор настраивают 2–4 раза в год.

Для оценки слуховых аппаратов КР приводит опросник «Международная оценка использования слуховых аппаратов» из 7 вопросов. Если во всех вопросах выбраны ответы 1 и 2, нужно скорректировать настройки, повторно обследовать слух и направить пациента на слухоречевую реабилитацию; если везде вариант 3 — нужно вмешаться в настройки; при вариантах 4 и 5 настройки менять не нужно.

При односторонней тугоухости нужна дополнительная дифференциальная диагностика, а при вестибулярных нарушениях и ушном шуме — дополнительные диагностические, лечебные и реабилитационные меры.

По показаниям пациента направляют на медико-социальную экспертизу для решения вопроса о стойкой нетрудоспособности. Вместе с группой инвалидности составляют индивидуальную программу реабилитации с выбранным способом коррекции слуха: традиционным или имплантационным слухопротезированием либо кохлеарной имплантацией.

5.1 Госпитализация

Показания к госпитализации — острая сенсоневральная тугоухость и замена речевого процессора системы кохлеарной имплантации (в круглосуточном или дневном стационаре).

Выписывают при выздоровлении или улучшении.

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Нейросенсорная тугоухость у взрослых»
Версия	3-я, опубликована в рубрикаторе 22.03.2023 (год утверждения в PDF не заполнен: «20__»)
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По правилу из приложения А2 КР — не реже одного раза в три года; следующая версия ожидалась не позднее марта 2026 года, но на 22.10.2026 в рубрикаторе действует эта
Код в рубрикаторе	518_3 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Пациенты	Взрослые

6.1 Неточности в самом тексте КР

- Пороги для кохлеарной имплантации не согласованы с классификацией: IV степень — 71–90 дБ, а показания говорят об «IV степени с порогами 80 дБ и более» и о среднем пороге «более 95 дБ» (по классификации это глухота).

- В разделе 3.1 пациента с острой тугоухостью направляют «в стационар или дневной стационар», а в следующей рекомендации — на экстренную госпитализацию.
- В рекомендации о слуховых аппаратах речевые частоты указаны как «500, 1000, 2000 и 4000 кГц» — должно быть «Гц».
- В таблице реимплантации у строки «Миграция корпуса внутренней части кохлеарного импланта…» не заполнена графа «Методы лечения».
- Одна и та же рекомендация об охранительном слуховом режиме имеет при острой тугоухости УДД 5, а при хронической — УДД 4.
- МРТ головного мозга рекомендована дважды, отдельными рекомендациями с разным объёмом (во второй — вместе с рентгенографией шейного отдела позвоночника).
- В схеме #дексаметазона на 7-й день препарат не вводят, а на 8-й снова дают 4 мг; так в тексте КР.
- Год утверждения на титульном листе не заполнен («20__»); PDF — скан с распознанным текстом, в нём много ошибок распознавания (например, «8181» вместо SISI, «1рз1 и соШга» вместо ipsi и contra).

Клинические рекомендации

Носовое кровотечение

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**R04.0** — Носовое кровотечение
Пациенты	взрослые, дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 08.12.2025, пересмотр не позднее 2028 года
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/977_1

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 22.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

1. Главное

- При кровотечении из передних отделов носа сначала плотно прижимают крылья носа к перегородке на 5 минут и дольше.
- Если кровотечение не угрожает жизни, сначала его останавливают местно — прижатием, сосудосуживающим средством, коагуляцией или тампонадой, — и только потом корректируют свёртываемость или отменяют антикоагулянты.
- Если кровотечение продолжается, а источник не виден, ставят переднюю тампонаду.
- Всем пациентам измеряют артериальное давление: это помогает выявить гипертензию и оценить кровопотерю.
- Госпитализируют, если первичные меры не помогли, кровопотеря большая или кровотечение интенсивное, есть признаки гиповолемии, тяжёлая сопутствующая патология или высокий риск рецидива, а также всегда при переливании крови, задней тампонаде, перевязке сосудов и эмболизации.

2. Клиника и классификация

2.1 Определение

Носовое кровотечение — кровотечение из повреждённых сосудов полости носа, околоносовых пазух или носоглотки, а также из сосудов полости черепа при повреждении верхней стенки полости носа.

2.2 Причины

Кровотечения бывают посттравматическими, в том числе после операций, и спонтанными. Спонтанное кровотечение — симптом местной или общей болезни.

Сосуды слизистой носа страдают при её атрофии, специфическом воспалении (туберкулёз, сифилис), опухолях носа и пазух, сосудистых мальформациях и гранулематозе с полиангиитом.

У детей кровотечение чаще всего вызвано повреждением слизистой (инородное тело, травма, в том числе ятрогенная), острыми инфекциями верхних дыхательных путей и опухолями.

У детей до двух лет носовое кровотечение бывает очень редко, примерно у одного из 10 000. Если оно случилось в этом возрасте, нужно исключить болезни крови и врождённую патологию, например гемангиому полости носа и носоглотки.

2.3 Классификация

По механизму кровотечение бывает вызвано изменениями сосудов носа, нарушением свёртывания крови или сочетанием причин. По источнику — из передних или задних отделов полости носа, из околоносовых пазух, носоглотки или внутричерепных сосудов.

2.4 Клиническая картина

При переднем кровотечении кровь в основном течёт наружу, при заднем — стекает в носоглотку.

Пациенты жалуются на кровянистые выделения из носа, часто на стекание крови по задней стенке глотки и недомогание. Если кровь заглатывалась, бывают дискомфорт в животе, тошнота и чёрный стул.

2.5 Общие симптомы и объём кровопотери

Шок	Признаки	Кровопотеря
Не выражен	Признаков нет	до 10% объёма крови (до 500 мл)
Лёгкий	Пульс до 100, систолическое давление выше 100 мм рт. ст., холодные конечности, нормальный диурез	15–20% (750–1250 мл)
Средний	Пульс до 120, систолическое давление 90–100 мм рт. ст., сниженное пульсовое давление, беспокойство, потливость, бледность, диурез меньше 50 мл в час	25–35% (1250–1750 мл)
Тяжёлый	Пульс больше 120, систолическое давление ниже 60 мм рт. ст. или не определяется, ступор, резкая бледность, холодные конечности, сухие язык и кожа, анурия	больше 35% (больше 1750 мл)

2.6 Анамнез

Уточняют, когда началось кровотечение, сколько длится и как часто повторяется, с какой стороны были прошлые кровотечения, были ли из-за них госпитализации и переливания крови. Расспрашивают о приёме антиагрегантов, антикоагулянтов и других препаратов, о гипертензии, коагулопатиях, анемии, кровотечениях у родственников, травмах и операциях на носу и пазухах.

Носовое кровотечение может быть первым признаком коагулопатии, наследственной телеангиэктазии, опухоли носа или носоглотки, болезни печени или почек, особенно если оно повторяется. Синяки и петехии без причины и кровотечения из внутренних органов в анамнезе говорят в пользу системного нарушения свёртывания.

Кровотечение на фоне антикоагулянтов (варфарин, гепарин, дабигатран, апиксабан и другие) или антиагрегантов (ацетилсалициловая кислота, клопидогрел) может потребовать отмены или снижения дозы. У таких пациентов кровотечения чаще повторяются и чаще бывают больше 250 мл, требуя переливания крови. Риск повышают также многие спреи для носа, в том числе сосудосуживающие и гормональные, и некоторые наркотические вещества.

---

3. Диагностика

Диагноз ставят, когда кровянистые выделения из носа подтверждены при риноскопии и фарингоскопии.

3.1 Осмотр

Каждого пациента осматривает оториноларинголог: оценивает состояние, ищет источник кровотечения и выбирает тактику.

Если госпитализация нужна, выбирают стационар с дежурным оториноларингологом. Если во время кровотечения ЛОР-врач пациента не осмотрел, в том числе потому, что кровотечение остановилось само, пациента направляют к нему планово.

Оценивают пульс, сознание, кожу и слизистые, чтобы не пропустить гиповолемию. Обморок, тахикардия, тахипноэ и бледность говорят о гемодинамических нарушениях из-за кровопотери. Кровоизлияния на коже и слизистых без травмы могут указывать на системное нарушение свёртывания.

При повторных кровотечениях из обеих половин носа или если они бывают у родственников, ищут телеангиэктазии на слизистой носа и рта, чтобы не пропустить наследственную геморрагическую телеангиэктазию (болезнь Рандю — Ослера — Вебера).

Всем пациентам измеряют артериальное давление, чтобы выявить гипертензию и оценить гиповолемию: гипотония может говорить о значительной кровопотере.

Если источник не виден при передней риноскопии, проводят эндоскопию полости носа и носоглотки.

Повторяющееся кровотечение с одной стороны может быть первым признаком опухоли, которую не видно при передней риноскопии, а у детей — инородного тела.

3.2 Анализы

Общий анализ крови назначают, чтобы оценить постгеморрагическую анемию и тромбоциты; для оценки кровопотери определяют гемоглобин и гематокрит.

3.3 Степень кровопотери у взрослого

Степень	Объём кровопотери	Гемоглобин, г/л	Гематокрит, %
I	до 500 мл	больше 120	больше 40
II	500–1000 мл	100–120	30–40
III	1000–1500 мл	80–100	20–30
IV	больше 1500 мл	меньше 80	меньше 20

При повторяющихся кровотечениях и при кровотечении, требующем госпитализации, исследуют гемостаз: МНО, фибриноген, АЧТВ и протромбиновое время. МНО особенно важно у пациентов на варфарине: значение выше 4,5 прогностически неблагоприятно.

При приёме прямых пероральных антикоагулянтов (дабигатран, ривароксабан и др.) эти показатели могут не отражать степень гипокоагуляции.

3.4 Консультации

Если есть гипертензия, анемия, коагулопатия или другие сопутствующие болезни, влияющие на кровотечение, пациента консультирует терапевт или педиатр.

При повторяющихся кровотечениях с признаками тромбоцитопатии или коагулопатии в анализах пациента консультирует гематолог.

---

4. Лечение

Цель — остановить кровотечение, устранить факторы риска и скорректировать последствия кровопотери, включая гиповолемию и анемию.

Если кровотечение не угрожает жизни, сначала его останавливают местно: прижатием крыльев носа, сосудосуживающим средством, коагуляцией или тампонадой. Только после этого корректируют свёртываемость или отменяют антикоагулянты и антиагреганты, потому что системная коррекция опасна, прежде всего тромбоэмболиями.

4.1 Остановка кровотечения

При кровотечении из передних отделов носа сначала плотно прижимают крылья носа к перегородке на 5 минут и дольше, обычно на 5–15 минут. Перед этим пациент сморкается, чтобы удалить сгустки; сидит или стоит, слегка наклонив голову вперёд. Это может сделать и сам пациент. Если кровь продолжает стекать, источник, скорее всего, находится глубже, и нужны другие методы.

Если кровотечение продолжается, а источник найден, взрослым на него накладывают турунду с сосудосуживающим средством, а взрослым и детям можно приложить гемостатик.

Однократно применяют #ксилометазолин или #эпинефрин на турунде; #оксиметазолин в спрее — по 2 впрыскивания в каждую ноздрю 3 раза в день 3–5 дней (знак # означает применение вне инструкции). Сосудосуживающие препараты осторожно применяют при гипертензии, ИБС и ишемии мозга.

На турунде можно однократно приложить к источнику #транексамовую кислоту (взрослым: 5 мл на кусочек ваты или марли на 10–30 минут) или этамзилат (взрослым и детям).

Если кровотечение продолжается, а источник найти не удаётся, ставят переднюю тампонаду.

Рассасывающиеся материалы, например коллагеновая гемостатическая губка, не нужно удалять, и это их преимущество: при удалении тампона кровотечение может возобновиться. Поэтому при высоком риске повторного кровотечения, например при наследственной телеангиэктазии или болезнях крови, по возможности используют их.
У детей источник обычно спереди, поэтому, если ребёнок позволяет, лучше обойтись без тампона; если он не готов к манипуляциям, предпочтительна передняя тампонада.

Если кровотечение из задних отделов не останавливается передней тампонадой, ставят переднюю и заднюю тампонаду с тампоном в области хоан и носоглотки.

Пациента с задним тампоном наблюдают и лечат в стационаре. Нитка или фиксатор не должны сильно давить на крыло носа, иначе образуется пролежень. Некоторые авторы назначают при задней тампонаде системные антибиотики.

Если кровотечение продолжается и источник найден, кровоточащий сосуд коагулируют.

Коагулировать можно химически (нитратом серебра), электрокоагулятором, лазером или радиоволной. Если перед этим приложить сосудосуживающее средство, коагуляция эффективнее.

Если коагуляция и тампонада не помогают, рассматривают эмболизацию сосудов или перевязку артерии.

В редких случаях перевязывают наружную сонную артерию на стороне кровотечения. Эмболизация эффективна до 87% случаев, но осложняется чаще, чем перевязка; её можно делать под седацией и при стоящих тампонах.

При повторяющихся кровотечениях из зоны Киссельбаха отслаивают слизистую перегородки носа.

Операцию не делают при субатрофии слизистой и выраженном искривлении перегородки.

4.2 Лекарства

При повышенном давлении назначают антигипертензивные препараты: так уменьшаются кровопотеря и риск рецидива.

Если первичные меры недостаточны, назначают гемостатики: транексамовую кислоту (внутривенно с 1 года, в таблетках с 3 лет), аминокапроновую кислоту, аминометилбензойную кислоту, этамзилат — в дозах по инструкции. При продолжающемся кровотечении лучше вводить внутривенно, таблетки подходят для профилактики рецидивов.

Этамзилат системно оправдан только при диапедезном кровотечении из мелких сосудов слизистой.

При травматическом кровотечении или риске тяжёлого кровотечения пациентам старше года как можно раньше, лучше в первые 3 часа после травмы, вводят транексамовую кислоту внутривенно.

Пациентов с коагулопатиями и переливание крови по возможности ведут вместе с гематологом, терапевтом или педиатром.

Детям с геморрагическим синдромом при дефиците витамина K вводят менадиона натрия бисульфит: новорождённым — до 4 мг в сутки, от месяца до года — 2–5 мг в сутки. Можно вводить и профилактически, не дожидаясь подтверждения дефицита.

После кровотечения или его остановки назначают увлажняющие и заживляющие средства для слизистой носа.

Они уменьшают сухость и корки, чтобы пациент не чистил нос сам; показаны и при субатрофическом рините.

5. Профилактика и госпитализация

Пациентам объясняют факторы риска повторного кровотечения, как останавливать его самому и когда обращаться к врачу.

Объясняют, что нельзя ковырять в носу, особенно детям, родителям и пожилым; пожилым — что риск связан с лекарствами и подъёмом давления. Слизистую сушат кислородные канюли и аппараты для дыхания под давлением. Пациентам на варфарине обязателен контроль МНО. Если кровотечения повторяются на фоне спреев для носа, дозу уменьшают и учат правильно ими пользоваться.

Если кровотечение связано с повышением давления, пациента консультирует терапевт, педиатр или кардиолог, чтобы подобрать антигипертензивную терапию.

5.1 Госпитализация

Нужна ли госпитализация после передней тампонады, решают по длительности кровотечения, объёму кровопотери, признакам гиповолемии, сопутствующим болезням, типу тампона и доступности амбулаторной помощи. При активном кровотечении или нестабильной гемодинамике пациента обследуют и лечат в приёмном или ЛОР-отделении.

При кровотечении на фоне гипертонической болезни ЛОР-врач останавливает кровотечение в приёмном отделении, затем пациента госпитализируют в терапевтический стационар, чтобы нормализовать давление.

При небольшом или уже остановившемся кровотечении пациента можно обследовать амбулаторно.

Госпитализируют, если первичные меры не помогли, кровопотеря значительная или кровотечение интенсивное, есть признаки гиповолемии, тяжёлая сопутствующая патология или высокий риск рецидива. Всегда госпитализируют при переливании крови, задней тампонаде, перевязке сосудов и эмболизации, а также после передней тампонады нерассасывающимся материалом, если удалить тампоны амбулаторно нельзя.

Значительной считается кровопотеря больше 10% объёма крови (около 500 мл у взрослого), интенсивным — кровотечение больше 1 мл/кг в минуту. Риск тяжёлого кровотечения повышают госпитализации из-за кровотечений в анамнезе, особенно с переливанием крови, и больше трёх эпизодов за последние 3 месяца.

Выписывают, когда кровотечение стойко остановлено, признаков гиповолемии нет, гемодинамика нормальная, а сопутствующие болезни компенсированы.

Исход во многом определяют скорость и объём кровопотери: массивная кровопотеря больше 40% объёма крови может быть несовместима с жизнью.

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Носовое кровотечение»
Версия	1-я, опубликована в рубрикаторе 08.12.2025
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее декабря 2028 года
Код в рубрикаторе	977_1 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов

6.1 Неточности в самом тексте КР

- У рекомендации о гемостатической терапии уровень доказательств записан как «уровень доказательств – 4» вместо принятого «уровень достоверности доказательств».
- В оглавлении PDF вместо номеров страниц нескольких разделов стоит «Ошибка! Закладка не определена».

Клинические рекомендации

Острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) у взрослых

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**B34.0** — Аденовирусная инфекция неуточненная **B34.2** — Коронавирусная инфекция неуточненная **B34.9** — Вирусная инфекция неуточненная **B97.0** — Аденовирусы как причина болезней, классифицированных в других рубриках **B97.4** — Респираторно-синцитиальный вирус как причина болезней, классифицированных в других рубриках **J00** — Острый назофарингит (насморк) **J01** — Острый синусит **J02** — Острый фарингит **J03** — Острый тонзиллит [ангина] **J04** — Острый ларингит и трахеит **J05** — Острый обструктивный ларингит [круп] и эпиглоттит **J06** — Острые инфекции верхних дыхательных путей множественной и неуточненной локализации **J20** — Острый бронхит **J21** — Острый бронхиолит **J22** — Острая респираторная инфекция нижних дыхательных путей неуточненная
Пациенты	взрослые
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 04.08.2025, пересмотр не позднее 2028 года
Разработчик	Общероссийская общественная организация "Российское научное медицинское общество терапевтов"; Национальная ассоциация специалистов по инфекционным болезням имени академика В. И. Покровского (НАСИБ)
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/724_2

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 22.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

1. Главное

- При неосложнённой ОРВИ антибиотики не назначают в первые 10–14 дней, даже если есть ринит, конъюнктивит, затемнение пазух на рентгенограмме, ларингит, круп или бронхит.
- Если носовое дыхание затруднено дольше 3–5 дней и есть подозрение на бактериальный синусит, делают рентгенографию или КТ пазух, чтобы вовремя направить пациента к оториноларингологу. Это осложнение бывает в 0,5–2% случаев, а изменения в пазухах не всегда означают бактериальное воспаление.
- Противовирусные препараты назначают не позднее 48 часов от начала болезни: в первой линии — препараты прямого действия, во второй — иммунотропные.
- При выраженной заложенности носа при рините и риносинусите назначают местные деконгестанты: они облегчают носовое дыхание и восстанавливают проходимость слуховой трубы.
- При бактериальном риносинусите препарат выбора — амоксициллин по 500–1000 мг 3 раза в сутки 7–10 дней.
- Срочно госпитализируют при частоте дыхания больше 24 в минуту, сатурации ниже 95% и очаговых изменениях на рентгенограмме грудной клетки.

2. Клиника и классификация

2.1 Определение

Острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) — группа вирусных болезней, которые передаются воздушно-капельным путём и поражают преимущественно верхние, реже нижние дыхательные пути.

Грипп A и B и новая коронавирусная инфекция (SARS-CoV-2) описаны в отдельных рекомендациях и здесь не рассматриваются.

2.2 Возбудители

Чаще всего ОРВИ вызывают респираторно-синцитиальный вирус (РСВ) A и B, респираторный энтеровирус, риновирус, аденовирус, метапневмовирус человека, вирусы парагриппа 1–4 типов и сезонные коронавирусы. В основном это РНК-содержащие вирусы. Их объединяют общие механизмы и пути передачи, стадии развития болезни и клинические проявления.

2.3 Возбудители и ведущие синдромы

Возбудитель	Основные синдромы
Вирусы парагриппа	Ларингит, ринофарингит, ложный круп
Респираторно-синцитиальный вирус	Бронхит, бронхиолит
Аденовирусы	Фарингит, тонзиллит, бронхит
Риновирусы	Ринит, фарингит
Коронавирусы человека	Ринофарингит, бронхит
Коронавирус ТОРС (тяжёлого острого респираторного синдрома)	Бронхит, бронхиолит, респираторный дистресс-синдром

2.4 Классификация

По течению ОРВИ бывает типичной (манифестной) и атипичной (бессимптомной, стёртой). По тяжести различают лёгкую, среднюю, тяжёлую и очень тяжёлую степень. По характеру течения — неосложнённую и осложнённую: со специфическими осложнениями, с осложнениями от вторичной микрофлоры или с обострением хронических болезней. По длительности — острую (5–10 дней), подострую (11–30 дней) и затяжную (больше 30 дней).

2.5 Критерии тяжести

Форма	Признаки
Лёгкая	Температура 37–37,5 °C или нормальная, умеренные катаральные явления, болезнь длится 4–6 дней
Среднетяжёлая	Температура 38–39 °C, выраженные катаральные явления; без осложнений выздоровление наступает через 6–10 дней
Тяжёлая	Температура 39–41 °C; на фоне слабых или резко выраженных катаральных симптомов развиваются угрожающие жизни осложнения

2.6 Клиническая картина

Инкубационный период — от 1 до 14 суток, у самых распространённых вирусов — 1–5 дней. Болезнь обычно начинается постепенно с умеренной интоксикации: температура поднимается до субфебрильной или фебрильной, появляются слабость, головная боль, боли в мышцах и суставах. Одновременно развивается катаральный синдром — першение в горле, кашель, насморк, иногда конъюнктивит. Возможно увеличение лимфоузлов, реже — печени (при аденовирусной инфекции).

2.7 Синдромы поражения дыхательных путей

Синдром	Признаки
Острый ринит	Воспаление слизистой полости носа: чихание, выделения из носа (ринорея), нарушение носового дыхания. Слизь, стекающая по задней стенке глотки, вызывает кашель.
Фарингит	Воспаление слизистой и лимфоидной ткани глотки: внезапное першение и сухость в горле, боль при глотании.
Тонзиллит	Изменения нёбных миндалин — и вирусные, и как обострение бактериальной (стрептококковой) инфекции. Характерны интоксикация, гиперемия и отёк миндалин, дужек, язычка и задней стенки глотки, рыхлые налёты в лакунах.
Ларингит	Воспаление гортани с вовлечением голосовых складок и подскладкового пространства. Первые симптомы — сухой «лающий» кашель и осиплость.
Трахеит	Воспаление слизистой трахеи: саднение и боль за грудиной, сухой надсадный кашель.
Бронхит	Надсадный кашель с небольшим количеством слизистой мокроты, удлинённый выдох, рассеянные сухие хрипы, в тяжёлых случаях одышка. Кашель держится 2 недели и дольше (до месяца). На второй неделе мокрота может стать желтовато-зеленоватой из-за фибрина и присоединения бактерий.

2.8 Осложнения

Осложнения бывают специфическими и вызванными вторичной микрофлорой. Специфические — менингизм, острая дыхательная недостаточность, энцефалопатия, инфекционно-токсический шок, респираторный дистресс-синдром взрослых, острая сердечно-сосудистая недостаточность, миокардит, тромбоэмболия.

Вторичная бактериальная микрофлора вызывает острый синусит, острый отит, острый бронхит, обострение хронических бронхолёгочных болезней и пневмонию.

2.9 Жалобы и анамнез

У всех пациентов уточняют недомогание, температуру, утомляемость и слабость, снижение аппетита, головную боль, боль в горле, затруднение носового дыхания, насморк, осиплость, сухой или влажный кашель, увеличение лимфоузлов, боль в животе, одышку, затруднённый вдох, рвоту, судороги и потерю сознания.

Выясняют, сколько длится болезнь, и есть ли причины, которые мешают сразу начать лечение или требуют его изменить из-за сопутствующих болезней.

Это непереносимость лекарств, неадекватное психоэмоциональное состояние, угрожающее жизни острое состояние или обострение хронической болезни, требующее участия профильного специалиста, и отказ от лечения.

Уточняют эпидемиологический анамнез: контакт с больным ОРВИ в пределах инкубационного периода, сезонный подъём заболеваемости, вспышки в организованных коллективах, а также была ли прививка от гриппа.

Выявляют факторы риска тяжёлого и осложнённого течения: хронические болезни лёгких и сердца, нарушения обмена веществ, хроническую болезнь почек, болезни печени, неврологические состояния, гемоглобинопатии, иммунодефициты (ВИЧ-инфекция, приём иммуносупрессоров), злокачественные опухоли, возраст старше 65 лет и беременность.

---

3. Диагностика

Диагноз ставят по жалобам, анамнезу, осмотру, лабораторным и инструментальным исследованиям. Задача — определить нозологию и клиническую форму, тяжесть, осложнения и показания к лечению.

3.1 Осмотр

Осмотр начинают с кожи и видимых слизистых: цвет (гиперемия, бледность, цианоз), влажность, отёчность, инъекция сосудов склер, конъюнктивит. Оценивают носовое дыхание и признаки ринита, осматривают ротоглотку: гиперемию дужек и задней стенки, миндалины, рыхлость и зернистость задней стенки, слизистый налёт, увеличение лимфоидных фолликулов.

Катаральные симптомы обязательно ищут уже на первом этапе, но они бывают и при некоторых бактериальных инфекциях, в частности при стрептококковом или менингококковом назофарингите.

Всем осматривают и пальпируют лимфоузлы головы и шеи, оценивая увеличение и болезненность.

Всем проводят пальпацию, перкуссию и аускультацию лёгких: оценивают частоту дыхания, дыхательные шумы, хрипы и крепитацию, которая появляется при пневмонии.

Измеряют пульс и артериальное давление, выслушивают сердце, чтобы оценить тяжесть, выявить тахикардию, шумы, осложнения и сопутствующие болезни.

3.2 Анализы

Всем делают общий анализ крови с лейкоцитарной формулой, чтобы оценить тяжесть, вовремя заметить осложнения и исключить бактериальные осложнения.

Для вирусной инфекции характерны лейкопения или нормальное число лейкоцитов, лимфоцитоз и моноцитоз.

Всем делают общий анализ мочи, чтобы выявить нарушение функции почек, декомпенсацию сопутствующих болезней, исключить инфекцию мочевых путей и нефропатию. При неосложнённой ОРВИ изменений нет; при выраженной лихорадке возможны преходящие повышение плотности мочи, небольшие лейкоцитурия, протеинурия и цилиндрурия.

При среднетяжёлом и тяжёлом течении делают биохимический анализ крови (АЛТ, АСТ, амилаза, мочевина) и исследуют электролиты.

Для своевременного назначения противовирусного лечения возбудитель определяют экспресс-методами.

Это иммунохроматографический тест на антигены вирусов гриппа A и B, РСВ, аденовируса и SARS-CoV-2 в мазке из носоглотки у пациентов, обратившихся не позднее 2 суток от начала симптомов.

Для определения возбудителя мазки из носоглотки и ротоглотки исследуют методами амплификации нуклеиновых кислот (ПЦР, LAMP и другими) на вирусы ОРВИ, гриппа и SARS-CoV-2.

Это самый эффективный метод: нуклеиновые кислоты вирусов находят в среднем до 7 дней, максимум до 2 недель от начала болезни, если сохраняются признаки поражения верхних дыхательных путей. Результат готов через 4–6 часов.

Пациентов с тонзиллитом и пневмонией обследуют по клиническим рекомендациям для этих болезней.

3.3 Инструментальные исследования

Для ранней диагностики дыхательной недостаточности измеряют сатурацию крови кислородом (SpO2) пульсоксиметром. Это простой и надёжный способ найти пациентов с гипоксемией, которым нужна респираторная поддержка.

При бронхите, который длится больше 3–5 дней, и при физикальных признаках поражения лёгких делают рентгенографию грудной клетки или КТ лёгких, чтобы исключить или подтвердить пневмонию.

Если носовое дыхание затруднено больше 3–5 дней и есть подозрение на синусит из-за присоединения бактериальной флоры, делают рентгенографию или КТ околоносовых пазух, чтобы вовремя направить пациента к оториноларингологу.

Такое осложнение бывает в 0,5–2% случаев ОРВИ у взрослых. Изменения в пазухах не всегда означают их бактериальное поражение.

При среднетяжёлом и тяжёлом течении, особенно у пожилых, регистрируют ЭКГ, чтобы оценить работу сердца и выявить нарушения ритма на фоне интоксикации.

3.4 Консультации

При подозрении на осложнения пациента консультируют смежные специалисты: оториноларинголог — при синусите и отите, невролог — при энцефалопатии, пульмонолог — при признаках пневмонии, гематолог — при выраженных изменениях крови и геморрагическом синдроме, кардиолог — при миокардите и острой сердечно-сосудистой недостаточности, акушер-гинеколог — при беременности.

При быстро нарастающей острой дыхательной недостаточности (частота дыхания больше 25 в минуту, SpO2 ниже 92%) или другой органной недостаточности (2 балла и больше по шкале SOFA) пациента консультирует анестезиолог-реаниматолог для перевода в отделение реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ).

3.5 Алгоритм на амбулаторном приёме

Если при осмотре есть катаральные явления, делают общий анализ крови и обследуют лёгкие. Без изменений в лёгких лечат амбулаторно; если на фоне лечения сохраняется лихорадка, повторяют анализ крови и при изменениях направляют к инфекционисту. При изменениях в лёгких делают рентгенографию; если признаков пневмонии нет, делают рентгенографию пазух и при изменениях в них направляют к оториноларингологу.

3.6 Дифференциальная диагностика

ОРВИ отличают от острых респираторных заболеваний бактериальной природы, в том числе вирусную пневмонию от бактериальной.

3.7 Отличия основных ОРВИ

Инфекция	Начало и течение	Температура и интоксикация	Нос и глотка	Кашель и другое
Парагрипп	Инкубация 2–7 дней, чаще 3–4; начало постепенное, течение подострое	37–38 °C, может долго держаться; интоксикация слабая или умеренная, 1–3 дня	Катаральные явления с первого дня, осиплость; заложенность носа; слабая или умеренная гиперемия зева, мягкого нёба и задней стенки глотки	Сухой лающий кашель, иногда до 12–21 дня; ведущий синдром — ларингит, ложный круп
РС-инфекция	Инкубация 3–6 дней; начало постепенное, течение подострое, иногда затяжное	Субфебрильная, иногда нормальная; интоксикация умеренная или слабая, 2–7 дней	Катаральные явления нарастают постепенно; заложенность носа, необильные серозные выделения; слабая гиперемия слизистых	Сухой приступообразный кашель до 3 недель с болью за грудиной; бронхит, бронхиолит, возможен бронхоспазм
Аденовирусная инфекция	Инкубация 4–14 дней; начало постепенное, течение затяжное, волнообразное	Фебрильная или субфебрильная; интоксикация умеренная, 8–10 дней	Сильно выраженные катаральные явления; обильные слизисто-серозные выделения, резкое затруднение носового дыхания; умеренная гиперемия и гиперплазия фолликулов задней стенки глотки	Влажный кашель; ринофаринго-конъюнктивит, тонзиллит, конъюнктивит, кератит; может быть полиаденит, увеличение печени и селезёнки, экзантема, диарея

4. Лечение

Задачи лечения — подавить размножение вируса в ранние сроки, не дать болезни прогрессировать, добиться полного выздоровления и предупредить осложнения.

Хирургическое лечение не проводится.

4.1 Базисная терапия

Всем пациентам при любой тяжести назначают базисную терапию: постельный режим, диету и обильное питьё. В рацион включают легкоусвояемые продукты, богатые витаминами; алкоголь в любом виде запрещён.

Всем пациентам без поражения лёгких проводят дезинтоксикацию. При лёгкой и средней тяжести амбулаторно пациент выпивает 2–3 литра жидкости в сутки. При средней тяжести в стационаре пьют и (или) получают инфузии 800–2000 мл растворов, влияющих на водно-электролитный баланс. При осложнённом и тяжёлом течении дезинтоксикацию проводят внутривенно с коррекцией электролитов.

При среднетяжёлом и тяжёлом течении и при поражении лёгких для купирования интоксикации назначают меглюмина натрия сукцинат внутривенно капельно со скоростью 1–4,5 мл/мин, в среднем 10 мл/кг в сутки, курсом до 11 дней.

4.2 Противовирусные препараты

Противовирусные препараты назначают не позднее 48 часов от начала болезни. Первая линия — препараты прямого противовирусного действия, вторая — иммунотропные препараты с опосредованным действием: интерфероны, другие иммуностимуляторы и общетонизирующие средства.

Препарат выбирают в зависимости от возбудителя. Раннее назначение предупреждает тяжёлое течение и осложнения, а нужен ли противовирусный препарат конкретному пациенту, врач решает индивидуально.

Препарат	Доза	УУР, УДД
Риамиловир (первая линия)	250 мг 3 раза в день 5 дней; начать не позднее 2-го дня болезни	C, 1
Умифеновир (первая линия)	200 мг 4 раза в сутки (каждые 6 часов) 5 суток. Противопоказан в I триместре беременности	C, 2
Энисамия йодид (первая линия)	500 мг 3 раза в сутки внутрь 5–7 дней. Противопоказан при беременности и кормлении грудью, тяжёлых поражениях печени и почек, непереносимости лактозы и фруктозы	C, 2
Имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты (вторая линия)	90 мг 1 раз в день 5–7 дней, желательно начать в первые 2 суток. Противопоказан при беременности и лактации	C, 5
Меглюмина акридонацетат (вторая линия)	По 4 таблетки однократно на 1, 2, 4, 6 и 8-е сутки (всего 20 таблеток). Противопоказан при беременности и лактации	B, 1
Оксиэтиламмония метилфеноксиацетат (вторая линия)	В первый день 200 мг 3 раза, следующие 7 дней по 200 мг 1 раз в сутки (на курс 2000 мг)	C, 5

Препарат	Доза	УУР, УДД
Азоксимера бромид (вторая линия)	Таблетки — по 1 под язык 2 раза в день 7 дней. Раствор — 6 мг в сутки парентерально 3 дня, затем через день, всего 10 инъекций, или интраназально либо под язык по 6 мг в сутки в 2–3 приёма. Свечи — 12 мг 1 раз в сутки, 10 свечей	C, 5
Тилорон (вторая линия)	125 мг в сутки первые 2 дня, затем по 125 мг через 48 часов, на курс 750 мг (6 таблеток)	C, 5
Антитела к гамма-интерферону, гистамину и CD4 (Эргоферон)	В 1-й день 8 таблеток: по 1 каждые 30 минут первые 2 часа, затем ещё 3 раза; со 2-го дня по 1 таблетке 3 раза в день до выздоровления	C, 2
Антитела к гамма-интерферону, CD4 и молекулам MHC (Рафамин)	Та же схема 1-го дня, затем по 1 таблетке 3 раза в день; всего 5 дней, с 18 лет	B, 2

Можно использовать интраназальные интерфероны: они действуют опосредованно и применяются в комплексной терапии с первых признаков болезни. В КР отмечено, что они не входят в перечень препаратов международных клинических рекомендаций.

Интерферон альфа-2b — по 3 капли (дозы) в каждый носовой ход 5–6 раз в день, 3000 МЕ на приём, 15 000–18 000 МЕ в сутки, 5 дней.

Интерферон гамма человеческий рекомбинантный — по 2 капли в каждый носовой ход после туалета носа 5 раз в день 5–7 дней.

Пациентам с неосложнённой ОРВИ, а также с частыми, тяжёлыми или затяжными респираторными инфекциями в анамнезе в комплексное лечение включают лизаты бактерий для стимуляции иммунитета. Их принимают с первых дней болезни по 1 капсуле утром натощак за 30 минут до еды, пока не исчезнут симптомы, но не меньше 10 дней.

4.3 Жаропонижающие

При температуре выше 38 °C и болях в мышцах и суставах назначают нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП). Препараты выбора — парацетамол по 500–1000 мг каждые 4–6 часов при необходимости, не больше 4000 мг в сутки, и ибупрофен по 400 мг 3 раза в сутки, не больше 1200 мг в сутки. Можно использовать комбинации ибупрофена с парацетамолом и парацетамола с фенилэфрином и фенирамином.

НПВП применяют только для снижения температуры и обезболивания, длительные курсы нецелесообразны. Они могут помешать врачу оценить, действует ли лечение.

4.4 Нос

Физиологический раствор натрия хлорида вводят в нос 2–3 раза в день: он разжижает секрет, удаляет слизь и восстанавливает работу мерцательного эпителия.

При выраженном затруднении носового дыхания в комплексном лечении ринита и риносинусита применяют местные деконгестанты, чтобы уменьшить заложенность носа и восстановить проходимость слуховой трубы.

Препарат	Доза в каждый носовой ход
Ксилометазолин	1–2 капли (1 впрыскивание) 3 раза в день
Нафазолин	1–3 капли 0,05–0,1% раствора 3–4 раза в сутки

Препарат	Доза в каждый носовой ход
Ипратропия бромид + ксилометазолин	Фиксированная комбинация при обильной ринорее; доза в КР не указана
Оксиметазолин	0,05% раствор, 1–2 капли или 1–2 впрыскивания 2 раза в сутки

При назофарингите и неосложнённом риносинусите с заложенностью носа, ринореей и стеканием слизи по задней стенке глотки с первого дня назначают комбинированный растительный препарат из корня горечавки, цветков первоцвета, травы щавеля, цветков бузины и травы вербены. Он улучшает работу мукоцилиарного аппарата и отток экссудата, ускоряет выздоровление и помогает предупредить осложнения.

Сухой экстракт — 160 мг (1 таблетка) 3 раза в день, измельчённое сырьё — 156 мг (2 таблетки) 3 раза в день, капли — по 50 капель 3 раза в день; курс 7–14 дней.

Беременным при насморке, назофарингите и остром риносинусите препарат можно назначить после консультации врача, в таблетках, а если их нельзя принимать — в каплях.

4.5 Горло

Для уменьшения воспаления и боли и профилактики вторичной инфекции слизистой ротоглотки назначают препараты для лечения заболеваний горла и антисептики в полосканиях, инсуффляциях, ингаляциях, таблетках и пастилках для рассасывания.

Используют грамицидин С с цетилпиридинием (в том числе с оксибупрокаином), бензидамин или флурбипрофен с цетилпиридинием, гексэтидин, лизоцим с пиридоксином, хлоргексидин, бензилдиметил-миристоиламино-пропиламмоний, биклотимол и препараты йода.

При фарингите и тонзиллите (боль в горле в покое и при глотании, гиперемия слизистой и миндалин, их увеличение) назначают растительный антисептик из корня алтея, цветков ромашки, травы тысячелистника, коры дуба, листьев грецкого ореха, травы хвоща и травы одуванчика. Он уменьшает боль и воспаление и помогает предупредить осложнения и новые эпизоды ОРВИ.

Таблетки — по 2 (96 мг) 5–6 раз в день, капли — по 25 капель 5–6 раз в день, пока не пройдёт боль в горле, затем ещё неделю 3 раза в день. Препарат можно назначать беременным и пациентам с соматическими болезнями после консультации врача.

4.6 Кашель

При сухом непродуктивном надсадном кашле, который сильно ухудшает качество жизни (боль, нарушение сна), назначают противокашлевые средства: бутамират, леводропропизин, антитела к брадикинину, морфину и гистамину или декстрометорфан в составе комбинированных препаратов.

Бутамират в сиропе — по 15 мл 4 раза в сутки. Леводропропизин — 60 мг 1–3 раза в сутки с промежутками не меньше 6 часов. Антитела к брадикинину, морфину и гистамину — по 1–2 таблетки или 5–10 мл раствора 3 раза в сутки, в первые 3 дня до 4–6 раз.

При остром вирусном бронхите и трахеите с влажным кашлем и бронхообструкцией назначают муколитики и отхаркивающие средства, но не в комбинации с противокашлевыми. Муколитики, в том числе растительные, применяют только при продуктивном кашле.

Ацетилцистеин — 600 мг в сутки до 5–7 дней; амброксол — 90 мг в сутки, в капсулах пролонгированного действия 75 мг в сутки, до 14 дней. Растительные комбинации экстрактов тимьяна с плющом или первоцветом принимают 10–14 дней.

Отхаркивающие и противокашлевые средства одновременно не назначают: подавление кашлевого рефлекса может вызвать застой мокроты.

При остром вирусном бронхите с влажным кашлем для отхождения вязкой мокроты проводят ингаляции через небулайзер гипертонического раствора натрия хлорида (3% или 7%) с гиалуронатом натрия по 5 мл 2 раза в день.

При бронхообструктивном синдроме из-за бронхоспазма назначают комбинацию ипратропия бромида с фенотеролом: в дозированном ингаляторе по 1–2 вдоха до 3–4 раз в сутки или через небулайзер по 1–2 мл до 3–4 раз в сутки.

При продуктивном кашле, особенно с признаками бронхиальной обструкции, взрослым можно назначить амброксол с гвайфенезином и левосальбутамолом по 10 мл 3 раза в день 2 недели.

4.7 Антибиотики

Антибиотики не назначают при неосложнённой ОРВИ в первые 10–14 дней, в том числе при рините, конъюнктивите, затемнении пазух на рентгенограмме, ларингите, крупе, бронхите и бронхообструктивном синдроме.

Антибиотики назначают при вероятной сопутствующей бактериальной инфекции, если не помогают патогенетическое, симптоматическое и противовирусное лечение, и при бактериальных осложнениях среднетяжёлой и тяжёлой ОРВИ — бронхите, пневмонии и других.

4.8 Антибиотики при бактериальном риносинусите

Препарат	Доза
Амоксициллин	500–1000 мг 3 раза в сутки внутрь, 7–10 дней
Амоксициллин и клавулановая кислота	500/125 мг 3 раза в сутки или 875/125 мг 2 раза в сутки внутрь, 7–10 дней
Азитромицин	500 мг 1 раз в сутки внутрь, 3 дня
Кларитромицин	500 мг 1 раз в сутки, 7–10 дней (кратность — как в КР)
Левофлоксацин	500 мг внутрь до 5–7 дней — при устойчивой флоре, неэффективности других антибиотиков, экзантеме или лекарственной аллергии на другие антибиотики

> В КР есть расхождение в сроках. Антибиотики не рекомендуют до 10–14 дней даже при затемнении пазух на рентгенограмме. Но рентгенографию пазух при подозрении на бактериальный синусит советуют делать уже после 3–5 дней заложенности, а в разделе об организации помощи сохранение высокой температуры больше 3 дней названо клиническим признаком вторичной бактериальной инфекции.

Пневмонию в этих рекомендациях не рассматривают: её лечат по клиническим рекомендациям по внебольничной пневмонии у взрослых.

4.9 Тяжёлое течение

При тяжёлой ОРВИ с инфекционно-токсическим шоком или отёком мозга назначают системные глюкокортикоиды; такого пациента лечат в ОРИТ по рекомендациям для неотложных состояний.

При поражении лёгких с дыхательной недостаточностью (SpO2 ниже 92%) дают кислород через носовые канюли, лицевую маску или аппарат высокопоточной оксигенации. Начинают с потока 5–7 л/мин, при необходимости увеличивают до 10 л/мин, чтобы SpO2 была выше 90%.

4.10 Другие препараты

Для защиты слизистой пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки на фоне приёма лекарств, в том числе НПВП, назначают омепразол 20 мг 1 раз в день.

Пробиотики назначают пациентам с болезнями желудочно-кишечного тракта, функциональными расстройствами пищеварения, кожными болезнями, а также при приёме антибиотиков дольше 7 дней сейчас или в предыдущие 1–2 месяца. Их дают в ранние сроки болезни вместе с другими препаратами.

4.11 Реабилитация

Реабилитацию начинают в период ранней реконвалесценции.

При вирусной и поствирусной астении назначают общетонизирующие препараты — оксиэтиламмония метилфеноксиацетат: в первый день 600 мг, следующие 7 дней по 200 мг, всего 2000 мг за 8 дней.

Восстановление проводят комплексно, с участием разных специалистов, последовательно и преемственно на всех этапах, с учётом резервов пациента и постоянным контролем результата. Физическую и умственную нагрузку увеличивают постепенно.

---

5. Наблюдение, профилактика, госпитализация

5.1 Госпитализация

Прежде чем выбрать тактику, определяют, неосложнённое или осложнённое течение у пациента.

Лёгкую и среднетяжёлую ОРВИ лечат амбулаторно. Если лечение не помогает или его нельзя провести дома, решают вопрос о госпитализации.

Госпитализируют пациентов с тяжёлым, среднетяжёлым и осложнённым течением, из групп риска, а также по эпидемическим показаниям, в том числе с лёгким течением, если пациент живёт в общежитии или в неблагоприятных условиях.

> В КР противоречие о среднетяжёлом течении: одна рекомендация раздела 6 предписывает лечить таких пациентов амбулаторно, следующая — госпитализировать.

Срочно госпитализируют при частоте дыхания больше 24 в минуту, SpO2 ниже 95% и очаговых изменениях на рентгенограмме грудной клетки.

В ОРИТ переводят при быстро нарастающей острой дыхательной недостаточности (частота дыхания больше 30 в минуту, SpO2 ниже 90%, систолическое давление ниже 90 мм рт. ст.) и другой органной недостаточности, например острой почечной.

> Пороги для ОРИТ в КР разные: в разделе 2.5 анестезиолога-реаниматолога зовут при частоте дыхания больше 25 в минуту и SpO2 ниже 92%, в разделе 6 переводят в ОРИТ при частоте дыхания больше 30 и SpO2 ниже 90%.

Схему ведения срочно пересматривают, если болезнь прогрессирует. Это признаки нехватки кислорода и сердечно-лёгочной недостаточности (одышка, цианоз, кровянистая мокрота, боль в груди, гипотония, низкая сатурация), поражения нервной системы (нарушение сознания, сонливость, судороги, сильная слабость, параличи), вторичной бактериальной инфекции (в том числе высокая температура и другие симптомы дольше 3 дней) и тяжёлого обезвоживания.

Выписывают при стойком улучшении, нормальной температуре, после стихания респираторно-катарального синдрома и при нормальном общем анализе крови.

К группам риска тяжёлого течения относятся беременные и родильницы, пациенты с хроническими болезнями лёгких, сердца и сосудов, сахарным диабетом и ожирением 2–3 степени, хронической болезнью почек, болезнями печени, некоторыми неврологическими состояниями, гемоглобинопатиями, иммунодефицитами, злокачественными опухолями, а также люди 65 лет и старше.

5.2 Наблюдение после болезни

При осложнениях пациента наблюдает терапевт, после аденовирусной инфекции — инфекционист в кабинете инфекционных заболеваний поликлиники.

Месяц после выписки прививки не делают, кроме анатоксина столбнячного и вакцины против бешенства по показаниям.

После болезни ограничивают пребывание на солнце на срок от 2 недель до месяца в зависимости от тяжести.

5.3 Профилактика

Вакцин против ОРВИ нет.

Среди контактных выявляют заболевших. Больного изолируют дома, при необходимости — в отдельном боксе стационара, до клинического выздоровления, в среднем на 1–2 недели; после этого он может вернуться к работе. Карантин для контактных не вводят.

При работе с больными ОРВИ носят маску и меняют её каждые 3–4 часа.

Обеззараживают посуду, воздух и поверхности, проводят влажную уборку и проветривают помещения.

После контакта с больным ОРВИ проводят химиопрофилактику. Экстренную профилактику в очаге продолжают 2 дня, если контакт прекратился, и 5–7 дней, если он сохраняется. Плановую сезонную профилактику проводят перед эпидемией людям с высоким риском заражения и неблагоприятного исхода.

Препарат	Доза для профилактики	УУР, УДД
Умифеновир	После контакта — 200 мг в сутки 10–14 дней; сезонно — 200 мг 2 раза в неделю 3 недели	B, 3
Оксодигидроакридинилацетат натрия	250 мг (1 ампула) или 4–6 мг/кг на введение; при длительном применении — с интервалом 3–7 суток	C, 4
Интерферон альфа-2b	По 3 капли в каждый носовой ход 2 раза в сутки 5–7 дней; при однократном контакте достаточно одного закапывания	B, 3
Интерферон гамма человеческий рекомбинантный	По 2–3 капли в каждый носовой ход за 30 минут до завтрака 10 дней	B, 3
Меглюмина акридонацетат	После контакта не позже 3 дней назад — 600 мг (4 таблетки) в сутки на 1, 2, 4, 6 и 8-е сутки	C, 5
Оксиэтиламмония метилфеноксиацетат	200 мг в сутки после еды 14 дней	C, 5
Азоксимера бромид	1 таблетка в день 10 дней, или 6 мг в сутки интраназально или под язык, или свечи 12 мг 1 раз в сутки, 10 свечей	C, 5
Тилорон	125 мг 1 раз в неделю 6 недель	C, 5
Антитела к гамма-интерферону (Анаферон)	1 таблетка в день 1–3 месяца в период подъёма заболеваемости	B, 2

Лизаты бактерий назначают для профилактики повторных респираторных инфекций и вторичной бактериальной инфекции независимо от сезона людям, живущим в неблагоприятных экологических условиях, и пациентам с хроническими болезнями дыхательных путей и глотки — хроническим бронхитом, ХОБЛ, бронхиальной астмой, хроническим риносинуситом, хроническим тонзиллитом. Их принимают тремя курсами по 10 дней с перерывами по 20 дней.

Взрослым перед эпидемическим сезоном и во время него длительно, от 6 месяцев до года, назначают #колекальциферол: без ожирения — 2000 МЕ в сутки или 10 000 МЕ в неделю, при ожирении — 3000–6000 МЕ в сутки (знак # означает применение вне инструкции).

Пациенту объясняют, что нужно срочно обратиться к врачу при высокой температуре, одышке, стойкой головной боли, повторной рвоте без облегчения и резком падении давления.

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) у взрослых»
Версия	2-я, опубликована в рубрикаторе 04.08.2025
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее августа 2028 года
Код в рубрикаторе	724_2 · открыть текст КР ↗
Разработчики	Российское научное медицинское общество терапевтов; Национальная ассоциация специалистов по инфекционным болезням имени академика В. И. Покровского
Пациенты	Взрослые

6.1 Неточности в самом тексте КР

- Среднетяжёлую ОРВИ раздел 6 в одной рекомендации предписывает лечить амбулаторно, а в следующей — госпитализировать.
- Пороги для реанимации расходятся: в разделе 2.5 — частота дыхания больше 25 в минуту и SpO2 ниже 92%, в разделе 6 — больше 30 в минуту и ниже 90%.
- Антибиотики не рекомендуют до 10–14 дней даже при затемнении пазух, но рентгенографию пазух при подозрении на бактериальный синусит советуют уже после 3–5 дней заложенности, а температуру дольше 3 дней раздел 6 считает признаком вторичной бактериальной инфекции.
- В алгоритме (приложение Б) рентгенография пазух стоит только на ветке с изменениями в лёгких без пневмонии, а в разделе 2.4 её назначают по длительности затруднения носового дыхания.
- КР написаны для взрослых, но рекомендация против антибиотиков говорит о «взрослой и детской практике».
- Кларитромицин при риносинусите указан в дозе 500 мг 1 раз в сутки; у оксиметазолина в одной фразе смешаны капли и впрыскивания; у бромгексина доза записана неразборчиво («по 8 мг 3 (1–2 таблетки) 3–4 раза в сутки»).
- В разделе 2.2 уровень доказательств записан как «уровень доказательности» и «уровень доказательства»; у рекомендации о пульсоксиметрии уровни стоят после комментария.
- Критерии качества требуют коагулограмму, маркёры воспаления и антибиотики при «остром бактериальном тонзиллите», хотя в тексте рекомендаций этого нет.
- В таблице приложения А3.4 у парагриппа в строке ведущего синдрома стоит оборванная фраза «выявляют крайне».

Клинические рекомендации

Острый ларингит

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**J04.0** — Острый ларингит **J04.2** — Острый ларинготрахеит
Пациенты	взрослые, дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 01.11.2024, пересмотр не позднее 2027 года
Разработчик	Союз педиатров России; Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/309_2

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 22.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

1. Главное

- Ларингоскопия обязательна каждому пациенту. С 12 лет гортань осматривают зеркалом; если у маленького ребёнка это не удаётся, проводят видеофиброринофаринголарингоскопию.
- При неосложнённом ларингите на фоне вирусной инфекции антибиотики не назначают, пока симптомы держатся меньше 10 дней.
- При дисфонии назначают полный голосовой покой на 1–2 суток, затем ограничение голосовой нагрузки; пациент отказывается от острой, солёной, горячей и холодной пищи, алкоголя и курения.
- Флегмонозный, абсцедирующий и инфильтративный ларингит и хондроперихондрит гортани — показание к срочной госпитализации в стационар, где есть отделение интенсивной терапии и можно интубировать трахею.
- Ларингит без стеноза гортани на фоне ОРВИ госпитализации не требует; экстренно госпитализируют при дыхательной недостаточности выше I степени.

2. Клиника и классификация

2.1 Определение

Острый ларингит (ОЛ) — острое воспаление слизистой оболочки гортани длительностью до 3 недель. Если болезнь длится дольше 3 недель, нужно исключать её аутоиммунную природу.

Абсцедирующий, или флегмонозный, ларингит — острый ларингит с образованием абсцесса, чаще на язычной поверхности надгортанника или на черпалонадгортанных складках. Он проявляется резкой болью при глотании и разговоре, отдающей в ухо, повышением температуры и плотным инфильтратом в тканях гортани. Острый хондроперихондрит гортани — острое воспаление хрящей гортани, при котором процесс захватывает надхрящницу и окружающие ткани.

Острый подскладочный ларингит (круп) — воспаление в подголосовом пространстве с отёком слизистой под голосовыми складками, затруднением дыхания и одышкой. Он встречается у детей от 6 месяцев до 6 лет.

2.2 Причины

Обычно острый ларингит — часть острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ): гриппа, парагриппа, аденовирусной инфекции, при которых воспалены также слизистая носа и глотки, а иногда и бронхи и лёгкие. Воспаление гортани может быть и продолжением катарального воспаления носа или глотки.

Основные возбудители бактериального ларингита — S. pneumoniae (20–43%) и H. influenzae (22–35%); довольно часто высевают Moraxella catarrhalis (2–10%), разные стрептококки и стафилококки, значительно реже — Neisseria, Corynebacterium и других.

Кроме инфекции, ларингит вызывают наружная и внутренняя травма шеи и гортани, в том числе ингаляционная, инородное тело, аллергия, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь и большая голосовая нагрузка. Предрасполагают к нему хронические болезни бронхов и лёгких, носа и околоносовых пазух, сахарный диабет, гипотиреоз, болезни желудочно-кишечного тракта, хроническая почечная недостаточность, нарушение разделительной функции гортани, алкоголь, курение и перенесённая лучевая терапия.

2.3 Классификация

По форме различают катаральный, отёчный, флегмонозный (инфильтративно-гнойный, в том числе инфильтративный и абсцедирующий) и острый подскладочный ларингит. По возбудителю ларингит бывает вирусным, бактериальным, грибковым и специфическим.

2.4 Клиническая картина

Основные симптомы — нарушение голоса от лёгкой дисфонии до афонии, острая боль в горле и кашель; может затрудняться дыхание и ухудшаться самочувствие. Болезнь начинается внезапно, при удовлетворительном состоянии или небольшом недомогании. При катаральном ларингите температура нормальная или субфебрильная; фебрильная температура обычно говорит о том, что воспалились нижние дыхательные пути или катаральный процесс перешёл во флегмонозный.

При инфильтративной и абсцедирующей формах сильно болит горло, трудно глотать даже жидкость, усиливается слюноотделение, голова в вынужденном положении, выражена интоксикация, нарастают признаки стеноза гортани. Чем тяжелее воспаление, тем ярче симптомы; общее состояние становится тяжёлым. Без адекватного лечения возможны флегмона шеи, медиастинит, сепсис, абсцедирующая пневмония и стеноз гортани.

Картина острого стеноза гортани одинакова при любой причине и зависит от степени сужения: дыхание становится шумным, меняется его ритм, при вдохе западают надключичные ямки и втягиваются межрёберные промежутки, пациент запрокидывает голову, гортань опускается на вдохе и поднимается на выдохе.

При неполной обструкции появляется стридор. Если преобладает отёк, дыхание свистящее, если гиперсекреция — хриплое и клокочущее. В терминальной стадии стеноза дыхание становится всё тише, потому что уменьшается дыхательный объём.

При абсцессе надгортанника на фоне острой боли сначала становится невозможно глотать, а затем, по мере прогрессирования, затрудняется дыхание. Голосовая щель может закрыться очень быстро, и тогда нужны экстренные меры для спасения жизни.

---

3. Диагностика

Диагноз ставят по анамнезу, жалобам, осмотру и ларингоскопии. Обычно болезнь начинается внезапно на фоне небольшого недомогания, пациента беспокоят изменение голоса, боль при глотании, кашель, повышенная температура. При тяжёлых формах ухудшается общее состояние, глотать больно даже жидкость, температура фебрильная, усилено слюноотделение, нарушено дыхание; шея и гортань болезненны при пальпации, подвижность хрящей гортани нарушена, голова и шея в вынужденном положении.

3.1 Осмотр

Пациента с подозрением на острый ларингит осматривает оториноларинголог, врач общей практики (семейный врач) или педиатр, чтобы поставить и уточнить диагноз.

При осмотре обязательно ищут признаки дыхательной недостаточности; главный из них — одышка. При I степени одышка возникает при физической нагрузке, при II — при малой нагрузке (неспешная ходьба, умывание, одевание), при III — в покое.

3.2 Стадии стеноза гортани

Стадия	Признаки
Компенсация	В покое одышки нет, при ходьбе появляется; просвет гортани сужен на треть.

Стадия	Признаки
Субкомпенсация	Инспираторная одышка при нагрузке с участием вспомогательных мышц, втяжение межрёберных промежутков, яремной и надключичных ямок, стридор, бледность кожи; давление нормальное или повышенное; просвет сужен наполовину и больше.
Декомпенсация	Дыхание поверхностное и частое, резкий стридор, вынужденное положение сидя, максимальные экскурсии гортани, бледно-синюшное лицо, потливость, акроцианоз, частый нитевидный пульс, давление снижено; просвет гортани щелевидный.
Асфиксия	Дыхание прерывистое или прекращается, голосовая щель резко сужена, сердечная деятельность угнетена, пульс частый, нитевидный, часто не прощупывается, кожа бледно-серая; потеря сознания, экзофтальм, непроизвольные мочеиспускание и дефекация, остановка сердца.

Если стеноз нарастает быстро, состояние тяжелее, потому что компенсаторные механизмы не успевают развиться. Это учитывают, решая вопрос об экстренной операции.

3.3 Ларингоскопия

Всем пациентам с острым ларингитом проводят ларингоскопию, чтобы осмотреть гортань.

Непрямая ларингоскопия гортанным зеркалом обязательна при осмотре пациентов 12 лет и старше оториноларингологом и в поликлинике, и в стационаре. У дошкольников и младших школьников в поликлинике она часто невозможна из-за эмоциональной лабильности и сильного глоточного рефлекса; тогда проводят видеофиброринофаринголарингоскопию.

При ларингоскопии определяют характер процесса, его локализацию, уровень, протяжённость и степень сужения дыхательных путей. Для острого ларингита типичны гиперемия и отёк слизистой гортани с усиленным сосудистым рисунком; голосовые складки розовые или ярко-красные, утолщены, голосовая щель при фонации овальная или линейная, со скоплением мокроты. Процесс может захватывать подскладковый отдел; при подскладковом ларингите видно валикообразное утолщение слизистой под голосовыми складками.

При катаральной форме изменения видны в основном на голосовых складках, в межчерпаловидном или подскладковом пространстве: расширенные поверхностные сосуды и слизистый или слизисто-гнойный секрет, усиливающий охриплость. При отёчной форме гиперемирована и отёчна вся слизистая гортани, голосовые складки смыкаются не полностью. При ларингите на фоне гриппа или ОРВИ бывают кровоизлияния в слизистую — от петехий до небольших гематом (геморрагический ларингит).

Белый или беловато-жёлтый фибринозный налёт означает переход в более тяжёлую, фибринозную форму, а серый или бурый налёт может быть признаком дифтерии. Если налёт у взрослого не связан с интубационной травмой, его нужно срочно дифференцировать с системными заболеваниями и туберкулёзом.

При инфильтративном ларингите поражённый отдел гортани значительно инфильтрирован, гиперемирован, увеличен и малоподвижен, часто видны фибринозные налёты, а там, где формируется абсцесс, просвечивает гной. При тяжёлой форме и хондроперихондрите гортань болезненна при пальпации, хрящи малоподвижны, кожа над гортанью может быть инфильтрирована и гиперемирована на фоне боли и общей гнойной инфекции. Абсцесс надгортанника выглядит как шаровидное образование на его язычной поверхности с просвечивающим гноем; он сопровождается сильной болью и нарушением глотания.

3.4 Анализы

Пациентам с острым ларингитом делают развёрнутый общий анализ крови, чтобы оценить общее состояние и выявить воспалительную реакцию — лейкоцитоз и повышение скорости оседания эритроцитов (СОЭ).

При флегмонозном ларингите всех пациентов при госпитализации комплексно обследуют клинически и лабораторно.

Гнойное отделяемое отправляют на посев на аэробные и факультативно анаэробные микроорганизмы с определением возбудителя и его чувствительности к антибиотикам и другим препаратам, чтобы выбрать адекватное лечение.

При поступлении в стационар проводят стандартное лабораторное обследование.

3.5 Другие исследования

Детям младшего и дошкольного возраста проводят пульсоксиметрию, чтобы оценить степень дыхательной недостаточности и решить, нужен ли кислород.

По показаниям и для дифференциальной диагностики проводят компьютерную томографию (КТ) гортани с внутривенным болюсным контрастированием.

КТ имеет смысл в стационаре, если подозревают гнойные осложнения или трудно отличить ларингит от других болезней гортани. Если у ребёнка с признаками стеноза КТ сделать нельзя, в сомнительных случаях делают рентгенографию шеи в прямой и боковой проекциях.

---

4. Лечение

Лечение выбирают по форме и тяжести воспаления.

4.1 Режим

Всем пациентам с острым ларингитом при любой дисфонии ограничивают голосовую нагрузку — не кричать и не шептать не менее 2 дней — и назначают лечебно-охранительный режим.

При дисфонии рекомендуют полный голосовой покой на 1–2 суток, затем ограничение любой голосовой нагрузки. Пациент отказывается от острой, солёной, горячей и холодной пищи, спиртного и курения.

> Сроки голосового покоя в КР расходятся: в рекомендации — не кричать и не шептать «не менее 2-х дней», в комментарии к ней — полный голосовой покой «на 1–2 суток».

При катаральном ларингите на фоне ОРВИ пить больше обычного не рекомендуется.

Польза обильного питья сомнительна, а повышенная во время болезни секреция антидиуретического гормона, напротив, задерживает жидкость.

4.2 Жаропонижающие и противокашлевые

Взрослым и детям с фебрильной лихорадкой назначают противовоспалительные и жаропонижающие препараты.

Детям с температурой выше 39–39,5 °C, кроме лекарств, применяют физическое охлаждение: ребёнка раскрывают и обтирают водой температуры 25–30 °C.

Препарат	Доза
Парацетамол	До 60 мг/кг в сутки. Детям — 10–15 мг/кг каждые 6 часов, не больше 60 мг/кг в сутки.
Ибупрофен	До 30 мг/кг в сутки. Детям — 7,5 мг/кг каждые 6–8 часов, не больше 30 мг/кг в сутки.

Детям с острым ларингитом и ларинготрахеитом противокашлевые и отхаркивающие препараты рутинно не назначают; исключение — мучительный кашель.

Прежде чем подавлять кашель, убеждаются, что нет состояний, при которых это опасно и которые требуют своего лечения, например бронхиальной обструкции, а у детей — ещё и острого обструктивного ларингита (крупа).

4.3 Местное лечение

Чтобы уменьшить воспаление слизистой гортани, назначают местную противовоспалительную терапию — вливания лекарств в гортань и ингаляции.

Для вливаний в гортань чаще всего используют антисептики из групп производных хинолина и четвертичных аммониевых соединений. Раствор подогревают до температуры тела и вливают по каплям, до 2 мл. Детям вливания в гортань не делают из-за угрозы ларингоспазма.

Применяют ингаляции через небулайзер аэрозолями средней и низкой дисперсности.

Ингаляция обычно длится 10 минут, между ингаляциями разных препаратов делают перерыв около 30 минут. Если в гортани есть корки, начинают с муколитика.

Препарат	Доза
Ацетилцистеин (раствор для инъекций и ингаляций)	Ингаляционно по 1 ампуле (3 мл) 1–2 раза в день, 5–7 дней.
#Будесонид	Ингаляционно 1000 мкг 1–2 раза в день, курс 5–8 процедур.

Можно использовать готовые аптечные смеси на основе растительных препаратов, с учётом противопоказаний и возраста — масло листьев эвкалипта прутовидного, а также 5–10% отвары цветков ромашки, листьев шалфея, травы тимьяна ползучего (чабреца), цветков календулы, листьев подорожника. Такие ингаляции бывают тёплыми и холодными; первая длится 1–2 минуты, следующие — 5–10 минут.

4.4 Антибиотики

При неосложнённом ларингите на фоне вирусной инфекции, если симптомы держатся меньше 10 дней, антибиотики не назначают.

Системные антибиотики назначают, если при неосложнённом течении симптомы сохраняются 10 дней, и при осложнённом течении.

Взрослым антибиотик целесообразен при затяжном ларингите — 10 дней и дольше, а также при выраженной инфильтрации голосовых складок и экссудации.
Взрослым антибиотик подбирают эмпирически и дают в таблетках: амоксициллин 500–1000 мг 3 раза в сутки 5–10 дней; амоксициллин с клавулановой кислотой 875/125 мг 2 раза в сутки 5–10 дней; цефиксим 400 мг 1 раз в сутки 5–10 дней; цефдиторен 400 мг 1 раз в сутки 10 дней; кларитромицин 250–500 мг 2 раза в сутки 6 дней; джозамицин 1000 мг 2 раза в сутки 5–10 дней.

4.5 Антибиотики у взрослых

Препарат	Когда	Доза внутрь
Амоксициллин	Препарат выбора	500 мг 3 раза в сутки; при факторах риска устойчивости пневмококка — 1000 мг 3 раза в сутки.
Амоксициллин + клавулановая кислота	Альтернатива; при факторах риска бета-лактамаз	500/125 мг 3 раза в сутки или 875/125 мг 2 раза в сутки.
Цефиксим	Альтернатива	400 мг 1 раз в сутки.
Цефдиторен	Альтернатива	400 мг; кратность в таблице зачёркнута, в тексте — 1 раз в сутки.
Кларитромицин	Аллергия на бета-лактамы	250–500 мг 2 раза в сутки.
Джозамицин	Аллергия на бета-лактамы	1000 мг 2 раза в сутки.

Факторы риска устойчивости пневмококка к бета-лактамам — антибиотики в предшествующие 3 месяца, дети дошкольного возраста в семье, посещающие детские учреждения, проживание в «закрытых» учреждениях. Амоксициллин с клавулановой кислотой выбирают при риске возбудителя, продуцирующего бета-лактамазы (H. influenzae, S. aureus, M. catarrhalis): при бронхиальной астме, сахарном диабете, хроническом бронхите, иммуносупрессии, в возрасте старше 65 лет и при неудаче предшествующего лечения амоксициллином.

> В тексте КР цефдиторен назначают 400 мг 1 раз в сутки 10 дней, а в таблице 1 кратность у него зачёркнута целиком («2 раза в сутки 1 раз в сутки»). У джозамицина в тексте стоит код АТХ J01FA09 — тот же, что у кларитромицина, — а в таблице J01FA07.

4.6 Антибиотики у детей

В тексте КР детям предлагают амоксициллин 40–60 или 80–90 мг/кг в сутки 5–7 дней; амоксициллин с клавулановой кислотой до 3 месяцев — 30 мг/кг в сутки в 2 приёма, с 3 месяцев — 25 мг/кг в сутки в 2 приёма или 20 мг/кг в сутки в 3 приёма, 5–10 дней; цефиксим в суспензии 8 мг/кг в сутки в 1–2 приёма 5–10 дней; цефтриаксон с 15 дней до 12 лет 20–80 мг/кг 1 раз в сутки, а при массе больше 50 кг — взрослые дозы; кларитромицин 7,5–15 мг/кг в сутки в 2 приёма не больше 14 дней; джозамицин 50 мг/кг в сутки в 2–3 приёма 5–10 дней; тиамфеникола глицинат ацетилцистеинат внутримышечно 10 дней.

Препарат	Когда	Доза
Амоксициллин	Препарат выбора	Внутрь 40–60 мг/кг в сутки; при факторах риска устойчивости пневмококка — 80–90 мг/кг в сутки.
Амоксициллин + клавулановая кислота	Альтернатива	Внутрь, суспензия 4:1 (125 мг + 31,25 мг в 5 мл или 250 мг + 62 мг в 5 мл) в 3 приёма каждые 8 часов; доза «45–60 мг/кг/сутки в 2–3 приёма» в таблице зачёркнута.
Цефиксим	Альтернатива	8 мг/кг в сутки 1 раз в сутки.
Цефтриаксон	Альтернатива	С 15 дней до 12 лет — 20–80 мг/кг 1 раз в сутки; при массе больше 50 кг — дозы для взрослых.
Кларитромицин	Аллергия на бета-лактамы	Внутрь 7,5 мг/кг в сутки в 2 приёма, не больше 1000 мг в сутки.
Джозамицин	Аллергия на бета-лактамы	50 мг/кг в сутки в 2–3 приёма.
Тиамфеникола глицинат ацетилцистеинат	Если нельзя ни бета-лактамы, ни макролиды	До 2 лет — по 125 мг 2 раза в сутки; 3–6 лет — по 250 мг 2 раза в сутки; 7–12 лет — по 250 мг 3 раза в сутки; взрослым — по 500 мг 2–3 раза в сутки; 10 дней.

> Детские дозы в тексте и в таблице 2 не совпадают. Кларитромицин в тексте — «для детей старше 12 лет разовая доза» 7,5–15 мг/кг/сут, в таблице — 7,5 мг/кг/сут в 2 приёма. Амоксициллин с клавулановой кислотой в тексте — 20–30 мг/кг/сут, в таблице доза 45–60 мг/кг/сут зачёркнута и указана только суспензия в 3 приёма. Цефиксим в тексте — в 1–2 приёма, в таблице — 1 раз в сутки. Для тиамфеникола возрастные группы «до 2 лет» и «от 3 до 6 лет» оставляют без дозы детей от 2 до 3 лет.

4.7 Лечение в стационаре

В стационаре антибиотики взрослым и детям назначают эмпирически с учётом региональной резистентности основных возбудителей. Когда состояние улучшится, можно перейти на приём антибиотика внутрь (ступенчатая терапия).

Препарат	Детям	Взрослым (осложнённый флегмонозный ларингит)
Амоксициллин + клавулановая кислота	С 3 месяцев внутривенно 25/5 мг/кг каждые 6–8 часов, 5–10 дней	Внутривенно 1,2 г 3 раза в сутки, 7–10 дней
Цефотаксим	Внутримышечно или внутривенно 150 мг/кг в сутки в 4 введения	Внутривенно 2 г 3 раза в сутки, 7–10 дней
Цефтриаксон	С 15 дней до 12 лет внутримышечно или внутривенно 20–80 мг/кг 1 раз в сутки, 5–10 дней	Внутримышечно или внутривенно 2 г 1 раз в сутки, 7–10 дней
Цефепим	При тяжёлом флегмонозном ларингите и осложнениях в отделении реанимации: больше 40 кг — 2 г каждые 12 часов, до 40 кг — 50 мг/кг каждые 12 часов, 7–10 дней	—
Меропенем	Там же: от 3 месяцев до 12 лет — 10–20 мг/кг 3 раза в сутки, больше 50 кг — доза для взрослых, 5–10 дней	—
Тиамфеникола глицинат ацетилцистеинат	До 2 лет — 125 мг 2 раза в сутки, 3–6 лет — 250 мг 2 раза, 7–12 лет — 250 мг 3 раза в сутки	500 мг 2–3 раза в сутки, 10 дней

При абсцедирующем и флегмонозном ларингите всем пациентам промывают полость абсцесса антисептиками — 0,01% раствором бензилдиметил[3-(миристоиламино)пропил]аммония хлорида моногидрата или гидроксиметилхиноксалиндиоксидом.

Всем пациентам с дисфагией при тяжёлых формах ларингита проводят дезинтоксикационную терапию, корректируют гиповолемию, назначают глюкокортикостероиды и парентеральное питание.

Чтобы предупредить стеноз гортани, проводят консервативную противовоспалительную терапию; для дестенозирующей терапии вводят глюкокортикоиды парентерально.

> В комментарии о дестенозирующей терапии фраза оборвана: указана доза «60–120 мг», но не названо, какого именно глюкокортикоида, и не сказано, для взрослых она или для детей.

4.8 Другие лекарства

Противогрибковые препараты эмпирически не назначают. Только после подтверждения кандидоза взрослым назначают флуконазол 100 мг в сутки или итраконазол 100 мг 1 раз в сутки на 15 дней.

Пациентам с аллергией — аллергическим ринитом, крапивницей, поллинозом, аллергическим конъюнктивитом — назначают системные антигистаминные препараты.

Препарат	Доза
Лоратадин, цетиризин	Детям 3–12 лет с массой больше 30 кг — 10 мг 1 раз в день, меньше 30 кг — 5 мг 1 раз в день; взрослым и детям старше 12 лет — 10 мг 1 раз в день.
Левоцетиризин	Детям 2–6 лет — 1,25 мг 2 раза в сутки; старше 6 лет и взрослым — 5 мг 1 раз в сутки.
Дезлоратадин	От 6 до 12 месяцев — 1 мг, с 1 года до 5 лет — 1,25 мг, 6–11 лет — 2,5 мг, взрослым и детям старше 12 лет — 5 мг; всё 1 раз в день.

> Левоцетиризину и лоратадину в КР приписан один и тот же код АТХ — R06AX13.

4.9 Хирургическое лечение

При неосложнённом остром ларингите операция не нужна.

Детям с декомпенсированным стенозом гортани для обеспечения дыхания проводят неотложную интубацию.

Если интубировать трахею невозможно, делают трахеостомию или коникотомию.

Осложнённые формы острого ларингита лечат хирургически.

4.10 Иное лечение

Пациента с острым ларингитом консультирует физиотерапевт.

При дисфонии на фоне острого ларингита КР рекомендует добавлять комплексные гомеопатические препараты, чтобы уменьшить расстройства голоса. Приведённый в КР препарат зарегистрирован по показанию «ларингиты различной этиологии» и назначается взрослым и детям старше 6 лет с первых дней болезни на 6 дней.

---

5. Наблюдение, профилактика, госпитализация

Пациентов голосоречевых профессий после острого ларингита наблюдает оториноларинголог до полного восстановления голоса.

Нетрудоспособность у них продлевают до полного восстановления голоса. Неосложнённый ларингит проходит за 7–14 дней, инфильтративные формы — дольше 14 дней.

Чтобы ларингит не стал хроническим, его вовремя лечат, повышают сопротивляемость организма, лечат гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь и инфекции верхних и нижних дыхательных путей, отказываются от курения и соблюдают голосовой режим.

Пациенту советуют ограничить голосовую нагрузку, отказаться от горячей, холодной и острой пищи, спиртного, курения и паровых ингаляций, постоянно увлажнять воздух в помещении увлажнителем; в составе комплексного лечения КР упоминает противовирусные препараты.

> В разделе 7 и в памятке для пациента паровые ингаляции запрещены, хотя в разделе 3.1 ингаляции отваров трав допускаются «тёплыми». Там же советуют противовирусные препараты, но в разделе о лечении такой рекомендации нет.

5.1 Госпитализация

Пациенты с острым ларингитом без стеноза гортани на фоне ОРВИ в госпитализации не нуждаются. Госпитализируют всех пациентов с осложнённым течением.

Пациентов с осложнёнными и тяжёлыми формами — флегмонозным, абсцедирующим, инфильтративным ларингитом и хондроперихондритом гортани — обязательно и срочно госпитализируют в учреждение, где есть отделение интенсивной терапии и возможность интубации трахеи.

Экстренно госпитализируют при острой дыхательной недостаточности выше I степени.

Выписывают, когда воспаление идёт на убыль, дыхательной недостаточности и осложнений нет.

При неосложнённом ларингите прогноз благоприятный. При осложнённых формах со стенозом гортани жизнь пациента спасают своевременная специализированная помощь и операция.

---

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Острый ларингит»
Версия	2-я, опубликована в рубрикаторе 01.11.2024
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)

Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее ноября 2027 года
Код в рубрикаторе	309_2 · открыть текст КР ↗
Разработчики	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов; Союз педиатров России
Пациенты	Взрослые и дети

6.1 Неточности в самом тексте КР

- Сроки голосового покоя расходятся: в рекомендации — «не менее 2-х дней», в комментарии — «1–2 суток».
- Цефдиторен: в тексте — 400 мг 1 раз в сутки, в таблице 1 кратность зачёркнута целиком.
- Джозамицину в тексте приписан код АТХ J01FA09 (код кларитромицина), в таблице — J01FA07.
- Детские дозы кларитромицина, амоксициллина с клавулановой кислотой и цефиксима в тексте и в таблице 2 различаются; у кларитромицина «разовая доза» дана в мг/кг/сут и «для детей старше 12 лет».
- Для тиамфеникола глицината ацетилцистеината нет дозы для детей от 2 до 3 лет: группы «до 2 лет» и «от 3 до 6 лет».
- В комментарии о дестенозирующей терапии не назван глюкокортикоид, к которому относится доза «60–120 мг».
- Левоцетиризину и лоратадину приписан один код АТХ R06AX13.
- Раздел 7 запрещает паровые ингаляции и советует противовирусные препараты, а раздел 3.1 допускает тёплые ингаляции и не содержит рекомендации о противовирусных.
- В комментарии о меропенеме для детей авторы ссылаются на справочник Vidal.

Клинические рекомендации

Острый синусит

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**J01** — Острый синусит
Пациенты	взрослые, дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 28.10.2024, пересмотр не позднее 2027 года
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/313_3

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 22.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

1. Главное

- Острый синусит — острое воспаление слизистой оболочки носа и околоносовых пазух, которое длится меньше 12 недель. Должны быть хотя бы два симптома: заложенность носа, выделения из носа или носоглотки, давление или боль в области лица, снижение или потеря обоняния.
- В 90–98% случаев синусит вызывают вирусы, бактерии — лишь в 2–10%.
- Системные антибиотики назначают при среднетяжёлом и тяжёлом синусите. При лёгком — только если синусит рецидивирующий и симптомы держатся 5–7 дней и дольше, при тяжёлой сопутствующей патологии или иммунодефиците.
- При впервые возникшем синусите начинают с незащищённого аминопенициллина — амоксициллина. Если за 3 дня заметного эффекта нет, препарат меняют.
- Сосудосуживающие капли назначают не дольше 5–7 дней, нос промывают солевыми растворами, пациентам старше 12 лет можно интраназальные глюкокортикостероиды.
- Госпитализируют при тяжёлом течении, орбитальных или внутричерепных осложнениях, если за 3–5 дней приёма системных антибиотиков нет улучшения и при ухудшении в любой момент.

2. Клиника и классификация

раздел 1 текста КР

2.1 Определение

Острый синусит — острое воспаление слизистой оболочки полости носа и околоносовых пазух, которое длится меньше 12 недель. Должны быть хотя бы два симптома: затруднённое носовое дыхание, выделения из носа или носоглотки, давление или боль в области лица, снижение или потеря обоняния. Часть симптомов может заменить находка при риноскопии, эндоскопии или на КТ.

У детей внезапно появляются хотя бы два симптома: заложенность носа, бесцветные или светлые выделения, кашель днём или ночью. Симптомы должны полностью пройти за 12 недель.

Рецидивирующим синусит называют, если за последний год было 4 эпизода и больше, а между ними — не меньше 8 недель без симптомов и без лечения.

Об остром поствирусном синусите говорят, если симптомы держатся дольше 10 дней после ОРВИ, а признаков бактериального синусита нет. Обычно он протекает легче и проходит без антибиотиков.

2.2 Критерии диагноза

У взрослых синусит начинается остро, симптомов два или больше, и один из них — заложенность носа или выделения, в том числе стекание слизи по задней стенке глотки. Могут быть боль или давление в проекции пазух, снижение или потеря обоняния. Длится не дольше 12 недель.

У детей синусит начинается остро, есть хотя бы два симптома: заложенность носа, выделения из носа, в том числе по задней стенке глотки, или кашель. Длится не дольше 12 недель.

Предварительный диагноз оториноларинголог подтверждает риноскопией или эндоскопией (гнойное отделяемое или отёк в области остиомеатального комплекса) либо КТ.

Боли может и не быть. При верхнечелюстном синусите она ощущается в проекции пазухи, реже в области переносицы и надбровья и может отдавать в верхние зубы. При сфеноидите болит в центре головы и в затылке, как будто надета каска.

У детей синусит часто сочетается с гипертрофией и хроническим воспалением глоточной миндалины и может проявляться упорным кашлем или сильно затруднённым носовым дыханием.

2.3 Тяжесть

Форма	Признаки
Лёгкая	Нет лихорадки. Умеренные симптомы, не влияющие или незначительно влияющие на качество жизни. Нет головной боли в проекции ОНП. Нет осложнений
Среднетяжёлая	Выраженные симптомы, умеренно или значительно влияющие на качество жизни. Тяжесть в проекции ОНП при движении или наклоне головы. Осложнение со стороны среднего уха (острый средний отит). Нет внутричерепных и орбитальных осложнений
Тяжёлая	Выраженные или мучительные симптомы. Болезненность в проекции ОНП, усиливающаяся при движении, наклоне головы, перкуссии. Внутричерепные или орбитальные осложнения

2.4 Классификация

По причине синусит бывает вирусным, бактериальным, травматическим, грибковым (как острый процесс — очень редко) и смешанным. Чисто бактериальный синусит встречается редко; обычно это сочетание вирусов или вирусов с бактериями.

По локализации различают гайморит, фронтит, этмоидит и сфеноидит. Если поражены все пазухи одной половины носа, это гемисинусит, если обеих — пансинусит.

2.5 Дифференциальная диагностика

У взрослых синусит отличают от обострения хронического риносинусита, аллергического и хронических ринитов, у детей — ещё от аденоидита и инородного тела в носу.

Дошкольникам без осложнений и без признаков бактериального синусита основным диагнозом лучше ставить аденоидит или острый назофарингит.

---

3. Диагностика

раздел 2 текста КР
Всем пациентам проводят общий осмотр и стандартный ЛОР-осмотр.

Эндоскопию полости носа и носоглотки проводят, чтобы оценить их состояние и провести дифференциальную диагностику.

Чаще всего она не даёт больше, чем передняя и средняя риноскопия, но помогает, например, отличить сфеноидит от аденоидита.

Спиральную КТ околоносовых пазух делают при подозрении на внутричерепные или орбитальные осложнения, при затяжном тяжёлом течении и в сложных диагностических случаях.

Рентгенографию пазух делают при среднетяжёлом и тяжёлом течении, а также в сложных случаях, если КТ сделать нельзя.

Рентгенография и КТ пазух совпадают только в 34% случаев, для верхнечелюстной пазухи — в 77%.

УЗИ пазух делают при подозрении на верхнечелюстной или лобный синусит, если рентгенография и КТ невозможны.

Развёрнутый общий анализ крови назначают при среднетяжёлом и тяжёлом течении.

Лейкоцитоз с нейтрофилёзом не доказывает бактериальный синусит, но если при повторном анализе он нарастает, это помогает решить вопрос об антибиотиках.

Гнойное отделяемое отправляют на посев с определением чувствительности в стационаре при среднетяжёлом и тяжёлом течении, при затяжном течении и если эмпирическая антибиотикотерапия не помогла.

Материал берут при пункции пазухи иглой Куликовского. Посев из носового хода делать бессмысленно: в него попадает посторонняя флора.

Другие исследования не нужны.

---

4. Лечение

раздел 3 текста КР

4.1 Когда нужен антибиотик

Взрослым антибиотики назначают при среднетяжёлом и тяжёлом синусите. При лёгком — только если синусит рецидивирующий и симптомы держатся 5–7 дней и дольше, а также при тяжёлой сопутствующей патологии (например, сахарном диабете) и иммунодефиците.

О бактериальном синусите говорят три признака и больше: гнойные выделения или выделения только из одной половины носа 3 дня и дольше; головная боль или давление в проекции верхнечелюстных или лобных пазух; температура 38,0 °C и выше; «вторая волна» болезни; лейкоцитоз выше 15×10^9/л. О нём же говорят выраженные с самого начала симптомы, которые держатся 3–4 дня и угрожают орбитальными или внутричерепными осложнениями.

Детям антибиотики назначают при признаках бактериального синусита, среднетяжёлом и тяжёлом течении. При лёгком — если есть хотя бы одно из условий: орбитальные или внутричерепные осложнения; три и больше признака бактериального синусита; иммунодефицит, муковисцидоз, первичная цилиарная дискинезия, некомпенсированный сахарный диабет I типа; 4 эпизода синусита и больше за последний год.

Взрослым при наличии показаний назначают системные антибиотики.

Детям при наличии показаний назначают системные антибиотики.

При впервые возникшем синусите начинают с незащищённых аминопенициллинов.

Если высок риск устойчивого пневмококка, дозу амоксициллина повышают. При сопутствующих болезнях, иммуносупрессии, в возрасте старше 65 лет и если амоксициллин уже не помог, начинают с защищённых аминопенициллинов.

Если за 3 дня заметного эффекта нет, препарат меняют, не дожидаясь конца курса. У детей эффект оценивают через 48–72 часа.

4.2 Дозы стартовой терапии

Взрослые

Препарат	Доза
Амоксициллин внутрь	500 мг × 3 р/сут — без факторов риска[1] 1000 мг × 3 р/сут — при факторах риска[1]
Амоксициллин + клавулановая кислота внутрь[2]	500/125 мг × 3 р/сут или 875/125 мг × 2 р/сут
Цефуроксим	250–500 мг × 2 р/сут
Цефиксим	400 мг × 1 р/сут
Цефдиторен внутрь	200 мг × 2 р/сут

Препарат	Доза
Цефподоксим внутрь	200 мг × 2 р/сут
Аллергия на β-лактамы	
Кларитромицин внутрь	250–500 мг × 2 р/сут
Левофлоксацин внутрь	500 мг × 1 р/сут
Моксифлоксацин внутрь	400 мг × 1 р/сут
Клиндамицин в/м (в КР — со знаком #)	400–900 мг × 3 р/сут, 7–10 дней

[1] Риск устойчивости пневмококка повышают антибиотики в предыдущие 3 месяца, дети-дошкольники в семье, которые ходят в детский сад, и проживание в закрытых учреждениях.

[2] Риск бета-лактамаз (H. influenzae, S. aureus, M. catarrhalis) повышают бронхиальная астма, сахарный диабет, хронический бронхит, иммуносупрессия, возраст старше 65 лет и неудачное лечение амоксициллином.

Неосложнённый синусит лечат 7 дней, осложнённый — 10–14 дней.

Макролиды — только запасной вариант при IgE-опосредованной непереносимости бета-лактамов. Фторхинолоны можно только взрослым и только если других вариантов нет; детям и подросткам они противопоказаны.

Дети

Препарат	Доза
Амоксициллин внутрь	40–60 мг/кг/сут — без факторов риска[1] 80–90 мг/кг/сут — при факторах риска[1]
Амоксициллин + клавулановая кислота внутрь	45–60 мг/кг/сут в 2–3 приёма
Цефуроксим	30 мг/кг/сут в 2 приёма, не более 500 мг в сутки
Цефиксим	8 мг/кг/сут в 1–2 приёма
Цефдиторен, цефподоксим (старше 12 лет) внутрь	200 мг × 2 р/сут
Аллергия на β-лактамы	
Кларитромицин внутрь	15 мг/кг/сут в 2 приёма, макс. 1000 мг/сут
Тиамфеникола глицинат ацетилцистеинат в/м (стационар, если β-лактамы невозможны)	125–250 мг 2–3 р/сут в зависимости от возраста

Амоксициллин с клавулановой кислотой назначают, если за последние 3 месяца ребёнок получал антибиотики или ходит в детский коллектив, а также если амоксициллин не помог за 48–72 часа. При лёгкой аллергии на пенициллины назначают цефалоспорины III поколения внутрь.

Дозы на килограмм рассчитаны на детей с массой меньше 40 кг; при массе 40 кг и больше назначают взрослые дозы.

Неосложнённый синусит лечат 7–10 дней, при орбитальных и внутричерепных осложнениях или рецидивирующем течении — 10–14 дней.

> Внутри КР есть расхождение: в тексте раздела 3.1 стартовая доза амоксициллина для детей — 50–60 мг/кг в сутки в 2–3 приёма, а в таблице 5 — 40–60 мг/кг в сутки (80–90 мг/кг при факторах риска). На сайте приведены данные таблицы.

4.3 Тяжёлое течение, парентерально

Взрослым при тяжёлом синусите вводят цефотаксим или цефтриаксон, внутривенно можно также амоксициллин с клавулановой кислотой. При риске анаэробов назначают клиндамицин вместе с цефалоспорином III поколения. Если стартовая парентеральная терапия не помогла, рассматривают цефоперазон с сульбактамом 2–4 г в сутки внутривенно в 2 введения, а при резистентных штаммах — препараты резерва по чувствительности.

Детям вводят ампициллин с сульбактамом 300 мг/кг в сутки в 3–4 введения, цефтриаксон 75 мг/кг в сутки в 2 введения или цефотаксим 100–200 мг/кг в сутки в 4 введения. Если это не помогло, назначают цефоперазон с сульбактамом 75–160 мг/кг в сутки в 2–4 введения (в КР — со знаком #, то есть вне инструкции).

4.4 Местная и симптоматическая терапия

Нос промывают изотонической стерильной морской водой или солевыми растворами. Слабые гипертонические растворы используют только в остром периоде и не дольше 5–7 дней.

Сосудосуживающие капли КР называет абсолютно необходимыми, но ограничивает их 5–7 днями из-за риска медикаментозного ринита. Нафазолин не применяют.

Детям до 6 лет подходят фенилэфрин 0,125%, оксиметазолин 0,01–0,025% и ксилометазолин 0,05% (с 2 лет).

Интраназальные глюкокортикостероиды пациентам старше 12 лет назначают одни при затяжном поствирусном синусите или вместе с системными антибиотиками. Детям до 12 лет одни глюкокортикостероиды назначают только при сопутствующем аллергическом рините.

Для лечения синусита без признаков бактериальной инфекции одним препаратом в России зарегистрирован только спрей мометазона.

Местные антибактериальные препараты назначают вместе с системными или одни при лёгком синусите с признаками бактериального воспаления (гнойными выделениями). Эффект оценивают через 3–4 дня.

При синусите зарегистрированы фрамицетин (детям с первых лет жизни) и комбинация дексаметазона, неомицина, полимиксина B и фенилэфрина (с 2,5 лет). Растворы антибиотиков для инъекций вводить в нос и пазухи нельзя.

При температуре, головной и лицевой боли назначают НПВП. Детям до 6 лет — только парацетамол (до 60 мг/кг в сутки) или ибупрофен (до 30 мг/кг в сутки), взрослым можно кетопрофен.

Можно назначить мукоактивные препараты, например ацетилцистеин или карбоцистеин. Перед назначением проверьте инструкцию: не все они разрешены при ЛОР-болезнях и вместе с антибиотиками.

Применяют растительные препараты с доказанным противовоспалительным и муколитическим действием: комбинации корня горечавки, цветков первоцвета, шалфея, цветков бузины и вербены, миртол, экстракт пеларгонии сидовидной.

Комбинированные препараты с парацетамолом без психотропных компонентов можно давать для облегчения симптомов с 12 лет.

Системные антигистаминные препараты назначают при сопутствующем аллергическом рините и в начале вирусной инфекции.

При вирусном синусите в комплексное лечение можно включить противовирусные препараты, в том числе растительного происхождения.

При лёгком синусите амбулаторно можно рассмотреть комплексные гомеопатические препараты по зарегистрированным показаниям.

Бактериофаги назначают взрослым с острым бактериальным синуситом; местно они оправданы при устойчивости к антибиотикам или их непереносимости.

4.5 Хирургия

Пункцию верхнечелюстной пазухи делают, если содержимое в пазухе подтверждено рентгенологически и течение тяжёлое или среднетяжёлое без эффекта от лечения с системными антибиотиками за 5–7 дней.

Детям пункцию и трепанопункцию делают только в стационаре; часто вместо них можно использовать синус-катетер.

Дренирование пазух, в том числе синус-катетером, проводят при затяжном экссудативном синусите без обструкции соустий. При впервые возникшем неосложнённом синусите оно не нужно.

При орбитальных или внутричерепных осложнениях оперируют в стационаре: вскрывают пазуху и дренируют абсцесс.

Другое лечение (раздел 3.3) и медицинская реабилитация (раздел 4) не нужны.

4.6 Профилактика

Детям из групп риска по респираторным болезням назначают местные и системные лизаты бактерий.

При рецидивирующем синусите и изменениях перегородки или латеральной стенки носа, которые к нему предрасполагают, проводят плановую операцию.

4.7 Особые случаи

Сопутствующий аллергический ринит затягивает синусит: нужны системные антигистаминные препараты и более высокая доза глюкокортикостероидов.

Одонтогенный синусит лечат хирургически, удаляя пломбировочный материал и секвестры. Из антибиотиков предпочтительны респираторные фторхинолоны, потому что преобладает анаэробная флора.

---

5. Госпитализация и осложнения

разделы 1.5, 3 и 6 текста КР
Экстренно в ЛОР-отделение госпитализируют при тяжёлом течении, в том числе с орбитальными и внутричерепными осложнениями, если за 3–5 дней системных антибиотиков нет улучшения и при прогрессирующем ухудшении в любой момент.

Орбитальные и внутричерепные осложнения говорят о тяжёлом течении, острый средний отит — о среднетяжёлом.

Выписывают, когда состояние стабильно удовлетворительное не меньше 3 дней.

---

6. Источник и актуальность

всегда полностью

Документ	Клинические рекомендации «Острый синусит»
Версия	3-я, год утверждения 2024, опубликована в рубрикаторе 28.10.2024

Статус	**Применяется** (карточка рубрикатора на 22.10.2026); год окончания действия не указан
Актуализация	По правилу из самой КР — «не реже чем один раз в три года» (прил. А2): следующая ожидается не позднее октября 2027
Код в рубрикаторе	313_3 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Пациенты	Взрослые и дети
Целевая аудитория	Оториноларингологи, терапевты, педиатры

6.1 Что исправлено после сверки с PDF

- Убрано предупреждение «пересмотр не позднее 2026»: в PDF и в карточке рубрикатора этой даты нет, она пришла из пересказа MedElement.
- Амоксициллин у взрослых: «500–1000 мг» заменено на две дозы с условием — 500 мг без факторов риска устойчивости пневмококка, 1000 мг при их наличии.
- Добавлены условия для амоксициллина/клавуланата и цефоперазона/сульбактама, тиамфеникол для детей в стационаре, предел цефуроксима «500 мг в сутки».
- Уточнены показания к пункции, ограничение ИГКС до 12 лет (только монотерапия), признаки степеней тяжести, критерии у детей («бесцветные или светлые выделения»).
- Убрана фраза «КТ рутинно не нужна»: в КР её нет.
- Добавлены разделы 5 «Профилактика» и 7 «Дополнительная информация».

6.2 Неточности в самом тексте КР

- Детская доза амоксициллина: текст раздела 3.1 — 50–60 мг/кг/сут, таблица 5 — 40–60 (80–90) мг/кг/сут.
- В таблице 5 у цефтриаксона указан код АТХ J01FA09 — это код кларитромицина; в тексте у цефтриаксона верный код J01DD04.
- Знак # у ряда препаратов в этой КР не расшифрован. ⚠ В российских КР им обычно отмечают применение вне инструкции — проверьте по инструкции препарата.

6.3 Шкалы доказательности

Шкала	Что означает
УУР А	Сильная рекомендация: все критерии эффективности важны, исследования высокого или удовлетворительного качества, выводы согласованы
УУР В	Условная рекомендация: не все критерии важны, не все исследования высокого качества и/или выводы не согласованы
УУР С	Слабая рекомендация: доказательств надлежащего качества нет
УДД 1–5	Для лечения: 1 — систематический обзор РКИ с метаанализом … 5 — только обоснование механизма действия или мнение экспертов. Для диагностики — отдельная шкала (табл. П1); точная расшифровка — по нажатию на бейдж

Клинические рекомендации

Острый тонзиллит и фарингит

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**J02** — Острый фарингит **J02.0** — Стрептококковый фарингит **J02.8** — Острый фарингит, вызванный другими уточненными возбудителями **J02.9** — Острый фарингит неуточненный **J03** — Острый тонзиллит [ангина] **J03.0** — Стрептококковый тонзиллит **J03.8** — Острый тонзиллит, вызванный другими уточненными возбудителями **J03.9** — Острый тонзиллит неуточненный
Пациенты	взрослые, дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 31.10.2024, пересмотр не позднее 2027 года
Разработчик	Союз педиатров России; Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов; Международная общественная организация "Евро-Азиатское общество по инфекционным болезням"; Межрегиональная ассоциация по клинической микробиологии и антимикробной химиотерапии
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/306_3

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 22.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

1. Главное

- Чаще всего тонзиллофарингит вызывают вирусы, и антибиотик при нём не нужен. Из бактерий лечения требует только БГСА — бета-гемолитический стрептококк группы А; стафилококк, пневмококк и другие микробы в мазке из зева означают колонизацию.
- По клинике вирусный тонзиллофарингит от бактериального не отличить. Пациентам старше 3 лет делают экспресс-тест на БГСА; если у ребёнка он отрицательный, результат подтверждают посевом.
- Антибиотик назначают только при доказанной или очень вероятной стрептококковой природе. При вирусной инфекции он не помогает и не предотвращает присоединение бактерий.
- Препарат выбора — амоксициллин, курс 10 дней.
- Если через 48–72 часа приёма антибиотика улучшения нет, пересматривают диагноз: это может быть ОРВИ или инфекционный мононуклеоз.
- Рутинно не нужны СРБ, прокальцитонин, общий анализ крови в поликлинике, АСЛ-О и контрольный мазок после лечения.

2. Клиника и классификация

раздел 1 текста КР

2.1 Определение

Острый тонзиллофарингит — острое инфекционное воспаление слизистой оболочки и лимфоидной ткани ротоглотки: нёбных миндалин и фолликулов задней стенки глотки. Термин объединяет острый тонзиллит и острый фарингит, потому что чаще воспалены оба отдела.

По локализации различают тонзиллит, фарингит и тонзиллофарингит — по тому, какой отдел ротоглотки воспалён больше. По причине — стрептококковый и нестрептококковый (вирусный). Тактику определяет именно причина.

2.2 Клиническая картина

Болезнь начинается остро, обычно с температурой выше 38 °C (реже она нормальная или субфебрильная) и боли в горле, которая усиливается при глотании и может отдавать в ухо. Регионарные лимфоузлы бывают увеличены и болезненны, маленькие дети отказываются от еды. Состояние удовлетворительное или средней тяжести.

На стрептококк указывают увеличенные подчелюстные или переднешейные лимфоузлы, высокая температура, сильная боль в горле, «пылающий зев», налёт на миндалинах и отсутствие насморка, кашля и конъюнктивита.

На вирусную природу указывают насморк, конъюнктивит и кашель. При инфекции вирусом Эпштейна — Барр бывают генерализованное увеличение лимфоузлов, печени и селезёнки. Петехии на мягком нёбе встречаются и при стрептококке, и при вирусе Эпштейна — Барр.

При тонзиллофарингите миндалины увеличены симметрично, и этим он отличается от паратонзиллярного абсцесса.

2.3 Что важно для выбора тактики

Все штаммы БГСА чувствительны к пенициллину и всем бета-лактамам. К макролидам устойчив примерно каждый пятый штамм, к клиндамицину — 3–4%.

Если при клинике тонзиллофарингита из зева высевают *S. aureus*, *S. pneumoniae* или другие бактерии, это колонизация, и антибиотики не нужны.

2.4 Дифференциальная диагностика

Инфекционным мононуклеозом чаще болеют подростки и молодые взрослые до 30 лет. Характерны слабость, увеличение лимфоузлов, печени и селезёнки, атипичные мононуклеары в крови. Диагноз подтверждают ПЦР на ДНК вируса Эпштейна — Барр и IgM к капсидному антигену.

Синдромом «рука — нога — рот» болеют дети до 5 лет, обычно летом: во рту появляются пузырьки без налётов на миндалинах, а на кистях и стопах — сыпь.

При ангине Симановского — Плаута — Венсана на одной миндалине образуется некротическая язва с гнилостным запахом.

При дифтерии зева налёт плотный, снимается с трудом и оставляет кровоточащую поверхность.

Синдром Маршалла (PFAPA) — периодическая лихорадка до 39–40 °C с тонзиллитом или фарингитом, афтозным стоматитом и шейным лимфаденитом. Приступы повторяются каждые 1–2 месяца, средний возраст детей — 5 лет, приступ быстро снимают системные кортикостероиды.

---

3. Диагностика

раздел 2 текста КР
Диагноз ставят по жалобам на сильную боль в горле при глотании, по осмотру (гиперемия, инфильтрация и отёк миндалин, увеличенные регионарные лимфоузлы) и по результату экспресс-теста на БГСА или посева.

Каждого пациента должен осмотреть оториноларинголог, педиатр, врач общей практики или терапевт.

У каждого пациента нужно отличить стрептококковый тонзиллофарингит от вирусного.

Экспресс-тест на БГСА делают пациентам старше 3 лет. Если он положительный, посев не нужен. Если отрицательный, взрослому посев тоже не нужен, а у ребёнка и подростка результат подтверждают посевом.

Детям до 3 лет тест обычно не делают; исключение — когда стрептококковый тонзиллит есть у кого-то рядом, например у старшего брата или сестры.

Мазок из зева на стрептококк группы А сеют пациентам старше 3 лет, если экспресс-тест не делали или он отрицательный. Результат готов в течение 72 часов.

Мазок берут до начала антибиотиков, до утренней гигиены рта, натощак или через 2 часа после еды, под контролем орофарингоскопии, не касаясь зубов и языка, из устьев крипт миндалин и с задней стенки глотки.

3.1 Что не нужно рутинно

В поликлинике СРБ и прокальцитонин не помогают отличить вирусное воспаление от бактериального. СРБ определяют при госпитализации, прокальцитонин — у тяжёлых пациентов в стационаре.

Общий анализ крови в поликлинике делают только при необходимости, например чтобы исключить мононуклеоз.

АСЛ-О годится только для ретроспективной диагностики, потому что повышается лишь на 7–9-й день. Его определяют при подозрении на ревматическую лихорадку, гломерулонефрит или PANDAS.

Контрольный мазок на БГСА после лечения не нужен, если пациент не относится к группе высокого риска ревматической лихорадки и симптомы не повторяются.

У детей старше 3 лет обращают внимание на насморк, кашель, охриплость и конъюнктивит: при стрептококковой инфекции они бывают не больше чем у 10% и только при сопутствующей вирусной инфекции.

3.2 Шкала Центора — МакАйзека

Признак	Баллы
Температура тела выше 38 °C	1
Отёчность и гиперемия миндалин, налёты на задней стенке глотки и миндалинах	1
Нет катаральных явлений и кашля	1
Переднешейный и/или подчелюстной лимфаденит	1
Возраст 5–14 лет / 15–44 года / 45 лет и старше	1 / 0 / −1

Баллы	Вероятность БГСА: ≥15 лет / 3–14 лет	Тактика
0–1	7–12% / 8–14%	Нет показаний к посеву и/или антибиотикам
2–3	21–38% / 23–37%	Антибиотик — по экспресс-тесту и/или посеву
4 и более	57% / 55%	Антибиотик по клинической картине

3.3 Шкала FeverPAIN

Один балл дают за каждый признак: температура за последние сутки, налёт на миндалинах, обращение в первые 3 дня из-за сильных симптомов, выраженные гиперемия и отёк миндалин, отсутствие кашля и насморка.

При 0–2 баллах вероятность стрептококка групп A, C или G — 16%, при 3 баллах — 43%, при 4–5 баллах — 63%.

Шкалы помогают найти пациентов с высокой вероятностью стрептококковой инфекции, но диагноз с абсолютной точностью не ставят.

---

4. Лечение

раздел 3 текста КР

4.1 Антибиотики

При вирусной инфекции системные антибиотики не назначают: они не действуют и не предотвращают присоединение бактерий.

Назначать антибиотики при вирусном тонзиллофарингите «для профилактики» не рекомендуется.

Антибиотики назначают только при доказанной или очень вероятной стрептококковой природе.

При стрептококковом тонзиллите препарат выбора — амоксициллин.

При мононуклеозе может появиться сыпь на амоксициллин, но она бывает и от других антибиотиков, и без них, поэтому при мононуклеозе любых системных антибиотиков лучше избегать.

Пенициллины, цефалоспорины, линкозамиды и макролиды, кроме азитромицина, назначают на 10 дней.

При рецидивирующем стрептококковом тонзиллофарингите назначают амоксициллин с клавулановой кислотой или клиндамицин (детям старше 3 лет) на 10 дней. Пациента консультирует оториноларинголог, чтобы исключить хронический тонзиллит, а у детей — синдром PFAPA.

Если через 48–72 часа приёма антибиотика температура и боль не уменьшились, пересматривают диагноз: вероятнее всего, это ОРВИ или инфекционный мононуклеоз.

При нетяжёлой аллергии на пенициллины назначают цефалоспорины II–III поколения: цефуроксим, цефиксим, цефдиторен или цефподоксим. Перекрёстная аллергия с пенициллинами бывает меньше чем в 2% случаев для II поколения и меньше чем в 1% для III.

Уровни доказательности у этих препаратов в КР разные: у цефуроксима — УУР С, УДД 5; у цефиксима — С и 5 для детей, В и 1 для взрослых; у цефдиторена — С и 2; у цефподоксима — В и 2. Курс — 10 дней.

При аллергии на цефалоспорины или тяжёлой реакции на бета-лактамы (анафилактический шок, отёк гортани, тяжёлая крапивница) назначают макролиды или линкозамиды, помня об устойчивости стрептококка к макролидам.

Бензатина бензилпенициллин вводят однократно внутримышечно вместо курса таблеток, только если есть сомнения, что пациент будет их принимать. Детям с массой до 27 кг — 600 тысяч ЕД, больше 27 кг — 1,2 миллиона ЕД.

4.2 Дозы внутрь

Препарат	Взрослые	Дети
Стартовая терапия — 10 дней		
Амоксициллин[1]	1,5 г/сут в 3 приёма или 1,0 г/сут в 2 приёма	50 мг/кг/сут в 2–3 приёма
Альтернатива		
Бензатина бензилпенициллин[2] **в/м, однократно**	2,4 млн ЕД	менее 27 кг — 600 тыс. ЕД; более 27 кг — 1,2 млн ЕД
Цефалексин	старше 10 лет: 500–1000 мг/сут в 2 приёма	3–10 лет, только таблетки: 25–50 мг/кг/сут в 4 приёма, не более 1000 мг/сут
Рецидив и/или неэффективность амоксициллина		
Амоксициллин + клавулановая кислота[1] [3] **(во время еды)**	1750 мг/сут по амоксициллину в 2 приёма	50 мг/кг/сут по амоксициллину в 2–3 приёма
Нетяжёлая аллергия на пенициллины		
Цефуроксим (сразу после еды)	1,0 г/сут в 2 приёма	20 мг/кг/сут в 2 приёма
Цефиксим	400 мг/сут в 1–2 приёма	8 мг/кг/сут в 1–2 приёма
Цефдиторен (после еды)	400 мг/сут в 2 приёма	с 12 лет: 400 мг/сут в 2 приёма
Цефподоксим (во время еды)	200 мг/сут в 2 приёма	с 12 лет: 200 мг/сут в 2 приёма
Аллергия на цефалоспорины и/или тяжёлая реакция на пенициллины		
Кларитромицин	500–1000 мг/сут в 2 приёма	15 мг/кг/сут в 2 приёма

Препарат	Взрослые	Дети
Джозамицин (между едой)	1,0 г/сут в 2 приёма	40–50 мг/кг/сут в 2 приёма
Азитромицин (за 1 час до еды)	500 мг/сут в 1 приём, **3 дня**	20 мг/кг/сут в 1 приём, 3 дня
Мидекамицин (за 1 час до еды)	1,2 г/сут в 3 приёма	старше 3 лет: 50 мг/кг/сут в 2 приёма
Спирамицин	6 млн МЕ/сут в 2 приёма	старше 6 лет, более 20 кг: 300 тыс. МЕ/кг/сут в 2 приёма
Клиндамицин (запивать большим объёмом воды)	0,6 г/сут в 4 приёма	20 мг/кг/сут в 3 приёма

[1] С осторожностью при подозрении на инфекционный мононуклеоз. [2] Если пациент может не соблюдать назначения, при ревматической лихорадке у него или у родственников, при неблагоприятных бытовых условиях и вспышках в коллективе. [3] Клавулановой кислоты — не больше 10 мг/кг в сутки из-за риска диареи.

> Текст КР и таблица 1 расходятся. Цефуроксим взрослым: в тексте — 250 мг 2 раза в сутки, в таблице — 1,0 г в сутки. Амоксициллин с клавулановой кислотой детям: в тексте — 40 мг/кг в сутки, в таблице — 50 мг/кг. Амоксициллин детям: в тексте — 50 мг/кг в сутки в 2 приёма, не больше 1000 мг в сутки, в таблице — в 2–3 приёма без ограничения. Клиндамицин: в тексте взрослым 300 мг 2 раза в сутки, детям 3–12 лет 20–30 мг/кг в сутки, в таблице — 0,6 г в сутки в 4 приёма и 20 мг/кг. Выбор за врачом; проверьте дозы по инструкции в ГРЛС.

4.3 Парентерально

Если пациент не может или не хочет принимать препарат внутрь, его вводят парентерально до стабилизации, а затем переходят на приём внутрь.

Препарат	Дети	Взрослые
Ампициллин	до 1 года 100 мг/кг/сут; 1–4 года 100–150 мг/кг/сут; от 4 лет 1–2 г/сут; в 4 введения	и дети более 40 кг: 250–500 мг каждые 6 ч
Амоксициллин + клавулановая кислота в/в	90 мг/кг/сут в 3 введения	и дети старше 12 лет: 1,2 г каждые 8 ч
Ампициллин + сульбактам	до 12 лет или менее 40 кг: 150 мг/кг/сут в 3–4 введения	1,5–3 г каждые 6–8 ч
Цефазолин	1 мес — 18 лет: 25–50 мг/кг/сут (тяжёлые — 100) в 3–4 введения	2,0 г каждые 8 ч
Цефтриаксон	до 12 лет: 20–80 мг/кг/сут 1 раз (более 50 кг — до 2 г/сут)	и дети старше 12 лет: 2 г 1 раз в сутки
Цефотаксим	до 12 лет: 100–150 мг/кг/сут в 2–4 введения	и дети старше 12 лет или более 50 кг: 1–2 г каждые 6–8 ч
Клиндамицин (непереносимость β-лактамов)	20–40 мг/кг/сут в 3–4 введения	0,4–0,6 г каждые 6–8 ч

4.4 Симптоматическое лечение

При температуре и боли назначают ибупрофен, парацетамол или, старше 15 лет, ацетилсалициловую кислоту; детям — только парацетамол и ибупрофен. Здоровым детям старше 3 месяцев жаропонижающее дают при температуре выше 39,0 °C в прямой кишке или выше 38,5 °C в подмышке.

Ибупрофен взрослым — 200–400 мг, детям — 7,5 мг/кг, не больше 30 мг/кг в сутки. Парацетамол взрослым — 500–1000 мг, детям — 10–15 мг/кг каждые 6 часов, не больше 60 мг/кг в сутки.

Системные кортикостероиды при боли в горле рутинно не назначают.

Исключение — сильный дискомфорт и угроза асфиксии, например при мононуклеозе. Тогда однократно внутрь дают #дексаметазон 0,3 или 0,6 мг/кг или #преднизолон 1 мг/кг (УУР В, УДД 1).

При сильной боли назначают местные анестетики и НПВП в спреях, растворах и таблетках для рассасывания с учётом возраста. При стрептококковой инфекции местное лечение антибиотики не заменяет.

Бензидамин разрешён с 3 лет, бензокаин с хлоргексидином — старше 4 лет, флурбипрофен — старше 12 лет, кетопрофен — с 12 лет. Средства для горла вообще применяют с 3–4 лет из-за риска ларингоспазма. Миндалины не «смазывают» и налёт механически не снимают.

Дополнительно, в том числе курсами между рецидивами, можно применять растительные препараты: корень алтея, ромашку, тысячелистник, кору дуба, хвощ, листья грецкого ореха, одуванчик.

Пища должна быть щадящей и мягкой: не острой, не кислой, не солёной, не горячей и не холодной.

При неосложнённом тонзиллофарингите хирургическое лечение не рекомендуется.

5. Профилактика, госпитализация, осложнения

разделы 5–7 текста КР
После тесного бытового контакта со стрептококковой инфекцией антибиотики для профилактики назначают беременным со сроком 37 недель и больше, новорождённым и родильницам в первые 28 дней, а также людям 75 лет и старше.

Больных стрептококковым тонзиллофарингитом изолируют от организованных коллективов и ограничивают их контакты.

При рецидивирующем тонзиллофарингите для профилактики рецидивов назначают лизаты бактерий.

При рецидивирующем тонзиллофарингите применяют БАД с естественными бактериями ротоглотки, например *S. salivarius* K12.

После стрептококкового тонзиллофарингита пациента наблюдают месяц: общий анализ крови и мочи делают через 7–10 дней и через 3 недели, а при жалобах со стороны сердца — ЭКГ.

Лечат обычно амбулаторно. На антибиотиках улучшение наступает через 12–24 часа. В детский коллектив ребёнок возвращается после полного выздоровления.

В инфекционное отделение госпитализируют при тяжёлом состоянии и если из-за отказа от еды и питья нужна инфузионная терапия. При подозрении на гнойное осложнение, атипичной картине или необходимости операции пациента консультирует оториноларинголог и его госпитализируют в хирургическое отделение.

Стрептококковая инфекция даёт гнойные осложнения — паратонзиллярный, парафарингеальный, ретрофарингеальный абсцессы, гнойный лимфаденит — и негнойные: острую ревматическую лихорадку, ревматическую болезнь сердца, постстрептококковый гломерулонефрит, стрептококковый токсический шок, PANDAS.

6. Источник и актуальность

всегда полностью

Документ	Клинические рекомендации «Острый тонзиллит и фарингит (Острый тонзиллофарингит)»
Версия	3-я, опубликована в рубрикаторе 31.10.2024
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР — не реже одного раза в три года: следующая ожидается не позднее октября 2027
Код в рубрикаторе	`306_3` · открыть текст КР ↗
Разработчики	Союз педиатров России; Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов; Евро-Азиатское общество по инфекционным болезням; Межрегиональная ассоциация по клинической микробиологии и антимикробной химиотерапии
Пациенты	Взрослые и дети

6.1 Неточности в самом тексте КР

- Дозы цефуроксима, амоксициллина, амоксициллина/клавуланата и клиндамицина в тексте и в таблице 1 различаются — подробно в блоке «Текст КР и таблица 1 расходятся» на вкладке «Лечение».
- В таблице 1 у бензатина бензилпенициллина в колонке «Дети» написано «у пациентов старше 12 лет при m<27 кг 600 тыс. ед» — по смыслу это дозировка по массе тела, как в тексте КР.
- Таблицы доз в PDF извлекаются вперемешку: все строки сверены по изображениям страниц 19–21.

Клинические рекомендации

Отит средний острый

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**H65.0** — Острый средний серозный отит **H65.1** — Другие острые негнойные средние отиты **H66.0** — Острый гнойный средний отит
Пациенты	взрослые, дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 28.10.2024, пересмотр не позднее 2027 года
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/314_3

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 22.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

1. Главное

- Острый средний отит — воспаление всех трёх отделов среднего уха: барабанной полости, клеток сосцевидного отростка и слуховой трубы. Проявляется болью в ухе, температурой, снижением слуха, иногда гноетечением.
- Диагноз ставят, когда одновременно есть внезапное начало, воспаление барабанной перепонки и признаки выпота: выбухание или сниженная подвижность перепонки при пневмоотоскопии или тимпанометрии. Внезапная оторея при исключённом наружном отите тоже подтверждает диагноз.
- Детям до 2 лет с признаками острого среднего отита антибиотик назначают всегда. В любом возрасте он нужен при гнойной форме, при симптомах дольше 72 часов, рецидивирующем отите, отягощающей сопутствующей патологии и если повторно осмотреть пациента нельзя.
- Препарат первой линии — амоксициллин. Если за 3 дня эффекта нет, его меняют на амоксициллин с клавулановой кислотой или цефиксим. Курс — 7–10 дней.
- Для обезболивания назначают НПВП или парацетамол; ушные капли с лидокаином и феназоном можно только при целой барабанной перепонке.
- Через 3–4 недели пациента осматривают повторно с пневмоотоскопией или тимпанометрией, чтобы не пропустить экссудативный средний отит.

2. Клиника и классификация

раздел 1 текста КР

2.1 Определения

Острый средний отит — воспаление всех трёх отделов среднего уха (барабанной полости, клеток сосцевидного отростка и слуховой трубы) с одним или несколькими симптомами: болью в ухе, повышением температуры, снижением слуха, иногда гноетечением. Поражается только слизистая оболочка.

Рецидивирующим отит называют, если за 6 месяцев было 3 эпизода и больше или за 12 месяцев — 4 и больше.

Затянувшимся отит называют, если симптомы воспаления среднего уха сохраняются 3–12 месяцев после одного или двух курсов антибиотиков.

У детей бывают возбуждение, раздражительность, рвота и понос. Обычно болезнь длится не дольше трёх недель.

2.2 Стадии

1) острый евстахеит; 2) катаральное воспаление; 3) доперфоративная стадия гнойного воспаления; 4) постперфоративная стадия гнойного воспаления; 5) репаративная стадия.

В катаральной стадии барабанная перепонка гиперемирована и утолщена, опознавательные знаки едва видны или не видны.

В гнойной стадии боль резко усиливается, температура поднимается до фебрильной, перепонка ярко-красная и выбухает, опознавательных знаков нет; возможна перфорация.

В постперфоративной стадии через перфорацию в слуховой проход поступает гной.

В репаративной стадии жалоб почти нет, цвет и толщина перепонки восстанавливаются, перфорация чаще закрывается рубцом, но слизистая среднего уха ещё не восстановилась.

2.3 Тяжесть

Лёгкое течение	Тяжёлое течение
Нет осложнений	Интратемпоральные или внутричерепные осложнения
Нет выбухания барабанной перепонки	Выраженное выбухание барабанной перепонки
Недолгая боль в ухе, хорошо снимается лекарствами	Выраженная боль (у маленьких детей — изменения поведения), плохо или не снимается лекарствами
Общее состояние не изменено: сон, еда, активность в норме	Общее состояние изменено
Нормальная температура или субфебрилитет не более 3 дней	Субфебрилитет более 3 дней или температура выше 38,0 °C

2.4 Клиническая картина

У детей старше 2 лет главный признак — внезапная боль в ухе на фоне воспаления барабанной перепонки (гиперемия, выбухание, сниженная подвижность при пневмоотоскопии), а после перфорации — оторея. У маленьких детей важнее выбухание перепонки и поведение: беспокойство, отказ от еды, ребёнок дёргает и трёт ухо.

Взрослые чаще жалуются на заложенность уха, аутофонию и шум в ухе.

Тугоухость кондуктивная; сенсоневральный компонент присоединяется редко.

2.5 Возбудитель и выбор антибиотика

Возбудителя иногда можно предположить по клинике: отит с конъюнктивитом чаще вызывает H. influenzae; стремительное начало с лихорадкой, спонтанной перфорацией и симптомами со стороны дыхательных путей — S. pyogenes; нарастающая боль, температура и спонтанная перфорация — S. pneumoniae.

---

3. Диагностика

раздел 2 текста КР
Диагноз ставят, когда одновременно есть три признака: внезапное начало, воспаление барабанной перепонки (гиперемия, инфильтрация) и выпот в барабанной полости (выбухание, сниженная подвижность при пневмоотоскопии или тимпанометрии). Внезапная оторея при исключённом наружном отите тоже подтверждает диагноз.

Каждого пациента должен осмотреть оториноларинголог.

Если реактивных изменений барабанной перепонки нет, её подвижность оценивают при пневматической отоскопии.

Тональную аудиометрию проводят при затяжном течении (дольше 10 дней), рецидивирующем отите или чтобы исключить нейросенсорную тугоухость.

Развёрнутый общий анализ крови делают всем пациентам.

Прокальцитонин определяют при подозрении на тяжёлое течение или в сложных случаях, чтобы подтвердить бактериальную природу отита.

3.1 Маркеры бактериального воспаления

Показатель	Катаральный отит	Гнойный отит
Лейкоциты <10 / 10–15 / >15 ×10⁹/л	50% / 38% / 12%	12% / 29% / 59%
СРБ <15 / 15–60 / ≥60 мг/л	33% / 50% / 17%	14% / 36% / 50%
ПКТ <0,5 / 0,5–2 / 2–10 нг/мл	58% / 38% / 4%	4% / 32% / 64%

Пороги для гнойного отита: лейкоциты >15×10⁹/л — ППР 85%, ПОР 64%; СРБ >30 мг/л — ППР 79%, ПОР 52%; ПКТ >2 нг/мл — ППР 94%, ПОР 74%. Таблица в PDF — изображение; значения перенесены вручную и сверены по изображению страницы 13.

Гнойное отделяемое отправляют на посев с определением чувствительности, если проводят парацентез или есть отделяемое из барабанной полости, а также в стационаре при тяжёлом и рецидивирующем отите.

КТ височных костей нужна при затяжном течении (дольше 10 дней), выраженном ухудшении и при подозрении на мастоидит или внутричерепные осложнения.

Если КТ сделать нельзя, при тех же показаниях делают рентгенографию височных костей по Шюллеру и Майеру.

---

4. Лечение

раздел 3 текста КР

4.1 Боль и температура

При боли и лихорадке назначают НПВП или парацетамол. Их дают разово: при боли в ухе или температуре выше 38,5 °C, а если в анамнезе были фебрильные судороги — уже при 38,0 °C.

Детям до 6 лет можно только парацетамол — до 60 мг/кг в сутки (10–15 мг/кг на приём) — или ибупрофен — до 30 мг/кг в сутки (8–10 мг/кг на приём).

Для местного обезболивания назначают ушные капли с лидокаином и феназоном, но только если барабанная перепонка цела.

4.2 Когда нужен антибиотик

Системные антибиотики назначают при наличии показаний.

Показание	Когда
Возраст до 2 лет	Во всех случаях при клинических признаках ОСО
Гнойная форма — в любом возрасте	Перфорация с гнойным отделяемым; или без перфорации — боль, не снимаемая анальгетиками, с выраженной гиперемией, отсутствием опознавательных знаков, выбуханием перепонки
Симптомы дольше 72 часов — в любом возрасте	Боль, лихорадка или интоксикация при отоскопических признаках ОСО 72 часа и более от начала
Рецидивирующее течение	3 и более эпизода за 6 месяцев или 4 и более за год

Показание	Когда
Сопутствующая патология	Сахарный диабет, иммунодефицит, муковисцидоз, синдромы цилиарной дискинезии, синдром Дауна, врождённые аномалии твёрдого и мягкого нёба
Нельзя повторно осмотреть	Нет возможности контрольного осмотра с отоскопией у ЛОР-врача или врача общей практики

4.3 Выбор антибиотика

Препарат первой линии — амоксициллин, если пациент не принимал его последние 30 дней, у него нет гнойного конъюнктивита и непереносимости аминопенициллинов.

Вторая линия — защищённые пенициллины или цефалоспорины III поколения. Если за 3 дня амоксициллин не помог, его меняют на амоксициллин с клавулановой кислотой или цефиксим.

При затянувшемся и рецидивирующем отите сразу начинают с амоксициллина с клавулановой кислотой или цефиксима внутрь.

Макролиды у детей — третья линия, и только при IgE-опосредованной непереносимости бета-лактамов, потому что устойчивость пневмококка к ним выше 40%.

При лёгкой непереносимости пенициллинов назначают цефалоспорины III поколения: амбулаторно цефиксим, в стационаре при необходимости цефтриаксон парентерально.

Курс длится 7–10 дней. Дольше лечат детей до 2 лет, пациентов с отореей и сопутствующими болезнями; при затянувшемся и рецидивирующем отите курс обычно не меньше 14 дней. Антибиотик не отменяют, пока не прекратилась оторея.

Тетрациклины, линкозамиды, аминогликозиды и ко-тримоксазол не применяют: они плохо действуют на пневмококк и гемофильную палочку и дают много побочных эффектов.

В постперфоративной стадии системные антибиотики продолжают.

4.4 Суточные дозы

Препарат	Взрослые	Дети
Препарат выбора		
Амоксициллин (независимо от еды)	0,5 г × 3 р/сут без факторов риска[1]; 1,0 г × 3 р/сут при факторах риска[2]	50–60 мг/кг/сут в 2–3 приёма[1]
Альтернативные препараты		
Амоксициллин + клавулановая кислота внутрь[3] (в начале еды)	500/125 мг × 3 р/сут или 875/125 мг × 2 р/сут	40–45 мг/кг/сут в 2–3 приёма
Амоксициллин + клавулановая кислота в/в[4]	3,6 г/сут в 3 введения	90 мг/кг/сут в 3 введения (4–40 кг); 60 мг/кг/сут (менее 4 кг)
Ампициллин + сульбактам в/в[3]	1,5–3 г/сут на 4 введения	150–300 мг/кг/сут на 3–4 введения
Цефтриаксон[4]	2,0–4,0 г/сут в 1 введение	50–80 мг/кг/сут в 1 введение
Аллергия на пенициллины (не анафилактическая)		

Препарат	Взрослые	Дети
Цефуроксим (сразу после еды)	500 мг/сут в 2 приёма (так в таблице КР)	до 3 лет: 30 мг/кг/сут в 2 приёма; старше 3 лет: 500 мг/сут на 2 приёма
Цефиксим	400 мг/сут в 1 приём	8 мг/кг/сут в 1 приём
Аллергия на пенициллины и цефалоспорины		
Кларитромицин внутрь (показание «острый средний отит» зарегистрировано только для гранул для суспензии 125 и 250 мг/5 мл)	1000 мг/сут в 2 приёма	15 мг/кг/сут в 2 приёма

[1] [2] Без / при факторах риска устойчивости пневмококка: антибиотики за предшествующие 3 месяца; дети-дошкольники в семье, посещающие детские учреждения; проживание в «закрытых» учреждениях. [3] Факторы риска β-лактамаз: сопутствующие заболевания (бронхиальная астма, сахарный диабет, хронический бронхит), иммуносупрессия, неудача терапии амоксициллином. [4] При высоком риске осложнений.

> Внутри КР есть расхождение. В комментарии к рекомендации об амоксициллине обычная доза для детей — 45–60 мг/кг в сутки, а при высоком риске устойчивого пневмококка — 80–90 мг/кг в сутки, тогда как в таблице 4 для детей указано 50–60 мг/кг в сутки.

Детям до 3 лет амоксициллин дают только в виде суспензии или диспергируемых таблеток. Амоксициллин с клавулановой кислотой и цефиксим в таблетках и капсулах разрешены с 12 лет; детям младше 12 лет с массой меньше 40 кг назначают гранулы, порошок для суспензии или диспергируемые таблетки.

4.5 Местная и вспомогательная терапия

При перфорации назначают ушные капли с фторхинолонами или с дексаметазоном в комбинации с противомикробными средствами, чтобы оторея прекратилась быстрее. Капли с аминогликозидами и спиртом нельзя: они ототоксичны.

Норфлоксацин разрешён детям старше 1 года, ципрофлоксацин — с 15 лет. Офлоксацин и дексаметазон с противомикробными средствами можно детям старше 1 года при остром гнойном отите и установленной тимпаностомической трубке.

Сосудосуживающие капли в нос назначают во всех стадиях, чтобы восстановить проходимость слуховой трубы, но не дольше 5–7 дней. Нафазолин не применяют.

Детям до 6 лет подходят фенилэфрин 0,125%, оксиметазолин 0,01–0,025% и ксилометазолин 0,05% (с 2 лет). До года — только капли, после года по возможности дозированный спрей.

Детям промывают нос изотоническим раствором морской воды 1–2 раза в день. Дошкольникам большие объёмы не используют, потому что это повышает риск отита.

Муколитики можно детям старше 2 лет. Показания проверяют по инструкции: не каждый муколитик для бронхов подходит при отите.

4.6 Хирургия

Парацентез делают при выраженных симптомах и выбухании перепонки без перфорации, при боли, которую не снимают НПВП, и если через 48–72 часа приёма антибиотиков нет улучшения. В сомнительных случаях решают в пользу парацентеза.

При внутривисочных или внутричерепных осложнениях проводят экстренную антромастоидотомию.

5. После острого периода и госпитализация

разделы 4–6 текста КР

Через 3–4 недели оториноларинголог повторно осматривает пациента с пневмоотоскопией или тимпанометрией, чтобы исключить экссудативный средний отит.

Если после отита пациент жалуется на снижение слуха, его направляют к сурдологу-оториноларингологу.

В репаративной стадии продувают слуховые трубы и делают пневмомассаж барабанных перепонок. То, что аэрация восстановилась, подтверждают объективно, в том числе тимпанометрией.

В репаративной стадии пациента консультирует физиотерапевт.

Всех детей прививают от пневмококковой инфекции по национальному календарю.

При рецидивирующем отите планово шунтируют барабанную полость (тимпаностомия).

Экстренно госпитализируют при тяжёлом течении, при лёгком течении без улучшения на адекватном лечении за 3–5 дней и при прогрессирующем ухудшении в любой момент.

Выписывают, когда состояние стабильно удовлетворительное не меньше 3 дней.

Отит тяжелее протекает и чаще осложняется при иммунодефиците и сахарном диабете. Чаще болеют пациенты с ГЭРБ, аллергическим ринитом и курильщики, в том числе пассивные.

6. Источник и актуальность

всегда полностью

Документ	Клинические рекомендации «Отит средний острый»
Версия	3-я, год утверждения 2024, опубликована в рубрикаторе 28.10.2024
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По правилу из приложения А2 КР — не реже одного раза в три года: следующая ожидается не позднее октября 2027
Код в рубрикаторе	314_3 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Пациенты	Взрослые и дети

6.1 Неточности в самом тексте КР

- Детская доза амоксициллина: в комментарии к рекомендации — 45–60 мг/кг/сут («стандартная») и 80–90 мг/кг/сут (при высоком риске устойчивого пневмококка), в таблице 4 — 50–60 мг/кг/сут.
- Цефуроксим взрослым в таблице 4 — «500 мг/сут в 2 приёма»; проверьте по инструкции в ГРЛС.
- У ушных капель с офлоксацином в одном месте указан код АТХ S01AX13 (ципрофлоксацин), выше по тексту у офлоксацина — S01AX11.
- Таблица 2 (маркеры бактериального воспаления) в PDF вставлена изображением — её значения перенесены вручную.
- Капли с норфлоксацином: здесь — детям старше 1 года, в КР «Наружные отиты» (663_2) — с 15 лет. Проверьте по инструкции в ГРЛС.

Клинические рекомендации

Отосклероз

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**H80** — Отосклероз
Пациенты	взрослые, дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 18.03.2024, пересмотр не позднее 2026 года
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/315_4

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 22.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

1. Главное

- Пациент жалуется на прогрессирующее снижение слуха на одно или оба уха и шум в ушах, а барабанная перепонка при отомикроскопии нормальная.
- Всем делают тональную пороговую аудиометрию: для отосклероза типично двустороннее повышение порогов воздушной проводимости на низких и средних частотах (0,125–2 кГц), чаще в виде восходящей кривой, с костно-воздушным интервалом.
- При акустической импедансометрии для отосклероза характерны тимпанограмма типа A или As и отсутствие акустического рефлекса.
- Стапедопластику предлагают пациентам старше 15 лет с кондуктивной или смешанной тугоухостью и костно-воздушным интервалом не меньше 25–30 дБ, если нет признаков активного отосклероза и общих противопоказаний.
- При кохлеарной форме и при активных очагах взрослым проводят инактивирующую терапию.
- Если слух и разборчивость речи недостаточны, в том числе после операции, при кохлеарной форме, противопоказаниях к операции или отказе от неё, подбирают слуховые аппараты.

2. Клиника и классификация

2.1 Определение

Отосклероз — первичное метаболическое поражение костной капсулы ушного лабиринта, особая форма остеодистрофии, обычно двусторонняя и очаговая, в энхондральном слое капсулы. Сначала кость разрушается и образуются мягкие кровенаполненные отоспонгиозные очаги, затем в них откладываются соли кальция и формируется очень плотная склеротическая кость. Фазы размягчения и склерозирования сменяют друг друга волнообразно.

2.2 Причины

Отосклероз наследуется по аутосомно-доминантному типу, ген проявляется у 20–40% носителей.

2.3 Классификация по аудиометрии

В России чаще всего пользуются классификацией Н. А. Преображенского и О. К. Патякиной (1973). Она основана на тональной пороговой аудиометрии (ТПА): учитывают средние пороги костной проводимости (КП) на частотах 0,5, 1 и 2 кГц.

Форма	Средний порог КП (0,5–2 кГц)
Тимпанальная	до 20 (единица в КР не указана)
Смешанная I	21–30 дБ
Смешанная II	больше 30 дБ
Кохлеарная	больше 50 дБ

> Границы форм в КР пересекаются: для смешанной формы II указано «>30 дБ» без верхней границы, а для кохлеарной — «КП >50 дБ». В таблице алгоритма обследования (приложение А3) смешанной форме отведены пороги КП «до 50 дБ», а смешанные формы I и II не разделены.

2.4 Другие классификации

Различают гистологический и клинический отосклероз, а также активную (незрелую, отоспонгиоз) и неактивную (зрелую) стадии. От стадии во многом зависит лечение.

По распространённости очагов на мультиспиральной компьютерной томографии (МСКТ) височных костей с мультипланарной реконструкцией выделяют фенестральную форму (очаги в области окна преддверия), ретрофенестральную (вокруг базального и апикального завитков улитки, у окна улитки, полукружных каналов и дна внутреннего слухового прохода) и смешанную. Очаги бывают единичными и множественными. Денситометрия оценивает плотность капсулы лабиринта: в норме она +2000… +2200 единиц Хаунсфилда (HU); при плотности ниже 1000 HU процесс активный (деминерализация, отоспонгиоз), выше 1000 HU — неактивный.

По тому, что хирург видит в нише окна преддверия во время операции, стапедиальный отосклероз делят на ограниченный, умеренный, распространённый и облитерирующий. Облитерирующие формы — самые сложные для стапедопластики, их делят на три степени: 1 — подножная пластина стремени равномерно утолщена очагами; 2 — очаги сужают нишу окна преддверия по краям, а пластина не изменена; 3 — очаги сужают нишу и захватывают и пластину, и суперструктуры стремени.

2.5 Клиническая картина

Основные симптомы — прогрессирующее, чаще двустороннее снижение слуха и шум в одном или обоих ушах: низко- и среднечастотный у половины пациентов, высокочастотный — у 10%. Примерно у половины пациентов речь в шуме разбирается лучше, чем в тишине (paracusis Willisii, паракузия Виллизия). На головокружение и нарушение равновесия жалуются лишь 24%.

---

3. Диагностика

Диагноз ставят, когда есть жалобы на прогрессирующее снижение слуха на одно или оба уха и шум в ушах, отомикроскопическая картина нормальная, по тональной пороговой аудиометрии тугоухость кондуктивная, смешанная или нейросенсорная при 100% разборчивости речи по речевой аудиометрии, а при акустической импедансометрии тимпанограмма типа А или As и акустических рефлексов нет.

Учитывают также латерализацию ультразвука и пороги его восприятия и данные компьютерной томографии височных костей с денситометрией: участки пониженной плотности на фоне плотной однородной капсулы лабиринта. При фенестральной форме очаг пониженной плотности виден в промонториальной стенке барабанной полости кпереди от окна преддверия, при кохлеарной — очаги повторяют ход завитков улитки и доходят до стенок внутреннего слухового прохода.

> В критериях диагноза о смешанной форме сказано, что у неё признаки, «характерные, как для фенестральной, так и смешанной форм». По смыслу, видимо, имелась в виду кохлеарная форма.

3.1 Жалобы и анамнез

Всех пациентов расспрашивают о прогрессирующем снижении слуха на одно или оба уха.

При всех формах слух снижается постепенно и как будто без причины. Тугоухость обычно двусторонняя, односторонняя — в 15–30% случаев. Если слух начал снижаться рано, очаги чаще облитерирующие и распространённые, а тугоухость нарастает быстро; при позднем начале очаги ограниченные, и быстрого прогрессирования нет.

Всех пациентов спрашивают о шуме в одном или обоих ушах.

Шум обычно низко- и среднечастотный (у 50%), реже высокочастотный (у 10%). В начале болезни он слышен только в тишине, а по мере нарастания тугоухости усиливается.

Всех пациентов спрашивают, не слышат ли они лучше в шумной обстановке.

Паракузия Виллизия встречается примерно у половины пациентов, чаще при выраженной фиксации стремени с сохранной костной проводимостью. Когда тугоухость становится смешанной, этот симптом находят реже.

Всех пациентов спрашивают о головокружении и нарушениях равновесия.

На них жалуются около 24% пациентов с отосклерозом. Их объясняют внутрилабиринтной гипертензией: после операции эти расстройства проходят.

3.2 Осмотр

Всем пациентам выполняют отомикроскопию или отоэндоскопию, чтобы оценить наружный слуховой проход и барабанную перепонку.

Барабанная перепонка целая, опознавательные контуры чёткие. Характерные признаки отосклероза видны лишь у 10–21% пациентов.

К таким признакам относят симптом Лемперта (истончённая барабанная перепонка изменённого цвета из-за атрофии фиброзного слоя), симптом Хилова (истончение кожи слухового прохода), симптом Тойнби (серы мало или нет), симптом Швартца (через истончённую перепонку просвечивают расширенные сосуды мыса — признак активной стадии, бывает у 50%) и симптом Вирховского — Тилло (снижены чувствительность кожи прохода и перепонки и потоотделение, проход широкий). Ни один из них не патогномоничен, их оценивают только вместе с другими проявлениями болезни.

Специфической лабораторной диагностики нет. Анализы делают при подготовке к плановой операции.

3.3 Исследование слуха

Всем пациентам проводят камертональные пробы Ринне, Федеричи и Вебера, чтобы скрининговo оценить характер тугоухости.

Камертоны С128–С512 показывают костно-воздушный интервал (пробы Ринне и Федеричи) и хуже слышащее ухо (проба Вебера) — это повод для тональной аудиометрии. При кохлеарной форме пробы Ринне и Федеричи положительные, а звук в пробе Вебера латерализуется в лучше слышащее ухо.

Всем пациентам выполняют тональную пороговую аудиометрию, чтобы оценить форму и степень тугоухости.

Оценивают пороги воздушной (ВП) и костной проводимости и величину костно-воздушного интервала (КВИ, резерв улитки). Типично двустороннее повышение порогов ВП на низких и средних частотах (0,125–2 кГц), чаще в виде восходящей кривой с небольшим подъёмом. С течением болезни растут и пороги КП — из-за поражения звукопроводящего аппарата и нарушения проведения внутри улитки. Нарушением микромеханики и гидродинамики улитки на частотах 0,5–2 кГц теория Р. Кархарта объясняет механическую природу сенсоневрального компонента. По виду кривой различают тимпанальную, смешанную и кохлеарную формы.

При речевой аудиометрии разборчивость речи составляет 100%.

Всем пациентам исследуют чувствительность к ультразвуку и его латерализацию, чтобы оценить характер тугоухости.

При отосклерозе пороги восприятия ультразвука — до 15 дБ, при кохлеарной форме — в норме или чуть выше. При кохлеарной форме с односторонней или асимметричной двусторонней тугоухостью ультразвук латерализуется в лучше слышащее ухо. Латерализация в хуже слышащее ухо (60,9% случаев) может указывать в том числе на гидропс лабиринта из-за нарушения гидродинамики; это характерно для болеющих дольше 10 лет и подтверждается экстратимпанальной электрокохлеографией (ЭКоГ).

Очаги могут вовлекать утрикулярный нерв и сдавливать эндолимфатический проток, а выраженная обструкция его дистального отдела — расширять саккулюс вплоть до контакта с основанием стремени. Однако ни одна методика не позволяет с полной уверенностью выявить гидропс лабиринта и определить, эндо- или перилимфатический он, хотя это важно для показаний к операции и её результата.

Всем пациентам выполняют акустическую импедансометрию — тимпанометрию и акустическую рефлексометрию, — чтобы исключить патологию среднего уха и оценить давление в нём, вентиляционную функцию слуховой трубы, подвижность барабанной перепонки и состояние цепи слуховых косточек.

Для отосклероза характерны тимпанограмма типа A или As и отсутствие акустического рефлекса.

Акустическая импедансометрия — комплексный метод, который включает тимпанометрию, определение акустического импеданса (сопротивления) и акустического миорефлекса.

3.4 Слух и импедансометрия при разных формах

Показатель	Тимпанальная	Смешанная	Кохлеарная
Тональная аудиометрия: вид кривой; пороги КП (0,5–2 кГц); КВИ	горизонтальная; до 20 дБ; 30–50 дБ	пологонисходящая; до 50 дБ; 30 дБ	крутонисходящая; выше 50 дБ; меньше 10 дБ
Разборчивость речи	100%	100%	100%
Пороги чувствительности к ультразвуку (в КР — «вт»)	10	10–15	больше 15
Феномен ускоренного нарастания громкости (ФУНГ)	нет	редко	часто
Тимпанометрия	тип А	тип А	тип А
МСКТ височных костей	фенестральная локализация очагов	фенестральная и улитковая локализация очагов	часто деминерализация улитки

> В таблице алгоритма обследования названия форм сдвинуты на одну колонку влево: «тимпанальная» стоит под заголовком «Алгоритм обследования», а над последней колонкой названия нет. Здесь колонки приведены по смыслу, в соответствии с классификацией: горизонтальная кривая и КП до 20 дБ — тимпанальная форма. Пороги ультразвука в таблице даны в ваттах («10 вт», «>15 вт»), а в тексте КР — в децибелах («до 15 дБ»). В таблице для всех форм указана только тимпанограмма типа А, а в тексте — «А» или «As». Текст ссылается на эту таблицу как на приложение Г1, но в приложении Г1 написано «Отсутствуют», а таблица стоит в приложении А3.

3.5 Компьютерная томография

Всем пациентам выполняют компьютерную томографию височных костей, чтобы подтвердить отосклероз, определить локализацию и распространённость очагов и оценить их активность.

МСКТ с шагом 0,3–1 мм в аксиальной и коронарной проекциях с мультипланарной реконструкцией и денситометрией — единственный объективный неинвазивный метод для этого; чувствительность 80–95%, специфичность 99,1%.

До операции МСКТ выявляет особенности строения и болезни височной кости, которые имитируют отосклеротическую тугоухость или снижают эффект операции: неотосклеротическую фиксацию цепи косточек, дегисценцию верхнего полукружного канала, расширение водопровода преддверия, остеодистрофии (синдром Ван-дер-Хуве), облитерирующий отосклероз, оссификацию окна улитки и лабиринта.

Снижение плотности капсулы лабиринта с нормальных +2000…+2200 до +1500…+300 HU говорит о начальной или далеко зашедшей деминерализации.

При фенестральной форме очаги чаще всего видны в области впередиоконной щели и переднего полюса основания стремени, переходят на его переднюю ножку. Плотность зрелых очагов обычно +1000…+1100 HU; при +500…+800 HU можно предположить активный отосклероз (отоспонгиоз). Тугоухость при фенестральных очагах бывает от тимпанальной до смешанной.

При смешанной форме, кроме фенестральных очагов, видны участки пониженной плотности капсулы вокруг улитки, переходящие на область окна улитки, иногда до дна внутреннего слухового прохода. На аудиограмме при этом может быть смешанная тугоухость 1–2 степени.

При кохлеарном отосклерозе в начальной стадии в капсуле вокруг улитки видны участки плотностью +1500…+1100 HU. В умеренно активной стадии вокруг базального и апикального завитков определяются хорошо заметные участки +1000…+600 HU, которые часто переходят на область окна улитки и могут доходить до дна внутреннего слухового прохода и горизонтального полукружного канала.

В стадии высокой активности деминерализация захватывает капсулу на уровне базального и апикального завитков, может доходить до преддверия и полукружных каналов, плотность +300…+600 HU. В этой стадии возможна костная облитерация структур лабиринта, чаще всего базального завитка и горизонтального полукружного канала.

> Плотность активных очагов в КР указана по-разному: в тексте о фенестральной форме — +500…+800 HU, в подписи к рисунку 1 — +300…+800 HU. В подписи к рисунку 3 для кохлеарной формы указано +600…+800 HU, а в тексте рядом — +1000…+600 HU для умеренной и +300…+600 HU для высокой активности.

МСКТ помогает найти и причину неудачной стапедопластики: оценить положение протеза и глубину его погружения в преддверие, некроз длинной ножки наковальни, перилимфатическую фистулу и гранулему окна преддверия.

---

4. Лечение

4.1 Инактивирующая терапия

Инактивирующую терапию проводят взрослым с кохлеарной формой, с тимпанальной и смешанной формами в активной стадии перед операцией, а также если активный отосклероз обнаружен во время операции. Цель — инактивировать очаги отоспонгиоза.

Терапия снижает активность отосклероза, тормозит нарастание сенсоневрального компонента, повышает плотность капсулы лабиринта, уменьшает вероятность реоссификации после операции, останавливает рост очагов и препятствует облитерации улитки.

Курсы назначают с учётом плотности очагов отоспонгиоза по МСКТ височных костей с денситометрией. Все препараты комплекса в КР отмечены знаком # — применение вне инструкции.

4.2 Один курс у взрослых

Препарат	Доза
#Ибандроновая кислота	Внутривенно болюсом за 15–30 секунд 3 мг/3 мл однократно в процедурном кабинете, 1 раз в 3 месяца, или внутрь 150 мг 1 раз в месяц за час до еды, запивая стаканом воды.
#Алендроновая кислота	Вместо ибандроновой: 70 мг 1 раз в неделю за час до еды, запивая стаканом воды.
#Кальция глюконат	500 мг 3 раза в день после еды.
#Натрия фторид	30–60 мг (0,5 мг/кг) в течение 2 месяцев.
#Альфакальцидол	0,25 мкг 1 раз в день.

Курс длится 3 месяца. В зависимости от плотности очагов проводят 1, 2 или 4 курса с перерывами по 3 месяца, пока плотность очагов не достигнет +1000…+1500 HU.

Плотность очагов по МСКТ	Число курсов
ниже +300 HU	4
+300…+600 HU	2
+600…+900 HU	1

> Активными КР считает очаги плотностью ниже 1000 HU, но число курсов указано только до +900 HU: для очагов +900…+1000 HU схемы нет.

4.3 Стапедопластика

Показания к операции: жалобы на снижение слуха и шум в ухе, кондуктивная или смешанная тугоухость с КВИ не меньше 30 дБ, нет признаков активного отосклероза по отомикроскопии и МСКТ с денситометрией, нет перфорации барабанной перепонки и инфекции слухового прохода, нет общих противопоказаний к плановой операции.

Стапедопластику выполняют пациентам старше 15 лет при кондуктивной или смешанной тугоухости с КВИ не меньше 25–30 дБ, если нет признаков активного отосклероза по отомикроскопии и КТ с денситометрией и нет общих противопоказаний к плановой операции.

Операция паллиативная. В её пользу говорит то, что в неоперированных ушах нейросенсорный компонент нарастает сильнее, чем в оперированных.
Операция противопоказана при остром воспалении и обострении хронического, при декомпенсации сопутствующих болезней. Относительные противопоказания — активный отосклероз, единственное слышащее ухо и широкий водопровод преддверия по МСКТ: описана глухота после операции у пациентов с этим синдромом.

> Порог КВИ для операции в КР назван трижды и по-разному: в показаниях к хирургическому лечению (раздел 3.2) — не меньше 30 дБ, в самой рекомендации — 25–30 дБ, в показаниях к госпитализации (раздел 6) — не меньше 25 дБ.

Основание стремени вскрывают двумя способами: стапедотомией (методика малого окна, поршневая) или стапедэктомией (большого окна, частичной или тотальной). Протезы делают из алло- и аутотканей и биосовместимых материалов — тефлона, керамики, пластипора, стали, титана, платины; сухожилие стременной мышцы и наковальне-стременное сочленение сохраняют или нет, окно преддверия изолируют аутотканью (вена, жир, клетчатка, фасция) или нет.

Шире всего в мире распространена поршневая методика J. Shea (1962): она мало травмирует внутреннее ухо, проста и даёт КВИ не больше 10 дБ у 58–98% пациентов.

Эффективны и стапедотомия, и частичная стапедэктомия; стапедэктомия быстрее сокращает КВИ в раннем послеоперационном периоде. Сенсоневральная тугоухость после операции развивается у 3,5–5,9%, глухота — у 0,9–2%.

Методику выбирают по данным обследования до операции (возраст, жалобы, анамнез, пороги КП и КВИ, строение височной кости по МСКТ) и по находкам во время операции: распространённости и активности очагов, строению ниши окна преддверия и канала лицевого нерва, кровоточивости тканей и давлению перилимфы.

Поршневую стапедопластику выбирают в молодом возрасте (до 40 лет), при активных очагах, узкой нише окна преддверия, распространённых формах с крупными очагами на промонториуме, облитерирующих формах и сильной кровоточивости. Аутотканевую — у пожилых пациентов, особенно с давним снижением слуха, при смешанных формах и расширенном водопроводе улитки по МСКТ. Если аутотканевая невозможна, ставят протез на аутовенозный трансплантат.

4.4 Выбор методики стапедопластики

Критерий	Поршневая	Протез на аутовену	Аутоткани
Молодой возраст (до 40 лет)	+	+	–
Болеет дольше 10 лет	–	–	+
Смешанная форма II	–	+	+
Активный отосклероз	+	+	–
Облитерирующий отосклероз	+	–	–
Анатомически узкая ниша окна преддверия	+	+	–
Гидропс лабиринта по ЭКоГ	+	+	+
Расширенный водопровод улитки, дегисценция верхнего полукружного канала и гидропс по ЭКоГ (перилимфатический гидропс)	–	+	+
Расширенный водопровод преддверия и гидропс по ЭКоГ (эндолимфатический гидропс)	–	в КР не заполнено	–

Чем больше диаметр отверстия в основании стремени и протеза при качественном выполнении, тем лучше гидродинамика лабиринта: пороги КП снижаются на 10–20 дБ по всей тон-шкале. При поршневой методике этого не бывает.

4.5 Доля пациентов с КВИ не больше 10 дБ после операции

Методика	10–12 дней	1 месяц	3 месяца	6 месяцев	1 год
Аутотканевая	38%	78%	96%	96%	100%
Поршневая	20%	50%	56%	78%	76%

> Текст ссылается на таблицу критериев выбора методики как на «табл. 1», но номера у неё нет; в строке об эндолимфатическом гидропсе клетка для протеза на аутовену пустая. На рисунке 7 столбцы методики с протезом на аутовену не подписаны значениями.

4.6 Кохлеарная имплантация и слухопротезирование

Взрослым с отосклерозом рекомендуют кохлеарную имплантацию; показания уточнены в комментарии.

Её рекомендуют при кохлеарной форме или высоких порогах после стапедопластики с двусторонней тугоухостью 4–5 степени, если разборчивость простых односложных слов по речевой аудиометрии с оптимально подобранными аппаратами на оба уха меньше 30%, по МСКТ и МРТ нет патологии улитки, а пациент достаточно мотивирован.

Электроакустическую реабилитацию (слуховые аппараты) проводят всем пациентам с недостаточным слухом и разборчивостью речи, в том числе после операции, при кохлеарной форме, при общих противопоказаниях к операции и при отказе от неё.

Слухопротезирование показано, если слух ниже социального: пороги КП больше 30 дБ или ВП больше 45 дБ на речевых частотах. Учитывают феномен ускоренного нарастания громкости, который бывает и после операции, и вне её, а также желание пациента, единственное слышащее ухо, противопоказания к операции и отказ от неё.

---

5. Наблюдение, профилактика, госпитализация

Реабилитация — те же слуховые аппараты при слухе ниже социального уровня (пороги КП больше 30 дБ или ВП 45 дБ и больше на речевых частотах): после операции, в том числе на единственном слышащем ухе, при противопоказаниях к операции или отказе от неё и при кохлеарной форме.

> Порог воздушной проводимости для слухопротезирования в разделе 3.3 записан как «более 45 дБ», а в разделе 4 — «45 и более дБ».

Методов профилактики отосклероза и диспансерного наблюдения в КР нет.

Первично пациента осматривают оториноларинголог и сурдолог-оториноларинголог.

5.1 Госпитализация

Планово госпитализируют для операции, если есть жалобы на снижение слуха и шум, тугоухость кондуктивная или смешанная с КВИ не меньше 25 дБ, нет признаков активного отосклероза по отомикроскопии и МСКТ, перфорации перепонки, инфекции слухового прохода и общих противопоказаний, а обследование, которое требует стационар, выполнено.

Выписывают на 7–10-й день после контрольной тональной аудиометрии: пороги КП должны остаться на дооперационном уровне, а КВИ в зависимости от методики — сохраниться прежним или сократиться за счёт улучшения порогов ВП.

После операции в зависимости от методики назначают постельный режим на 1–2 суток с положением на противоположном ухе. Месяц ухо берегут от воды и громких звуков, летать на самолёте нельзя 3 месяца.

В информации для пациента сказано, что операция даёт положительный результат у девяти из десяти пациентов, а неэффективна менее чем у 1%.

> Информация для пациента расходится с основным текстом. В ней сказано, что пациентов лечит и наблюдает сурдолог, а в разделе 6 первичный приём ведут оториноларинголог и сурдолог-оториноларинголог. В ней же сказано, что слуховые аппараты помогают лишь на поздних стадиях, когда операция не показана, а в разделе 3.3 их рекомендуют и после операции, и при отказе от неё.

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Отосклероз»
Версия	4-я, опубликована в рубрикаторе 18.03.2024
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	На титульном листе КР указано «Пересмотр не позднее: 2026», следующая версия ожидается не позднее 2026 года
Код в рубрикаторе	315_4 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Пациенты	Взрослые и дети

6.1 Неточности в самом тексте КР

- Порог КВИ для стапедопластики указан трижды по-разному: 30 дБ (показания, раздел 3.2), 25–30 дБ (рекомендация), 25 дБ (показания к госпитализации, раздел 6).
- В классификации Преображенского — Патякиной границы смешанной формы II («>30 дБ») и кохлеарной («>50 дБ») пересекаются, у тимпанальной формы («до 20») нет единицы; в таблице приложения А3 смешанной форме отведено «до 50 дБ».
- В таблице алгоритма обследования (приложение А3) названия форм сдвинуты на одну колонку влево.
- Пороги ультразвука в таблице приложения А3 даны в ваттах, а в тексте раздела 2.4 — в децибелах.
- В тексте для отосклероза названа тимпанограмма типа «А» или «As», в таблице приложения А3 — только тип А.
- Текст ссылается на приложение Г1 (формы отосклероза) и Г2 (стапедопластика), но в приложении Г1 написано «Отсутствуют», приложения Г2 нет, а нужные таблицы стоят в приложении А3. Приложение Б (алгоритмы) пустое.
- В критериях диагноза для смешанной формы написано «признаки характерные, как для фенестральной, так и смешанной форм» — вероятно, вместо «кохлеарной».
- Плотность активных очагов на МСКТ в тексте и подписях к рисункам 1 и 3 не совпадает.
- Число курсов инактивирующей терапии указано только для очагов до +900 HU, хотя активными считаются очаги ниже 1000 HU.
- Порог ВП для слухопротезирования: «более 45 дБ» в разделе 3.3 и «45 и более дБ» в разделе 4.
- Таблица критериев выбора методики стапедопластики названа в тексте «табл. 1», но не пронумерована; одна клетка в ней пустая.
- Информация для пациента противоречит разделам 3.3 и 6: в ней лечит сурдолог, а слуховые аппараты помогают «лишь на поздних стадиях».
- В разделе 3.1 остались черновые фрагменты: «источник, где указана дозировка», «Достигаемым техническим результатом является…», «препаратофективен»; тональная аудиометрия сокращается то ТПА, то ТАП.

Клинические рекомендации

Паратонзиллярный абсцесс

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**J36** — Перитонзиллярный абсцесс **J39.0** — Ретрофарингеальный и парафарингеальный абсцесс **J39.1** — Другой абсцесс глотки
Пациенты	взрослые, дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 20.11.2024, пересмотр не позднее 2027 года
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/664_2

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 22.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

1. Главное

- Паратонзиллярный абсцесс лечит оториноларинголог в стационаре, и основа лечения — хирургическое вскрытие абсцесса.
- Чаще всего, более чем в 70% случаев, абсцесс располагается спереди и сверху — между капсулой миндалины и верхней частью передней дужки.
- Антибиотики широкого спектра, действующие и на анаэробы, назначают сразу, не дожидаясь посева; курс обычно 10–14 дней.
- При частых ангинах, повторном или затяжном абсцессе, плохом дренировании и кровотечении после вскрытия удаляют миндалины одновременно со вскрытием абсцесса.
- После простого вскрытия двустороннюю тонзиллэктомию делают планово через 3 месяца.

2. Клиника и классификация

2.1 Определение

Паратонзиллярный абсцесс — гнойное расплавление клетчатки вокруг миндалины, между её псевдокапсулой и глоточной фасцией, покрывающей констрикторы глотки.

2.2 Причины

Чаще всего абсцесс развивается как осложнение ангины, реже — хронического тонзиллита. Возможен одонтогенный путь — от кариеса задних нижних зубов (вторых моляров, зубов мудрости) и периостита альвеолярного отростка, а также инфицирование инородным телом, например рыбной костью.

Возбудители — чаще всего бета-гемолитический стрептококк группы А и неспорообразующие анаэробы.

При обращении отёчная форма паратонзиллита встречается редко, инфильтративная — у 15–20%, абсцедирующая — у 80–85% пациентов. От начала болезни до абсцесса обычно проходит 4–6 дней, но иногда всего несколько часов.

2.3 Локализация

Передневерхний (супратонзиллярный) абсцесс — больше 70% случаев, между капсулой миндалины и верхней частью передней дужки. Задний — около 15%, между миндалиной и задней дужкой. Нижний — чуть больше 5%, между нижним полюсом миндалины и боковой стенкой глотки. Боковой — меньше 5%, между средней частью миндалины и боковой стенкой глотки.

2.4 Клиническая картина

Абсцесс обычно возникает на фоне ангины или через несколько дней после неё. Сначала появляется боль при глотании, которая становится постоянной, резко усиливается при попытке проглотить слюну и отдаёт в ухо и зубы. Беспокоят головная боль и разбитость, температура поднимается до фебрильной, пациенты отказываются от еды и питья. Почти всегда постепенно нарастает тризм, речь становится невнятной и гнусавой. Из-за боли при поворотах пациент держит голову набок и поворачивается всем корпусом.

При передневерхнем абсцессе верхний полюс миндалины вместе с дужками и мягким нёбом резко выбухает к средней линии, язычок смещён в противоположную сторону, миндалина оттеснена книзу и кзади.

При заднем абсцессе припухлость видна в области задней дужки, процесс может переходить на боковую стенку глотки; миндалина и передняя дужка мало изменены, язычок и мягкое нёбо отёчны.

При нижнем абсцессе в глотке видны лишь отёк и инфильтрация нижней части передней дужки, хотя жалобы выражены. Может вовлекаться корень языка, иногда отекает язычная поверхность надгортанника, и отёк, распространяясь на гортань, может привести к её стенозу.

Боковой абсцесс встречается реже всего, но протекает тяжелее всех: гною трудно прорваться в глотку. Выражены отёк и инфильтрация мягких тканей шеи на стороне поражения, кривошея и тризм, а в глотке видно лишь умеренное выбухание всей миндалины.

2.5 Жалобы и анамнез

Важно узнать о недавних ангинах, хроническом тонзиллите, прошлых паратонзиллитах и абсцессах и их лечении, о кариесе и возможном инородном теле, например рыбной кости.

Характерны сильная, обычно односторонняя боль в горле, усиливающаяся при глотании и отдающая в ухо и зубы, ощущение инородного тела, гнусавость, неприятный запах изо рта, боль в шее при поворотах головы, тризм и слюнотечение. Из общих жалоб — слабость, разбитость, фебрильная температура и головная боль; они неспецифичны и требуют дифференциальной диагностики.

---

3. Диагностика

Диагноз ставят по анамнезу, осмотру с тщательной оценкой подчелюстной области и лимфоузлов, фарингоскопии и анализам.

Каждого пациента с подозрением на абсцесс осматривает оториноларинголог.

Местные признаки, наиболее выраженные при переднем абсцессе: яркая гиперемия, отёк и инфильтрация дужек, миндалин, мягкого нёба и язычка, асимметрия мягкого нёба, смещение миндалины, ограничение открывания рта, регионарный лимфаденит.

Фарингоскопию проводят всем детям и взрослым; её данные решают диагноз.

Если есть подозрение, что воспаление распространилось на гортаноглотку, проводят непрямую ларингоскопию или фиброларингоскопию.

КТ и УЗИ шеи делают в тяжёлых случаях, когда нужно уточнить диагноз и локализацию абсцесса или отличить его от воспаления глубоких отделов шеи.

3.1 Анализы

Всем делают развёрнутый анализ крови, СРБ и анализ мочи. Высокий лейкоцитоз со сдвигом влево и высокий СРБ говорят о высоком риске осложнений и требуют коррекции лечения, в том числе антибиотиков.

Гной после вскрытия отправляют на посев на аэробы и анаэробы с определением чувствительности, а мазок с миндалин — на дифтерийную палочку, чтобы исключить дифтерию.

Лучше брать не сам гной, а смыв или мазок со стенок полости: ферменты гноя разрушают микробы. Материал доставляют в лабораторию в транспортной среде, оптимально за 40 минут.

3.2 Дифференциальная диагностика

Абсцесс отличают от дифтерии, скарлатины, абсцесса язычной миндалины, абсцессов подъязычной области, флегмоны дна полости рта, опухолей ротоглотки и перикоронита.

При дифтерии слизистая бледно-цианотичная, налёты сероватые и выходят за пределы миндалин, но тризма нет.

При скарлатине есть сыпь на коже, чёткая граница поражённой слизистой и «малиновый» язык. При абсцессе язычной миндалины нет тризма и типичных изменений в ротоглотке. При флегмоне дна полости рта боль и отёк в подчелюстной области, язык малоподвижен, а дужки и миндалины не изменены.

Опухоли миндалины развиваются медленно, без температуры, сильной боли и тризма, а лимфоузлы плотные, малоболезненные и малоподвижные.

Изредка припухлость в глотке вызвана близко расположенной сонной артерией или её аневризмой; диагноз подсказывает видимая пульсация.

---

4. Лечение

Пациента лечит оториноларинголог в специализированном учреждении; основа лечения — хирургическая санация полости абсцесса.

4.1 Хирургическое лечение

Впервые возникший абсцесс вскрывают и дренируют.

Правила при любой технике: убедиться, что в месте вскрытия нет пульсации; глубже 0,5 см продвигаться только тупым путём; вскрывать достаточно широко, до 4 см.

Разрез выбирают по локализации, под местной аппликационной анестезией. Передневерхний абсцесс вскрывают через переднюю дужку в типичном месте или в месте наибольшего выбухания, задний — через заднюю дужку, отступив 0,5 см от края, нижний — в нижней части передней дужки. Ткани рассекают вдоль сосудов на глубину 0,5–1 см, дальше раздвигают корнцангом.

Затем регулярно разводят края разреза, пока полость не начнёт заживать.

При частых ангинах в анамнезе, повторном паратонзиллите или абсцессе, затяжном течении, плохом дренировании и кровотечении после вскрытия удаляют нёбные миндалины одновременно со вскрытием абсцесса: так убирается и сам очаг инфекции.

Такую операцию делают в любом возрасте, от 3–4 до 70 лет и старше. Противопоказания — терминальное или крайне тяжёлое состояние из-за болезней внутренних органов, тромбоз сосудов мозга, разлитой менингит.

После операции осматривают нишу миндалины: выпячивание в ней — признак парафарингеального абсцесса.

4.2 Антибиотики

Системные антибиотики назначают сразу, не дожидаясь посева. Так как в абсцессе обычно есть анаэробы, нужны препараты широкого спектра, которые действуют и на них.

Препарат	Доза
Амоксициллин и клавулановая кислота	С 12 лет или с массой от 40 кг — 500/125 мг 3 раза в сутки или 875/125 мг 2 раза в сутки. Можно #амоксициллин с сульбактамом по 1 г 2–3 раза в сутки с 12 лет, до 10 дней. Детям до 12 лет — 20–40 мг/кг в сутки в 2–3 приёма.
Цефтриаксон	Внутримышечно или внутривенно 2 г 1 раз в сутки; длительность в таблице КР указана так: «в течение 4–14 дней до 10 дней». Новорождённым до 2 недель — 20–50 мг/кг 1 раз в сутки, не больше 50 мг/кг; детям от 15 дней до 12 лет — 20–80 мг/кг 1 раз в сутки.
Цефотаксим	Внутримышечно или внутривенно 1 г 2 раза в сутки, до 10 дней. Новорождённым и детям до 12 лет — 50–100 мг/кг в сутки с интервалом 6–12 часов; недоношенным — не больше 50 мг/кг в сутки.

Препарат	Доза
Клиндамицин	300 мг 2 раза в сутки, при тяжёлом течении — до 1,2–4,8 г в сутки в 2–4 приёма. Детям при непереносимости цефалоспоринов III поколения — #20–40 мг/кг в сутки в 3–4 приёма.

Курс обычно 10–14 дней. Препараты выбора — пенициллины, в том числе с ингибиторами бета-лактамаз. Если глотать таблетки трудно, используют диспергируемые формы, суспензии или инъекции. При выраженном отёке тканей глотки и шеи, сильном тризме и высоком риске генерализации назначают парентеральные цефалоспорины III поколения, а при их непереносимости — клиндамицин. Детям предпочтительны ампициллин с сульбактамом и амоксициллин с клавулановой кислотой.

4.3 Другие лекарства

При выраженных воспалительных проявлениях назначают НПВП в обычных дозах.

Всем назначают системные антигистаминные препараты.

КР рекомендует и средства для повышения сопротивляемости — препараты кальция, витамины С и А, — избегая полипрагмазии.

При выраженной интоксикации проводят инфузионную дезинтоксикационную терапию.

Всем назначают местные противовоспалительные, обезболивающие и антисептические средства: полоскания, инсуффляции, ингаляции, таблетки для рассасывания. Системные антибиотики они не заменяют.

После операции, не раньше чем через 3 недели после стихания воспаления, пациента консультирует физиотерапевт.

4.4 После вскрытия

После вскрытия абсцесса двустороннюю тонзиллэктомию делают планово через 3 месяца.

После тонзиллэктомии месяц ограничивают физическую нагрузку.

---

5. Профилактика, госпитализация, осложнения

При диспансеризации выявляют факторы риска — хронический тонзиллит и рецидивирующие ангины; профилактика включает закаливание и своевременное лечение зубов и дёсен.

Лечат в хирургическом стационаре. Показание к госпитализации — необходимость вскрыть абсцесс или удалить миндалины со вскрытием абсцесса. После вскрытия состояние улучшается уже через 12–24 часа. После абсцесстонзиллэктомии без осложнений выписывают на 5–7-е сутки.

Без лечения или при неправильном лечении высок риск гнойных осложнений: флегмоны шеи, медиастинита, тонзиллогенного сепсиса, инфекционно-токсического шока. Риск выше при иммунодефиците — врождённом, на иммуносупрессорах и цитостатиках, при ВИЧ.

---

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Паратонзиллярный абсцесс»
Версия	2-я, опубликована в рубрикаторе 20.11.2024
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее ноября 2027 года
Код в рубрикаторе	664_2 · открыть текст КР ↗

Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Пациенты	Взрослые и дети

6.1 Неточности в самом тексте КР

- Для цефтриаксона в таблице 1 написано «в течение 4-14 дней до 10 дней» — сроки противоречат друг другу; на сайте указано «до 10 дней».
- Знак # у амоксициллина с сульбактамом и у детской дозы клиндамицина означает применение вне инструкции.

Клинические рекомендации

Полипозный риносинусит

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**J33.0** — Полип полости носа **J33.1** — Полипозная дегенерация синуса **J33.8** — Другие полипы синуса **J33.9** — Полип носа неуточненный
Пациенты	взрослые
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 26.12.2024, пересмотр не позднее 2027 года
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/890_1

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 22.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

1. Главное

- Диагноз ставят по жалобам, анамнезу, осмотру и инструментальным данным: передней риноскопии, эндоскопии полости носа и носоглотки и КТ околоносовых пазух.
- Препарат выбора — мометазон в виде назального спрея по 100 мкг в каждую половину носа 2 раза в сутки курсом 3–6 месяцев. Если за 5–6 недель симптомы не уменьшились, обсуждают операцию.
- Системные антибиотики при полипозном риносинусите не рекомендуются.
- При тяжёлом течении, а также при сочетании с бронхиальной астмой рекомендуется генно-инженерная биологическая терапия: дупилумаб, омализумаб или меполизумаб.
- Если лекарства не помогают или полипоз распространённый, показана операция, оптимально — функциональная эндоскопическая риносинусохирургия.
- В первый год после операции пациента осматривают каждые 3 месяца.

2. Клиника и классификация

2.1 Определение

Полипозный риносинусит (ПРС) — фенотип хронического риносинусита. Это неоднородное по причинам и механизмам хроническое воспаление слизистой оболочки носа и околоносовых пазух (ОНП), которое длится больше 12 недель и сопровождается её ремоделированием, образованием и повторным ростом полипов.

Полипы носа — доброкачественные новообразования слизистой оболочки носа и околоносовых пазух.

Т2-эндотип ПРС — воспаление с эозинофилией крови или ткани либо с повышенным общим IgE. К нему относят эозинофильный хронический риносинусит, аллергический грибковый риносинусит и центральную компартментную атопическую болезнь (CCAD) — изолированные полипозные изменения слизистой верхней и средней носовых раковин и задневерхних отделов перегородки у пациентов с установленной аллергией на ингаляционные аллергены.

2.2 Причины

В развитии ПРС участвуют нарушения врождённого и адаптивного иммунитета, аллергия, генетически обусловленные болезни (иммунодефициты, муковисцидоз, первичная цилиарная дискинезия), изменения внутриносовой анатомии и инфекция — бактериальная, грибковая, вирусная. Вместе или по отдельности они поддерживают хроническое воспаление слизистой носа, которое ведёт к образованию полипов и рецидивам.

Эозинофильный и неэозинофильный эндотипы ПРС различаются клиническими проявлениями, течением и ответом на лечение.

Из анатомических изменений у больных риносинуситом чаще всего встречаются искривление перегородки носа (36%), concha bullosa (30%), клетки Оноди (12%) и клетки Галлера (6%), реже — парадоксальный изгиб средней раковины (3%) и пневматизация крючковидного отростка (2%).

2.3 Классификация

Единой классификации нет. Клинически и эндоскопически различают три стадии: в первой полипы ограничены средним носовым ходом, во второй выходят за его пределы, в третьей обтурируют соответствующую половину носа.

Для эндоскопической оценки используют шкалу Lund — Kennedy: полипы, отёк и отделяемое оценивают отдельно справа и слева, каждый признак — от 0 до 2 баллов.

2.4 Шкала Lund — Kennedy

Признак	0 баллов	1 балл	2 балла
Полипы	Полипов нет	Полипы в среднем носовом ходе	Полипы выходят за пределы среднего носового хода
Отёк	Отёка нет	Умеренный отёк	Значительный отёк
Отделяемое	Отделяемого нет	Прозрачное отделяемое	Густое гнойное отделяемое

Данные КТ оценивают по шкале Lund — Mackay: снижение пневматизации каждой пазухи справа и слева отдельно оценивают в 0 баллов, если изменений нет, в 1 балл при частичном затенении и в 2 балла при тотальном. Остиомеатальный комплекс оценивают в 0 баллов, если он интактен, и в 2 балла, если он обтурирован. Сумма для каждой стороны — от 0 до 12 баллов, всего — от 0 до 24.

> Таблица шкалы Lund — Mackay в приложении Г3 не совпадает с текстом раздела 1.5. Верхнечелюстная пазуха и передние клетки решётчатой кости записаны в ней дважды, а задних клеток решётчатой кости нет. Остиомеатальному комплексу в таблице дана оценка 0, 1 или 2 балла, а в тексте — только 0 или 2. В строке «Общее количество баллов» справа стоят 0, 7 и 14, слева — 0, 1 и 2, хотя ключ под таблицей говорит о сумме от 0 до 12 на сторону. Считайте по тексту раздела 1.5.

По гистологическому строению различают отёчные полипы с преимущественно эозинофильной инфильтрацией (70–85% клеток), фиброзные полипы с преобладанием нейтрофилов, полипы с гиперплазией серозно-слизистых желёз и полипы с атипией стромы.

2.5 Клиническая картина

Пациентов беспокоят заложенность носа, слизистые или слизисто-гнойные выделения, стекание отделяемого по задней стенке глотки, тяжесть и давление в области носа и проекции пазух, диффузная головная боль, снижение или потеря обоняния. Иногда к этому присоединяются жжение и раздражение в горле, кашель, охриплость, недомогание, снижение работоспособности и сонливость. Важно оценить, насколько выражены симптомы и как долго они длятся. При обострении симптомы усиливаются.

2.6 Жалобы и анамнез

Жалобы полезно разделить на группы. Назальные — затруднённое носовое дыхание, выделения, ухудшение или отсутствие обоняния. Болевые — лицевая боль, ощущение полноты и давления в лице, головная и зубная боль. Оро- и назофарингеальные — неприятный запах изо рта, стекание отделяемого по задней стенке глотки, кашель, заложенность или боль в ушах. Системные — недомогание, утомляемость, снижение работоспособности. Такое разделение помогает подтвердить диагноз, оценить тяжесть и найти факторы, влияющие на выбор лечения.

Выясняют, когда и из-за чего появились симптомы, в какой последовательности, насколько они выражены и как менялись, что на них влияет, какие обследования уже проводились и как пациента лечили. Отдельно уточняют связь симптомов с сезонными или круглогодичными аллергенами, непереносимость ацетилсалициловой кислоты и других нестероидных противовоспалительных препаратов, симптомы бронхиальной астмы, ПРС у близких родственников, одно- или двустороннюю локализацию симптомов и повторяющиеся носовые кровотечения.

---

3. Диагностика

Диагноз ставят по жалобам, анамнезу, данным физикального и инструментального обследования: передней риноскопии, эндоскопической ревизии полости носа и носоглотки, КТ околоносовых пазух.

3.1 Жалобы

У всех пациентов с подозрением на ПРС и с установленным диагнозом уточняют, есть ли две жалобы или больше, причём одна из них — заложенность носа или выделения из носа; учитывают также боль и давление в проекции пазух, снижение или потерю обоняния. Это нужно, чтобы подтвердить диагноз и оценить тяжесть.

Тяжесть заболевания у всех пациентов оценивают по визуальной аналоговой шкале (ВАШ).

Пациент ставит оценку от 0 (симптома нет) до 10 баллов (симптом выражен максимально). Лёгкому течению соответствуют 0–3 балла, умеренному — 3–7, тяжёлому — 7–10. Заметно ухудшают качество жизни симптомы на 5 баллов и выше.
Диагностическая специфичность выше, если два или больше субъективных симптома сочетаются с объективными признаками — данными эндоскопии носа и лучевой визуализации.

> В комментарии к рекомендации сказано, что оценка жалоб даёт много ложноположительных заключений, но тут же приведены специфичность 89% и чувствительность 2%. Высокая специфичность означает как раз мало ложноположительных результатов, так что цифры, по-видимому, переставлены местами.

> Границы степеней тяжести по ВАШ в КР перекрываются: 0–3, 3–7 и 7–10 баллов. Куда относить 3 и 7 баллов, не сказано.

3.2 Осмотр

Каждого пациента с подозрением на ПРС или с установленным диагнозом осматривает оториноларинголог, чтобы поставить диагноз и оценить особенности течения.

Важны пальпация и перкуссия в проекции пазух, признаки назальной обструкции (затруднённое дыхание, гнусавость), вязкое слизистое или слизисто-гнойное отделяемое и сами полипы. При долгом течении и распространённом процессе полипы бывают видны уже в преддверии носа, а иногда расширяется спинка наружного носа.

Всем пациентам проводят переднюю риноскопию, чтобы оценить распространённость процесса и сопутствующую внутриносовую патологию.

Всем пациентам выполняют эндоскопическую эндоназальную ревизию полости носа и носоглотки, чтобы определить локализацию и распространённость изменений слизистой.

Эндоскопия позволяет отличить ПРС от болезней со сходными симптомами — опухолей, гипертрофии глоточной миндалины и задних концов нижних носовых раковин. Вместе с жалобами и анамнезом она заметно повышает точность диагноза: специфичность и чувствительность метода — 84% и 66%.

3.3 Лучевая диагностика

Всем пациентам выполняют КТ околоносовых пазух, чтобы оценить распространённость полипоза, внутриносовые структуры и костные стенки пазух.

Для повторных исследований в динамике вместо мультиспиральной КТ можно делать конусно-лучевую томографию носа и пазух: лучевая нагрузка ниже, и годовая доза на одну анатомическую зону не превышается.

При подозрении на новообразование носа и пазух в дополнение к КТ проводят МРТ околоносовых пазух.

Обычная рентгенография пазух дешевле и доступнее, но при ПРС она мало информативна по сравнению с КТ.

3.4 Лабораторные исследования

У всех пациентов операционный материал направляют на патолого-анатомическое исследование, чтобы различить субтипы полипозного риносинусита.

Всем пациентам делают цитологическое исследование отделяемого, отпечатков и мазков со слизистой верхних дыхательных путей, чтобы выявить аллергическое воспаление и выбрать тактику лечения.

О выраженном аллергическом компоненте говорят эозинофилы больше 10% в поле зрения.

3.5 Консультации и другие исследования

При подозрении на бронхиальную астму или атопию пациента консультирует пульмонолог и (или) аллерголог-иммунолог, чтобы уточнить диагноз и согласовать лечение.

При подозрении на первичную цилиарную дискинезию исследуют скорость мукоцилиарного транспорта сахариновым тестом.

---

4. Лечение

Лекарственное и хирургическое лечение улучшают качество жизни при ПРС значительно и почти одинаково, поэтому адекватная лекарственная терапия стоит на первом месте.

4.1 Кортикостероиды

Кортикостероиды в виде назальных спреев назначают как стартовую терапию при ограниченном полипозе, когда полипы не выходят за пределы среднего носового хода, а также до и после операции.

Предпочтительны препараты с высокой топической активностью и низкой биодоступностью: они безопаснее при длительном применении. Спреи уменьшают полипы, заложенность носа, улучшают обоняние, предупреждают рецидивы и повышают качество жизни.

Если за 5–6 недель применения мометазона симптомы не уменьшились, рассматривают хирургическое лечение.

Системные кортикостероиды назначают при гиперреактивности бронхов, бронхиальной астме, непереносимости нестероидных противовоспалительных препаратов, рефрактерном течении ПРС, выраженной атопии, а также для подготовки к операции и после неё, чтобы уменьшить воспаление.

Длительный или частый приём системных кортикостероидов может повышать риск нежелательных явлений и осложнений.

4.2 Другие препараты

Блокаторы лейкотриеновых рецепторов назначают дополнительно или вместо системных кортикостероидов — при их непереносимости или при рефрактерном течении ПРС, устойчивом к кортикостероидам.

Системные антибиотики при ПРС не рекомендуются: доказательств эффективности недостаточно, а риски — резистентность микрофлоры, анафилаксия, осложнения со стороны желудочно-кишечного тракта — реальны.

Макролиды обсуждают из-за их иммуномодулирующего и противовоспалительного действия, но оптимальный препарат, доза и длительность неизвестны, поэтому однозначного вывода об их эффективности при ПРС сделать нельзя.

4.3 Генно-инженерная биологическая терапия

При тяжёлом течении ПРС, а также при сочетании ПРС с бронхиальной астмой назначают генно-инженерную биологическую терапию (ГИБТ) — дупилумаб, омализумаб или меполизумаб, — чтобы повысить эффективность лечения и снизить риск рецидивов.

Это рекомбинантные человеческие или гуманизированные моноклональные антитела класса IgG, которые избирательно связывают IgE, интерлейкины или субъединицы их рецепторов (ИЛ-5, ИЛ-4/13).

Биологическую терапию назначают при двустороннем полипозе и операциях в анамнезе, если есть три критерия из следующих: признаки Т2-воспаления (эозинофилы в ткани не меньше 10 в поле зрения, или в крови не меньше 150 клеток/мкл, или общий IgE не меньше 100 МЕ/мл); потребность в системных кортикостероидах (2 курса и больше за год или приём дольше 3 месяцев) либо противопоказания к ним; значимое снижение качества жизни (SNOT-22 не меньше 40); аносмия при оценке обоняния; бронхиальная астма, требующая регулярных ингаляционных кортикостероидов.

Ответ оценивают по пяти критериям: уменьшение полипов, меньшая потребность в системных кортикостероидах, лучшее качество жизни, улучшение обоняния и меньшее влияние сопутствующих болезней. 4–5 критериев — хороший ответ, 2–3 — умеренный, 0–1 — слабый или его нет. Эффект оценивают через 6 месяцев и через год. Если ответа нет, пересматривают диагноз, прекращают лечение и при необходимости переходят на другой препарат.

Лечение длительное, и при перерыве возможен рецидив. При беременности препараты применяют, только если ожидаемая польза для матери выше риска для плода. При грудном вскармливании решают, прекратить кормление или отменить препарат, с учётом пользы того и другого.

Продолжать ли терапию, врач решает по тяжести заболевания и тому, как контролируются обострения.

4.4 Дозы

Препарат	Доза
Мометазон, назальный спрей	По 100 мкг в каждую половину носа 2 раза в сутки, курс 3–6 месяцев. После достижения эффекта — по 2 впрыскивания в каждую половину носа 1 раз в сутки (200 мкг в сутки).
Преднизолон	Коротким курсом, если назальные кортикостероиды не контролируют симптомы: 30–60 мг в сутки в таблетках 14 дней.
Дупилумаб	Подкожно 300 мг (2 мл раствора 150 мг/мл) 1 раз в 2 недели, с 18 лет. Пропущенное лечение возобновляют как можно скорее; пожилым дозу не меняют.
Омализумаб	Подкожно 75–600 мг 1 раз в 2 или 4 недели; дозу и частоту определяют по исходному IgE и массе тела и корректируют при значительном изменении массы.
Меполизумаб	Взрослым с плохо контролируемым тяжёлым ПРС — подкожно 100 мг 1 раз в 4 недели, длительно.

4.5 Хирургическое лечение

Операцию выполняют, если лекарственная терапия неэффективна, а также при распространённом полипозе носа и пазух, чтобы восстановить носовое дыхание.

Оптимальный вариант — функциональная эндоскопическая риносинусохирургия (ФЭРСХ): удаление полипозно изменённой слизистой носа и пазух, восстановление проходимости естественных соустий и устранение анатомических нарушений — чаще всего септопластика и (или) резекция носовых раковин, а также резекция решётчатой буллы под видеоэндоскопическим контролем.

В зависимости от выраженности изменений можно ограничиться минимально инвазивными вмешательствами, которые обеспечивают дренирование и аэрацию пазух.

Всем пациентам перед операцией назначают кортикостероиды в виде назальных спреев: так меньше кровопотеря, лучше видно операционное поле и короче операция.

Результат операции во многом зависит от предоперационной лекарственной подготовки.

4.6 Реабилитация

После любой операции проводят комплексную реабилитацию, чтобы восстановить носовое дыхание и функцию слизистой носа и пазух.

Она включает охранительный режим 10–14 дней и дольше, санацию носа и пазух под эндоскопическим контролем в режиме «ирригация — аспирация» в раннем послеоперационном периоде и бережное удаление плотных продуктов воспаления и фибрина, чтобы не образовались синехии. При избытке вязкого отделяемого или корках нос орошают 0,9% раствором натрия хлорида: так местные препараты лучше контактируют со слизистой.

---

5. Наблюдение, профилактика, госпитализация

Пациенты с ПРС находятся под диспансерным наблюдением оториноларинголога, чтобы вовремя заметить ухудшение на фоне лечения или рецидив после операции и скорректировать лечение.

Специфической профилактики нет. Если до и после операции 6–12 месяцев применять назальные кортикостероиды, у большинства пациентов воспаление уменьшается, качество жизни растёт, рецидивы реже, а ремиссия длиннее.

Кратность осмотров определяют индивидуально, но в первый год после операции пациента осматривают каждые 3 месяца. При рецидиве, требующем повторной операции, и при подозрении на осложнённое течение делают КТ пазух.

Пациентам с ПРС нужны ежедневные назальные кортикостероиды, нередко всю жизнь с небольшими перерывами.

> Длительность назальных кортикостероидов в КР указана по-разному: курс мометазона — 3–6 месяцев (раздел 3.1), до и после операции — 6–12 месяцев (раздел 5), а в разделе 7 — ежедневно, нередко всю жизнь.

Оториноларинголог наблюдает пациента систематически, не реже раза в 3 месяца. Результат зависит не только от операции и опыта хирурга, но и от того, насколько пациент привержен лечению и выполняет рекомендации.

> В разделе 5 сказано, что кратность обследований решают индивидуально, а осмотры каждые 3 месяца нужны в первый год после операции. В разделе 7 и в информации для пациента — наблюдение всегда не реже раза в 3 месяца.

Главная задача — комплексное лечение, которое контролирует симптомы и улучшает качество жизни. Иногда нужны повторные щадящие эндоскопические вмешательства в полости носа и пазухах.

При сопутствующей бронхиальной астме пациента наблюдает и аллерголог-иммунолог.

5.1 Госпитализация

Обследовать и лечить пациентов можно как амбулаторно, так и в стационаре.

Планово госпитализируют на ФЭРСХ, с одномоментной коррекцией внутриносовых структур или без неё, если нет противопоказаний к операции. Плановая госпитализация в дневной или круглосуточный стационар возможна также для подбора и коррекции терапии и для лечения генно-инженерными биологическими препаратами.

После операции выписывают при удовлетворительном общем состоянии и улучшении или восстановлении носового дыхания.

По алгоритму КР после диагностики пациента с аллергией или бронхиальной астмой направляют к аллергологу-иммунологу или пульмонологу. Если показаний к операции нет, его наблюдают и лечат амбулаторно; при отрицательной динамике, как и при наличии показаний, госпитализируют для ФЭРСХ в специализированный стационар, после чего продолжают наблюдение и лекарственное лечение.

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Полипозный риносинусит»
Версия	1-я, опубликована в рубрикаторе 26.12.2024
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее декабря 2027 года
Код в рубрикаторе	`890_1` · открыть текст КР ↗
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Пациенты	Взрослые

6.1 Неточности в самом тексте КР

- Таблица шкалы Lund — Mackay в приложении Г3 расходится с текстом раздела 1.5: верхнечелюстная пазуха и передние клетки решётчатой кости повторены дважды, задних клеток решётчатой кости нет, остиомеатальный комплекс оценён в 0–1–2 балла вместо 0 или 2, а строка «Общее количество баллов» (0–7–14 и 0–1–2) не соответствует сумме от 0 до 12 на сторону.
- В комментарии о жалобах заявлена высокая вероятность ложноположительных заключений, но приведены специфичность 89% и чувствительность 2% — по смыслу цифры переставлены.
- Границы степеней тяжести по ВАШ перекрываются: 0–3, 3–7 и 7–10 баллов.
- Длительность назальных кортикостероидов указана по-разному: 3–6 месяцев (3.1), 6–12 месяцев (5), ежедневно, нередко всю жизнь (7).
- Кратность наблюдения: в разделе 5 — индивидуально, каждые 3 месяца в первый год после операции; в разделе 7 — всегда не реже раза в 3 месяца.
- Назальные кортикостероиды перед операцией рекомендованы дважды с разными уровнями: в разделе 3.1 — УУР С, УДД 5, в разделе 3.2 — УУР В, УДД 2.
- В оглавлении подраздел «Физикальное обследование» пронумерован как 2.1 вместо 2.2, а приложение А3.1 стоит на странице 30, раньше приложения А3 на странице 31.

Клинические рекомендации

Травма носа

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**S00.3** — Поверхностная травма носа **S01.2** — Открытая рана носа **S02.2** — Перелом костей носа
Пациенты	взрослые, дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 20.11.2024, пересмотр не позднее 2027 года
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/815_1

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 22.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

1. Главное

- Перелом костей носа ищут на рентгенограмме костей лицевого скелета в боковой проекции (взрослым и детям с 3 лет), но её чувствительность не выше 70%, поэтому нормальный снимок перелома не исключает.
- Гематому или абсцесс перегородки носа вскрывают и дренируют, затем ставят переднюю тампонаду и делают ежедневные перевязки, пока не прекратится отделяемое.
- Если травма привела к деформации носа, кости репонируют и фиксируют; раннее вмешательство делают в первые 7 суток, а при тяжёлом состоянии или выраженном отёке его можно отложить до 15 суток.
- При изолированном переломе, даже открытом, системные антибиотики рутинно не назначают; их назначают при загрязнённых и гнойных ранах, выраженном отёчно-токсическом синдроме, осложнённой гематоме или абсцессе перегородки, сочетанной и комбинированной травме и тяжёлой сопутствующей патологии.
- Если повреждены кожа или слизистая и рана загрязнена землёй, проводят экстренную профилактику столбняка — как можно раньше, но не позже 20-го дня после травмы.
- Госпитализируют при тяжёлом состоянии, кровотечении, выраженном отёке или боли, деформации носа со смещением перегородки, осложнениях травмы, тяжёлой сопутствующей патологии, приёме антикоагулянтов или антиагрегантов, а также когда нужна закрытая репозиция.

2. Клиника и классификация

2.1 Определения

Травма носа — повреждение носа прямым или опосредованным действием травмирующего фактора снаружи или изнутри, при котором нарушается целость тканей и структур наружного носа и полости носа и страдают функции носа.

Поверхностной называют травму наружного носа, при которой не повреждены кожа, кости носа и слизистая полости носа и нет неврологических симптомов.

Ушиб носа — закрытое повреждение тупым предметом без видимого нарушения кожи и слизистых, с разрывом мелких сосудов и кровоизлиянием. При кровоподтёке кровь пропитывает мягкие ткани наружного носа, тогда как гематома — это скопление крови в ограниченной полости. Ссадина — повреждение поверхностного слоя кожи, при котором видно место размозжения кожных сосудов.

Перелом костей носа (ПКН) — частичное или полное нарушение целости носовых костей, лобных отростков верхней челюсти, перегородки носа или носовой ости. Перелом закрытый, если кожа носа цела, и открытый, если отломки сообщаются с внешней средой через рану.

Рана носа — повреждение кожи наружного носа на всю глубину, часто с обнажением хрящей и костей и более глубоких структур полости носа, иногда с отрывом крыла или кончика носа.

2.2 Механизм травмы

При ударе во фронтальной плоскости ломаются носовые кости и западает спинка носа. Удар сбоку может разъединить носовую кость и лобный отросток верхней челюсти и сформировать сколиоз наружного носа, но чаще линия перелома проходит выше шва между ними. Обычно одновременно ломается и перегородка носа, чаще всего её хрящевой отдел.

У детей младшего возраста кости наружного носа эластичны, поэтому переломы бывают редко, а гематома и абсцесс перегородки носа — чаще.

При переломе нередко рвётся и отслаивается надхрящница или надкостница перегородки, и между хрящом и надхрящницей скапливается кровь — так образуется гематома перегородки носа. Если она инфицируется, развивается абсцесс, четырёхугольный хрящ расплавляется, и нос деформируется, а его функции нарушаются.

Травма носа бывает изолированной или сочетается с повреждением околоносовых пазух, глаза, скуловой области, нижней челюсти, полости рта, ушной раковины, сотрясением или ушибом головного мозга.

2.3 Классификация

Общепринятой классификации переломов нет. По классификации Ю. Н. Волкова (1958) переломы бывают открытыми и закрытыми, без деформации и с деформацией наружного носа.

По классификации С. Б. Бесшапочного (1984) переломы делят на переломы без деформации и с деформацией наружного носа; последние бывают одно- и двусторонними, с боковым смещением отломков, со смещением кзади или с сочетанием обоих.

По классификации А. С. Лопатина (2019) переломы бывают изолированными и сочетанными, открытыми и закрытыми; переломы со смещением делят по направлению удара — латеральному, фронтальному, фронтолатеральному и базальному.

По распространённости переломы бывают изолированными (с деформацией наружного носа или без неё), комбинированными — с травмой кожи лица, внутриносовых структур или околоносовых пазух — и сочетанными — с челюстно-лицевой или черепно-мозговой травмой, травмой конечностей, туловища и внутренних органов.

Перелом со смещением проходит три стадии. Острая стадия — первые 14 дней: кости репонируют по стандартной методике. Застарелый перелом — от двух недель до двух месяцев: репозиция возможна только вместе с операцией на перегородке носа. Стойкая деформация — больше двух месяцев: отломки можно сопоставить только после остеотомии.

2.4 Клиническая картина

Поверхностная травма проявляется слабо: в месте удара есть боль, небольшая припухлость и умеренное покраснение кожи без её повреждения.

При ушибе пирамида носа увеличена и её контуры сглажены из-за отёка; при кровоподтёке и ссадине меняются цвет и целость кожи; при переломе пирамида смещена вбок или вдавлена; при гематоме перегородка утолщена, а носовые ходы сужены. Бывают носовое кровотечение, боль и болезненность при пальпации, нарушение дыхания и обоняния. При сочетанной травме добавляются отёки, кровоподтёки, гематомы и раны в других зонах, нарушения зрения и сознания.

Симптомы перелома — отёк, боль, деформация наружного носа, крепитация и подвижность отломков, носовое кровотечение и затруднённое носовое дыхание.

У детей с переломом деформацию носа удаётся увидеть только в 57,5% случаев из-за выраженного отёка. Кроме того, у 7,4% детей деформация была и до травмы.

При переломе нередко повреждены кожа носа и слизистая полости носа, бывают эмфизема мягких тканей носа и лица и экхимозы. Носовое кровотечение частое, но при неосложнённом изолированном переломе оно редко бывает сильным и повторяющимся.

Перелом часто сопровождается кровоизлиянием в веки и мягкие ткани орбиты — «симптомом очков», однако этот же симптом бывает при переломе переднего основания черепа и травме кавернозного синуса.

Крепитация и подвижность отломков встречаются меньше чем в половине случаев, поэтому их отсутствие перелом не исключает. Боль в области носа тоже не специфична: она бывает при ушибах и воспалительных болезнях носа.

2.5 Жалобы и анамнез

Выясняют обстоятельства и механизм травмы, направление удара, была ли потеря сознания. Уточняют, были ли раньше травмы носа с деформацией и операции на носу. При комбинированной травме с повреждением кожи узнают о прививках от столбняка. При общем осмотре оценивают артериальное давление, пульс и частоту дыхания.

---

3. Диагностика

Диагноз ставят по факту травмы со слов пострадавшего или очевидцев; по жалобам на боль, изменение формы носа, затруднённое дыхание, кровотечение и нарушение обоняния; по осмотру — повреждениям кожи, деформации, крепитации и подвижности отломков, кровотечению. Перелом подтверждают рентгенографией костей лицевого скелета, а при противопоказаниях — УЗИ костей носа. При сочетанной травме повреждения пазух, орбиты, скуловой кости, верхней челюсти и черепа ищут на рентгенограммах черепа и КТ.

3.1 Осмотр

Каждого пациента с травмой носа осматривает оториноларинголог, чтобы определить характер и выраженность повреждений.

Всем пациентам пальпируют челюстно-лицевую область, чтобы уточнить характер травмы и выраженность повреждений.

При осмотре фиксируют отёк, гематомы, ссадины и раны, оценивают, есть ли деформация и насколько она выражена. При пальпации ищут крепитацию отломков, подкожную эмфизему и гематому, оценивают область носового клапана, подвижность крыльев носа и подвижной части перегородки. Для врачебной и судебно-медицинской экспертизы важно сфотографировать повреждения.

3.2 Анализы

Если травма сопровождается кровотечением, исследуют коагулограмму: она нужна, чтобы оценить гемостаз и кровопотерю и подготовиться к операции, если она потребуется.

3.3 Лучевая диагностика

Взрослым и детям с 3 лет делают рентгенографию костей лицевого скелета, чтобы выявить костные повреждения.

Снимок в боковой проекции важен и для диагноза, и юридически: в 70,2% случаев он показывает перелом и характер смещения отломков. Обычно ломаются обе носовые кости, но бывают одиночные и множественные переломы, поэтому, чтобы уточнить сторону перелома, боковые снимки делают при положении головы на левой и на правой стороне.
Чувствительность рентгенографии при переломе костей носа не выше 70%, а смещение во фронтальной плоскости на боковом снимке не видно. У детей до 3 лет снимок малоинформативен из-за слабой оссификации и преобладания хрящей. Поэтому отрицательный результат перелома не исключает.

Если подозревают смещение отломков в переднезаднем направлении, а на боковом снимке изменений нет, взрослым и детям с 3 лет делают рентгенографию околоносовых пазух.

Смещение отломков снаружи внутрь, невидимое на боковых снимках, выявляют на рентгенограмме околоносовых пазух в носоподбородочной проекции.

При комбинированной и сочетанной травме черепа делают КТ лицевого отдела черепа или челюстно-лицевой области и (или) КТ головного мозга.

КТ нужна при комбинированных и сочетанных переломах, признаках черепно-мозговой травмы (ЧМТ), неинформативной рентгенографии при клинических признаках перелома, планировании расширенной операции, подозрении на назальную ликворею, тяжёлом состоянии, продолжающемся или повторяющемся носовом кровотечении. Зону исследования выбирают по сопутствующей патологии.

Чувствительность КТ при переломе приближается к 100%. Исследование проводят в режиме спирального сканирования с толщиной среза 3 мм; оно показывает положение отломков, перегородку носа, повреждения пазух, орбиты, мозгового черепа, мягких тканей и мозга. Перед операцией рекомендуют 3D-реконструкцию.

Если лучевые методы противопоказаны, делают УЗИ костей носа.

УЗИ просто, неинвазивно, не облучает пациента и его можно повторять, чтобы контролировать репозицию и сращение отломков. Исследуют в четырёх проекциях: передней продольной, передней поперечной, правой и левой боковой.

3.4 Консультации

При подозрении на повреждение органа зрения пациента консультирует офтальмолог.

Всех пациентов с травмой носа консультирует невролог, чтобы вовремя выявить сопутствующую патологию.

При массивном кровотечении и сочетанной травме регистрируют ЭКГ, чтобы оценить сердечно-сосудистую систему и спланировать лечение.

---

4. Лечение

Консервативное лечение уменьшает боль и отёк, предупреждает бактериальное воспаление в зоне повреждения, ускоряет заживление и восстановление функций носа.

4.1 Обезболивание

Всем пациентам при отсутствии противопоказаний назначают анальгетики.

Сильная боль и стресс от травмы способствуют развитию или утяжелению травматического шока.

Применяют анальгетики-антипиретики и нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) по отдельности или вместе; у взрослых и детей, в том числе после операции, рекомендуют сочетать НПВП с парацетамолом, а также метамизол натрия. У детей из НПВП можно ибупрофен с 3 месяцев и кетопрофен с 15 лет, а кетопрофен в гранулах для приготовления раствора — с 6 лет. Метамизол натрия детям амбулаторно не назначают, а в стационаре используют, только если нет других разрешённых детям анальгетиков, из-за риска серьёзных нежелательных явлений.

4.2 Анальгетики у взрослых

Препарат	Разовая доза	Интервал	Максимум в сутки	Длительность
Парацетамол	1 г внутривенно, инфузия 15 минут	4 ч	4 г	5–7 суток
Диклофенак	75 мг внутримышечно (в таблице КР — «75 мл»)	12 ч	150 мг	2 суток
Кеторолак	30 мг внутривенно, внутримышечно	6 ч	60–90 мг	2 суток
Кетопрофен	100 мг внутривенно, внутримышечно	12 ч	200 мг	не более 2 суток

Препарат	Разовая доза	Интервал	Максимум в сутки	Длительность
Лорноксикам	8 мг внутривенно, внутримышечно	12 ч	16 мг	1–7 суток
Декскетопрофен	50 мг внутривенно, внутримышечно	8–12 ч	150 мг	2 суток
Метамизол натрия	500–1000 мг внутривенно, внутримышечно	8–12 ч	2 г	1–5 суток

В таблице 2 разовая доза диклофенака записана как «75 мл в/м» — единица измерения указана неверно; по смыслу таблицы и суточному максимуму 150 мг речь идёт о 75 мг.

4.3 Анальгетики у детей

Препарат	Разовая доза	Интервал	Максимум в сутки	Длительность
Парацетамол внутривенно	Инфузия 15 минут: меньше 10 кг — 7,5 мг/кг; 10–50 кг — 15 мг/кг; больше 50 кг — 1000 мг	4 ч	Меньше 10 кг — до 30 мг/кг; 10–50 кг — до 60 мг/кг, но не более 2 г (для 33–50 кг в той же ячейке — не более 3 г); больше 50 кг — 4 г	5–7 суток
Парацетамол внутрь	10–15 мг/кг	6 ч	не более 60 мг/кг	3–5 суток
Парацетамол ректально	3–12 месяцев — 50–100 мг; 1–3 года — 100–150 мг; 3–5 лет — 150–200 мг; 5–10 лет — 250–350 мг; 10–14 лет — 350–500 мг	6 ч	до 60 мг/кг	до 5 суток
Ибупрофен внутрь	3–6 месяцев — 50 мг; 6–12 месяцев — 50 мг; 1–3 года — 100 мг; 4–6 лет — 150 мг; старше 6 лет — 200–400 мг	6–8 ч (в ячейке есть и «8 ч» без пояснения)	3–6 месяцев — 150 мг; 6–12 месяцев — 200 мг; 1–3 года — 300 мг; 4–6 лет — 450 мг; 6–12 лет — 800 мг; 12–17 лет — 1 г	4 суток
Ибупрофен ректально	3–9 месяцев — 60 мг; 9–24 месяца — 60 мг	3–9 месяцев — 8 ч; 9–24 месяца — 6 ч	3–9 месяцев — 180 мг; 9–24 месяца — 240 мг	не более 3 суток
Метамизол натрия	С 15 лет — 500–1000 мг внутривенно, внутримышечно; 2–14 лет — 50–100 мг/кг внутримышечно, внутривенно; от 3 месяцев до года — 50–100 мг на 10 кг внутримышечно	8–12 ч	с 15 лет — 2 г	1–5 суток; детям младше 15 лет — 3 суток

В таблице 3 есть несогласованности. Для внутривенного парацетамола диапазоны веса пересекаются: для 33–50 кг указан суточный максимум 3 г, а для 10–50 кг — 2 г. Для метамизола натрия детям 2–14 лет указано 50–100 мг/кг, а детям до года — 50–100 мг на 10 кг, то есть в 10 раз меньше на килограмм. Дозы стоит сверить с инструкцией.

4.4 Профилактика столбняка и антибиотики

Если повреждены кожа или слизистая и травма получена при ударе о землю или в рану попала почва, вводят вакцину для профилактики столбняка.

Экстренную профилактику проводят как можно раньше, вплоть до 20-го дня после травмы, учитывая инкубационный период столбняка. Она включает первичную хирургическую обработку раны и одновременное введение столбнячного анатоксина, противостолбнячного иммуноглобулина человека или столбнячного антитоксина по инструкции.

При изолированном переломе костей носа, в том числе открытом, системные антибиотики до и после операции рутинно не назначают.

Профилактические антибиотики не снижают риск инфекционных осложнений после репозиции костей носа ни у взрослых, ни у детей.

Системные антибиотики назначают при загрязнённых и гнойных ранах кожи и слизистой, выраженном отёчно-токсическом синдроме, осложнённой гематоме или абсцессе перегородки носа, сочетанной и комбинированной травме и тяжёлой сопутствующей патологии.

При явном бактериальном воспалении или высоком риске его развития назначают препараты широкого спектра — бета-лактамы: цефазолин, цефтриаксон, ампициллин с сульбактамом, амоксициллин с клавулановой кислотой. При аллергии на бета-лактамы применяют клиндамицин.

Ампициллин с сульбактамом и амоксициллин с клавулановой кислотой шире, чем цефазолин, действуют на грамотрицательные и анаэробные бактерии.

Препарат	Доза
Ампициллин и сульбактам	Внутримышечно и внутривенно. Взрослым по тяжести инфекции 3–12 г в сутки в 3 введения, детям — 150 мг/кг в сутки в 3 введения (новорождённым — в 2), 5–14 дней.
Амоксициллин и клавулановая кислота	Внутривенно. Взрослым и детям старше 12 лет — по 1 г (по амоксициллину) 3 раза в сутки, детям младше 12 лет — 25 мг/кг 3 раза в сутки, 5–14 дней.

4.5 Отёк, кровотечение, уход за носом

При выраженном отёке взрослым и детям старше 15 лет назначают ангиопротекторы, чтобы раньше можно было репонировать отломки и предупредить осложнения.

На спинку носа местно наносят троксерутин (взрослым и детям старше 15 лет) или гель гепарина натрия на неповреждённую кожу 2 раза в день, пока отёк не пройдёт.

При обильном кровотечении, а также для профилактики кровотечения во время и после операции назначают гемостатические средства.

Кровотечение бывает из полости носа и из повреждённых мягких тканей при открытых ранах. Механическую остановку кровотечения обычно дополняют гемостатиками: этамзилатом, транексамовой или аминокапроновой кислотой.

Препарат	Взрослые	Дети
Этамзилат	Для остановки кровотечения — 250–500 мг внутривенно или внутримышечно, затем по 250 мг каждые 4–6 часов. При репозиции — 250–500 мг за час до операции, при необходимости 250–500 мг во время операции и 500–750 мг равномерно в течение суток после неё.	10–15 мг/кг в сутки в 3–4 приёма, 5–10 дней. Во время операции — 8–10 мг/кг внутривенно, затем 10–15 мг/кг в течение суток.
Транексамовая кислота	Внутривенно капельно или медленно струйно со скоростью 1 мл/мин (50 мг/мин), 10–15 мг/кг каждые 6–8 часов до остановки кровотечения.	Старше 1 года — 20 мг/кг в сутки до остановки кровотечения.
Аминокапроновая кислота	Внутривенно капельно: 4–5 г за первый час, при продолжающемся кровотечении — по 1 г в час не дольше 8 часов; при необходимости инфузии повторяют каждые 4 часа; не более 30 г в сутки. Курс 3–14 дней.	100 мг/кг за первый час, затем 33 мг/кг в час; не более 18 г/м² в сутки (до года — 3 г, 2–6 лет — 3–6 г, 7–10 лет — 6–9 г, старше 10 лет — как взрослым). При острой кровопотере: до года — 6 г, 2–4 года — 6–9 г, 5–8 лет — 9–12 г, 9–10 лет — 18 г.

> Для аминокапроновой кислоты у детей дозы при острой кровопотере больше указанных рядом максимальных суточных доз: например, до года — 6 г при максимуме 3 г, в 9–10 лет — 18 г при максимуме 6–9 г.

Всем пациентам для облегчения носового дыхания назначают деконгестанты и другие назальные препараты.

Сосудосуживающие спреи и капли уменьшают реактивный отёк слизистой после травмы и облегчают дыхание после операции.

Препарат	Доза
Фенилэфрин 0,125%	Интраназально: до года — 1 капля, 1–6 лет — 1–2 капли, старше 6 лет — 3–4 капли до 3 раз в сутки, до 7 дней.
Оксиметазолин	До года — 0,01%, 1–6 лет — 0,025%, старше 6 лет — 0,05%; по 1–2 капли интраназально 2–3 раза в сутки, до 5 дней.
Ксилометазолин	2–6 лет — 0,05%, старше 6 лет — 0,1%; спрей по 1 дозе 2–3 раза в сутки, до 5 дней.

При повреждении кожи или слизистой с признаками инфицирования раны или высоким риском инфицирования назначают местные антисептики.

Используют бензилдиметил-миристоиламино-пропиламмоний (спрей — не детям до 3 лет), повидон-йод и хлоргексидин. Как часто обрабатывать рану, зависит от воспаления и экссудата; обрабатывают до разрешения инфекции или начала заживления.

Всем пациентам промывают нос, чтобы ускорить заживление слизистой.

Уход за полостью носа после травмы и операции ускоряет заживление и предупреждает осложнения, например синехии. Используют стерильные изотонические растворы морской воды 2–3 раза в день, пока слизистая не эпителизируется и не стихнет воспаление.

4.6 Хирургическое лечение

Неотложно при травме носа останавливают кровотечение и проводят первичную хирургическую обработку открытых ран. При переломе операция нужна, чтобы восстановить форму наружного носа, устранить смещение внутриносовых структур и вернуть дыхание.

При открытых ранах и открытых переломах рану хирургически обрабатывают, иссекают инфицированные ткани и накладывают косметический шов.

Перед швом рану тщательно осматривают, удаляют инородные тела и зондируют раневой канал.

Если гемостатики и тампонада не помогают, кровотечение останавливают хирургически.

Метод выбирают по источнику. При кровотечении из передних отделов отслаивают участок мукоперихондрия с последующей тампонадой, выскабливают расширенный сосуд, применяют криокоагуляцию или электрокаустику. При обильном кровотечении перевязывают наружную сонную артерию, эндоскопически клипируют сосуды или выполняют эндоваскулярную эмболизацию. При кровотечении из решётчатых артерий делают этмоидотомию наружным, внутренним или эндоназальным доступом.

Гематому или абсцесс перегородки носа вскрывают и дренируют.

После вскрытия ставят переднюю тампонаду и делают ежедневные перевязки, пока не прекратится отделяемое.

Если травма привела к деформации наружного носа, кости репонируют и фиксируют отломки, чтобы восстановить форму носа и дыхание.

Операция бывает ранней — в первые 7 суток после травмы, отложенной — на 8–15-е сутки, и плановой — через 6 месяцев и позже.

Рано оперируют при минимальном или умеренном отёке, а также при комбинированной травме с повреждением внутриносовых структур или пазух и при гематоме перегородки. Ранняя операция помогает избежать септических осложнений и синехий.

При тяжёлом состоянии, выраженном отёке, комбинированных переломах костей и перегородки носа и ранениях лица операцию можно отложить до 15 суток.

> По классификации в разделе 1.5 острая стадия, когда кости репонируют по стандартной методике, длится 14 дней, а после двух недель репозиция возможна только с операцией на перегородке. В разделе 3.2 отложенная операция допускается до 15-х суток.

Планово (риносептопластикой) переломы оперируют при сочетанной травме с переломом основания черепа и назальной ликвореей и при тяжёлых функциональных нарушениях.

Кости репонируют наружным (пальцевым), эндоназальным (инструментальным) или экстраназальным (открытым) способом. У детей наружный способ эффективен лишь в 22% случаев, поэтому им лучше репонировать эндоназально элеваторами Манакова или Волкова с последующей передней тампонадой. Открытый способ применяют, когда одновременно оперируют по поводу внутричерепной травмы или травмы лобных пазух и верхней челюсти.

При комбинированных назосептальных переломах в остром периоде одновременно репонируют кости и выполняют септопластику. При сочетанной травме репозицию лучше делать вместе с другими хирургами, если они оперируют под наркозом.

При подозрении на черепно-мозговую травму вправление откладывают до осмотра невролога или нейрохирурга и нужных обследований.

4.7 Анестезия, тампонада, повязка

При операциях по поводу открытых и закрытых переломов и смещения внутриносовых структур проводят анестезию наружного носа и полости носа.

Взрослым при изолированной травме наносят местный анестетик на слизистую полости носа и вводят анальгетики внутримышечно или проводят проводниковую анестезию артикаином. Детям рекомендуют сочетанную анестезию.

При переломах костей наружного носа и внутриносовых структур ставят переднюю тампонаду, чтобы удержать сопоставленные отломки и остановить кровотечение при травме слизистой.

Тампон вводят на стороне деформации и удаляют на 2–3-и сутки после операции; срок зависит от подвижности отломков. Польза длительной тампонады (больше 3–5 дней) после репозиции не доказана.

При переломах, сложных травмах и после операций накладывают пращевидную повязку, чтобы отломки не сместились.

Наружную шину после закрытой репозиции рутинно не применяют, только при тяжёлых оскольчатых переломах.

При выраженных реактивных воспалительных явлениях пациента консультирует физиотерапевт.

Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области и магнитотерапия уменьшают воспаление и отёк и ускоряют заживление.

На время лечения пациенту советуют ограничить физическую активность, избегать действий, которые могут сместить отломки, в том числе во сне, есть полноценную витаминизированную легкоусвояемую пищу и не ходить в горячую ванну, душ, сауну и бассейн.

---

5. Наблюдение, профилактика, госпитализация

После операций по поводу деформации наружного носа или перегородки пациента в течение года наблюдает оториноларинголог; обязательные осмотры — через 1, 3 и 6 месяцев и через год после операции.

Травмы предупреждают общими социальными мерами профилактики травматизма.

Это соблюдение техники безопасности в детских учреждениях, на производстве и в быту, разъяснительная работа с родителями и пропаганда здорового образа жизни.

5.1 Госпитализация

Госпитализируют при тяжёлом состоянии, выраженном отёке, кровотечении, сильной боли; при комбинированных переломах костей и перегородки носа с повреждением пазух и ранениями лица; при травматической деформации носа со смещением перегородки или нарушением дыхания; при тяжёлой сопутствующей патологии; пациентов, принимающих антикоагулянты или антиагреганты; при осложнениях — гематоме и абсцессе перегородки, воспалении пазух и соседних областей; а также если нужна закрытая репозиция.

Выписывают при удовлетворительном состоянии и нормальных клинических показателях, улучшении формы носа и носового дыхания и отсутствии осложнений.

Прогноз благоприятный, если лечение проведено по рекомендациям и пациент выполняет назначения врача.

Пациенту объясняют, что при выраженном отёке лица, деформации носа, повреждении мягких тканей, кровотечении из носа или нарушении дыхания нужна экстренная консультация оториноларинголога: запоздалое лечение может привести к опасным осложнениям.

---

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Травма носа»
Версия	1-я, опубликована в рубрикаторе 20.11.2024
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее ноября 2027 года
Код в рубрикаторе	815_1 · открыть текст КР ↗

Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Пациенты	Взрослые и дети

6.1 Неточности в самом тексте КР

- В разделе 1.4 коды МКБ записаны с лишней точкой: «S.00.3», «S.02.2», «S.02.20», «S.02.21»; на титульном листе — правильно (S00.3, S02.2 и т. д.).
- В таблице 2 разовая доза диклофенака указана как «75 мл в/м» вместо миллиграммов.
- В таблице 3 для внутривенного парацетамола пересекаются весовые диапазоны с разными суточными максимумами (33–50 кг — 3 г, 10–50 кг — 2 г); для метамизола натрия доза у детей 2–14 лет (50–100 мг/кг) в 10 раз больше на килограмм, чем у детей до года (50–100 мг на 10 кг). Для ибупрофена внутрь в графе интервала стоят и «6–8 ч», и «8 ч» без пояснения.
- Для аминокапроновой кислоты у детей дозы при острой кровопотере (до года — 6 г, 9–10 лет — 18 г) превышают указанные рядом максимальные суточные дозы (3 г и 6–9 г).
- Острая стадия перелома в разделе 1.5 — 14 дней, а в разделе 3.2 отложенная операция допускается до 15-х суток.
- Критерии качества требуют рентгенографии или КТ у всех пациентов, тогда как рентгенографию рекомендуют только с 3 лет.
- В рекомендации о коагулограмме написано «система гомеостаза» вместо «гемостаза»; в оглавлении номера страниц разделов 6, 7 и критериев качества не совпадают с текстом.

Клинические рекомендации

Хронический синусит

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**J32.0** — Хронический верхнечелюстной синусит **J32.1** — Хронический фронтальный синусит **J32.2** — Хронический этмоидальный синусит **J32.3** — Хронический сфеноидальный синусит **J32.4** — Хронический пансинусит **J32.8** — Другие хронические синуситы **J32.9** — Хронический синусит неуточненный **J34.1** — Киста или мукоцеле носового синуса
Пациенты	взрослые, дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 14.10.2025, пересмотр не позднее 2028 года
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/955_1

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 22.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

1. Главное

- Хронический синусит у взрослого диагностируют, если два симптома или больше держатся 12 недель и дольше, причём один из них — заложенность носа или выделения из носа; диагноз подкрепляют эндоскопические признаки или изменения на КТ.
- Основа консервативного лечения — промывание носа солевым раствором всем пациентам и интраназальные глюкокортикостероиды с 12 лет; чтобы оценить эффект гормонов, их применяют не меньше 3 месяцев.
- Системные антибиотики назначают только при среднетяжёлом и тяжёлом обострении или осложнениях; стартовый препарат в амбулаторной практике — амоксициллин с клавулановой кислотой.
- Взрослым, которым не помогли 1–2 курса адекватной консервативной терапии, выполняют функциональную риносинус-хирургию.
- Случайно найденную бессимптомную кисту пазухи большинство экспертов не оперируют: многие кисты медленно уменьшаются сами или не меняются.
- Мукоцеле медленно растёт, растягивает и иногда разрушает стенку пазухи, поэтому его всегда лечат хирургически.

2. Клиника и классификация

2.1 Определение

Хронический синусит (хронический риносинусит, ХРС) — воспаление слизистой оболочки околоносовых пазух, которое держится больше 12 недель и сопровождается двумя симптомами или больше. Один из них — заложенность носа или выделения из носа (наружу или в носоглотку); к нему могут добавляться боль или давление в области лица и снижение или потеря обоняния.

Ретенционные (истинные, секретирующие) кисты пазух образуются, когда закупориваются выводные протоки желёз слизистой; изнутри и снаружи они выстланы мерцательным цилиндрическим эпителием. Лимфоэктатические (несекретирующие, ложные, интрамуральные) кисты лежат в толще слизистой, не имеют внутренней эпителиальной выстилки и возникают из-за хронического воспаления в пазухах или баротравмы.

Мукоцеле — доброкачественное, медленно растущее кистовидное образование пазухи. Оно возникает, когда естественное соустье стойко перестаёт дренировать пазуху, и часто растягивает, реже разрушает её стенки.

2.2 Причины

С развитием ХРС связывают аллергический ринит, первичную цилиарную дискинезию, муковисцидоз, бронхиальную астму, гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь (ГЭРБ), иммунодефицит и аутоиммунные системные болезни.

Важный фактор риска — анатомические особенности в области остиомеатального комплекса: искривление перегородки носа, буллёзная или парадоксально изогнутая средняя носовая раковина, гиперпневматизация решётчатой буллы, супрабуллярной или инфраорбитальной клетки, аномалии крючковидного отростка, добавочное соустье верхнечелюстной пазухи. Они нарушают вентиляцию носа и отток секрета из носа и пазух. У детей, гораздо реже у взрослых, ХРС бывает связан с гипертрофией аденоидов.

У детей, особенно дошкольников, главная причина ХРС — муковисцидоз, реже первичная цилиарная дискинезия. По отечественным данным, связи между ХРС и искривлением перегородки носа у детей не найдено.

Предрасполагать к ХРС может и аллергический отёк слизистой в области среднего носового хода; аллергический ринит и хронический синусит часто сочетаются.

Одонтогенный синусит связан с болезнями зубов и стоматологическим лечением. Хронический верхнечелюстной синусит может осложнять периодонтит или пародонтит; частая причина — эндодонтическое лечение, когда в пазуху через каналы попадают инфицированный детрит или пломбировочный материал. Воспаление в пазухе могут вызвать и дентальная имплантация с предшествующим наращиванием кости. При одонтогенном синусите среди возбудителей преобладают анаэробы.

ГЭРБ тоже может способствовать ХРС: рефлюктат, попадая на слизистую носа и носоглотки, вызывает воспаление и нарушает мукоцилиарный клиренс, а это может привести к блоку остиомеатального комплекса.

Важный фактор риска — курение: табак токсичен для слизистой носа, сушит её и меняет свойства слизи.

Связь ретенционных кист с воспалением в носу и травмами не доказана. Лимфоэктатические кисты чаще всего вызывает хроническое, прежде всего аллергическое, воспаление слизистой; риск повышают гипервентиляция верхнечелюстной пазухи и баротравма. Радикулярная одонтогенная киста растёт из эпителиальной гранулёмы у верхушки корня кариозного зуба, зубная киста может оттеснять дно верхнечелюстной пазухи или прорастать в неё, фолликулярная развивается очень медленно из зубного фолликула.

Мукоцеле в подавляющем большинстве случаев — следствие операций на пазухах; другие причины — травма, хроническое воспаление пазух, опухоли и лучевая терапия. Больше чем в трети случаев причину найти не удаётся; описаны и врождённые мукоцеле. У детей мукоцеле чаще всего возникает из-за вторичного хронического синусита при муковисцидозе.

2.3 Классификация

По локализации, с указанием стороны, синусит бывает верхнечелюстным, этмоидальным, фронтальным и сфеноидальным. Если воспалены пазухи только одной стороны, говорят о гемисинусите, если несколько пазух — о полисинусите.

В практике принято делить хронический синусит на полипозный риносинусит и синусит без полипов.

По возбудителю синусит бывает бактериальным, грибковым и бактериально-грибковым.

По тяжести течения, которую оценивают по суммарной выраженности симптомов на визуально-аналоговой шкале (ВАШ) от 0 до 10, выделяют лёгкую форму (0–3 балла), среднетяжёлую (4–7) и тяжёлую (8–10).

> Классификация по тяжести ссылается на приложение Г1, но там описана ВАШ только для интенсивности боли и с другой градацией: до 2 см — слабая боль, 2–4 — умеренная, 4–6 — сильная, 6–8 — сильнейшая, до 10 — невыносимая. Как считать суммарную выраженность симптомов, в КР не сказано.

Классификация EPOS 2020 года построена на эндотипах и фенотипах. Первичный синусит бывает односторонним (локализованным) — с воспалением 2-го типа или не 2-го типа, сюда же относят аллергический грибковый и изолированный синусит одной пазухи — и двусторонним (диффузным) — с теми же двумя эндотипами, эозинофильным или неэозинофильным. Вторичный односторонний синусит связан с одонтогенным процессом, мицетомой («грибковым шаром») или опухолью. Вторичный двусторонний бывает механическим, воспалительным и иммунным; его фенотипы — первичная цилиарная дискинезия, муковисцидоз, гранулематоз с полиангиитом, эозинофильный гранулематоз с полиангиитом и селективный иммунодефицит.

Кисты в России обычно делят по классификации М. И. Кадымовой на ретенционные, лимфоэктатические, одонтогенные (радикулярные) кисты верхнечелюстной пазухи и кисты, связанные с пороками развития.

Больше 90% кист находятся в верхнечелюстной пазухе, около 5% — в клиновидной, в лобной пазухе и клетках решётчатого лабиринта — крайне редко. Больше чем в 80% случаев киста односторонняя; несколько кист бывает лишь у четверти пациентов.

Мукоцеле чаще всего поражает лобные пазухи, реже клетки решётчатого лабиринта, верхнечелюстные и клиновидные пазухи; некоторые авторы считают самой частой лобно-решётчатую локализацию. Описаны и крайне редкие места — нижняя стенка орбиты, крыловидное пространство, средняя и нижняя носовые раковины.

2.4 Клиническая картина

Клиника ХРС неспецифична: заложенность носа, выделения спереди и по задней стенке глотки, головная или лицевая боль, снижение или отсутствие обоняния, ощущение неприятного запаха в носу. Главные симптомы, сильнее всего влияющие на самочувствие, — заложенность и выделения. У детей ключевым симптомом бывает и кашель, связанный со стеканием слизи по задней стенке глотки. От острого синусита хронический отличается тем, что симптомы держатся больше 12 недель, не проходя полностью.

Кисты пазух часто ничем себя не проявляют и находятся случайно на снимках головы. Большая киста чаще всего вызывает головную или лицевую боль, редко — внезапное истечение из носа янтарной жидкости при самопроизвольном разрыве, онемение верхней губы или зубную боль. Заложенность носа, выделения и кашель от стекания слизи у пациента с кистой, скорее всего, вызваны сопутствующим аллергическим ринитом или ХРС.

Проявления мукоцеле зависят от его локализации и размера. Основные симптомы — головная боль, давление в области лица, заложенность носа, выделения и боль вокруг глаза. Небольшое мукоцеле может протекать бессимптомно, но гораздо реже, чем киста.

2.5 Жалобы и анамнез

Взрослые жалуются на стойкую, одностороннюю или попеременную заложенность носа, слизистые или слизисто-гнойные выделения, необходимость сморкаться или стекание слизи по задней стенке глотки — сильнее после пробуждения или постоянно в течение дня, на неприятный запах в носу или носоглотке, снижение обоняния вплоть до аносмии. При хроническом сфеноидите бывает периодическая боль в темени и затылке.

Для хронического фронтита характерна сильная боль в проекции лобной пазухи на стороне поражения при обострении или при перемене атмосферного давления. Бывает ощущение давления позади спинки носа и глазных яблок, сильнее при обострении.

У маленьких детей жалобы узнают от родителей или опекунов: частые затяжные «насморки», заложенность носа, слизистые выделения, кашель, в основном ночью или лёжа на спине.

Если на снимках нашли кистоподобное образование, прежде всего выясняют, есть ли головная или лицевая боль, постоянна ли она и что её вызывает или усиливает. Расспрашивают о прошлых операциях на носу и пазухах и стоматологическом лечении.

---

3. Диагностика

3.1 Критерии диагноза

У взрослого хронический синусит диагностируют, если 12 недель и дольше есть два симптома или больше, причём один из них — заложенность носа, затруднённое носовое дыхание или выделения из носа (спереди или по задней стенке глотки); к ним могут присоединяться боль или распирание в проекции пазух и снижение или потеря обоняния. Диагноз подкрепляют эндоскопические признаки — полипы, слизисто-гнойные выделения или отёк и обструкция слизистой, в основном в среднем носовом ходе, — и изменения слизистой остиомеатального комплекса или пазух на КТ.

У ребёнка нужны два симптома или больше в течение 12 недель и дольше из четырёх: затруднённое носовое дыхание, боль или распирание в проекции пазух, выделения из носа или стекание по задней стенке глотки, кашель. Эндоскопические признаки и изменения на КТ те же, что у взрослых.

Кисту пазухи диагностируют по КТ или МРТ: округлое однородное мягкотканное образование на широком основании с чёткими границами, без разрушения кости и выраженной деформации стенок. Отличить ретенционную кисту от лимфоэктатической можно только гистологически, по оболочке удалённой кисты.

Одонтогенную кисту верхнечелюстной пазухи диагностируют по КТ — однородное образование на широком основании на нижней стенке пазухи, с чёткими границами, оболочкой костной плотности и связью с корнями верхних зубов — вместе с заключением стоматолога-хирурга или челюстно-лицевого хирурга о болезни соседних зубов.

Мукоцеле диагностируют по КТ: образование в пазухе с округлым ровным контуром и однородным содержимым без кальцинатов и включений; соседние кости могут истончаться, а образование — выпячиваться в соседние области.

3.2 Осмотр и консультации

Всех пациентов с хроническим синуситом и с подозрением на кисту или мукоцеле осматривает оториноларинголог: оценивает состояние, собирает жалобы и анамнез, планирует лечение.

Если аллергологический анамнез отягощён, пациента с хроническим синуситом, а взрослого — и с подозрением на кисту или мукоцеле, консультирует аллерголог.

При симптомах рефлюкса пациента консультирует гастроэнтеролог.

При признаках муковисцидоза или первичной цилиарной дискинезии пациента консультирует генетик.

При подозрении на одонтогенный синусит или кисту верхнечелюстной пазухи пациента консультирует стоматолог-хирург или челюстно-лицевой хирург, чтобы подтвердить или исключить зубную причину.

3.3 Посев

При среднетяжёлом и тяжёлом течении и при обострении гнойное отделяемое отправляют на посев на аэробы и факультативные анаэробы с определением чувствительности, чтобы подобрать или скорректировать антибиотик.

Лучший материал — аспират прямо из поражённой пазухи, полученный при пункции верхнечелюстной пазухи или во время операции.

3.4 Инструментальные исследования

Всем пациентам с предполагаемым хроническим синуситом проводят эндоскопию полости носа и носоглотки, чтобы осмотреть синоназальные структуры и подтвердить диагноз.

Спиральную КТ пазух делают при признаках осложнений во время обострения, перед операцией и когда нужна дифференциальная диагностика.

КТ — самый информативный метод и у взрослых, и у детей. Она показывает изолированное воспаление, блок соустья, инородное тело, диффузный грибковый процесс или мицетому, опухоль, аномалии пазух, позволяет заподозрить одонтогенную причину. Типичные признаки ХРС — утолщение слизистой и снижение пневматизации в области соустий.
Чтобы спланировать объём операции, КТ делают не раньше чем за 6 месяцев до неё.

Спиральную КТ пазух делают всем пациентам с подозрением на кисту, найденную другим методом и дающую постоянные или периодические симптомы, и всем с подозрением на мукоцеле.

Если мукоцеле трудно отличить от других образований, КТ делают с внутривенным болюсным контрастированием: контраст накапливают оболочка мукоцеле, но не его содержимое.

---

4. Лечение

Причин ХРС много, и они могут действовать одновременно, поэтому лечение подбирают каждому пациенту индивидуально.

Основа консервативного лечения — лекарства; по показаниям их можно назначать и после функциональной риносинус-хирургии.

Доказательств, что кисты и мукоцеле пазух поддаются консервативному лечению, нет; симптомы могут уменьшиться, только если лекарства помогают при сопутствующем ХРС или аллергическом рините.

4.1 Базовая терапия

Всем пациентам с ХРС назначают промывание носа гипертоническим или изотоническим солевым раствором: оно очищает полость носа и уменьшает нагрузку антигенами на слизистую.

Промывание важно и как часть лечения после операции.

Пациентам старше 12 лет назначают интраназальные глюкокортикостероиды (ИНГКС), чтобы уменьшить симптомы.

Единой схемы доз, кратности и длительности нет, допустимы и низкие, и высокие дозы. Чтобы оценить эффект, лечение продолжают не меньше 3 месяцев.
Носовые кровотечения из-за сухости слизистой чаще бывают при высоких дозах. Официально зарегистрированное показание при хроническом риносинусите есть только у назального спрея мометазона: взрослым и детям старше 12 лет — по 2 дозы (100 мкг) в каждую половину носа 2 раза в сутки, то есть 400 мкг в сутки.

4.2 Системные антибиотики

Системные антибиотики назначают при среднетяжёлом и тяжёлом обострении, в том числе с периорбитальными и внутричерепными осложнениями, а также при таком обострении у пациентов с болезнями, повышающими риск бактериальной инфекции.

Препарат	Когда и в какой дозе
Амоксициллин и клавулановая кислота	Стартовый препарат при обострении в амбулаторной практике у детей и взрослых. Детям от 3 месяцев до 12 лет или с массой меньше 40 кг — 40 мг/кг в сутки в 3 приёма каждые 8 часов (суспензии 125/31,25 мг и 250/62,5 мг в 5 мл); суспензию 400/57 мг в 5 мл дают по 45 мг/кг в сутки в 2 приёма. При высоком риске полирезистентного пневмококка — суспензия 600/42,9 мг в 5 мл, 90 мг/кг в сутки по амоксициллину в 2 приёма. С массой больше 40 кг и старше 12 лет — таблетки 500/125 мг 3 раза в сутки или 875/125 мг 2 раза в сутки.
Цефиксим	При лёгкой аллергии на пенициллины. Детям младше 12 лет или с массой меньше 50 кг — 8 мг/кг в сутки 1 раз в день; старше 12 лет — 400 мг 1 раз в день.
Цефиксим, цефтриаксон, цефотаксим	Если не помог амоксициллин с клавулановой кислотой. Старше 12 лет или с массой от 50 кг: цефиксим внутрь 400 мг 1 раз в день, цефтриаксон внутривенно или внутримышечно 1–2 г 1 раз в сутки, цефотаксим внутривенно или внутримышечно 1 г каждые 12 часов. Детям младше 12 лет или с массой меньше 50 кг: цефиксим 8 мг/кг в сутки 1 раз в день, цефтриаксон 75–80 мг/кг в сутки 1 раз в день, цефотаксим 100–200 мг/кг в сутки в 2–4 введения.
#Левофлоксацин, #моксифлоксацин	Только взрослым амбулаторным пациентам при непереносимости всех бета-лактамов или тяжёлой аллергии на пенициллины: #левофлоксацин 500 мг внутрь 1 раз в сутки или #моксифлоксацин 400 мг внутрь 1 раз в сутки, курсом 10–14 дней. Знак # означает применение вне инструкции.

Ребёнка с обострением, которому нужны системные антибиотики, но нельзя назначить пенициллины, лучше лечить в стационаре; препарат выбирают по тяжести, локализации и распространённости воспаления и чувствительности выделенного микроба.

Если стартовый антибиотик амбулаторно не помог, стоит решить вопрос о направлении пациента в ЛОР-отделение стационара по неотложному каналу. В стационаре при среднетяжёлом течении лучше давать препараты внутрь, а если это невозможно — парентерально; при тяжёлом, в том числе осложнённом, обострении антибиотики вводят внутривенно.

Если не помогли цефалоспорины III поколения или выделены устойчивые к ним штаммы, назначают препарат резерва — цефалоспорин IV поколения, карбапенем, оксазолидинон, гликопептид и другие — с учётом чувствительности возбудителя.

Эффект антибиотика должен появиться на третьи сутки; если он есть, препарат продолжают 10–14 дней.

4.3 Местные антибиотики

При лёгком обострении у пациента, которому раньше делали синусотомию, при появлении гнойных выделений назначают местные антибиотики.

Эффект оценивают через 3–4 дня; если его нет, решают вопрос о системных антибиотиках.

В России при ХРС зарегистрированы назальный спрей фрамицетина — для детей с первых лет жизни — и комбинированный спрей с дексаметазоном, неомицином, полимиксином B и фенилэфрином — с 2,5 лет. Разовую и суточную дозы соблюдают строго по инструкции. Фрамицетин при обострении применяют не дольше 7 дней, комбинированный препарат — не дольше 10 дней.

Растворы антибиотиков для внутримышечного и внутривенного введения в нос и пазухи вводить нельзя: они для этого не предназначены и повреждают мерцательный эпителий. В пазуху можно вводить тиамфеникола глицинат ацетилцистеинат.

4.4 Другие лекарства

При обострении, если нет противопоказаний, назначают растительные препараты с доказанным противовоспалительным и муколитическим действием, чтобы симптомы прошли быстрее.

Эффективны комбинированные препараты с экстрактами корня горечавки жёлтой, цветков первоцвета, травы щавеля, цветков бузины чёрной и травы вербены, а также миртол.

При обострении назначают сосудосуживающие капли или спреи в нос, чтобы облегчить отток секрета из пазух.

Нафазолин очень токсичен, в ЛОР-практике его применять нельзя. Предпочтительны оксиметазолин 0,01–0,05% и ксилометазолин 0,05–0,1%. Применяют их строго по назначению и под контролем врача, не дольше 5–7 дней, иначе возникает медикаментозный ринит.

Муколитики назначают, чтобы разжидить отделяемое и облегчить его отток.

Карбоцистеин дают коротким курсом, до 2–3 недель, при обострении с густым секретом в носу; возможны и курсы около 3 месяцев вместе с противовоспалительными средствами. Одновременно с другими отхаркивающими и муколитиками, в том числе местными, его не назначают, иначе усиливается стекание слизи по задней стенке глотки.

При температуре, головной или лицевой боли во время обострения назначают нестероидные противовоспалительные препараты или парацетамол.

Детям до 6 лет можно только парацетамол — до 60 мг/кг в сутки — или ибупрофен — до 30 мг/кг в сутки.

4.5 Хирургическое лечение

При тяжёлом обострении, в том числе с орбитальными и внутричерепными осложнениями, оперируют в неотложном или экстренном порядке. При среднетяжёлом обострении, если консервативное лечение не помогает, можно неотложно провести малоинвазивные манипуляции. Остальных пациентов оперируют планово по показаниям; если показаний нет или есть противопоказания, лечат консервативно и наблюдают у оториноларинголога.

Под функциональной риносинус-хирургией КР понимает фронтотомию, этмоидотомию, сфеноидотомию, гайморотомию и вмешательства на структурах полости носа. У взрослых, если позволяет оснащение, предпочтительна эндоскопическая техника; у детей при плановой операции она обязательна.

Кисты и неосложнённые мукоцеле оперируют планово, обычно теми же методами функциональной риносинус-хирургии; при кистах верхнечелюстной пазухи и мукоцеле лобной пазухи иногда используют микрогайморотомию и фронтотомию через переднюю стенку.

При тяжёлом обострении хронического верхнечелюстного синусита, а при среднетяжёлом — если консервативное лечение не помогает, пазуху пунктируют, чтобы её дренировать.

Через пункцию пазуху промывают антисептиком, удаляют секрет и вводят антибиотик.

Пунктировать можно только при наличии снимков, которые исключают гипоплазию и ателектаз верхнечелюстной пазухи и показывают скопление в ней секрета.

При тяжёлом обострении пункция часто не заменяет санирующую операцию. Детям пункцию делают только в стационаре.

Для дренирования можно поставить синус-катетер или зондировать пазухи через естественные соустья.

Взрослым, которым не помогли 1–2 курса адекватной консервативной терапии, выполняют функциональную риносинус-хирургию, чтобы восстановить аэрацию пазух, убрать симптомы и предотвратить осложнения.

> Внутри КР есть расхождение: в рекомендации об операции у взрослых показанием служит неэффективность 1–2 курсов консервативной терапии, а в разделе 6 показанием к плановой госпитализации для операции названа неэффективность адекватной консервативной терапии в течение 6 месяцев.

Ребёнку с хроническим синуситом и гипертрофией аденоидов III степени, если консервативное лечение 3–6 месяцев не помогло, первым этапом удаляют аденоиды.

Операцию делают планово, если нет противопоказаний, предпочтительно под общим обезболиванием в ЛОР-отделении или стационаре кратковременного пребывания и, если есть оснащение, с эндоскопом.

Детям со среднетяжёлым и тяжёлым ХРС, если лечение 3–6 месяцев не помогло, а гипертрофия аденоидов исключена или аденоиды удалены больше 6 месяцев назад, выполняют функциональную эндоскопическую риносинус-хирургию.

Оперируют планово. Операция не мешает росту пазух и лицевого скелета, но у детей выше риск рубцов и повторного сужения, а маленькие структуры требуют современного оборудования.

Детям с изолированным поражением пазухи выполняют эндоскопическую операцию, чтобы её дренировать.

Её делают независимо от состояния аденоидов, если на КТ видно отграниченное тотальное или субтотальное затемнение одной пазухи или резкое снижение её пневматизации и есть типичные жалобы. У детей нужна онконастороженность в отношении любого образования на КТ, кроме кист с чёткими типичными признаками, которые не растут.

Кисту пазухи с постоянными или периодическими симптомами удаляют эндоскопически: опорожняют её и полностью или частично удаляют оболочку.

Случайно найденную бессимптомную кисту большинство экспертов оперировать не советуют: кисты, кроме одонтогенных, часто медленно уменьшаются сами или не меняются.

Всем пациентам с мукоцеле выполняют эндоскопическую операцию, чтобы его дренировать.

При лобной локализации лучшим методом считают эндоскопическую марсупиализацию с передней этмоидэктомией и фронтотомией по Драфу. При латеральном расположении, дефекте передней стенки лобной пазухи и большом мукоцеле, распространяющемся в полость черепа, используют наружный доступ.

4.6 Другое лечение

Пациенты со вторичным ХРС, у которых изменения в носу и пазухах — проявление другой болезни, наблюдаются и лечатся у профильного специалиста. Одонтогенные кисты верхнечелюстной пазухи лечат вместе со стоматологом-хирургом или челюстно-лицевым хирургом.

---

5. Наблюдение, профилактика, госпитализация

5.1 После операции

После операции всех пациентов амбулаторно наблюдает оториноларинголог, чтобы оценить состояние полости носа и не пропустить поздние осложнения.

Первый осмотр — через 7–14 дней после выписки, затем ещё несколько раз в течение года, чтобы следить за течением болезни и вовремя менять лечение. Осмотры нужны, чтобы контролировать полость носа (при плохом уходе образуются корки и синехии), выявлять и предотвращать осложнения и при необходимости выполнять манипуляции.

Месяц после операции пациент соблюдает щадящий режим и избегает всего, что повышает давление и может вызвать кровотечение: интенсивных нагрузок, перегрева и переохлаждения. Чтобы не заразиться острой респираторной инфекцией, лучше не бывать в людных местах и больше оставаться дома.

5.2 Профилактика

Первичная профилактика защищает от вредных факторов среды, вторичная — выявляет болезнь как можно раньше. Хроническому синуситу помогают предотвратить своевременное лечение зубов и гастроэзофагеального рефлюкса, отказ от курения и техника безопасности при работе с веществами, вредными для дыхательных путей.

Мукоцеле предупреждает соблюдение принципов функциональной хирургии при операциях на носу и пазухах, лимфоэктатические кисты — своевременное лечение хронического воспаления в носу, радикулярные кисты — своевременное лечение верхних зубов.

Пациенту объясняют, что хронический синусит трудно вылечить, но его симптомы можно уменьшить; обычно нужен пожизненный контроль, а тактику определяет оториноларинголог, иногда вместе с другими специалистами.

Важно изменить образ жизни: бросить курить или хотя бы курить меньше, а при аллергии соблюдать гипоаллергенный быт. Важны и приверженность лечению, соблюдение доз, правильная техника введения лекарств и промывания.

5.3 Госпитализация

Пациентов с хроническим синуситом, кистами и мукоцеле лечит прежде всего оториноларинголог, при необходимости вместе с аллергологом-иммунологом, гастроэнтерологом, ревматологом, стоматологом-хирургом или челюстно-лицевым хирургом. Консервативное лечение и лечение лёгких обострений проводят амбулаторно.

В ЛОР-отделение экстренно госпитализируют при внутричерепных или внутриглазничных осложнениях, при тяжёлом обострении, а при среднетяжёлом — если амбулаторное лечение 5–7 дней не помогло или состояние прогрессивно ухудшается в любые сроки.

Планово для операции госпитализируют при подтверждённом хроническом синусите, не отвечающем на адекватную консервативную терапию 6 месяцев; при возврате симптомов после операции; у детей, у которых жалобы и признаки синусита сохраняются после удаления аденоидов; при изолированном воспалении с субтотальным или тотальным снижением пневматизации на КТ дольше 2 месяцев; при подозрении на новообразование пазухи неясной природы; при «синдроме молчащего синуса» верхнечелюстной пазухи на КТ; при кисте с постоянными или периодическими симптомами и при мукоцеле.

Выписывают, когда операция выполнена в нужном объёме, общее состояние удовлетворительное и нет местного или системного острого инфекционного воспаления.

5.4 Прогноз

Успех лечения зависит от анатомии носа и пазух у конкретного пациента, хронических системных болезней, активного и пассивного курения, профессиональных вредностей, климата и экологии, а также от того, насколько пациент соблюдает лечение.

Одонтогенные кисты сами не проходят, и их лечат несколько специалистов вместе.

---

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Хронический синусит»
Версия	1-я, опубликована в рубрикаторе 14.10.2025
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее октября 2028 года
Код в рубрикаторе	955_1 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Пациенты	Взрослые и дети

6.1 Неточности в самом тексте КР

- Сроки операции у взрослых расходятся: в рекомендации о функциональной риносинус-хирургии — после 1–2 неэффективных курсов консервативной терапии, в показаниях к плановой госпитализации

(раздел 6) — после 6 месяцев неэффективной терапии.

- Классификация по тяжести (0–3, 4–7, 8–10 баллов суммарной выраженности симптомов) ссылается на приложение Г1, где описана ВАШ только для боли и с другой градацией.
- В определении симптомы должны держаться «более 12 недель», а в критериях диагноза — «12 недель и более» (≥12 недель).
- Удаление аденоидов в рекомендации названо «аденоидэктомией», а в комментарии к ней — «аденотомией».
- В комментарии об антибиотиках у детей повторяется оборот: «в случае невозможности применения при невозможности применения».
- В оглавлении разделы «Хирургическое лечение» и «Иное лечение» пронумерованы как «3.» вместо 3.2 и 3.3.

Клинические рекомендации

Хронический средний отит

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**H65.2** — Хронический серозный средний отит **H65.3** — Хронический слизистый средний отит **H65.4** — Другие хронические негнойные средние отиты **H66.1** — Хронический туботимпанальный гнойный средний отит **H66.2** — Хронический эпитимпано-антральный гнойный средний отит **H66.3** — Другие хронические гнойные средние отиты **H72.0** — Центральная перфорация барабанной перепонки **H90.0** — Кондуктивная потеря слуха двусторонняя **H90.1** — Кондуктивная потеря слуха односторонняя с нормальным слухом на противоположном ухе **H90.2** — Кондуктивная потеря слуха неуточненная **H90.6** — Смешанная кондуктивная и нейросенсорная тугоухость двусторонняя **H90.7** — Смешанная кондуктивная и нейросенсорная тугоухость односторонняя, с нормальным слухом на противоположном ухе **H90.8** — Смешанная кондуктивная и нейросенсорная тугоухость неуточненная
Пациенты	взрослые, дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 29.10.2024, пересмотр не позднее 2027 года
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/698_2

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 22.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

1. Главное

- Основное лечение хронического гнойного среднего отита — хирургическое, и любой такой пациент — потенциальный кандидат на операцию. Оперируют в ремиссии, не раньше чем через 3–6 месяцев после последнего обострения.
- При диагностике всем делают тональную пороговую аудиометрию: она определяет степень и вид тугоухости и позволяет прогнозировать результат операции. Если пороги костной проводимости на разговорных частотах выше 30 дБ, качественного улучшения слуха не стоит ждать даже после безупречной операции.
- При подозрении на холестеатому или её рецидив назначают МРТ височных костей: в режимах T1, T2 и диффузионно-взвешенных изображениях она отличает холестеатому от секрета, грануляций и холестероловой гранулемы.
- В консервативном лечении главную роль играют местные средства — антисептики, ушные капли с противомикробными препаратами и кортикостероидами; топические фторхинолоны не ототоксичны и подходят при перфорации. Местное лечение работает только после тщательного удаления содержимого из среднего уха аспирацией или промыванием.
- Неоперированных пациентов осматривают раз в 6 месяцев, а после тимпанопластики или санирующей операции — раз в год не меньше 5 лет, чтобы не пропустить рецидив перфорации, холестеатомы и тугоухости.

2. Клиника и классификация

2.1 Определение

Хронический гнойный средний отит (ХГСО) — хроническое воспаление полостей среднего уха со стойкой перфорацией барабанной перепонки, постоянным или периодическим гноетечением из уха и прогрессирующим снижением слуха дольше 3 месяцев.

Мукозит — хроническое катаральное воспаление слизистой среднего уха. Тимпаносклероз — необратимый исход неспецифического воспаления с тугоухостью из-за фиксации звукопроводящей цепи. Тимпанофиброз — незаконченный процесс, при котором фиброзирование в барабанной полости преобладает над воспалением. Холестеатома — белесовато-перламутровое эпидермальное образование с оболочкой (матриксом), покрытой многослойным плоским эпителием; матрикс плотно прилежит к кости и нередко врастает в неё.

2.2 Причины

У взрослых ХГСО развивается на фоне хронических болезней полости носа, околоносовых пазух и носоглотки, после перенесённых острых средних отитов, при системной и специфической патологии. Запускает процесс обычно острый средний отит, после которого остаётся стойкая перфорация или ретракция с атрофичной неомембраной, а также травматическая или ятрогенная перфорация: после врачебных манипуляций она сохраняется у 1,3–10,8% пациентов.

Хронизации способствуют анатомические особенности среднего уха и слуховой трубы, неадекватная антибактериальная терапия острого отита без дренирования среднего уха, устойчивые штаммы возбудителей, ретракция после острого отита, экссудативный средний отит, ослабление местной иммунной защиты, а также болезни носоглотки и носа, нарушающие мукоцилиарный клиренс слуховой трубы.

Главный возбудитель среди аэробов — синегнойная палочка (Pseudomonas aeruginosa), второй по значимости — золотистый стафилококк. Из анаэробов чаще высевают пептококки и пептострептококки, реже бактероиды; анаэробы чаще сопутствуют холестеатоме. В 1,4–20% случаев флора грибковая, обычно Aspergillus и Candida.

2.3 Классификация

По МКБ-10 различают две формы ХГСО: мезотимпанит (туботимпанальный отит) и эпитимпанит (эпитимпано-антральный отит). При мезотимпаните поражается в основном слизистая мезо- и гипотимпанума, при эпитимпаните процесс из эпитимпанума распространяется в клетки сосцевидного отростка и поражает костные структуры среднего уха.

По клинико-морфологической классификации хронический средний отит бывает неперфоративным — экссудативным, адгезивным (рубцовым), с тимпаносклерозом или тимпанофиброзом — и перфоративным: сухим, с мукозитом, с тимпаносклерозом или с холестеатомой.

Место перфорации отражает только преимущественную локализацию воспаления и не говорит о том, что происходит в среднем ухе: даже при мезотимпаните цепь слуховых косточек разрушена у 10–22%, а холестеатома в барабанной полости есть у 11,6–42% пациентов. Поэтому для планирования операции эти изменения нужно диагностировать.

По классификации Европейской академии отологии и нейроотологии и Японского отологического общества (EAONO/JOS) различают 4 типа холестеатомы — врождённую, ненатянутой части, натянутой части перепонки и вторичную при перфорации натянутой части — и 4 стадии: 1 — в одном регионе, 2 — в двух и более, 3 — с внечерепным осложнением, 4 — с внутричерепным. Регионы обозначают по системе STAM: труднодоступные зоны (надтубарный и тимпанальный синусы), барабанная полость, аттик и сосцевидный отросток.

2.4 Клиническая картина

Пациенты жалуются на снижение слуха и шум в ухе; при осмотре видна перфорация барабанной перепонки с выделениями или холестеатомой.

Мезотимпанит — форма с перфорацией в натянутой части барабанной перепонки, встречается у 48–69% больных ХГСО. Её считают относительно благоприятной, потому что признаков активной остеодеструкции нет.

Эпитимпанит встречается у 15–19% больных: перфорация находится в ненатянутой части перепонки, в среднем ухе идёт кариозный процесс, который может привести к лабиринтным и внутричерепным осложнениям. Кость в 79–97% случаев разрушает холестеатома. Ретракционный карман считают начальной стадией холестеатомы: в 80% случаев она развивается именно из него.

При эпимезотимпаните, который выявляют у 17–33% пациентов, есть признаки обеих форм.

---

3. Диагностика

Диагноз ставят по совокупности жалоб, анамнеза, осмотра, лабораторных и инструментальных исследований.

3.1 Жалобы и анамнез

Пациента расспрашивают, снижен ли слух на одно или оба уха.

Снижение слуха отмечают 93–99% пациентов, чаще с двух сторон. При долгом течении, когда формируются тимпаносклероз, тимпанофиброз и ретракционный карман, тугоухость становится выраженной.

Уточняют, как долго, как часто и какие бывают выделения из уха.

Оторея — вторая по значимости жалоба, она бывает у 76–100% пациентов. Около половины отмечают выделения 1–2 раза в год после переохлаждения, попадания воды в ухо или ОРЗ, почти треть — частые или постоянные выделения в последние годы. Выделения бывают от скудных слизистых до гнойных с ихорозным запахом.

Редкие обострения при выраженной тугоухости характерны для тимпаносклероза, тимпанофиброза и холестеатомы, постоянные выделения — для мукозита, гнойные выделения с неприятным запахом — для холестеатомы. Эпитимпанит опасен тем, что долго протекает бессимптомно.

Спрашивают о шуме в одном или обоих ушах.

Шум беспокоит 19–48% пациентов. Низкочастотный шум обычно связан с дефектом перепонки, высокочастотный — с поражением внутреннего уха. При тимпаносклерозе и тимпанофиброзе шум усиливается.

Спрашивают о заложенности, ощущении жидкости и дискомфорте в ухе.

Такие жалобы чаще бывают, когда натянутая часть барабанной перепонки сохранена.

Спрашивают о головокружении в прошлом.

Системное головокружение или неустойчивость бывают у 10–27% больных с холестеатомой — при обострении, нагрузке, наклонах и поворотах головы. В половине случаев это говорит о фистуле лабиринта. Если разрушена стенка канала лицевого нерва, возможен его парез.

Спрашивают о головной боли.

Головная боль разной локализации часто появляется при обострении. Для неосложнённого эпитимпанита боль в ухе и головная боль не характерны: обычно они означают, что возникло осложнение.

3.2 Осмотр

Всем выполняют отоскопию или видеоотоскопию: при ХГСО это определяющий метод диагностики вместе с отоэндоскопией.

Оценивают барабанную перепонку (тонкая, толстая, рубцовая, очаги тимпаносклероза), ретракционные карманы и их глубину, размер и место перфорации и её края, слизистую барабанной полости (мукозит, тимпаносклероз, полипы, грануляции, эпидермизация), видимые слуховые косточки (кариес, лизис), латеральную стенку аттика и адитус.

3.3 Степени мукозита при осмотре

Степень	Что видно
I	Слизистая медиальной стенки барабанной полости утолщена, свободного отделяемого нет
II	Подушкообразное утолщение слизистой медиальной стенки с большим количеством слизистых желёз и скудным слизистым отделяемым
III	Выраженная полиповидная гиперплазия слизистой мезогипотимпанума со слизистым отделяемым

Отоэндоскопия позволяет увидеть холестеатому в 61% случаев. При эпитимпаните перфорация бывает точечной, видна только при продувании, прикрыта серной коркой или временно отсутствует в стойкой ремиссии — тогда внимательно осматривают латеральную стенку аттика в поисках даже минимальной деструкции. Иногда болезнь маскируется под рецидивирующий экссудативный отит, а за прозрачным экссудатом виден холестеатомный мешок при небольшом ретракционном кармане в ненатянутой части. Глубокие карманы осматривают эндоскопами с углом обзора 0°, 30° и 70°.

Фистулу лабиринта помогает распознать фистульная проба.

Проходимость слуховой трубы проверяют пустым глотком, пробой Тойнби, приёмом Вальсальвы или продуванием баллоном Политцера. Чем сильнее мукозит, тем хуже вентиляционная и дренажная функции трубы. Дисфункция трубы может объяснять ретракцию перепонки до операции и в отдалённом послеоперационном периоде, её учитывают при хирургии и реабилитации. Если при хроническом серозном отите с трубой всё в порядке, нужно заподозрить спонтанную отоликворею.

Оценивают полость носа, околоносовые пазухи и носоглотку: искривление перегородки, гипертрофический ринит, хронические болезни пазух и носоглотки нарушают функцию слуховых труб и снижают эффективность лечения.

3.4 Слух: камертоны и аудиометрия

При подозрении на снижение слуха исследуют слух камертонами.

Количественные (камертоны С128–2048) и качественные (С128–512) пробы Ринне, Федериче и Вебера — скрининг, который показывает вид тугоухости, кондуктивной или сенсоневральной, и хуже слышащее ухо. По ним составляют слуховой паспорт; они же служат показанием к тональной пороговой аудиометрии.

При диагностике ХГСО выполняют тональную пороговую аудиометрию (ТПА).

ТПА точно определяет степень и вид тугоухости — кондуктивную, смешанную или нейросенсорную — и возможности реабилитации, позволяет прогнозировать результат операции и следить за ним в отдалённом периоде. Если пороги костной проводимости выше 30 дБ в диапазоне разговорных частот, качественного улучшения слуха нельзя ожидать даже после идеально выполненной операции. Динамику лучше оценивать на одном и том же аудиометре и одному и тому же исследователю.

Для ХГСО характерна кондуктивная и смешанная тугоухость; её степень зависит от дефекта перепонки, целости и подвижности цепи слуховых косточек и токсического действия воспаления на внутреннее ухо. Глухота при ХГСО часто связана с фистулой лабиринта из-за разрушения кости холестеатомой.

По аудиограмме холестеатому не распознать: костно-воздушный интервал не коррелирует с вариантом разрушения цепи, а холестеатома и грануляции сами могут проводить звук к внутреннему уху.

3.5 Лучевая диагностика

При ХГСО без холестеатомы для оценки сосцевидного отростка можно сделать рентгенографию височных костей в укладках по Шюллеру и Майеру.

Её делают, только если нет подозрения на холестеатому и осложнённого течения.

Пациентам с ХГСО выполняют компьютерную томографию (КТ) височных костей, чтобы оценить их структуры.

КТ — метод первичной диагностики. Она показывает распространённость процесса и анатомические особенности — низкое стояние дна средней черепной ямки, высокое стояние луковицы яремной вены, предлежание сигмовидного синуса, дегисценции лицевого канала и лабиринта, перегородку Кёрнера, — а также стенки барабанной полости и антромастоидального отдела, цепь косточек, слизистую и узкие пространства барабанной полости. Исследование проводят в аксиальной и коронарной проекциях с мультипланарной реконструкцией; идеальная толщина среза — 0,5–0,8 мм.

КТ выявляет признаки ХГСО в 99% случаев, деструкцию стенок среднего уха — в 55–97%. Отличить холестеатому от фиброза, грануляций, экссудата и гноя по плотности нельзя: у всех она от +30 до +40 HU. Заподозрить холестеатому в 88% случаев позволяют расположение образования, разрушение стенок барабанной полости, косточек и антромастоидальной области, расширение входа в антрум, разрушение латеральной стенки аттика или адитуса, дефект задней стенки слухового прохода, разрушение лицевого канала и фистула лабиринта, чаще горизонтального полукружного канала.

При ХГСО без холестеатомы на КТ видны изменения слизистой, рубцы вокруг цепи косточек, иногда её дефект — чаще из-за лизиса длинной ножки наковальни. Антрум при мезотимпаните в ремиссии обычно пневматизирован, сосцевидный отросток, как правило, компактный, склеротический.

Оперированное ухо КТ оценивает плохо: рубцы, грануляции и пластический аутоматериал по плотности не отличаются от холестеатомы. Заподозрить её можно только по росту «подозрительного» образования в динамике.

Чтобы объективно оценить распространённость процесса, КТ делают не раньше чем через 3–6 месяцев после обострения. КТ в период обострения необоснованно расширяет объём операции и оправдана только при осложнённом течении.

При подозрении на холестеатому или её рецидив выполняют магнитно-резонансную томографию (МРТ) височных костей.

В режимах T1, T2, EPI DWI и non-EPI DWI МРТ надёжно выявляет холестеатому и её рецидив после операции: чувствительность 77–100%, специфичность 86–100%. За холестеатому говорят низкий сигнал в T1 и высокий или средний — в T2 и non-EPI DWI. На точность влияет размер холестеатомы; для поиска рецидива МРТ выгоднее ревизионной операции и служит ей альтернативой.

Некоторые авторы для поиска холестеатомы советуют сочетать или совмещать КТ и МРТ: чувствительность тогда 96%, специфичность 100%.

При ХГСО с холестеатомой, осложнённой фистулой лабиринта, проводят вестибулометрию.

Её назначают при системном головокружении, неустойчивости и признаках фистулы. Если фистулу найти до операции, можно предупредить послеоперационные кохлеовестибулярные расстройства.

3.6 Лабораторные исследования

Общие лабораторные анализы выполняют при подготовке к плановой операции.

Отделяемое из уха сеют на аэробную и факультативно-анаэробную флору и определяют чувствительность к антимикробным препаратам.

Посев нужен при любом ХГСО, чтобы подобрать этиотропную терапию.

При подозрении на грибковый процесс отделяемое из ушей сеют на дрожжевые и мицелиальные грибы.

Удалённые ткани уха исследуют цитологически и патоморфологически.

Патоморфологическое исследование делают всякий раз, когда удаляют патологическую ткань. При атипичном воспалении спектр анализов расширяют, чтобы исключить туберкулёз и гранулематоз Вегенера; если ответа нет, а стандартное лечение не помогает, исследования повторяют через 3 месяца.

3.7 Консультации

При сопутствующих болезнях и подозрении на осложнение пациента консультируют невролог, нейрохирург и терапевт.

При атипичном воспалении и осложнениях могут понадобиться также фтизиатр и ревматолог.

---

4. Лечение

Цель лечения — санировать среднее ухо, чтобы добиться стойкой ремиссии и предупредить осложнения и тугоухость.

4.1 Консервативное лечение

Консервативную терапию проводят при обострении и для подготовки к операции при неосложнённом течении.

Её назначают при обострении, чтобы добиться ремиссии перед операцией, и в раннем периоде после санирующей операции. Она включает бета-лактамные антибиотики, анальгетики, кортикостероиды и процедуры для улучшения функции слуховой трубы.

При неосложнённом течении лечат амбулаторно, при осложнённом — в стационаре. Как основное лечение консервативная терапия носит паллиативный характер и оправдана только у пациентов с тяжёлыми сопутствующими болезнями при регулярном наблюдении.

При сухом перфоративном среднем отите никакого лечения не проводят.

> Расхождение в КР: в разделе 3.1 сказано, что при сухом перфоративном отите лечения не проводят, а в разделе 3.2 — что при перфорации без возможности улучшить слух тимпанопластику нужно выполнять, чтобы предупредить рецидивы, и что лучшие результаты тимпанопластики бывают именно при сухих перфорациях. В алгоритме (приложение Б) от сухого перфоративного отита стрелки ведут к лечению. Вероятно, запрет относится только к консервативной терапии.

Антибиотик выбирают с учётом флоры, её чувствительности и способности препарата проникать через гематоэнцефалический барьер. Препараты выбора — бета-лактамы (пенициллины и другие бета-лактамные антибиотики), в некоторых случаях — респираторные фторхинолоны.

Системные препараты назначают, как правило, при выраженном обострении и при тяжёлых распространённых деструктивных формах. Периоперационная антибиотикопрофилактика должна соответствовать характеру и объёму операции.

При смешанной флоре КР советует сочетать 2–3 препарата, например цефалоспорины и фторхинолоны. Возможно сочетание местных противомикробных препаратов с противогрибковыми.

Главная роль в лечении принадлежит местным средствам: антисептикам, ушным противомикробным препаратам, местным противогрибковым средствам и кортикостероидам в комбинации с противомикробными. Самые эффективные и безопасные — топические фторхинолоны: к ним чувствительны 75,6% возбудителей, они не ототоксичны и подходят при перфорации. Местное лечение действует только после тщательного удаления содержимого из среднего уха аспирацией или промыванием.

Грануляции в барабанной полости по возможности удаляют или прижигают соединениями серебра; они хорошо регрессируют и под действием топических кортикостероидов.

Кортикостероиды в каплях или в комбинированных препаратах назначают при вялотекущем воспалении слизистой (мукозите). Если местное лечение не помогает 1–3 месяца, что характерно для мукозита, выполняют операцию с дренированием.

При холестеатоме местно эффективны препараты борной кислоты: кроме антисептического действия, они подсушивают ткани и этим уменьшают воспаление.

При грибковой флоре противомикробные препараты и кортикостероиды в каплях противопоказаны. Таких пациентов ведут строго по алгоритмам применения местных противогрибковых средств; лечение часто долгое и требует участия миколога.

> Расхождение в КР: абзацем выше КР допускает сочетать противомикробные ушные препараты с противогрибковыми, а здесь при грибковой флоре противомикробные капли противопоказаны. Кроме того, «антибиотики для наружного применения» обозначены кодом АТХ D01A, который относится к противогрибковым препаратам.

Дисфункцию слуховой трубы лечат по порядку. Сначала устраняют болезни носа и носоглотки — от деконгестантов и назальных кортикостероидов до операции. Затем улучшают проходимость трубы продуванием по Политцеру или курсом катетеризаций с введением лекарств. Наконец, налаживают её самостоятельное открытие и закрытие специальной гимнастикой или электростимуляцией мышц трубы.

4.2 Хирургическое лечение

Основное лечение ХГСО — хирургическое: только операция позволяет полностью санировать ухо и улучшить качество жизни, поэтому любой пациент с ХГСО — потенциальный кандидат на неё. Оперируют в ремиссии, не раньше чем через 3–6 месяцев после последнего обострения: так операция меньше по объёму, безопаснее и эффективнее.

Вынужденная операция при обострении или осложнении — это только санация среднего уха открытого типа, при внутричерепных осложнениях расширенная; из-за кровоточивости тканей она технически сложна и чаще даёт ятрогенные осложнения. Пациентов с осложнениями оперируют в ургентных отделениях, вне обострения — в специализированных отделениях и центрах, где владеют реконструктивной хирургией среднего уха. Ранняя операция на «сухом ухе» лучше санирует очаг, сохраняет слух и анатомию и сокращает реабилитацию.

При ХГСО с мукозитом II и III степени выполняют дренирующие операции.

Методику выбирают индивидуально: по форме ХГСО и распространённости процесса, анатомии височной кости, степени тугоухости, состоянию слуховой трубы, осложнениям и опыту хирурга.

Чтобы санировать среднее ухо и улучшить слух, выполняют тимпанопластику.

При мезотимпаните делают тимпанопластику разных типов и миринготомию в зависимости от разрушения цепи косточек, используя протезы из хряща, наковальни, кортикальной кости, титана и аутоматериалы для пластики перепонки. Доступ — через слуховой проход, эндауральный или заушный, под местной анестезией или наркозом, под эндоскопом или микроскопом, в один или два этапа.
Результат зависит от времени после последнего обострения, изменений в среднем ухе, места и размера перфорации, функции слуховой трубы и состояния слизистой, способа реконструкции, опыта хирурга и послеоперационного ведения. Обязательное условие успешной тимпанопластики — отсутствие выделений минимум 3–6 месяцев.

Тимпанопластика эффективна в 43–98% случаев; риск глухоты оперированного уха — 1–2%. Лучшие результаты, у 93,3%, бывают при сухих перфорациях, независимо от техники укладки трансплантата.

Мастоидотомия при тимпанопластике у пациентов без холестеатомы не улучшает ни анатомический результат, ни аэрацию сосцевидного отростка, но увеличивает объём и риск операции. Обязательной её считают при вялотекущем хроническом перфоративном отите без холестеатомы, если системные и местные антибиотики не помогли.

Эндоскоп как дополнение к микроскопу улучшает обзор барабанной полости, но преимущества операций только под эндоскопом перед микроскопом по данным систематического обзора не доказаны.

При тотальных и субтотальных дефектах перепонки с изменённой слизистой большинство хирургов сочетают аутофасцию, аутохрящ и кожные трансплантаты, чтобы не было реперфорации. Тонкие пластинки аутохряща препятствуют ретракции и не ухудшают акустику.

При мукозите тимпанопластика оправдана: после восстановления функции трубы и аэрации утолщённая слизистая становится нормальной. Слизистую удаляют инструментами или лазером. При выраженном мукозите лучше результаты, если оставить дренажную трубку под меатальным лоскутом или вскрыть антрум и дренировать через него барабанную полость до 2 недель.

Второй этап тимпанопластики выполняют через 8–12 месяцев. Если перфорация есть, а слух улучшить нельзя, тимпанопластику всё равно делают, чтобы предупредить рецидивы ХГСО.

Искусственные протезы и аутопротезы при оссикулопластике по слуху не различаются, но искусственный протез без прикрытия аутохрящом смещается в 6 раз чаще.

4.3 Холестеатома: санирующие операции

При ХГСО с холестеатомой выполняют санирующие операции.

Главный принцип — удалить холестеатому полностью и устранить причины рецидива.

При эпитимпаните и эпимезотимпаните с холестеатомой в зависимости от распространённости выполняют «открытые», «полуоткрытые» или «закрытые» санирующие операции с тимпанопластикой или без неё. Из-за объёма и длительности их делают под общей анестезией.

Если холестеатома ограничена аттиком или аттиком и адитусом, можно ограничиться аттикотомией через слуховой проход, но обязательно тщательно убрать процесс из синусов и карманов среднего уха.

«Открытая» техника (с удалением задней стенки слухового прохода) избавляет от повторных операций, но не от регулярного ухода за полостью у оториноларинголога. После «закрытой» обязательна ревизия через 8–12 месяцев или МРТ для исключения рецидива. «Закрытые» операции опаснее внутричерепными осложнениями, поэтому, если постоянное наблюдение после операции невозможно, предпочтительна «открытая» методика.

«Закрытые» методики (аттикоадитотомия, аттикоантротомия, раздельная антромастоидотомия) предпочтительны при ограниченной холестеатоме, «открытые» (модифицированная радикальная, консервативно-радикальная, общеполостная операция, антромастоидотомия с удалением задней стенки, радикальная мастоидэктомия) — при распространённой деструкции, активной холестеатоме или вялотекущем обострении.

Современная тенденция — «полуоткрытая» (гибридная) техника: аттикоантро- или мастоидотомия с облитерацией антрума и сосцевидного отростка аутотканями или инертными материалами и тимпанопластикой. Анатомия уха остаётся близкой к исходной, болезни послеоперационной полости нет, и пожизненное наблюдение не нужно.

> Неточность в КР: частота рецидивов холестеатомы напечатана с ошибками — «у 342%» после «закрытой» и «у 712%» после «открытой» техники, видимо, потеряно тире в диапазонах. Сразу после этого сказано, что при «открытой» технике рецидивов меньше, но «эта техника» повышает риск рецидива в 2,9 раза по сравнению с «закрытой» и поэтому рекомендуется только при повторных операциях. По приведённым цифрам чаще рецидивирует «закрытая» техника, так что фраза противоречива.

Если после «закрытой» операции найден рецидив холестеатомы, объём операции расширяют до антромастоидотомии с удалением задней стенки слухового прохода и формированием открытой полости.

После операции слуховой проход тампонируют с противомикробными препаратами: после тимпанопластики на 10–14 дней, после санирующей операции — на 14–21 день; дополнительно воздействуют на слуховую трубу и слизистую лекарствами и физиотерапией. Важно и квалифицированное наблюдение в отдалённом периоде.

4.4 Слухопротезирование

Если слух асоциальный (тугоухость больше II степени) и улучшить его нельзя, проводят электроакустическую реабилитацию.

Слухопротезирование показано при порогах костной проводимости выше 30 дБ на оба уха, в том числе в отдалённом периоде после операции.

5. Наблюдение, профилактика, госпитализация

Пациентов, которым операция противопоказана, отложена или которые от неё отказались, наблюдает специалист поликлиники раз в 6 месяцев, а при обострении назначает консервативное лечение.

После тимпанопластики и санирующих операций пациент раз в год приходит к врачу поликлиники и к отохирургу клиники, где его оперировали, не меньше 5 лет после операции. Цель — вовремя найти рецидив перфорации, холестеатомы и тугоухости.

Для профилактики обострений санируют нос и носоглотку, объясняют пациенту характер болезни, учат беречь ухо от воды и предупреждать обострения при ОРЗ и своевременно обращаться к врачу поликлиники и в клинику, где была операция.

После операции, в зависимости от методики, назначают постельный режим с положением на противоположном ухе. Месяц нужно избегать физических нагрузок, 3 месяца — авиаперелётов, а ухо беречь от воды до конца реабилитации.

5.1 Госпитализация и выписка

Пациента первично осматривают оториноларинголог и сурдолог-оториноларинголог.

Экстренно госпитализируют при обострении ХГСО с внечерепными или внутричерепными осложнениями.

Планово госпитализируют для операции при ХГСО, в том числе с холестеатомой, в стадии вялотекущего воспаления или ремиссии не меньше 3–6 месяцев. Показания — снижение слуха с шумом в ухе, снижение слуха со скудными выделениями, которые не проходят от консервативного лечения, или любые клинические проявления ХГСО независимо от вида тугоухости, если нет общих противопоказаний и пациент обследован по требованиям стационара.

После экстренной госпитализации выписывают, когда угрозы жизни нет и жизнедеятельность восстановлена, после плановой — в зависимости от объёма операции и самочувствия: на 3–5-й день после окончания противовоспалительной и симптоматической терапии, с тампонами в слуховом проходе. Тампоны удаляют амбулаторно через 2–3 недели, а слух по ТПА проверяют амбулаторно через 3 и 12 месяцев.

Эффективность лечения оценивают по жалобам на снижение слуха и выделения, по отоэндоскопии (закрылась ли перфорация, нет ли отореи, эпидермизирована ли полость), по ТПА, по КТ или МРТ (санировано ли ухо, нет ли деструкции и холестеатомы) и по вестибулометрии при фистуле лабиринта.

ХГСО ведёт к прогрессирующей тугоухости и осложнениям: лабиринтиту, периферическому парезу лицевого нерва, менингиту, абсцессу мозга и тромбозу сигмовидного синуса.

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Хронический средний отит»
Версия	2-я, год утверждения 2024, опубликована в рубрикаторе 29.10.2024
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По правилу из приложения А2 КР — не реже одного раза в три года: следующая версия ожидается не позднее октября 2027 года
Код в рубрикаторе	698_2 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Пациенты	Взрослые и дети

6.1 Неточности в самом тексте КР

- При сухом перфоративном среднем отите раздел 3.1 запрещает любое лечение, а раздел 3.2 и алгоритм в приложении Б предусматривают при перфорации тимпанопластику.
- Сочетание противомикробных ушных препаратов с противогрибковыми допускается, но при грибковой флоре противомикробные капли противопоказаны; «антибиотики для наружного применения» обозначены кодом противогрибковых препаратов D01A.
- Частота рецидивов холестеатомы напечатана с ошибками («у 342%», «у 712%», «4,28,4%»), а вывод о том, что «открытая» техника повышает риск рецидива в 2,9 раза, противоречит приведённым цифрам.
- Сроки тампонады после операции различаются: в разделе 3.2 — 10–14 дней после тимпанопластики и 14–21 день после санирующей операции, в разделе 6 — удаление тампонов через 2–3 недели.
- Название и коды МКБ охватывают и негнойные формы (H65.2–H65.4), но определение и весь текст КР посвящены только хроническому гнойному среднему отиту.
- В рекомендации о дренирующих операциях мукозит разделён на «стадии», хотя при осмотре описаны его «степени».
- В критериях качества у консервативного лечения указан УДД 4, а в самой рекомендации — УДД 5; критерия «хирургическое лечение при неэффективности консервативной терапии» в рекомендациях нет, по тексту КР операция — основное лечение.
- В оглавлении PDF номера страниц многих разделов искажены («100», «133», «232» и т. п.).

Клинические рекомендации

Хронический тонзиллит

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**J31.2** — Хронический фарингит **J35.0** — Хронический тонзиллит **J35.8** — Другие хронические болезни миндалин и аденоидов **J35.9** — Хроническая болезнь миндалин и аденоидов неуточненная
Пациенты	взрослые, дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 20.11.2024, пересмотр не позднее 2027 года
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/683_2

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 22.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

1. Главное

- Диагноз ставят по фарингоскопии: решают местные признаки хронического воспаления миндалин, и важнее всего жидкий гной в лакунах. Размер миндалин для диагноза значения не имеет.
- Во время острого воспаления глотки хронический тонзиллит не диагностируют: признаки можно достоверно оценить только через 3–4 недели после него.
- По классификации Солдатова тонзиллит бывает компенсированным и декомпенсированным; форму определяют по анамнезу за последние три года.
- Консервативное лечение проводят курсами между обострениями: при компенсированной форме 2 раза в год, весной и осенью, при рецидивах ангин — до 4 раз в год, за 1–1,5 месяца до ожидаемого обострения.
- Тонзиллэктомия показана при любой декомпенсации, а при рецидивирующих ангинах — если противорецидивное лечение не помогло.

2. Клиника и классификация

2.1 Определение

Хронический тонзиллит — инфекционно-аллергическое заболевание всего организма с местными проявлениями: стойким воспалением нёбных миндалин с альтерацией, экссудацией и пролиферацией.

2.2 Местные признаки

Выделяют пять групп местных признаков: гиперемия и валикообразное утолщение краёв нёбных дужек; рубцовые спайки между миндалинами и дужками; разрыхлённые или, наоборот, рубцово изменённые и уплотнённые миндалины; казеозно-гнойные пробки или жидкий гной в лакунах; увеличенные регионарные лимфоузлы.

Признак Гизе — гиперемия краёв передних дужек. Признак Зака — отёк в месте соединения передних и задних дужек. Признак Преображенского — валикообразное утолщение краёв верхних отделов передних и задних дужек.

2.3 Классификация Солдатова

При компенсированной форме местные признаки видны, а общих симптомов почти или совсем нет. При декомпенсированной к местным признакам добавляется хотя бы один вид декомпенсации: рецидивы ангин; паратонзиллит или паратонзиллярный абсцесс; тонзиллогенная интоксикация — долгий субфебрилитет, недомогание, снижение трудоспособности без другой причины; тонзиллогенные функциональные нарушения внутренних органов; заболевания органов, связанные с тонзиллитом. Форму определяют по анамнезу за последние три года.

2.4 Классификация Преображенского — Пальчуна

При простой форме есть только местные признаки, и почти всегда в анамнезе были ангины.

При токсико-аллергической форме I степени периодически бывают субфебрилитет, слабость, быстрая утомляемость, боли в суставах, увеличенные и болезненные регионарные лимфоузлы, непостоянные функциональные нарушения со стороны сердца и нестойкие отклонения в анализах.

При II степени функциональные нарушения сердца подтверждаются на ЭКГ, бывают сердцебиение и нарушения ритма, боли в сердце и суставах во время ангины и вне её, функциональные нарушения почек, печени, суставов и сосудов, а также связанные с тонзиллитом болезни: паратонзиллярный абсцесс, парафарингит, тонзиллогенный сепсис, ревматизм, артрит, приобретённые пороки сердца, гломерулонефрит.

Описано около 100 болезней, связанных с хроническим тонзиллитом; чаще всего страдают сердце, суставы, почки, эндокринная система и кожа. В трудных случаях тактику выбирают вместе с профильным специалистом.

2.5 Жалобы и анамнез

Пациенты могут жаловаться на несильную боль, першение, ощущение инородного тела в горле, периодический сухой кашель и неприятный запах изо рта. Эти жалобы неспецифичны — они бывают и при хроническом фарингите, болезнях гортани, полости рта и зубов, — а у части пациентов их нет вовсе.

При декомпенсированной форме бывают общие жалобы: долгое недомогание, снижение работоспособности, затяжной субфебрилитет. Они тоже неспецифичны, поэтому нужно обследование, чтобы исключить другие причины.

У детей и взрослых, особенно часто и долго болеющих, выясняют местные и общие жалобы и уточняют, как часто были ангины. Ангины в анамнезе многие авторы считают самым надёжным признаком хронического тонзиллита, но сведения о них должны быть подтверждены.

---

3. Диагностика

Диагноз ставят по анамнезу (ангины, долгая утомляемость, субфебрилитет, регионарный лимфаденит, болезни, связанные с тонзиллитом), осмотру, лабораторным данным и фарингоскопии.

3.1 Осмотр

Фарингоскопию проводят детям и взрослым, чтобы исключить острый тонзиллит и найти местные признаки хронического.

Пока есть острое воспаление глотки, хронический тонзиллит не диагностируют: его признаки можно достоверно оценить только через 3–4 недели.

Всем проводят осмотр верхних дыхательных путей с хорошим освещением, шпателем и зеркалами, фарингоскопию и эпифарингоскопию.

Решающее значение имеют фарингоскопические признаки, и важнее всего жидкий гной в лакунах, часто с неприятным запахом. Увеличение лимфоузлов может быть вызвано и другими воспалительными процессами головы и шеи. Размер миндалин для диагноза значения не имеет.

Осматривают при ярком направленном свете двумя шпателями, при необходимости зондом. За 20–30 минут до осмотра пациенту не стоит есть, пить горячее, холодное и газированное, курить и разговаривать на холоде, чтобы не было преходящей гиперемии. Вторым шпателем надавливают на дужку, чтобы увидеть содержимое лакун и спайки.

3.2 Анализы

Общий анализ крови и мочи, СРБ и ревматоидный фактор назначают, чтобы выявить связанное с тонзиллитом заболевание.

Антистрептолизин-О (АСЛ-О) определяют, чтобы отличить активную стрептококковую инфекцию от носительства.

Высокий АСЛ-О без стрептококка в посевах говорит о возможной внутриклеточной персистенции и считается подтверждением декомпенсации. Но высокий АСЛ-О без симптомов со стороны миндалин сам по себе не повод для лечения.

Возраст	Норма АСЛ-О, МЕ/мл
До 7 лет	до 100
7–14 лет	150–200
С 14 лет	до 250

Отделяемое с нёбных миндалин сеют на бета-гемолитический стрептококк группы А (БГСА) или делают экспресс-тест.

Анализы крови и мочи, посевы и цитология содержимого лакун для самого диагноза значения почти не имеют. Они нужны, чтобы уточнить форму, роль микрофлоры, связь с болезнями других органов и эффект лечения.

Лазерная допплеровская флоуметрия, УЗИ и другие дополнительные методы пока не получили распространения, доказательств их эффективности нет.

---

4. Лечение

Хронический тонзиллит лечат между обострениями. Ангину лечат по рекомендациям по острому тонзиллофарингиту, а паратонзиллит и абсцесс — по рекомендациям по этим заболеваниям.

Перед любым лечением проверяют зубы, околоносовые пазухи и носоглотку и при необходимости санируют их.

4.1 Консервативное лечение

Консервативное лечение показано при компенсированной и простой форме — курсами 2 раза в год, весной и осенью. При декомпенсации в виде рецидивов ангин и при токсико-аллергической форме I степени — до 4 курсов в год, за 1–1,5 месяца до ожидаемой ангины. При других видах декомпенсации и токсико-аллергической форме II степени — если операция противопоказана.

Лечение помогает, только если лакуны дренируются, а складки и карманы очищаются от экссудата и детрита.

Системные антибиотики назначают при обострении, если выделен стрептококк или появляются признаки осложнений, — это пенициллины. Вне обострения, при функциональных нарушениях внутренних органов, отрицательных посевах на БГСА и стойко высоком АСЛ-О, предпочтение отдают 14-членным макролидам, курсом до 2 недель.

Нужны ли антибиотики между обострениями, специалисты спорят, поэтому решение принимают индивидуально, по объективным данным и динамике симптомов и анализов.

Если подтверждена грибковая природа, назначают противогрибковые препараты внутрь с учётом чувствительности.

Между обострениями курсами назначают растительные препараты с корнем алтея, цветками ромашки, травой тысячелистника, корой дуба, травой хвоща и корнем одуванчика, чтобы реже были ангины.

4.2 Местное лечение

Между обострениями промывают лакуны миндалин: курс из 10 процедур ежедневно или через день. Промывать можно не раньше чем через 2–3 недели после острого воспаления.

Промывают стерильным раствором натрия хлорида или растворами антисептиков, соблюдая дозы и возрастные ограничения и помня об аллергии на препараты йода. Смазывание миндалин курсом 10–15 процедур проводят отдельно или сразу после промывания.

Детям дошкольного и младшего школьного возраста миндалины не промывают и не смазывают из-за риска рефлекторного ларингоспазма.

Назначают антисептики в виде полосканий, инсуффляций, ингаляций и таблеток для рассасывания.

Взрослым при обострении назначают НПВП для местного применения.

Топические бактериальные лизаты в таблетках для рассасывания уменьшают число и длительность обострений.

В ремиссии пациента консультирует физиотерапевт; перед физиотерапией проводят курс промываний.

4.3 Тонзиллэктомия

Двустороннюю тонзиллэктомию делают между обострениями, чтобы радикально убрать очаг инфекции.

По классификации Солдатова операция показана при любой декомпенсации, кроме рецидивов ангин, если противорецидивное лечение не проводилось. При рецидивах ангин — если консервативное лечение не помогло и ангины продолжаются или появился другой вид декомпенсации.

По классификации Преображенского — Пальчуна — при токсико-аллергической форме II степени, а также при простой форме и форме I степени, если 2–3 тщательных курса консервативного лечения в год не помогли.

Детям операция показана при частых стрептококковых ангинах (не меньше 7 за последний год, не меньше 5 в год за последние 2 года или не меньше 3 в год за последние 3 года), при двух паратонзиллярных абсцессах и больше (иногда и после одного) и по заключению профильных специалистов, если операция нужна для лечения сопутствующей болезни.

Критерии Paradise: тонзиллэктомию рассматривают при 7 эпизодах боли в горле за год, 5 в каждом из двух лет или 3 в каждом из трёх лет. Эпизодом считается боль в горле хотя бы с одним признаком: температура 38,3 °C и выше, экссудат на миндалинах, шейные лимфоузлы больше 2 см и болезненные, БГСА в посеве или положительный экспресс-тест.

Абсолютные противопоказания: болезни крови (гемофилия, лейкозы, геморрагические диатезы), аномальные сосуды глотки (пульсация боковой стенки), тяжёлая сердечная недостаточность II–III степени, выраженная почечная недостаточность, тяжёлый сахарный диабет с кетонурией, тяжёлые болезни печени, тяжёлые нервно-психические болезни, злокачественные опухоли, активный туберкулёз.

Относительные противопоказания: острые инфекции и 3–4 недели после них, острые воспаления и обострения хронических, в том числе ЛОР-органов, эпидемии гриппа, менструация, неактивный туберкулёз, преходящая тромбоцитопения, нетяжёлый сахарный диабет, кариозные зубы.

Самое частое осложнение — кровотечение из ниши миндалины во время операции или в первые 5–7 дней, но оно возможно и на 8–15-е сутки. Поэтому первые 5–7 дней пациент лежит в стационаре, а после выписки ещё 5–7 дней наблюдается в поликлинике на больничном.

4.4 После операции

В первые сутки пациент соблюдает постельный режим и молчит; через несколько часов можно сделать несколько глотков воды. Дальше режим щадящий, пища жидкая или протёртая, не горячая и не холодная. Назначают местные и системные обезболивающие и предупреждают обострение сопутствующих болезней.

Для обезболивания и уменьшения воспаления назначают НПВП.

После тонзиллэктомии месяц ограничивают физическую нагрузку, соблюдают режим сна и отдыха.

---

5. Наблюдение, профилактика, госпитализация

При компенсированной форме курсы лечения проводят 2 раза в год. Если 3 года не было ангин и других признаков декомпенсации, пациента снимают с диспансерного учёта.

При декомпенсации в виде рецидивов ангин курсы проводят 3–4 раза в год. Если за год лечение не помогло, ангины осложняются или появляется другой вид декомпенсации, пациента направляют на операцию.

После тонзиллэктомии пациент находится на диспансерном наблюдении 6 месяцев.

Для профилактики рецидивов и восстановления нормальной микрофлоры ротоглотки применяют БАД с естественными бактериями ротоглотки, например *S. salivarius* K12.

Риск хронического тонзиллита повышают несбалансированное питание (особенно недостаток витаминов A, B, E), переутомление, плохая гигиена жилья и рабочего места, загрязнённый воздух, курение, в том числе пассивное, болезни зубов, носа и пазух, частые ОРВИ и их неправильное лечение.

Лечит обычно оториноларинголог амбулаторно.

В хирургическое отделение госпитализируют при неэффективности лечения, подозрении на гнойное осложнение (паратонзиллярный, парафарингеальный, ретрофарингеальный абсцесс, гнойный лимфаденит) или новообразование и когда нужна операция. Тонзиллэктомию проводят в ЛОР-отделении планово и выписывают на 5–7-е сутки, если послеоперационный период протекает без осложнений.

Тонзиллит чаще переходит в декомпенсированную форму при иммунодефиците (врождённом, на иммунодепрессантах и цитостатиках, при ВИЧ). Аутоиммунные осложнения вероятнее при стрептококковом тонзиллите и ревматической лихорадке у пациента или близких родственников.

---

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Хронический тонзиллит»
Версия	2-я, опубликована в рубрикаторе 20.11.2024
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее ноября 2027 года
Код в рубрикаторе	683_2 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Пациенты	Взрослые и дети

6.1 Неточности в самом тексте КР

- В разделе 1.4 указан код J31.1 «Хронический назофарингит», а в карточке рубрикатора — J31.2 «Хронический фарингит». На сайте приведён код из текста КР.

- Бензидамин в комментарии отнесён к «пенициллинам, чувствительным к бета-лактамазам» (код АТХ J01CE) — это ошибка: бензидамин — нестероидный противовоспалительный препарат для местного применения.